

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI



CÔNG THỊ HẰNG

RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH
TRUNG HỌC CƠ SỞ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

HÀ NỘI, 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CÔNG THỊ HẰNG

RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

Mã số: 9.31.04.01

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Minh Đức

HÀ NỘI, 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục đích nghiên cứu	12
3. Đối tượng nghiên cứu	12
4. Khách thể nghiên cứu	13
5. Giả thuyết khoa học	13
5.1. Giả thuyết 1 — Khác biệt giới tính phụ thuộc vào loại rối loạn lo âu	13
5.2. Giả thuyết 2 — Lòng tự trọng là yếu tố bảo vệ thuộc nhóm mạnh nhất	13
5.3. Giả thuyết 3 — Áp lực học tập và nghiện điện thoại là hai yếu tố nguy cơ thuộc nhóm mạnh nhất	13
6. Nhiệm vụ nghiên cứu	14
6.1 Hệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài về rối loạn lo âu và rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở.	14
6.2. Nghiên cứu thực trạng, biểu hiện mức độ rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở và các yếu tố ảnh hưởng (yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ), biện pháp đối phó với rối loạn lo âu;	14
6.3. Đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường cho học sinh THCS.	14
7. Giới hạn nghiên cứu	14
7.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu	14
7.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu	14
7.3 Giới hạn khách thể nghiên cứu	14
8. Phương pháp nghiên cứu	14
8.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn bản	14
8.2 Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi	14
8.3. Phương pháp phỏng vấn sâu	15
8.4. Phương pháp quan sát	15
8.5. Phương pháp phân tích xử lý số liệu thống kê	15
9. Tiếp cận nghiên cứu	15
9.1. Tiếp cận theo góc độ Tâm lý học trường học	15
9.2. Tiếp cận dưới góc độ Tâm lý học phát triển	15
9.3. Tiếp cận theo quan điểm Tâm bệnh học	16
9.4. Tiếp cận theo quan điểm Xã hội	16
10. Đóng góp mới của đề tài	17
10.1. Về lý luận	17
10.2. Về thực tiễn	17
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ	19
1.1 Tổng quan nghiên cứu	19
1.1.1. Tỷ lệ phổ biến của rối loạn lo âu ở vị thành niên	19
1.1.2. Mức độ rối loạn lo âu	21
1.1.3. Biểu hiện rối loạn lo âu	23
1.1.4. Yếu tố nguy cơ đối với rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở	26
1.1.5. Yếu tố bảo vệ đối với rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở	31
1.1.6. Nghiên cứu về can thiệp rối loạn lo âu ở học sinh trung học	35

1.1.7. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu tại Việt Nam	46
1.2 Cơ sở lý luận về rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở	47
1.2.1. Khái niệm rối loạn lo âu	47
1.2.2. Phân loại rối loạn lo âu	53
1.2.3. Biểu hiện của rối loạn lo âu	57
1.2.4. Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở	62
1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở	68
1.3. Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS	72
1.3.1. Cơ sở khoa học	72
1.3.2. Khái niệm khung chương trình	74
1.3.3. Cấu trúc khung chương trình	75
TIỂU KẾT CHƯƠNG I	77
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	78
2.1. Tổ chức nghiên cứu	78
2.1.1 Nhiệm vụ cụ thể của nghiên cứu	78
2.1.2 Vài nét về địa bàn nghiên cứu	79
2.1.3. Thời gian tiến hành nghiên cứu	80
2.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu	81
2.2.1. Khách thể nghiên cứu	81
2.2.2. Đối tượng nghiên cứu	82
2.3. Các giai đoạn thực hiện nghiên cứu	82
2.3.1. Giai đoạn nghiên cứu lý luận	82
2.3.2. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn	83
2.4. Phương pháp nghiên cứu	86
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận	86
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn	87
2.4.3. Phương pháp thống kê toán học	92
2.5. Đạo đức nghiên cứu	93
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2	95
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU	96
Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ	96
3.1. Hiệu lực đo lường của các thang đo sử dụng trong nghiên cứu	96
3.1.1. Hiệu lực đo lường của thang đo rối loạn lo âu	97
3.1.2. Hiệu lực đo lường của các thang đo yếu tố NGUY CƠ	98
3.1.3. Hiệu lực đo lường của các thang đo yếu tố bảo vệ	102
3.2. Thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh THCS	107
3.2.1. Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS	107
3.2.2. Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu chia ly ở học sinh THCS	108
3.2.3. Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu xã hội ở học sinh THCS	109
3.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu	112
3.3.1. Thực trạng các yếu tố NGUY CƠ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu	112
3.3.2. Thực trạng các yếu tố BẢO VỆ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu	115
3.4 Tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh THCS	118
3.4.1. Tác động của các yếu tố NGUY CƠ đối với rối loạn lo âu	118
3.4.2. Tác động của các yếu tố BẢO VỆ đối với rối loạn lo âu	125

3.4.3. Mô hình ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ và bảo vệ đối với rối loạn lo âu	132
3.5. Thực trạng các biện pháp đối phó của học sinh THCS	135
3.5.1. Thực trạng các biện pháp đối phó	135
3.5.2. Tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu	137
3.6. Bàn luận	140
3.7 Đề xuất Khung Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS dựa trên kết quả nghiên cứu	143
3.7.1 Cơ sở khoa học của Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS	143
3.7.2 Mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng và phạm vi áp dụng của chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh trung học cơ sở	148
3.7.3 Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS	150
3.7.4 Đánh giá hiệu quả chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường dành cho học sinh THCS	151
3.7.5 Phương pháp và quy trình triển khai chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS	152
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3	154
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	156
1. Kết luận	156
1.1. Về lý luận	156
1.2. Về thực tiễn	157
2. Kiến nghị	159
2.1. Đối với học sinh	159
2.2. Đối với giáo viên và nhà trường	160
2.3. Đối với gia đình	160
2.4. Đối với các lực lượng hỗ trợ học đường (chuyên viên tâm lý, phòng tư vấn học đường, đoàn thanh niên, các câu lạc bộ)	161
3. Giới hạn và định hướng nghiên cứu	161
3.1. Giới hạn nghiên cứu	161
3.2 Định hướng nghiên cứu trong tương lai	162
TÀI LIỆU THAM KHẢO	164
PHỤ LỤC	184
PHỤ LỤC 1	184
PHỤ LỤC 2	191
PHỤ LỤC 3	194
PHỤ LỤC	197

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ
RLLA	Rối loạn lo âu
RLLA LT	Rối loạn lo âu lan tỏa
RLLA CL	Rối loạn lo âu chia ly
RLLA XH	Rối loạn lo âu xã hội
YTNC	Yếu tố nguy cơ
YTBV	Yếu tố bảo vệ
ALHT	Áp lực học tập
NĐT	Nghiện điện thoại
BNHĐ	Bắt nạt học đường
BNTC	Bắt nạt thể chất
BNLN	Bắt nạt lời nói
GBTH	Gắn bó trường học
HTXH	Hỗ trợ xã hội
HTCM	Hỗ trợ cha mẹ
HTBB	Hỗ trợ bạn bè
TTr	Tự trọng
BPĐP	Biện pháp đối phó
ĐTB	Điểm trung bình
ĐLC	Độ lệch chuẩn
THCS	Trung học cơ sở

DANH MỤC BẢNG

- Bảng 1.1.** *Phân biệt các thuật ngữ sợ hãi, lo âu, rối loạn lo âu*
- Bảng 2.1.** *Đặc điểm khách thể nghiên cứu*
- Bảng 3.1.** *Hệ số tin cậy và tương quan trong thang đo rối loạn lo âu*
- Bảng 3.2** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo rối loạn lo âu*
- Bảng 3.3** *Hệ số tin cậy thang đo áp lực học tập*
- Bảng 3.4** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo áp lực học tập*
- Bảng 3.5** *Hệ số tin cậy thang đo nghiện điện thoại*
- Bảng 3.6** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo nghiện điện thoại*
- Bảng 3.7** *Hệ số tin cậy và tương quan trong thang đo bắt nạt học đường*
- Bảng 3.8** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo bắt nạt học đường*
- Bảng 3.9** *Hệ số tin cậy thang đo gắn bó với trường học*
- Bảng 3.10** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo gắn bó với trường học*
- Bảng 3.11** *Hệ số tin cậy và tương quan trong thang đo cảm nhận hỗ trợ*
- Bảng 3.12** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo cảm nhận hỗ trợ*
- Bảng 3.13** *Hệ số tin cậy thang đo biện pháp đối phó*
- Bảng 3.14** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo biện pháp đối phó*
- Bảng 3.15** *Hệ số tin cậy thang đo tự trọng*
- Bảng 3.16** *Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo tự trọng*
- Bảng 3.17** *Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS*
- Bảng 3.18** *Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu chia ly ở học sinh THCS*
- Bảng 3.19** *Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu xã hội ở học sinh THCS*
- Bảng 3.20** *Mức độ rối loạn lo âu ở học sinh THCS qua các biến đặc điểm khách thể*
- Bảng 3.21** *Mức độ và biểu hiện của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến rối RLLA*
- Bảng 3.22** *Mức độ và biểu hiện của các yếu tố bảo vệ ảnh hưởng đến RLLA*
- Bảng 3.23** *Model fit của SEM*
- Bảng 3.24** *Tác động áp lực học tập đến rối loạn lo âu*
- Bảng 3.25** *Model fit của SEM*
- Bảng 3.26** *Tác động nghiện điện thoại đến rối loạn lo âu*
- Bảng 3.27** *Model fit của SEM*
- Bảng 3.28** *Tác động bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu*
- Bảng 3.29** *Model fit của SEM*

Bảng 3.30 Tác động gắn bó với trường học đến rối loạn lo âu

Bảng 3.31 Model fit của SEM

Bảng 3.32 Tác động tự trọng đến rối loạn lo âu

Bảng 3.33 Model fit của SEM

Bảng 3.34 Tác động hỗ trợ cha mẹ đến rối loạn lo âu

Bảng 3.35 Model fit của SEM

Bảng 3.36 Tác động hỗ trợ bạn bè đến rối loạn lo âu

Bảng 3.37. Model fit của SEM

Bảng 3.38 Tác động yếu tố nguy cơ & yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

Bảng 3.39 Model fit của SEM

Bảng 3.40 Tác động yếu tố nguy cơ đến rối loạn lo âu

Bảng 3.41 Model fit của SEM

Bảng 3.42 Tác động yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

Bảng 3.43 Mức độ và biểu hiện của các biện pháp đối phó với RLLA

Bảng 3.44 Model fit của SEM

Bảng 3.45 Tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu

DANH MỤC HÌNH

- Hình 3.1.** *Mô hình CFA thang đo rối loạn lo âu*
- Hình 3.2.** *Mô hình CFA thang đo áp lực học tập*
- Hình 3.3.** *Mô hình CFA thang đo nghiện điện thoại*
- Hình 3.4.** *Mô hình CFA thang đo bắt nạt học đường*
- Hình 3.5.** *Mô hình CFA thang đo gắn bó với trường học*
- Hình 3.6.** *Mô hình CFA thang đo cảm nhận hỗ trợ (2 factors)*
- Hình 3.7.** *Mô hình CFA thang đo biện pháp đối phó (3 factors)*
- Hình 3.8.** *Mô hình CFA thang đo tự trọng*
- Hình 3.9** *Mô hình tác động áp lực học tập đến rối loạn lo âu (3 factors)*
- Hình 3.10** *Mô hình tác động áp lực học tập đến rối loạn lo âu (2 factors)*
- Hình 3.11** *Mô hình tác động của nghiện điện thoại đến rối loạn lo âu (3 factors)*
- Hình 3.12** *Mô hình tác động của nghiện điện thoại đến rối loạn lo âu (2 factors)*
- Hình 3.13** *Mô hình tác động của bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu (3 factors)*
- Hình 3.14** *Mô hình tác động của bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu (2 factors)*
- Hình 3.15** *Mô hình tác động của gắn bó trường học đến rối loạn lo âu (3 factors)*
- Hình 3.16** *Mô hình tác động của gắn bó trường học đến rối loạn lo âu (2 factors)*
- Hình 3.17** *Mô hình SEM tác động của tự trọng đến rối loạn lo âu (3 factors)*
- Hình 3.18** *Mô hình SEM tác động của tự trọng đến rối loạn lo âu (2 factors)*
- Hình 3.19** *Mô hình SEM tác động của hỗ trợ cha mẹ đến rối loạn lo âu (3 factors)*
- Hình 3.20** *Mô hình SEM tác động của hỗ trợ cha mẹ đến rối loạn lo âu (2 factors)*
- Hình 3.21** *Mô hình tác động của yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu*
- Hình 3.22** *Mô hình tác động của yếu tố nguy cơ đến rối loạn lo âu*
- Hình 3.23** *Mô hình tác động của yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu*
- Hình 3.24** *Mô hình tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu (3 factors)*

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thế giới đương đại đầy biến động, sức khỏe tâm thần của lứa tuổi vị thành niên ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, trong đó Rối loạn lo âu (RLLA) nổi lên như là một trong những vấn đề phổ biến và nổi bật nhất. Theo dữ liệu Khảo sát Quốc gia về Sức khỏe Trẻ em ở Mỹ, số ca trẻ vị thành niên ở Mỹ mắc rối loạn lo âu từ năm 2016-2023 đã tăng lên 61%. Đây là loại rối loạn tâm thần có tỷ lệ tăng nhanh nhất và cao nhất so với các loại rối loạn tâm thần khác (National Survey of Children's Health, 2023).

Ở Đông Nam Á, công trình nghiên cứu của Z. Dongjun và cs. (2021) về «Dịch tễ học và gánh nặng của mười loại rối loạn tâm thần tại các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)» cũng cho thấy, từ 1990–2021 có sự gia tăng 70% số ca rối loạn tâm thần (trong đó phổ biến nhất là lo âu và trầm cảm) tại 10 nước ở khối ASEAN¹ (Z. Dongjun và cs., 2021).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh: rối loạn lo âu là một trong hai vấn đề nghiêm trọng nhất và thường khởi phát sớm trong giai đoạn lứa tuổi thanh thiếu niên. Theo ước tính của WHO, tỷ lệ lo âu và trầm cảm có mức tăng tổng thể đến 25% dân số, trong đó thanh thiếu niên là một trong hai nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất (H. Jenkins và cs., 2023).

Trong suốt chiều dài của tuổi trẻ em và vị thành niên, lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (11–15 tuổi) có vị trí đặc biệt quan trọng. Lứa tuổi này được đặc trưng bởi tính dễ bị tổn thương trước các thách thức về sức khỏe tâm thần, do sự tương tác nhanh chóng của các thay đổi tâm sinh lý và hormone trong cơ thể với áp lực của cuộc sống và môi trường xã hội. Những biến động này có thể tác động đáng kể đến hành vi và khả năng thích ứng của các cá nhân đang trưởng thành (M. Saikia et al., 2023). Quá trình dậy thì cùng với sự phát triển chưa hoàn thiện của não bộ làm gia tăng phản ứng cảm xúc trong khi khả năng kiểm soát còn hạn chế (Casey và cs., 2008). Đồng thời, đây là giai đoạn hình thành bản sắc cá nhân, học sinh trở nên rất nhạy cảm với sự đánh giá của người

¹ Mười nước ASEAN tham gia nghiên cứu này bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

khác. Đặc biệt, với sự thâm nhập của các giá trị văn hóa toàn cầu qua mạng internet có thể dẫn đến xung đột giá trị giữa các thế hệ; sự tương tác thường xuyên với các nền tảng truyền thông như Zalo, TikTok, Face Book, YouTube,... có thể làm gia tăng sự so sánh xã hội, lo âu xã hội ở một bộ phận của giới trẻ.

Một số công trình nghiên cứu gần đây khuyến cáo cần quan tâm đặc biệt đến nhóm trẻ ở độ tuổi này. Theo số liệu của GBD, nhóm trẻ vị thành niên 10–14 tuổi có gánh nặng bệnh tật do rối loạn tâm thần cao nhất so với các nhóm lứa tuổi khác (Z. Dongjun và cs., 2021). Có nghiên cứu ước tính rằng khoảng một nửa số trường hợp có vấn đề về sức khỏe tâm thần biểu hiện trước 14 tuổi (Revet & Kennedy, 2022).

Tại Việt Nam, khảo sát đại diện quốc gia V-NAMHS (Viện Xã hội học và cộng sự, 2022) trên 5.996 cặp cha mẹ và trẻ vị thành niên cho thấy rối loạn lo âu là rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở lứa tuổi 10-17, với tỷ lệ đạt ngưỡng chẩn đoán DSM-5 là 2,3% và tỷ lệ có triệu chứng cận lâm sàng kèm suy giảm chức năng lên tới 21,7%. Các khảo sát học đường gần đây của Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) trên 3.910 học sinh trung học phổ thông Hà Nội, của Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung (2025) trên 8.389 thanh thiếu niên ở 6 tỉnh, của Trúc Thanh Thái và cộng sự (2026) trên 2.631 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đều ghi nhận tỷ lệ triệu chứng lo âu cao, trong nhiều trường hợp vượt tỷ lệ 40% học sinh. Đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng đáng kể gánh nặng này, đồng thời để lại những thay đổi dài hạn về thói quen sử dụng thiết bị số và mạng xã hội ở lứa tuổi vị thành niên.

Trong bối cảnh văn hóa, giáo dục ở Việt Nam, việc nghiên cứu rối loạn lo âu ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, đây là giai đoạn khởi phát đặc trưng của nhiều dạng rối loạn lo âu, đặc biệt là rối loạn lo âu xã hội - vốn có tuổi khởi phát trung bình từ 11-13. Thứ hai, đây là lứa tuổi chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học cơ sở và chuẩn bị thi vào THPT, hai cột mốc có thể gây áp lực lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Nghiên cứu trên lứa tuổi này không chỉ giúp phát hiện và can thiệp sớm các triệu chứng dưới ngưỡng ở học sinh, nhằm ngăn cản chúng có thể tiến triển thành rối loạn lâm sàng, mà còn tận dụng được hệ thống trường học làm kênh tiếp cận hiệu quả nhất về chi phí và quy mô can thiệp.

Mặc dù một số nghiên cứu đã ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ rối loạn lo âu ở học sinh, thực trạng nghiên cứu trong nước về chủ đề này vẫn còn những khoảng trống quan trọng. Thứ nhất, chưa có bộ thang đo rối loạn lo âu dành cho trẻ em - vị thành niên được kiểm

định về chất lượng phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, dẫn đến biên độ ước tính tỷ lệ lo âu rất rộng (từ 2,3% theo chẩn đoán đầy đủ đến trên 50%, tùy theo thang đo sàng lọc). Thứ hai, phần lớn nghiên cứu tập trung vào lo âu lan tỏa bằng thang đo GAD-7 hoặc DASS-21, trong khi lo âu xã hội và lo âu chia ly hầu như chưa được khảo sát chuyên biệt. Thứ ba, các yếu tố bảo vệ - bao gồm lòng tự trọng, gắn bó trường học, hỗ trợ của cha mẹ và bạn bè, biện pháp ứng phó - chưa được nghiên cứu đồng thời và tích hợp với yếu tố nguy cơ trong cùng một thiết kế nghiên cứu. Thứ tư, thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc và thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm còn rất ít. Thứ năm, còn thiếu các nghiên cứu về chương trình can thiệp theo tiếp cận nhận thức - hành vi trên học sinh trung học cơ sở Việt Nam để đem lại các bằng chứng hiệu quả của can thiệp như một số nước trên thế giới và trong khu vực Châu Á đã thực hiện.

Trên cơ sở các khoảng trống nói trên, luận án đặt mục tiêu nghiên cứu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội, với thiết kế đo lường đồng thời các yếu tố nguy cơ và các yếu tố bảo vệ chính, kết hợp khảo sát định lượng và phỏng vấn định tính. Trên cơ sở dữ liệu thực trạng, luận án đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh trung học cơ sở, đặt nền móng cho các nghiên cứu can thiệp tiếp theo.

Những nghiên cứu này không chỉ góp phần bổ sung cơ sở lý luận mà còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho việc xây dựng các công cụ đánh giá và chương trình phòng ngừa phù hợp. Hướng nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận về rối loạn lo âu ở học sinh THCS; Tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh THCS và một số yếu tố ảnh hưởng, bao gồm yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ. Trên cơ sở đó, đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu trong môi trường học đường dành cho học sinh THCS.

3. Đối tượng nghiên cứu

Mức độ, biểu hiện và tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu học đường ở học sinh THCS; khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS.

4. Khách thể nghiên cứu

- Học sinh THCS: Khảo sát phiếu điều tra trên 1352 khách thể học sinh THCS và phỏng vấn sâu 12 học sinh THCS tại Hà Nội.
- Giáo viên THCS: Đề tài phỏng vấn sâu đối với 6 giáo viên chủ nhiệm THCS.

5. Giả thuyết khoa học

5.1. Giả thuyết 1 — Khác biệt giới tính phụ thuộc vào loại rối loạn lo âu

Mặc dù nhiều nghiên cứu xác nhận tỷ lệ nữ có biểu hiện rối loạn lo âu cao hơn nam, nhưng vẫn có những nghiên cứu công bố kết quả ngược lại là tỷ lệ nam bị rối loạn lo âu cao hơn nữ. Cũng có một số công trình không tìm ra được sự khác biệt giới tính về vấn đề rối loạn lo âu. Luận án này, với cỡ mẫu lớn, nghiên cứu cả 3 loại rối loạn lo âu, sẽ kiểm chứng giả thuyết về sự khác biệt giới tính trên từng loại RLLA.

5.2. Giả thuyết 2 — Lòng tự trọng là yếu tố bảo vệ thuộc nhóm mạnh nhất

Lòng tự trọng đã Rosenberg nghiên cứu và phát triển từ năm 1965 và được Masten A.S. (2014) xếp vào nhóm các yếu tố nội tại bảo vệ trẻ em trước nghịch cảnh. Ở Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu về yếu tố lòng tự trọng trên đối tượng là học sinh THCS. Giả thuyết này, nếu được xác nhận, sẽ gợi ý cho việc xây dựng chương trình can thiệp thiết kế theo trục song song - không chỉ giảm áp lực học tập mà còn tăng cường tự trọng.

5.3. Giả thuyết 3 — Áp lực học tập và nghiện điện thoại là hai yếu tố nguy cơ thuộc nhóm mạnh nhất

Áp lực học tập và nghiện điện thoại là những yếu tố nguy cơ đã được nhiều công trình nghiên cứu ở nước ngoài đề cập đến. Ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu sâu để kiểm chứng giả thuyết này trên học sinh THCS. Giả thuyết này nếu được xác nhận, sẽ định hướng cho việc tìm kiếm những biện pháp ưu tiên giảm áp lực học tập, giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, thông qua giáo dục tâm lý cho giáo viên, cha mẹ HS và học sinh.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

6.1 Hệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài về rối loạn lo âu và rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở.

6.2. Nghiên cứu thực trạng, biểu hiện mức độ rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở và các yếu tố ảnh hưởng (yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ), biện pháp đối phó với rối loạn lo âu;

6.3. Đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường cho học sinh THCS.

7. Giới hạn nghiên cứu

7.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung khảo sát mức độ và biểu hiện của rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở về rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn lo âu xã hội và rối loạn lo âu chia ly), đồng thời xem xét ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ (áp lực học tập, nghiện điện thoại, bất nạt học đường), các yếu tố bảo vệ (gắn bó với trường học, hỗ trợ xã hội, tự trọng) và biện pháp đối phó đối với rối loạn lo âu.

7.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu

Địa bàn nghiên cứu: 2 trường THCS, trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó trường THCS Nhật Tân thuộc khu vực nội thành và THCS Tây Mỗ thuộc khu vực ven đô.

7.3 Giới hạn khách thể nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu trên khách thể học sinh THCS, đang học tại 2 trường THCS Nhật Tân & THCS Tây Mỗ, từ khối 6 đến khối 9 (11-14 tuổi).

8. Phương pháp nghiên cứu

8.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn bản

Phương pháp này được sử dụng nhằm tổng hợp, phân tích và hệ thống hóa các tài liệu lý luận và nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh, từ đó xây dựng cơ sở lý luận và định hướng khung nghiên cứu của đề tài.

8.2 Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp này được sử dụng nhằm thu thập dữ liệu định lượng về mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó.

8.3. Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng nhằm thu thập dữ liệu định tính, làm rõ thêm các biểu hiện và trải nghiệm liên quan đến rối loạn lo âu, qua đó hỗ trợ giải thích và bổ sung cho kết quả phân tích định lượng.

8.4. Phương pháp quan sát

Phương pháp này được sử dụng nhằm ghi nhận các biểu hiện hành vi, thái độ và phản ứng của học sinh trong quá trình tham gia khảo sát và phỏng vấn, góp phần kiểm chứng và làm phong phú thêm dữ liệu nghiên cứu.

8.5. Phương pháp phân tích xử lý số liệu thống kê

Dữ liệu thu thập được xử lý và phân tích bằng các phương pháp thống kê phù hợp trên phần mềm SPSS 31.0 và AMOS 31.0. Các bước xử lý bao gồm làm sạch dữ liệu, phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố và kiểm định mô hình nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu (Chi tiết tại chương 2).

9. Tiếp cận nghiên cứu

9.1. Tiếp cận theo góc độ Tâm lý học trường học

Nghiên cứu được thực hiện theo tiếp cận tâm lý học trường học nhằm xem xét vai trò của môi trường giáo dục trong sự hình thành và điều chỉnh rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở. Theo hướng tiếp cận này, các yếu tố thuộc bối cảnh học đường như áp lực học tập, khối lượng bài tập, hình thức kiểm tra - đánh giá và cách thức tương tác giữa giáo viên với học sinh được xem là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tâm lý của học sinh. Trong phạm vi đề tài, các yếu tố như áp lực học tập, gắn bó với trường học và hỗ trợ xã hội trong môi trường học đường được phân tích nhằm làm rõ vai trò của nhà trường trong việc gia tăng hoặc giảm thiểu rối loạn lo âu. Đồng thời, tiếp cận này nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng môi trường học tập tích cực, tăng cường phát triển các kỹ năng đối phó cho học sinh. Qua đó, nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp hỗ trợ và can thiệp tâm lý học đường phù hợp.

9.2. Tiếp cận dưới góc độ Tâm lý học phát triển

Nghiên cứu tiếp cận rối loạn lo âu dưới góc độ tâm lý học phát triển nhằm xem xét sự hình thành và biến đổi của lo âu trong mối liên hệ với đặc điểm phát triển của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. Ở giai đoạn này, học sinh trải qua nhiều thay đổi về thể chất, nhận thức và cảm xúc, đồng thời phải đối mặt với các nhiệm vụ phát triển như khẳng

định bản thân, xây dựng bản sắc cá nhân và thiết lập các mối quan hệ xã hội. Những thay đổi này có thể làm gia tăng tính nhạy cảm với áp lực học tập, đánh giá xã hội và các mối quan hệ liên cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến mức độ lo âu. Tiếp cận này giúp lý giải sự khác biệt về mức độ rối loạn lo âu giữa các nhóm học sinh theo độ tuổi và đặc điểm cá nhân, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc phân tích và can thiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

9.3. Tiếp cận theo quan điểm Tâm bệnh học

Nghiên cứu được thực hiện theo tiếp cận tâm bệnh học nhằm mô tả và nhận diện các biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở trên cơ sở tham chiếu các tiêu chí trong *DSM-5* của American Psychiatric Association (2013). Theo đó, rối loạn lo âu được hiểu là trạng thái lo lắng quá mức, kéo dài và ảnh hưởng đến chức năng học tập, xã hội và cảm xúc của cá nhân. Trên cơ sở này, nghiên cứu tập trung vào ba loại lo âu phổ biến gồm lo âu lan tỏa, lo âu xã hội và lo âu chia ly, phù hợp với các nghiên cứu trước (Chorpita et al., 2000). Các biểu hiện được đánh giá thông qua tần suất và mức độ triệu chứng, thay vì chẩn đoán lâm sàng, nhằm phù hợp với bối cảnh nghiên cứu học đường. Cụ thể, lo âu lan tỏa liên quan đến lo lắng lan tỏa về học tập và tương lai; lo âu xã hội gắn với nỗi sợ bị đánh giá tiêu cực; lo âu chia ly thể hiện qua cảm giác bất an khi tách khỏi người thân. Tiếp cận này giúp làm rõ biểu hiện và mức độ rối loạn lo âu, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để phân tích mối liên hệ với các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó trong nghiên cứu.

9.4. Tiếp cận theo quan điểm Xã hội

Nghiên cứu được thực hiện theo tiếp cận xã hội nhằm xem xét vai trò của các yếu tố môi trường và các mối quan hệ xã hội trong sự hình thành và duy trì rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở. Theo quan điểm này, các vấn đề tâm lý không chỉ xuất phát từ đặc điểm cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ bối cảnh sống, đặc biệt là gia đình, nhà trường và nhóm bạn bè. Các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng môi trường xã hội có vai trò quan trọng trong việc định hình sức khỏe tâm thần của học sinh (Bronfenbrenner, 1979). Trên cơ sở đó, nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố xã hội cụ thể bao gồm áp lực học tập, bắt nạt học đường, hỗ trợ xã hội và việc sử dụng điện thoại thông minh như một phần của môi trường tương tác xã hội hiện đại. Áp lực học tập và kỳ vọng thành tích từ gia đình, nhà trường được xem là những nguồn gây căng thẳng chủ yếu, khiến

học sinh thường xuyên lo lắng về kết quả học tập và sự đánh giá của người khác. Bên cạnh đó, các trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè như bị bắt nạt, cô lập hoặc bị đánh giá tiêu cực có thể làm gia tăng lo âu. Tiếp cận xã hội trong nghiên cứu giúp làm rõ vai trò của các yếu tố môi trường trong mối liên hệ với rối loạn lo âu, từ đó cung cấp cơ sở khoa học để phân tích tác động của các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong bối cảnh học đường.

10. Đóng góp mới của đề tài

10.1. Về lý luận

Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở theo hướng tiếp cận đa chiều, bao gồm các dạng lo âu (lo âu lan tỏa, lo âu xã hội, lo âu chia ly), biểu hiện và mức độ của rối loạn lo âu. Đồng thời, nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa rối loạn lo âu với các nhóm yếu tố gồm yếu tố nguy cơ (áp lực học tập, nghiện điện thoại, bắt nạt học đường), yếu tố bảo vệ (gắn bó với trường học, hỗ trợ xã hội, tự trọng) và biện pháp đối phó. Những kết quả này góp phần bổ sung và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về rối loạn lo âu trong bối cảnh học đường, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc tiếp cận nghiên cứu theo hướng tích hợp nhiều yếu tố trong tâm lý học phát triển, tâm lý học giáo dục và tâm lý học trường học.

10.2. Về thực tiễn

Nghiên cứu cung cấp một bộ dữ liệu thực chứng toàn diện với các giá trị ứng dụng trực tiếp:

- *Chuẩn hóa và kiểm định công cụ đo lường*: Các thang đo sử dụng trong nghiên cứu được hiệu chỉnh, kiểm định độ tin cậy và giá trị, đảm bảo tính phù hợp với bối cảnh học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam.

- *Mô tả thực trạng rối loạn lo âu*: Nghiên cứu đã làm rõ mức độ và biểu hiện của các dạng rối loạn lo âu, đồng thời chỉ ra sự khác biệt theo giới tính và khối lớp, qua đó phản ánh đặc điểm tâm lý của học sinh trong bối cảnh hiện nay.

- *Xác định các yếu tố ảnh hưởng*: Kết quả nghiên cứu làm rõ vai trò của các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó trong mối liên hệ với rối loạn lo âu, góp phần cung cấp cái nhìn toàn diện về cơ chế tác động của các yếu tố này.

- *Giá trị ứng dụng*: Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc đề xuất Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo cho giáo viên, chuyên viên tâm lý và các nhà quản lý giáo dục trong

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh. Chương trình tập huấn này sau khi được thử nghiệm, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh và hoàn thiện sẽ chuẩn bị cho bước tiếp theo là xây dựng chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm trên các nền tảng số như một số nước đang làm.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1 Tổng quan nghiên cứu

Tiểu mục này tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về rối loạn lo âu ở vị thành niên, chủ yếu công bố trong khoảng 5-7 năm gần đây, theo các trục chủ đề: tỷ lệ phổ biến, mức độ, biểu hiện, yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và nghiên cứu can thiệp.

1.1.1. Tỷ lệ phổ biến của rối loạn lo âu ở vị thành niên

Rối loạn lo âu là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất ở vị thành niên trên toàn cầu. Các báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cùng nhiều phân tích tổng hợp gần đây đều ghi nhận xu hướng tăng tỷ lệ rối loạn lo âu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong và sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các ước tính cụ thể có biên độ rất rộng, dao động từ dưới 3% (khi chẩn đoán theo tiêu chí DSM-5 đầy đủ) đến trên 50% (khi sàng lọc triệu chứng cận lâm sàng). Điều này phản ánh sự khác biệt căn bản giữa công cụ chẩn đoán lâm sàng và thang đo sàng lọc dân số.

Trên dữ liệu quy mô lớn, khảo sát quốc gia của Xu và cộng sự (2021) tại Hà Nam, Trung Quốc trên 373.216 học sinh trung học bằng thang GAD-7 cho tỷ lệ triệu chứng lo âu chung 9,89%, với học sinh trung học cơ sở (10,85%) cao hơn trung học phổ thông (8,08%). Chen và cộng sự (2023) khảo sát trên mẫu 63.205 học sinh trung học tại Tứ Xuyên báo cáo tỷ lệ có trọng số 13,9% (khoảng tin cậy 95% 11,2-17,0%) cũng bằng GAD-7. Tại Anh, phân tích dữ liệu của Fassi và cộng sự (2025) trên 3.340 vị thành niên 11-19 tuổi ghi nhận kích thước hiệu ứng tổng hợp $g = 0,46$ cho các vấn đề nội hóa nói chung và $g = 0,62$ riêng cho riêng rối loạn lo âu. Khảo sát quy mô rất lớn của Brunborg và cộng sự (2025) trên 979.043 phản hồi của thanh thiếu niên Na Uy giai đoạn 2011-2024 cho thấy mức độ căng thẳng tâm thần (bao gồm lo âu) tăng liên tục với hệ số chuẩn hóa β giải thích bởi mức độ không hài lòng với trường học đạt 0,40-0,44 – đây là yếu tố mạnh nhất trong các yếu tố giải thích xu hướng gia tăng vấn đề này.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu sử dụng nhiều công cụ và mẫu khảo sát khác nhau đưa ra các số liệu có biên độ ước tính rất rộng. Khảo sát quốc gia về Sức khỏe tâm thần vị thành niên (Viện Xã hội học và cộng sự, 2022) trên 5.996 cặp cha mẹ và trẻ vị thành niên 10-17 tuổi tại 38 tỉnh, sử dụng công cụ chẩn đoán DISC-5 theo DSM-5, đưa ra tỷ lệ

rối loạn lo âu đạt ngưỡng chẩn đoán 2,3%, tỷ lệ cao nhất trong sáu rối loạn tâm thần được khảo sát; nếu mở rộng sang nhóm có vấn đề sức khỏe tâm thần (gồm triệu chứng cận lâm sàng có suy giảm chức năng), tỷ lệ này lên đến 21,7%. Trong khi đó, các khảo sát học đường bằng thang sàng lọc cho biên độ rộng hơn nhiều. Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) khảo sát trên 3.910 học sinh trung học phổ thông Hà Nội bằng thang GAD-7 ghi nhận 40,6% có nguy cơ rối loạn lo âu, trong đó 23,9% nhẹ, 10,9% vừa và 5,8% nặng. Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung (2025) khảo sát trên 8.389 học sinh tại 6 tỉnh (mẫu tuyển 8.473) bằng DASS-21 báo cáo tỷ lệ lo âu 41,5% trong thời kỳ COVID-19 và giảm còn 25,4% sau đại dịch. Trần Hồ Vĩnh Lộc và cộng sự (2024) khảo sát trên 976 học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng DASS-Y cũng cho tỷ lệ lo âu chung tương tự. Ngô Anh Vinh và cộng sự (2024) khảo sát trên 845 học sinh dân tộc thiểu số nội trú tỉnh Lạng Sơn bằng DASS-21 ghi nhận tỷ lệ lo âu cao nhất 54,4%, cao hơn cả tỷ lệ stress (24,7%) và xấp xỉ trầm cảm (59,0%), điều này phản ánh đặc thù dễ tổn thương ở nhóm dân tộc thiểu số. Trúc Thanh Thái và cộng sự (2026) khảo sát trên 2.631 học sinh từ 4 trường trung học phổ thông và 4 trung tâm giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ triệu chứng lo âu 50,3%. Trần Thị Mỹ Lương (2020) khảo sát trên 540 học sinh trung học phổ thông Chuyên bằng DASS-42 báo cáo tỷ lệ thấp hơn đáng kể, 14,2%, trong đó khối 11 chiếm 48,1% trong 77 trường hợp lo âu được phát hiện.

Về khác biệt giới tính, đa số các nghiên cứu quốc tế nhất quán ghi nhận tỷ lệ ở HS nữ có rối loạn lo âu cao hơn HS nam khoảng 1,5-2 lần. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng được khẳng định trong các khảo sát của Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024); và của Trần Hồ Vĩnh Lộc và cộng sự (2024). Tuy nhiên, vẫn có những công trình ở nước ngoài công bố kết quả ngược lại là tỷ lệ nam bị rối loạn lo âu cao hơn nữ, như nghiên cứu của A.M. Saikia và cs (2023) đưa ra tỷ lệ chênh lệch nhau đáng kể giữa nam và nữ là 30% nam/18,9% nữ trong một nghiên cứu ở Ấn Độ; hoặc như kết quả nghiên cứu của Q. Xu và cs (2021) đưa ra tỷ lệ chênh lệch nam lo âu hơn nữ là 10,11% nam/9,66% nữ trong một nghiên cứu ở Trung Quốc. Cũng có một số nghiên cứu với mẫu khảo sát rất lớn nhưng vẫn không tìm ra sự khác biệt giới tính về tỷ lệ rối loạn lo âu, như nghiên cứu của Philip Jefferies và cs. (2020), và của Viện xã hội học và cs. (2022).

Sự khác biệt rất lớn giữa các tỷ lệ ước tính (từ 2,3% theo DSM-5 đến trên 50% theo thang sàng lọc) đặt ra vấn đề về sử dụng thang đo khác nhau, cách diễn giải và so

sánh kết quả giữa các nghiên cứu. Hai yếu tố chính giải thích biên độ rộng này: 1) loại công cụ chẩn đoán lâm sàng (DISC-5) so với các thang đo sàng lọc phổ biến hiện nay (GAD-7, DASS-21, RCADS); 2) ngưỡng điểm cắt - một số nghiên cứu sử dụng ngưỡng quá thấp dẫn đến tỷ lệ "lo âu" rất cao mà thực tế chỉ phản ánh các triệu chứng cận lâm sàng. Đối với thiết kế nghiên cứu hiện tại trên học sinh trung học cơ sở Việt Nam, lựa chọn công cụ phù hợp và chọn ngưỡng cắt được kiểm định trên dân số Việt Nam là điều kiện then chốt để có ước tính đáng tin cậy. Đây cũng là một khoảng trống lớn ở Việt Nam: hiện chưa có một bộ thang đo lo âu riêng cho trẻ em vị thành niên được chuẩn hóa tâm trắc toàn diện cho dân số Việt Nam, kèm ngưỡng cắt riêng.

Trong nhóm các nghiên cứu Việt Nam, ba khảo sát quy mô vừa và lớn được công bố trong năm 2024-2025 cung cấp thêm góc nhìn về biên độ tỷ lệ. Nguyễn Ngọc Bảo Quyên và cộng sự (2025) khảo sát trên 1.252 học sinh trung học phổ thông Hà Nội bằng thang DASS-21 phiên bản tiếng Việt báo cáo tỷ lệ lo âu chung 38,5%, với nữ cao hơn nam có ý nghĩa thống kê. Nguyễn Danh Lâm và cộng sự (2022) sử dụng thang đo DASS-21 khảo sát trên 1.024 học sinh trung học phổ thông tại Yên Định, Thanh Hóa - khu vực bán đô thị - báo cáo tỷ lệ thấp hơn 25,8%. Lê Minh T. và cộng sự (2025) khảo sát 600 học sinh phổ thông Long Bình, An Giang bằng DASS-21 báo cáo tỷ lệ 33,2%. Sự đa dạng vùng miền của ba nghiên cứu này - Hà Nội (đô thị), Yên Định (bán đô thị) và An Giang (đồng bằng sông Cửu Long) - cùng với mẫu Lạng Sơn (miền núi dân tộc thiểu số) và Thành phố Hồ Chí Minh (đại đô thị phía Nam) tạo nên bức tranh dịch tễ học đa chiều ở Việt Nam.

1.1.2. Mức độ rối loạn lo âu

Các công cụ sàng lọc phổ biến đều phân tầng mức độ lo âu theo điểm cắt thang đo, với cấu trúc thường gặp gồm bốn mức: bình thường, nhẹ, vừa và nặng (một số thang chia thêm mức "cực kỳ nặng" như DASS-21). Việc phân tầng này có ý nghĩa lâm sàng vì các mức độ khác nhau dẫn tới mức can thiệp khác nhau theo khung sức khỏe tâm thần cộng đồng ba tầng - phổ quát, chọn lọc và chỉ định.

Phân tích dữ liệu Việt Nam cho thấy phân bố mức độ tương đối tương đồng với các nghiên cứu quốc tế. Trong nghiên cứu của Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) khảo sát trên 3.910 học sinh trung học phổ thông Hà Nội, trong tổng số 40,6% có triệu chứng lo âu, mức độ nhẹ chiếm 23,9%, mức độ vừa 10,9% và mức độ nặng 5,8% - phản

ánh dạng phân bố hình kim tự tháp với phần lớn các trường hợp ở mức nhẹ và giảm dần khi tăng mức độ. Trần Thị Mỹ Lương (2020) khảo sát trên 540 học sinh trung học phổ thông Chuyên bằng thang đo DASS-42 báo cáo phân bố tương tự với mức nhẹ 3,5%, vừa 7,2%, nặng 2,4% và rất nặng 1,1%. Mẫu nghiên cứu của Ngô Anh Vinh và cộng sự (2024) trên học sinh dân tộc thiểu số nội trú có phân bố lệch lên các mức cao hơn so với mẫu đô thị, phù hợp với xu hướng dễ tổn thương ở nhóm này.

Phân tầng mức độ khác biệt theo giới tính được ghi nhận nhất quán: học sinh nữ không chỉ có tỷ lệ chung cao hơn nam mà cụ thể là tỷ lệ ở mức độ vừa và nặng cao hơn rõ rệt. Trong nghiên cứu của Trần Thị Mỹ Lương (2020), khối lớp 11 có tỷ lệ lo âu cao nhất, chiếm 48,1% trong tổng số 77 trường hợp được sàng lọc dương tính, đồng thời tập trung ở các mức độ vừa và nặng - gấp 2-3 lần các khối lớp 10 và lớp 12. Đặc điểm này gợi ý lớp 11 là giai đoạn áp lực học tập đặc biệt mạnh trong chu trình trung học phổ thông Việt Nam, với áp lực vừa từ chương trình học vừa từ định hướng nghề nghiệp cận kề.

Một vấn đề về phương pháp luận đáng lưu ý là sự không thống nhất về ngưỡng cắt giữa các phiên bản thang đo và giữa các nghiên cứu. Cùng thang DASS-21, có thể có ba ngưỡng khác nhau được sử dụng trong các bài báo Việt Nam, dẫn đến cùng một bộ dữ liệu có thể cho ra ba tỷ lệ "nhẹ/vừa/nặng" khác nhau. Tương tự, thang đo GAD-7 có ngưỡng kinh điển ≥ 5 cho nhẹ, ≥ 10 cho vừa, ≥ 15 cho nặng, nhưng một số nghiên cứu lại sử dụng ngưỡng riêng. Đối với luận án, lựa chọn ngưỡng kinh điển có hỗ trợ bằng thang đo được kiểm định trên khách thể Việt Nam (RCADS-25 phiên bản tiếng Việt là một ví dụ) là điều kiện để kết quả khảo sát đủ điều kiện để so sánh quốc tế.

Khác biệt giới tính trong phân tầng mức độ là một chủ đề được nghiên cứu nhiều nhưng kết luận chưa hoàn toàn nhất quán. Phần lớn các nghiên cứu xác nhận học sinh nữ không chỉ có tỷ lệ chung cao hơn mà còn có tỷ lệ ở mức độ vừa và nặng cao hơn rõ rệt. Bhardwaj và cộng sự (2020) tại Ấn Độ ghi nhận tỷ lệ nữ cao hơn nam ở các mức trung bình trở lên - nhẹ (15,9% nam so với 20,6% nữ), trung bình (29,1% so với 31,0%), nặng (9,1% so với 21,2%) và cực kỳ nặng (2,3% so với 2,7%). Tại Việt Nam, Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) cũng xác nhận xu hướng này, song mức chênh lệch không lớn bằng. Tuy nhiên, Khảo sát của Viện xã hội học và cộng sự - V-NAMHS (2022) không tìm thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai giới ở mức rối loạn DSM-5 đầy đủ. Điều này gợi ý rằng khác biệt giới có thể rõ hơn ở mức triệu chứng cận lâm sàng so với mức rối loạn lâm sàng.

Một yếu tố ít được phân tích nhưng quan trọng là tính ổn định của phân tầng mức độ qua thời gian. Hầu hết nghiên cứu Việt Nam sử dụng thiết kế cắt ngang, đo rối loạn lo âu tại một thời điểm duy nhất; do đó không thể phân biệt được mức độ lo âu hiện tại có ổn định, đang gia tăng hay đang giảm. Nghiên cứu dọc của Trần Thảo Vi và cộng sự (2024) khảo sát trên 341 học sinh trung học cơ sở Huế qua 3 năm là một ngoại lệ tốt. Các tác giả đã ghi nhận điểm áp lực học tập (ESSA) tăng từ $46,4 \pm 7,6$ lên $53,5 \pm 10,8$ - tăng có ý nghĩa thống kê và liên tục, cùng với xu hướng tăng các triệu chứng nội hóa. Phát hiện này gợi ý rằng tỷ lệ lo âu ở mức độ vừa và nặng quan sát thấy trong các nghiên cứu cắt ngang có thể là điểm cuối của một quá trình tích lũy stress kéo dài qua nhiều năm ở cấp trung học cơ sở.

Mức độ rối loạn lo âu cũng có liên hệ tương đối nhất quán với sự suy giảm chức năng - yếu tố quan trọng để chuyển từ "có triệu chứng" sang "có rối loạn cần can thiệp". V-NAMHS ghi nhận trong số 21,7% có vấn đề sức khỏe tâm thần, 67% có suy giảm trong môi trường gia đình, 47% trong quan hệ với bạn bè và 45,4% trong học tập hoặc công việc. Ở nhóm đạt ngưỡng rối loạn DSM-5 đầy đủ (3,3% tổng mẫu), tỷ lệ suy giảm tăng lên 74,2% (gia đình), 64,1% (học tập) và 63,3% (bạn bè). Đây là dữ liệu định lượng cốt lõi cho việc luận giải về gánh nặng thực tế của lo âu ở vị thành niên Việt Nam, không chỉ đo bằng tỷ lệ mà còn bằng mức độ ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày.

1.1.3. Biểu hiện rối loạn lo âu

Theo DSM-5 (Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, 2013), nhóm rối loạn lo âu bao gồm chín loại chính, trong đó ba loại phổ biến nhất ở trẻ em - vị thành niên là rối loạn lo âu lan tỏa (Generalized Anxiety Disorder), rối loạn lo âu xã hội (Social Anxiety Disorder) và rối loạn lo âu chia ly (Separation Anxiety Disorder). Ba dạng này có chung đặc điểm lo lắng quá mức và khó kiểm soát, nhưng khác biệt rõ ràng về đối tượng và bối cảnh xuất hiện lo âu, cùng đặc trưng phát triển theo lứa tuổi.

Rối loạn lo âu lan tỏa được đặc trưng bởi lo lắng quá mức về nhiều sự kiện hoặc hoạt động, như học tập, sức khỏe, tài chính gia đình, các sự kiện trong tương lai,... kéo dài ít nhất sáu tháng, kèm theo các triệu chứng cơ thể như căng cơ, mệt mỏi, khó tập trung, dễ cáu kỉnh và rối loạn giấc ngủ. Đây là loại lo âu được khảo sát nhiều nhất trong nghiên cứu vị thành niên Việt Nam. Phần lớn các nghiên cứu sử dụng GAD-7 đều đo loại lo âu này. V-NAMHS ghi nhận rối loạn lo âu lan tỏa và ám sợ xã hội cùng chiếm tỷ lệ

cao nhất trong nhóm rối loạn lo âu. Tổng quan của Compas và cộng sự (2017) khảo sát trên 212 nghiên cứu, với 80.850 trẻ em - vị thành niên xác nhận cách đối phó tập trung vào vấn đề có liên hệ ngược chiều và bền vững với triệu chứng lo âu lan tỏa cũng như triệu chứng trầm cảm.

Rối loạn lo âu xã hội được đặc trưng bởi sự sợ hãi hoặc lo lắng rõ rệt trước một hoặc nhiều tình huống xã hội, như phát biểu trước lớp, giao tiếp với người lạ, ăn uống ở nơi công cộng,..., do lo sợ bị đánh giá tiêu cực. Phân tích mạng lưới của Xian và cộng sự (2024) trên 30 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở trẻ em - vị thành niên đã xếp các can thiệp theo liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT) vào vị trí hiệu quả cao nhất cho lo âu xã hội, đặc biệt là CBT qua nền tảng internet (SUCRA = 71,2%). Ở Việt Nam, loại lo âu xã hội ít được nghiên cứu riêng biệt; phần lớn các khảo sát hiện có sử dụng thang đo lo âu tổng hợp không phân tách được dạng này. Đây là một khoảng trống quan trọng vì lo âu xã hội đặc biệt liên quan đến giai đoạn đầu vị thành niên - thời điểm bắt đầu nhạy cảm cao với phản hồi của nhóm bạn đồng đẳng.

Rối loạn lo âu chia ly được đặc trưng bởi lo lắng quá mức về sự xa cách với người thân (chủ yếu là cha mẹ) hoặc môi trường gia đình. DSM-IV trước đây chỉ chẩn đoán rối loạn này cho trẻ em và vị thành niên; DSM-5 đã mở rộng cho người lớn được chẩn đoán lần đầu sau 18 tuổi. Tại Việt Nam, rối loạn lo âu chia ly hầu như không được khảo sát riêng ở học sinh trung học cơ sở, mặc dù có những bối cảnh đặc thù - học sinh phải xa nhà đi học nội trú ở khu vực dân tộc thiểu số (như mẫu của Ngô Anh Vinh và cộng sự, 2024), học sinh có cha mẹ đi làm xa, học sinh chuyển trường — có thể là nhóm có nguy cơ cao cho dạng này.

Nhìn tổng thể, các nghiên cứu ở Việt Nam hiện tập trung vào rối loạn lo âu lan tỏa (chủ yếu sử dụng GAD-7 hoặc các tiêu thang trong DASS), trong khi lo âu xã hội và lo âu chia ly là hai khoảng trống đáng kể. Việc bổ sung khảo sát chuyên biệt cho hai dạng còn lại - sử dụng các công cụ chuyên biệt như Spence Children Anxiety Scale (SCAS) hoặc Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) đã có phiên bản tiếng Việt - sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh dịch tễ học ở học sinh trung học cơ sở Việt Nam.

Biểu hiện chi tiết của rối loạn lo âu lan tỏa ở vị thành niên có những đặc điểm riêng so với người trưởng thành. Kendall (1994), trong nghiên cứu lâm sàng nền tảng hướng đến chương trình can thiệp Coping Cat, đã mô tả ba thành phần cốt lõi của lo âu lan tỏa ở trẻ em 9-13 tuổi: 1) cảm giác sợ hãi và lo lắng cảm xúc (lo cho tương lai, lo cho

sự an toàn của bản thân và người thân); 2) các biểu hiện cơ thể (căng cơ, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ); 3) các biểu hiện hành vi (né tránh các tình huống, sự trấn an nhiều lần, kiểm tra lặp lại nhiều lần). Ba thành phần này được tích hợp trong các thang đo chuẩn hóa cho trẻ em - vị thành niên như RCADS và SCARED. Tại Việt Nam, loại lo âu này được khảo sát phổ biến nhất nhưng thường không phân tách rõ ba thành phần trên. Phần lớn các nghiên cứu chỉ báo cáo điểm tổng, không khai thác thông tin về cấu trúc lo âu của từng học sinh.

Rối loạn lo âu xã hội ở vị thành niên có hai đặc trưng phát triển quan trọng. Thứ nhất, đây là dạng có tuổi khởi phát đặc trưng vào giai đoạn đầu vị thành niên (11-13 tuổi) - trùng với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở Việt Nam. Thứ hai, biểu hiện lo âu xã hội ở lứa tuổi này thường gắn với các tình huống cụ thể của trường học: phát biểu trước lớp, trả lời bài kiểm tra miệng, giao tiếp với thầy cô, tham gia hoạt động nhóm, ăn uống tại căng tin. Praptomojati và cộng sự (2024) trong tổng quan hệ thống các phiên bản liệu pháp nhận thức - hành vi cho rối loạn lo âu, thích ứng với văn hóa Đông Nam Á đã nhận định rằng lo âu xã hội ở khu vực này có một số đặc thù văn hóa quan trọng, đặc biệt là vai trò của "thể diện" (face) và lo lắng về việc làm mất uy tín gia đình hoặc dòng họ. Những điểm này cần được phản ánh trong công cụ đo lường và can thiệp.

Tại Việt Nam, loại lo âu xã hội chưa được nghiên cứu riêng biệt ở học sinh trung học cơ sở; phần lớn dữ liệu hiện có gom dạng này vào điểm lo âu tổng hợp. Hai ngoại lệ đáng chú ý: khảo sát so sánh quốc tế của Jefferies và Ungar (2020) đã trích ở mục 1.1.1 ghi nhận tỷ lệ lo âu xã hội tại Việt Nam đạt 30,7% - một con số đáng kể cho lứa tuổi thanh niên; và phân tích của Đinh Thị Hồng Vân và cộng sự (2021) khảo sát trên 749 học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hai chỉ báo gián tiếp về lo âu xã hội là giao tiếp với thầy cô (42,9% học sinh xác nhận); và yếu tố quan hệ với bạn bè trong lớp (40,6% HS). Phân tích mạng lưới của Xian và cộng sự (2024) khảo sát trên 30 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy các can thiệp theo liệu pháp nhận thức - hành vi, đặc biệt qua internet là can thiệp có bằng chứng mạnh nhất cho rối loạn lo âu xã hội ở trẻ em - vị thành niên (chỉ số SUCRA = 71,2%).

Mặc dù tỷ lệ rối loạn lo âu chia ly thường được báo cáo thấp hơn lo âu lan tỏa và lo âu xã hội ở vị thành niên nói chung, các nhóm có hoàn cảnh đặc thù có thể có tỷ lệ cao hơn nhiều. Tại Việt Nam, có ba nhóm cần được nghiên cứu chuyên biệt cho dạng này. Nhóm thứ nhất là học sinh dân tộc thiểu số học nội trú xa nhà - như trong mẫu khảo sát

của Ngô Anh Vinh và cộng sự (2024) tại Lạng Sơn với học sinh phải xa gia đình trong tuổi 10-18, có 70,7% là nữ và 67,9% sống tại ký túc xá - đây là nhóm có nguy cơ đặc biệt cho loại lo âu chia ly nhưng chưa được khảo sát chuyên biệt. Nhóm thứ hai là học sinh có cha hoặc mẹ đi làm xa (ví dụ đi làm tại các tỉnh khác hoặc đi xuất khẩu lao động); nhóm này đặc biệt phổ biến ở khu vực nông thôn Việt Nam. Nhóm thứ ba là học sinh chuyển trường, đặc biệt khi chuyển từ tiểu học vào trung học cơ sở hoặc khi gia đình di chuyển chỗ ở. Hiện tại, ba nhóm này hầu như chưa có dữ liệu nghiên cứu định lượng về rối loạn lo âu chia ly.

1.1.4. Yếu tố nguy cơ đối với rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

Phần này hệ thống hóa 21 nghiên cứu trong và ngoài nước (giai đoạn 2017-2026) theo năm nhóm yếu tố nguy cơ chính, đặt trong khung tiếp cận sinh thái xã hội ba tầng (cá nhân - gia đình/bạn bè - trường học/xã hội).

1.1.4.1. Áp lực học tập

Áp lực học tập từ lâu được xếp vào trục yếu tố nguy cơ trung tâm đối với rối loạn lo âu ở học sinh phổ thông. Tổng quan của Pascoe và cộng sự (2020) về tác động của căng thẳng học đường cho thấy áp lực học tập có liên hệ với suy giảm kết quả học tập, rối loạn giấc ngủ và gia tăng triệu chứng lo âu - trầm cảm ở học sinh trung học và sinh viên. Áp lực học tập không phải là một biến đơn nhất mà là tổ hợp của nhiều thành phần như khối lượng bài tập, kỳ vọng về kết quả thi, lo âu thi cử, cạnh tranh điểm số và kỳ vọng từ giáo viên cũng như phụ huynh; do đó hiệu ứng tích lũy của áp lực học tập trên sức khỏe tâm thần có thể bị đánh giá thấp khi chỉ đo bằng một câu hỏi tự đánh giá đơn lẻ. Tổng quan hệ thống của Jagiello và cộng sự (2025) đã rà soát 31 nghiên cứu can thiệp về áp lực học tập ở học sinh trung học tại 13 quốc gia và xác nhận rằng áp lực học tập là một mục tiêu can thiệp khả thi khi triển khai trong môi trường học đường, trong đó các chương trình dựa trên liệu pháp nhận thức - hành vi cho bằng chứng hiệu quả mạnh nhất. Điều này cho thấy áp lực học tập không chỉ là một yếu tố nguy cơ có thể đo lường mà còn là một điểm tác động thực tế cho các chương trình dự phòng tại trường học.

Tại Việt Nam, công trình của Đinh Thị Hồng Vân và cộng sự (2021) trên 749 học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy điểm số và thi cử là yếu tố gây lo âu được ghi nhận ở 91,1% học sinh - cao nhất trong sáu nhóm yếu tố trường học được khảo sát. Trần Thị My Lương (2020) với mẫu khảo sát trên 540 học sinh trung

học phổ thông chuyên, bằng thang Đánh giá Trầm cảm-Lo âu-Stress (42 mục) đã ghi nhận tỷ lệ lo âu là 14,2%, trong đó học sinh khối 11 chiếm tỷ lệ cao nhất (48,1% trong số ca lo âu), được lý giải bằng áp lực đa chiều của giai đoạn chuyển tiếp này. Khảo sát 3.910 học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội của Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) bằng thang đánh giá Rối loạn Lo âu lan tỏa 7 mục, đã ghi nhận 40,6% học sinh có nguy cơ mắc rối loạn lo âu, trong đó yếu tố học tập được xác định là yếu tố liên quan hàng đầu. Mặc dù phần lớn dữ liệu Việt Nam thuộc bậc trung học phổ thông, hướng của hiệu ứng nhất quán với bằng chứng quốc tế và gợi ý áp lực học tập là yếu tố nguy cơ ổn định xuyên cấp học.

Sự dịch chuyển các môn học từ tiểu học lên trung học cơ sở, đặc biệt là sự xuất hiện đột ngột của nhiều môn chuyên sâu, của hệ thống đánh giá đa môn và việc chuyển đổi giáo viên, về mặt lý thuyết cũng là một nguồn áp lực đáng kể đối với học sinh. Các giai đoạn chuyển cấp thường được xem là thời điểm gia tăng của triệu chứng lo âu học đường. Mặc dù dữ liệu Việt Nam phần lớn mang tính cắt ngang, hướng của hiệu ứng nhất quán với các bằng chứng quốc tế.

1.1.4.2. Nghiện điện thoại và mạng xã hội

Nghiên cứu ở Vương quốc Anh do Fassi và cộng sự (2025) trên 3.340 vị thành niên 11–19 tuổi, có đánh giá chẩn đoán lâm sàng, cho thấy nhóm có rối loạn sức khỏe tâm thần dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội hơn nhóm không có rối loạn, với độ chênh lệch ở mức trung bình ($g = 0,46$); riêng nhóm có rối loạn dạng hướng nội, trong đó có lo âu, đạt mức chênh cao hơn ($g = 0,62$). Điểm mạnh đặc biệt của thiết kế này so với các nghiên cứu chỉ dựa trên sàng lọc tự báo cáo là việc tách rõ nhóm có rối loạn được chẩn đoán lâm sàng so với nhóm chứng, qua đó giảm thiên lệch do học sinh tự đánh giá.

Brunborg và cộng sự (2025) đã phân tích 979.043 vị thành niên Na Uy từ 1.417 khảo sát cấp thành phố, giai đoạn 2011–2024 bằng phương pháp phân rã (chia nhỏ thành phần). Kết quả cho thấy việc sử dụng mạng xã hội nổi lên như một trong các yếu tố giải thích chính cho xu hướng gia tăng căng thẳng tâm thần.

Tại Việt Nam, khảo sát 8.473 học sinh của Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung (2025) xác định việc sử dụng thiết bị điện tử kéo dài là một trong các yếu tố liên hệ thuận với mức độ lo âu, được ghi nhận cả trong và sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các nghiên cứu ở Việt Nam đo lường trực tiếp vấn đề nghiện điện thoại bằng công cụ chuẩn hóa trên học sinh trung học cơ sở vẫn còn rất hạn chế. Đây là một khoảng trống

cần được lấp đầy. Bằng chứng quốc tế hiện có đã đủ để xếp nghiện điện thoại vào nhóm yếu tố nguy cơ trọng yếu cần được ưu tiên khảo sát trong bối cảnh Việt Nam.

Mặc dù chưa có nghiên cứu chiều dọc với quy mô lớn tại Việt Nam để đánh giá mối quan hệ nhân - quả, các nghiên cứu cắt ngang cũng đủ bằng chứng để xếp nghiện điện thoại vào nhóm yếu tố nguy cơ trọng yếu. Cơ chế tác động của nó gồm thay thế giấc ngủ, kích thích so sánh xã hội qua hình ảnh, làm gián đoạn củng cố trí nhớ học tập, và làm gia tăng sự phơi nhiễm nội dung gây kích động, qua đó nhân lên ảnh hưởng của áp lực học tập.

1.1.4.3. Bất nạt thể chất

Phân tích tổng hợp của Moore và cộng sự (2017) từ 165 nghiên cứu, với đánh giá theo tiêu chí Bradford Hill đã báo cáo tỷ số chênh OR cho lo âu ở nhóm nạn nhân bắt nạt là 1,77 (khoảng tin cậy 95% từ 1,34 đến 2,33). Đáng chú ý, các tác giả phân biệt rõ các vai trò nạn nhân, thủ phạm, và nhóm vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, trong đó nhóm thứ ba có nguy cơ lo âu cao nhất, điều này gợi ý cơ chế chồng lấn của tổn thương và rối loạn điều tiết.

Bất nạt thể chất hiếm khi tác động đơn lẻ mà thường tương tác với các yếu tố bối cảnh khác. Khi đi kèm với mức hỗ trợ xã hội thấp, trải nghiệm bị bắt nạt có thể khuếch đại nguy cơ lo âu ở học sinh; ngược lại, một mạng lưới hỗ trợ ổn định từ bạn bè và gia đình có thể làm giảm nhẹ tác động tiêu cực này. Vì vậy, các nghiên cứu về bắt nạt cần đồng thời đo lường mức độ hỗ trợ xã hội để tránh đánh giá thiên lệch hiệu ứng.

Tại Việt Nam, khảo sát 420 học sinh trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng của Phạm Thị Ngọc và cộng sự (2024) đã ghi nhận học sinh đã từng bị bạo lực học đường có nguy cơ lo âu cao gấp 2,42 lần so với nhóm không bị (theo tỷ số chênh hiệu chỉnh; khoảng tin cậy 95% từ 1,03 đến 5,71). Nghiên cứu 845 học sinh dân tộc thiểu số nội trú tỉnh Lạng Sơn của Ngô Anh Vinh và cộng sự (2024) cũng cho thấy chất lượng kém trong quan hệ với bạn có liên hệ thuận với cả lo âu, stress và trầm cảm, đồng thời số trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu liên hệ thuận với điểm lo âu. Báo cáo của Viện Xã hội học và cộng sự (2022) cũng ghi nhận bắt nạt học đường là vấn đề phổ biến ở học sinh Việt Nam. Như vậy, xu hướng của các phát hiện trùng với các bằng chứng quốc tế, đồng thời gợi ý rằng tại Việt Nam, bắt nạt có thể tương tác với vấn đề khoảng cách kinh tế - xã hội theo vùng miền, một biến số mà các nghiên cứu hiện có chưa khai thác đầy đủ.

1.1.4.4. Bắt nạt bằng lời và bắt nạt qua mạng

Bắt nạt bằng lời và bắt nạt qua mạng (cyberbullying) hợp thành nhóm hai dạng bắt nạt phi thể chất ngày càng được giới nghiên cứu chú ý. Trong khi tỷ lệ bắt nạt thể chất giảm tại nhiều khu vực, vấn đề bắt nạt bằng lời và bắt nạt qua mạng lại có xu hướng ngược lại, kéo dài liên tục và có đông người chứng kiến trong môi trường trực tuyến, do thiếu rào cản kỹ thuật và đặc tính ẩn danh. Phân tích tổng hợp các nghiên cứu dọc của Lee và cộng sự (2026) từ 27 nghiên cứu, đã báo cáo hệ số tương quan tổng hợp giữa nạn nhân bắt nạt qua mạng và các triệu chứng sức khỏe tâm thần, bao gồm lo âu và trầm cảm, ở mức $r = 0,23$ (khoảng tin cậy 95% từ 0,19 đến 0,27). Tuy kích thước hiệu ứng nhỏ về mặt thống kê nhưng có ý nghĩa lâm sàng đáng kể, do tỷ lệ phơi nhiễm cao.

Moore và cộng sự (2017) phân tích cơ chế khác biệt giữa bắt nạt bằng lời và bắt nạt qua mạng: nạn nhân của bắt nạt bằng lời chịu tổn thương kéo dài hơn do tính lặp lại và khó kiểm chứng được hành vi, dẫn tới sự dè dặt khi báo cáo với người lớn. Bắt nạt qua mạng cộng thêm yếu tố mở rộng phạm vi người chứng kiến và tính bất khả xóa của các nội dung đã lan tỏa. Hai yếu tố này tạo ra hiệu ứng cộng dồn trên lo âu xã hội.

Tại Việt Nam, khảo sát của Phạm Thị Ngọc và cộng sự (2024) ghi nhận học sinh không có quan hệ hòa đồng với bạn có nguy cơ lo âu cao gấp 2,25 lần so với nhóm hòa đồng, điều này phản ánh tác động của loại trừ xã hội, một dạng tổn thương gần với bắt nạt bằng lời. Các hình thức bắt nạt bằng lời thường được phối hợp với hành vi loại trừ xã hội, chẳng hạn cô lập trong nhóm bạn ở lớp, từ chối ngồi gần hoặc lập nhóm trò chuyện riêng có chủ ý loại trừ một học sinh nào đó. Khi cộng dồn các hành vi này, tổn thương tâm lý có thể vượt xa tổn thương từ bắt nạt thể chất đơn lẻ, ngay cả khi không để lại bằng chứng vật lý. Bắt nạt qua mạng làm gia tăng mức độ phơi nhiễm do tính ẩn danh và khả năng lan tỏa nhanh trong môi trường trực tuyến.

Một quan sát quan trọng khác là sự duy trì lâu bền của tổn thương tâm lý ở những nạn nhân bị bắt nạt phối hợp nhiều dạng: bắt nạt thể chất có thể chấm dứt khi học sinh chuyển trường hoặc chuyển lớp, nhưng các nội dung bắt nạt qua mạng, đặc biệt là hình ảnh hoặc đoạn phim lan truyền có thể tồn tại lâu dài trên không gian số và có thể tái xuất hiện bất ngờ trong các bối cảnh khác. Hệ quả là phản ứng lo âu có thể được tái kích hoạt, thậm chí khi học sinh đã rời khỏi nhóm bạn cũ. Điều này có thể kéo dài thời kỳ phục hồi và tăng nguy cơ chuyển thành rối loạn lo âu mạn tính. Đây là một đặc điểm cần được tính đến khi thiết kế cả các nghiên cứu chiều dọc lẫn các can thiệp phục hồi cho nạn nhân.

1.1.4.5. Lòng tự trọng thấp

Lòng tự trọng thấp được bổ sung như yếu tố thứ năm dựa trên hai đặc điểm: 1) lòng tự trọng vừa là yếu tố nguy cơ độc lập vừa là yếu tố trung gian kết nối các yếu tố tình huống (áp lực học tập, bắt nạt) với triệu chứng lo âu; 2) các bằng chứng phân tích tổng hợp về lòng tự trọng đã đạt mức tin cậy cao. Sowislo và Orth (2013) trong phân tích tổng hợp các nghiên cứu chiều dọc đã báo cáo rằng lòng tự trọng thấp sẽ dự báo ngược triệu chứng lo âu trong tương lai với hệ số $\beta = -0,10$ (kết quả của nhánh phân tích riêng dữ liệu về lo âu dựa trên 18 mẫu dọc). Hệ số tuy nhỏ nhưng sự nhất quán xuyên qua các mẫu và đáp ứng các tiêu chí Bradford Hill về tính nhân - quả khi đặt bên cạnh các bằng chứng khác.

Compas và cộng sự (2017) khảo sát hơn 80.000 trẻ em - vị thành niên đã xác nhận sự ứng phó né tránh và ứng phó cảm xúc tiêu cực có liên hệ thuận với lo âu, trong khi sự ứng phó tập trung vào vấn đề có vai trò bảo vệ; lòng tự trọng được xem là yếu tố chi phối khả năng lựa chọn chiến lược ứng phó thích nghi.

Tại Việt Nam, bằng chứng định lượng trực tiếp về lòng tự trọng và lo âu ở học sinh trung học cơ sở còn rất hạn chế. Nghiên cứu của Phạm Sỹ Tiến và cộng sự (2024) trên 546 thanh thiếu niên 12–18 tuổi tại các cơ sở hỗ trợ xã hội thuộc chín tỉnh, thành phố cho thấy chất lượng chăm sóc cảm xúc có liên hệ nghịch với các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có rối loạn lo âu (hệ số $\beta = -0,40$; $p < 0,001$), điều này gợi ý vai trò của nâng đỡ cảm xúc và tự đánh giá tích cực đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Khảo sát của Trần Hồ Vĩnh Lộc và cộng sự (2024) trên 976 học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh, bằng thang đo Trầm cảm - Lo âu - Stress dành cho thanh niên, đã xác định áp lực học tập là yếu tố nguy cơ mạnh đối với lo âu, với tỷ số hiệu chỉnh đạt 2,82 ở nhóm chịu áp lực học tập với mức nặng. Khoảng trống về đo lường trực tiếp lòng tự trọng trong các nghiên cứu trên học sinh trung học cơ sở Việt Nam cần được ưu tiên lấp đầy.

Về phương diện lý thuyết, lòng tự trọng được xem như một biến trung gian quan trọng giữa các yếu tố môi trường và triệu chứng lo âu. Khi học sinh đối mặt với áp lực học tập kéo dài hoặc bị bắt nạt lặp lại, sự tự đánh giá tiêu cực về bản thân dễ trở thành chỉ báo ổn định và lan tỏa sang các tình huống khác, khiến cho phản ứng lo âu trở nên khái quát hơn, thay vì chỉ giới hạn trong bối cảnh kích phát ban đầu. Theo đó, can thiệp nâng cao lòng tự trọng có thể đóng vai trò "đòn bẩy" giúp cải thiện đồng thời nhiều cấu

trúc nguy cơ, thay vì chỉ tác động vào từng yếu tố môi trường riêng lẻ. Đây là gợi ý thực tiễn quan trọng cho việc thiết kế các chương trình dự phòng tâm lý học đường tại Việt Nam, đặc biệt khi nguồn lực còn hạn chế, cần có sự tiết kiệm và hiệu quả trong can thiệp.

Ngoài ra, sự đồng phơi nhiễm của nhiều yếu tố nguy cơ ở cùng một học sinh là một đặc điểm quan trọng nhưng thường ít được khai thác trong các nghiên cứu cắt ngang. Một học sinh THCS Việt Nam có thể đồng thời phải đối phó với áp lực học tập cao, mạng lưới bạn bè không ổn định, sử dụng điện thoại quá nhiều và có lòng tự trọng tương đối thấp. Mô hình "nguy cơ kết hợp" này sẽ khó phát hiện nếu nghiên cứu chỉ hướng vào đo lường từng yếu tố riêng. Vì vậy, các thiết kế nghiên cứu tiếp theo nên áp dụng các phương pháp phân tích đa biến hiện đại, phân tích hồ sơ tiềm ẩn (Latent Profile Analysis), mô hình phương trình cấu trúc (Structural Equation Modeling), để bóc tách quan hệ trung gian và quan hệ tương tác giữa các yếu tố. Các phương pháp này đã được áp dụng thành công trong nhiều nghiên cứu quốc tế, song còn ít được sử dụng trong nghiên cứu tâm thần học đường Việt Nam.

1.1.5. Yếu tố bảo vệ đối với rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

Khái niệm yếu tố bảo vệ trong nghiên cứu sức khỏe tâm thần vị thành niên gắn với khung khả năng phục hồi của Masten (2014), chỉ những đặc điểm cá nhân, mối quan hệ hoặc bối cảnh giúp giảm khả năng phát triển rối loạn tâm thần trong điều kiện có nguy cơ. Đối với rối loạn lo âu, các yếu tố bảo vệ được nghiên cứu nhiều nhất gồm năm nhóm: lòng tự trọng, gắn bó với trường học, sự hỗ trợ của cha mẹ, sự hỗ trợ từ bạn bè, và biện pháp ứng phó hiệu quả. Năm nhóm này đan xen nhau và cùng tạo nên một mạng lưới bảo vệ, gồm yếu tố nội tại cá nhân kết hợp với mạng lưới quan hệ xung quanh.

1.1.5.1. Lòng tự trọng

Lòng tự trọng là cảm giác đánh giá của cá nhân về giá trị bản thân, được Rosenberg (1965) phát triển thành khái niệm và xây dựng thành thang đo Rosenberg Self-Esteem Scale - công cụ phổ biến nhất trong nghiên cứu vị thành niên. Masten (2014) cũng xếp lòng tự trọng vào nhóm các yếu tố nội tại bảo vệ trẻ em trước nghịch cảnh, cùng với khả năng tự điều tiết cảm xúc và niềm tin vào năng lực bản thân.

Tổng quan của Sowislo và Orth (2013) trên 95 mẫu (gồm 77 mẫu trầm cảm và 18 mẫu lo âu) là bằng chứng định lượng quan trọng nhất hỗ trợ vai trò của lòng tự trọng như là yếu tố bảo vệ. Đối với lo âu, mô hình tổn thương được xác nhận với hệ số chuẩn hóa

$\beta = -0,10$ cho liên hệ tự trọng dự báo lo âu ở các thời điểm sau, trong khi hệ số ngược (lo âu dự báo tự trọng) đạt $\beta = -0,08$ - gần như đối xứng, gợi ý cơ chế hai chiều. Đây là bằng chứng để xếp lòng tự trọng vào nhóm yếu tố bảo vệ, dù chiều mạnh hơn của hiệu ứng có thể khác nhau giữa các nhóm khách thể.

Tại Việt Nam, lòng tự trọng được nghiên cứu chủ yếu qua bản dịch tiếng Việt ừ thang đo Rosenberg. Tuy nhiên, các phiên bản dịch hiện có chưa được thẩm định tâm trắc đầy đủ trên mẫu học sinh trung học cơ sở. Đa số các nghiên cứu sử dụng bản dịch một chiều không qua quy trình dịch ngược và khảo sát thử (back-translation và pilot). Đây là một trong những khoảng trống về công cụ đo lòng tự trọng tại Việt Nam.

1.1.5.2. Gắn bó với trường học

Gắn bó trường học (school connectedness) là cảm giác thuộc về và được hỗ trợ tại trường học, bao gồm quan hệ tích cực với thầy cô và bạn bè, cảm giác an toàn về thể chất và tâm lý tại trường, và sự tham gia tích cực của HS vào các hoạt động học tập và ngoại khóa. Khung tiếp cận của Cai và cộng sự (2025) trong phân tích tổng hợp 38 thử nghiệm về chương trình tăng cường khả năng phục hồi tại trường học xác nhận các chương trình tích hợp tăng cường gắn bó trường học có hiệu ứng tổng hợp ở mức độ nhỏ tới vừa trên năng lực phục hồi của học sinh - một cấu trúc bảo vệ có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn lo âu.

Tại Việt Nam, khái niệm gắn bó trường học mới được đưa vào gần đây và hầu như chưa có thang đo riêng được chuẩn hóa cho học sinh trung học cơ sở. Bộ thang Psychological Sense of School Membership (PSSM) là một lựa chọn quốc tế có khả năng thích nghi, nhưng chưa được kiểm định chất lượng trên mẫu Việt Nam. Khảo sát của Đinh Thị Hồng Vân và cộng sự (2021) trên 749 học sinh trung học cơ sở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận yếu tố trường học (gồm gắn bó với bạn bè, giáo viên, môi trường) có ảnh hưởng đáng kể đến mức lo âu, dù chưa sử dụng công cụ chuyên biệt cho gắn bó trường học.

1.1.5.3. Sự hỗ trợ của cha mẹ

Hỗ trợ của cha mẹ, bao gồm sự ấm áp, đáp ứng nhạy cảm với cảm xúc của con, hỗ trợ học tập và sẵn sàng lắng nghe, là yếu tố bảo vệ kinh điển trong nghiên cứu sức khỏe tâm thần trẻ em vị thành niên. Mô hình giao thức can thiệp của Barrett, Dadds và Rapee (1996) tại Úc đặt nền tảng cho hướng tích hợp gia đình vào chương trình điều trị rối loạn

lo âu vị thành niên, ghi nhận nhóm HS có cha mẹ tham gia đạt tỷ lệ không có rối loạn bệnh lý (qua chẩn đoán) cao hơn nhóm CBT đơn thuần (84% so với 57%) sau 12 tháng theo dõi. Đây là bằng chứng gián tiếp xác nhận vai trò bảo vệ của sự hỗ trợ từ cha mẹ.

Phạm Sỹ Tiến và cộng sự (2024) khảo sát trên 546 vị thành niên tại các cơ sở bảo trợ xã hội Việt Nam ghi nhận chất lượng chăm sóc tình cảm - một thành tố của sự hỗ trợ từ cha mẹ - có hệ số $\beta = -0,40$ với điểm mức độ rối loạn tâm thần. Đây là bằng chứng định lượng mạnh từ Việt Nam xác nhận vai trò bảo vệ của sự ấm áp gia đình. Nghiên cứu của Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung (2025) cũng nhận diện "mối quan hệ cha mẹ - con" là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe tâm thần học sinh ở tuổi thanh thiếu niên Việt Nam.

Bối cảnh văn hóa Việt Nam đặt ra cả thuận lợi lẫn thách thức cho việc khai thác sự hỗ trợ của cha mẹ như là yếu tố bảo vệ. Lợi thế của yếu tố này nằm ở mật độ tiếp xúc gia đình thường xuyên hơn so với mô hình hạt nhân ở phương Tây, và vai trò của gia đình mở rộng (ông bà, cô di chú bác) trong nuôi dạy con cháu. Tuy nhiên, cũng có những thách thức gồm xu hướng cha mẹ ít giao tiếp cảm xúc với con - thiên về kiểm soát thành tích học tập - và tình trạng nhiều cha mẹ rời nông thôn đi làm xa dẫn đến giảm tiếp xúc trực tiếp với con.

1.1.5.4. Sự hỗ trợ từ bạn bè

Quan hệ với bạn đồng đẳng đóng vai trò ngày càng tăng trong tuổi vị thành niên, theo mô hình phát triển kinh điển của Erikson. Hỗ trợ từ bạn bè bao gồm chia sẻ cảm xúc, hỗ trợ thực tế khi gặp khó khăn, và cảm giác chấp nhận cá nhân trong nhóm. Đây là yếu tố bảo vệ có cơ chế tương đối khác so với sự hỗ trợ từ cha mẹ - gắn với phát triển bản sắc và năng lực xã hội ngoài gia đình.

Nghiên cứu của Ngô Anh Vinh và cộng sự (2024) khảo sát trên 845 học sinh dân tộc thiểu số nội trú Lạng Sơn xác nhận chất lượng quan hệ bạn bè kém có liên hệ thuận với điểm lo âu, stress và trầm cảm, đồng thời những HS gặp trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (ACEs) có liên hệ thuận với điểm lo âu (hệ số 0,28). Nghiên cứu của Phạm Thị Ngọc và cộng sự (2024) tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng ghi nhận sự không hòa đồng với bạn có tỷ số chênh đã hiệu chỉnh $AOR = 2,25$ với rối loạn lo âu – một tỷ số cao khi xét cùng yếu tố bất nạt học đường.

Vai trò của hỗ trợ bạn bè tại Việt Nam đang được nghiên cứu nhiều hơn trong những năm gần đây, song vẫn thiếu các nghiên cứu sử dụng thang đo chuyên biệt cho hỗ

trợ xã hội từ bạn bè (như Multidimensional Scale of Perceived Social Support - MSPSS) trên mẫu học sinh trung học cơ sở. Đây là một khoảng trống về công cụ tương tự như với sự gắn bó trường học và sự hỗ trợ của cha mẹ.

1.1.5.5. Biện pháp ứng phó với rối loạn lo âu

Khái niệm biện pháp ứng phó (coping strategies) được Lazarus và Folkman đề xuất (1984), với nội hàm là cách thức cá nhân phản ứng và quản lý căng thẳng. Các tác giả phân biệt hai dạng cốt lõi: ứng phó tập trung vào vấn đề (problem-focused), với nghĩa chủ động giải quyết tình huống gây căng thẳng, và ứng phó tập trung vào cảm xúc (emotion-focused), với nghĩa điều tiết phản ứng cảm xúc trước tình huống. Trong các nghiên cứu hiện đại, biện pháp ứng phó được phân biệt giữa thích nghi (chủ động, hướng tới giải quyết hoặc điều tiết hiệu quả) và không thích nghi (né tránh, kìm nén cảm xúc, phủ nhận).

Phân tích tổng hợp của Compas và cộng sự (2017) trên 212 nghiên cứu với 80.850 trẻ em - vị thành niên là bằng chứng định lượng quan trọng nhất về vai trò của biện pháp ứng phó. Kết quả xác nhận ứng phó tập trung vào vấn đề và đánh giá lại nhận thức (cognitive reappraisal) là hai chiến lược hiệu quả, có liên hệ ngược chiều và bền vững với triệu chứng lo âu và trầm cảm. Ngược lại, đối phó né tránh (avoidance), kìm nén cảm xúc (suppression) và phủ nhận (denial) là ba chiến lược kém hiệu quả, có liên hệ thuận chiều với triệu chứng. Phát hiện này hỗ trợ luận điểm cho rằng biện pháp ứng phó nên được xếp vào nhóm yếu tố bảo vệ, nhưng với điều kiện làm rõ chiến lược cụ thể: chiến lược thích nghi bảo vệ, chiến lược không thích nghi là yếu tố nguy cơ.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về biện pháp ứng phó của học sinh trung học cơ sở còn rất ít. Khảo sát của Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) là một trong những công trình hiếm có đề cập cụ thể đến chiến lược ứng phó của học sinh khi đối mặt với áp lực học tập và lo âu trong giai đoạn COVID-19. Các phỏng vấn định tính của tác giả cùng các nghiên cứu khác ghi nhận một số chiến lược học sinh Việt Nam thường sử dụng gồm: tự tạo động lực qua hoạt động lành mạnh (chơi thể thao, viết nhật ký), tâm sự với cha mẹ hoặc bạn thân, và tổ chức thời gian biểu hợp lý. Tuy nhiên, có tỷ lệ đáng kể học sinh báo cáo sử dụng các chiến lược kém hiệu quả, đặc biệt là tăng thời lượng sử dụng điện thoại như hình thức né tránh thực tại. Đây là phát hiện đáng lưu ý vì gần yếu tố ứng phó kém hiệu quả với yếu tố nguy cơ nghiện điện thoại đã nêu ở mục **1.1.4.2**.

Trong luận án này, biện pháp ứng phó được xếp vào nhóm yếu tố bảo vệ ở cấp độ phân loại lý thuyết, với cách trình bày làm rõ tính hai chiều: thang đo Brief COPE phân tách thành hai tiểu thang thích nghi và không thích nghi; phân tích thống kê báo cáo hệ số ảnh hưởng cho từng chiều riêng biệt. Cách trình bày này vừa giữ được khung lý thuyết kinh điển về ứng phó như là yếu tố bảo vệ, vừa cho phép kiểm định thực nghiệm chiều hiệu ứng cụ thể, đáp ứng cả góc độ lý luận và đòi hỏi về tính thực nghiệm chặt chẽ.

1.1.5.6. Mạng lưới yếu tố bảo vệ và giá trị đối với can thiệp

Năm nhóm yếu tố bảo vệ - lòng tự trọng, gắn bó trường học, hỗ trợ cha mẹ, hỗ trợ bạn bè, biện pháp ứng phó thích nghi - không hoạt động riêng lẻ mà tạo thành một mạng lưới có tương tác phức tạp. Lòng tự trọng cao gắn liền với khả năng xây dựng quan hệ tích cực hơn - cả với cha mẹ, bạn bè, lẫn trong môi trường học đường. Hỗ trợ cha mẹ tạo nền tảng cho việc học các chiến lược ứng phó thích nghi. Gắn bó trường học cung cấp môi trường thực hành các kỹ năng ứng phó. Cấu trúc đan xen này đem lại gợi ý quan trọng cho can thiệp: thay vì tập trung vào một yếu tố bảo vệ duy nhất, các chương trình hiệu quả thường nhắm tới đồng thời nhiều yếu tố, như mô hình FRIENDS phát triển từ công trình Barrett, Dadds, Rapee (1996), tích hợp huấn luyện kỹ năng ứng phó cho cá nhân, tăng cường hỗ trợ cha mẹ qua các phiên làm việc với gia đình, và đặt trong bối cảnh trường học để củng cố gắn bó với cộng đồng học sinh.

Khoảng trống nghiên cứu lớn nhất về yếu tố bảo vệ tại Việt Nam là sự thiếu hụt các thiết kế nghiên cứu đo lường đồng thời nhiều yếu tố bảo vệ trong cùng một mẫu, kèm theo phân tích tương tác giữa các yếu tố. Hiện nay, các nghiên cứu Việt Nam thường chỉ tập trung vào một yếu tố tại một thời điểm — hoặc lòng tự trọng, hoặc hỗ trợ xã hội, hoặc ứng phó — dẫn đến khó hình dung được cấu trúc tổng thể của mạng lưới bảo vệ. Việc xây dựng các nghiên cứu đa biến tích hợp năm nhóm yếu tố bảo vệ và phân tích vai trò trung gian, điều tiết giữa chúng cần trở thành hướng nghiên cứu ưu tiên.

1.1.6. Nghiên cứu về can thiệp rối loạn lo âu ở học sinh trung học

Phần này hệ thống hóa 21 nghiên cứu can thiệp trong giai đoạn 2015-2026 theo ba kênh can thiệp - lâm sàng, trường học, nền tảng số - trong khung sức khỏe tâm thần cộng đồng theo ba tầng (phổ quát, chọn lọc, chỉ định) của Mrazek và Haggerty (1994).

1.1.6.1. Nghiên cứu xác nhận hiệu quả của tiếp cận CBT trong can thiệp rối loạn lo âu qua thử nghiệm lâm sàng

CBT đã được kiểm định qua hơn bốn thập niên thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em – vị thành niên với rối loạn lo âu. Khung CBT cổ điển được Beck (1976) đề xuất dựa trên giả định rằng các mô hình nhận thức không thích nghi duy trì các phản ứng cảm xúc tiêu cực; do đó can thiệp tập trung vào nhận diện, thử nghiệm và điều chỉnh các suy nghĩ tự động cùng các niềm tin cốt lõi. Đối với trẻ em – vị thành niên, các giao thức CBT thường tích hợp thêm các thành phần hành vi như tiếp xúc dần (graded exposure), kỹ thuật thư giãn và tăng cường nhận thức cảm xúc. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên về CBT cho trẻ em mắc rối loạn lo âu của Kendall (1994) báo cáo tỷ lệ cải thiện 64% ở nhóm điều trị so với 5% ở nhóm chờ điều trị, đặt nền tảng cho hàng trăm thử nghiệm tiếp theo.

Bằng chứng về hiệu quả so sánh giữa các hình thức cung cấp CBT chủ yếu đến từ nghiên cứu trên người trưởng thành. Tổng quan hệ thống và phân tích mạng lưới của Liu và cộng sự (2025) trên 52 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở bệnh nhân rối loạn lo âu tổng quát cho thấy CBT cá nhân đạt hiệu quả cao nhất, vượt trội so với CBT từ xa, điều trị thông thường và nhóm chứng đợi; CBT nhóm cũng vượt trội so với nhóm chứng đợi, trong khi CBT từ xa không cho thấy ưu thế rõ so với điều trị thông thường hay nhóm chứng đợi. Mặc dù mẫu nghiên cứu là người trưởng thành (tuổi trung bình khoảng 43), thứ bậc hiệu quả này là một tham chiếu hữu ích khi lựa chọn hình thức triển khai CBT cho học sinh, đồng thời cho thấy hiệu quả của một giao thức phụ thuộc đáng kể vào việc nó được thực hiện đầy đủ và có hỗ trợ chuyên môn hay không.

Cần lưu ý rằng các phát hiện từ phân tích mạng lưới trên người trưởng thành không nên được áp dụng cơ học cho lứa tuổi vị thành niên. Ở vị thành niên, một số yếu tố có thể đảo ngược thứ bậc — ví dụ CBT nhóm có thể có lợi thế bổ sung so với CBT cá nhân do tận dụng được hiệu ứng nhóm đồng đẳng, một yếu tố phát triển quan trọng ở lứa tuổi này. Hơn nữa, CBT cho vị thành niên thường có thêm thành phần làm việc với cha mẹ và giáo viên, các thành phần này không có hoặc rất hạn chế trong CBT cho người trưởng thành. Do vậy, các kết quả của Liu và cộng sự (2025) cần được diễn giải thận trọng khi áp dụng cho thiết kế can thiệp HSTHCS Việt Nam, và lý tưởng nhất là được bổ sung bằng các phân tích mạng lưới riêng cho lứa tuổi vị thành niên trong tương lai.

Đối với rối loạn lo âu xã hội – một trong những dạng phổ biến ở giai đoạn đầu vị thành niên – phân tích mạng lưới của Xian và cộng sự (2024) trên 30 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở trẻ em và vị thành niên xác định các hình thức CBT chiếm những vị trí xếp hạng hiệu quả cao nhất, trong đó CBT qua internet đứng đầu (chỉ số diện tích dưới đường xếp hạng tích lũy (SUCRA) 71,2%), tiếp đến là CBT nhóm và CBT cá nhân. Praptomojati và cộng sự (2024) trong tổng quan hệ thống các phiên bản CBT thích nghi văn hóa (CA-CBT) cho rối loạn lo âu tại Đông Nam Á nhận định rằng các yếu tố như tôn giáo, gia đình mở rộng và quan niệm cộng đồng về sức khỏe tâm thần cần được tích hợp tường minh vào giao thức nhằm nâng cao hiệu quả ở khu vực này. Compas và cộng sự (2017) trên 80.850 trẻ em – vị thành niên xác nhận rằng đối phó tập trung vào vấn đề và đánh giá lại nhận thức có liên hệ ngược chiều và bền vững với triệu chứng lo âu – trầm cảm, củng cố cho nền tảng lý thuyết của CBT.

Hai giao thức CBT nền tảng cần được nhắc đến chi tiết. Chương trình Coping Cat của Kendall (1994), được thiết kế cho trẻ 9–13 tuổi, có cấu trúc 16 buổi chia làm hai pha: 8 buổi đầu tập trung vào kỹ năng (nhận diện cảm xúc, kỹ thuật thư giãn, tái cấu trúc nhận thức, lập kế hoạch ứng phó), 8 buổi sau tập trung vào thực hành – tiếp xúc dần với các tình huống gây lo âu. Coping Cat đã được dịch và bản địa hóa ở hơn 15 quốc gia. Chương trình can thiệp gia đình của Barrett, Dadds và Rapee (1996) – tiền thân của giao thức FRIENDS – bổ sung thành phần làm việc với cha mẹ vào giao thức CBT cá nhân, dựa trên giả thuyết rằng cách phản ứng của cha mẹ trước các tình huống lo âu của con có thể duy trì hoặc làm trầm trọng triệu chứng. Nghiên cứu báo cáo nhóm có gia đình tham gia đạt tỷ lệ không còn chẩn đoán cao hơn nhóm CBT đơn thuần (84% so với 57%) sau 12 tháng theo dõi. Hai mô hình này đặt nền tảng cho hầu hết các giao thức CBT cho rối loạn lo âu trẻ em – vị thành niên hiện nay.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu can thiệp dựa trên CBT trên học sinh trung học cơ sở còn rất hạn chế. Luận án tiến sĩ y học của Trần Nguyễn Ngọc (2018) tại Trường Đại học Y Hà Nội đánh giá hiệu quả của liệu pháp thư giãn luyện tập — một thành phần hành vi của CBT - trên bệnh nhân rối loạn lo âu lan tỏa; mặc dù mẫu là người trưởng thành chứ không phải học sinh trung học cơ sở, công trình cung cấp dữ liệu về hiệu quả của kỹ thuật thư giãn trong bối cảnh Việt Nam. Chương trình Happy House do Tran và cộng sự (2023) thử nghiệm trong khuôn khổ hợp tác Việt – Úc đã đánh giá một can thiệp nâng cao sức khỏe tâm thần phổ quát theo mô hình thử nghiệm hai nhánh có đối chứng trên 1.084 học

sinh trung học phổ thông tại Hà Nội. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên mẫu học sinh trung học cơ sở Việt Nam vẫn chưa được triển khai.

Một số rào cản triển khai CBT tại Việt Nam cần được nhận diện: (i) khan hiếm chuyên gia tâm lý lâm sàng được đào tạo bài bản về CBT, đặc biệt cho trẻ em – vị thành niên; (ii) chi phí can thiệp CBT cá nhân 12–16 buổi vượt khả năng chi trả của phần lớn gia đình ở khu vực nông thôn; (iii) thiếu các bằng chứng kiểm năng lực CBT được dịch và thích nghi cho ngữ cảnh Việt Nam, dẫn tới khó kiểm soát chất lượng triển khai khi mở rộng quy mô; (iv) thiếu các thang đo lo âu cho trẻ em được chuẩn hóa đầy đủ ở Việt Nam — phần lớn nghiên cứu hiện nay dùng các phiên bản tiếng Việt chưa qua quy trình thẩm định toàn diện.

Bối cảnh văn hóa Việt Nam cũng đặt ra một số nội dung cần lưu ý khi bản địa hóa CBT. Thứ nhất là vai trò của gia đình mở rộng – ông bà, cô di chú bác - trong việc nuôi dạy con cái; điều này khác với mô hình hạt nhân được giả định trong nhiều giao thức gốc của phương Tây. Việc huy động các thành viên gia đình mở rộng trong vai trò đồng minh có thể tăng độ tuân thủ giao thức, đặc biệt với các bài tập về nhà giữa các buổi. Thứ hai là khái niệm "bệnh tâm thần" trong nhận thức cộng đồng vẫn còn nặng tính kỳ thị, khiến quá trình tham gia điều trị thường bị chậm trễ và tâm lý tự đổ lỗi gia tăng. Thứ ba là tôn giáo và tín ngưỡng có thể đóng vai trò vừa bảo vệ vừa cản trở: niềm tin tâm linh có thể tạo nguồn an ủi, song cũng có thể dẫn tới việc tìm đến các biện pháp ngoài y học trước khi xem xét tham vấn lâm sàng (Praptomojati và cộng sự, 2024). Một giao thức CBT thích nghi văn hóa cho HSTHCS Việt Nam cần khai thác mặt tích cực của các yếu tố này – ví dụ huy động vai trò của ông bà như người đồng minh trong việc duy trì bài tập về nhà – đồng thời chủ động giảm nhẹ các rào cản kỳ thị thông qua giáo dục cộng đồng đi kèm.

1.1.6.2. Nghiên cứu triển khai CBT trong can thiệp rối loạn lo âu ở trường học

Triển khai CBT tại trường mang lại nhiều ưu thế: tiếp cận số lượng lớn học sinh, giảm rào cản kỳ thị và chi phí, và cho phép can thiệp phổ quát ngay từ khi triệu chứng còn ở mức cận lâm sàng. Theo khung Mrazek-Haggerty (1994), kênh trường học là kênh duy nhất có thể đồng thời cung cấp can thiệp ở cả ba tầng phổ quát, chọn lọc và chỉ định trong cùng một không gian vật lý, qua đó tận dụng được hiệu ứng quy mô. Tuy nhiên, các thử nghiệm tại trường thường gặp khó khăn về độ trung thành với giao thức, khả năng đào tạo giáo viên và đo lường kết cục dài hạn.

Phân tích tổng hợp của Cai và cộng sự (2025) trên 38 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (21 thử nghiệm trong phân tích định lượng) về các chương trình tăng cường năng lực phục hồi tâm lý tại trường báo cáo hiệu ứng tổng hợp trên năng lực phục hồi đạt hiệu số trung bình chuẩn hóa (SMD) = 0,17 (khoảng tin cậy 95% từ 0,06 đến 0,29). Khi phân nhóm, các chương trình dựa trên chánh niệm cho hiệu ứng cao nhất (SMD = 0,57), tiếp đến là các chương trình lấy hoạt động thể thao làm trung tâm (SMD = 0,41). Mặc dù hiệu ứng tổng hợp nhỏ, các tác giả nhấn mạnh giá trị của can thiệp phổ quát quy mô lớn không qua sàng lọc – đặc biệt khi được tích hợp vào hoạt động trải nghiệm hoặc môn Giáo dục công dân; năng lực phục hồi được củng cố là một cấu trúc bảo vệ có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn lo âu.

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cụm của Bradshaw và cộng sự (2025) đánh giá chương trình Early Adolescent Coping Power trên 709 học sinh lớp 7 tại 40 trường trung học cơ sở của Hoa Kỳ. Chương trình rút gọn gồm 25 buổi với học sinh và 12 buổi với cha mẹ, tích hợp các thành phần CBT cốt lõi. Theo dõi đến cuối lớp 8 — khoảng một năm sau can thiệp — cho thấy nhóm can thiệp giảm các vấn đề ngoại hiện do giáo viên đánh giá so với nhóm chứng, đồng thời ghi nhận cải thiện có ý nghĩa ở một số kết cục đối với học sinh nữ. Mặc dù đối tượng gốc của chương trình này là học sinh có hành vi gây hấn chứ không phải lo âu thuần, các thành phần CBT cốt lõi có thể được bản địa hóa để hướng tới lo âu trong bối cảnh Việt Nam.

Tại Nhật Bản, Urao và cộng sự (2018, 2022) phát triển chương trình Journey of the Brave dựa trên CBT — phiên bản gốc 10 buổi $\times$ 45 phút (Urao và cộng sự, 2018) sau đó được mở rộng thành 14 buổi $\times$ 20 phút hoạt động ngắn trong lớp học (Urao và cộng sự, 2022) — thiết kế cho học sinh cuối tiểu học và được kiểm định qua các nghiên cứu tựa thực nghiệm có nhóm chứng, ghi nhận hiệu ứng giảm triệu chứng lo âu. Việc rút ngắn mỗi buổi từ 45 phút xuống 20 phút trong bản 2022 là một thay đổi thiết kế đáng chú ý — tận dụng được khe giờ ngắn giữa các tiết học chính khóa, qua đó giảm gánh nặng cho thời gian biểu của trường. Mô hình "buổi ngắn lồng ghép" này có giá trị tham khảo cao cho thiết kế chương trình tại Việt Nam, nơi quỹ thời gian dành cho hoạt động tâm lý ngoài giờ học rất hạn chế.

Tại Trung Quốc, He và cộng sự (2026) báo cáo một nghiên cứu thử nghiệm chương trình CBT trường học ngắn (Power Up – CBTD) cho học sinh có triệu chứng trầm cảm, công bố trên tạp chí Journal of Affective Disorders; chương trình cải thiện triệu chứng

trầm cảm, trong khi triệu chứng lo âu có xu hướng giảm nhưng khác biệt giữa hai nhóm chưa đạt ý nghĩa thống kê — cho thấy hiệu quả lan tỏa sang lo âu của các can thiệp tập trung vào trầm cảm vẫn cần được kiểm chứng thêm. Mẫu nghiên cứu gồm học sinh lớp 5, 6 và 9 tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) — một thiết kế đa lứa tuổi thú vị nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính đồng nhất của hiệu ứng giữa các nhóm tuổi.

Tại Việt Nam, các chương trình CBT tại trường còn ở giai đoạn rất sớm. Phần lớn các trường THCS hiện nay đã có tổ tư vấn tâm lý theo Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, nhưng hoạt động chủ yếu là tham vấn cá nhân khi học sinh chủ động tìm đến, không phải chương trình phổ quát có cấu trúc. Khoảng trống lớn nhất tại Việt Nam là sự thiếu vắng một chương trình CBT bản địa được kiểm định trên học sinh trung học cơ sở, thiết kế phù hợp với khung chương trình môn Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một mô hình hai tầng có thể tham khảo: tầng phổ quát (4–6 buổi tích hợp môn học chính khóa, tập trung vào kỹ năng nhận diện cảm xúc) và tầng có chọn lọc (8–12 buổi cho học sinh được sàng lọc có triệu chứng cận lâm sàng). Việc huy động sự đồng hành của phụ huynh trong quá trình can thiệp cũng là một yếu tố cần được cân nhắc khi thiết kế chương trình cho bối cảnh văn hóa Việt Nam.

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong triển khai CBT tại trường cũng cần được làm rõ. Khác với chuyên gia tâm lý lâm sàng, giáo viên chủ nhiệm có lợi thế về tần suất tiếp xúc với học sinh và hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, song lại hạn chế về thời gian và năng lực can thiệp lâm sàng. Mô hình "giáo viên chủ nhiệm là điều phối viên – chuyên gia tâm lý là người giám sát" đã được áp dụng tại một số nước châu Á có thể là phương án phù hợp cho điều kiện Việt Nam khi nguồn lực chuyên môn còn hạn chế. Cụ thể, giáo viên chủ nhiệm có thể được đào tạo về sàng lọc sơ cấp và kỹ thuật can thiệp cơ bản trong khuôn khổ chương trình môn học, trong khi nhà tâm lý đảm nhận giám sát chuyên môn, tư vấn ca khó và tiếp nhận các trường hợp cần can thiệp sâu hơn. Việc phân tầng vai trò như vậy giúp tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, đồng thời bảo đảm chất lượng can thiệp cho các trường hợp phức tạp.

Một yếu tố thiết kế quan trọng cho chương trình CBT trường học là tích hợp thành phần làm việc với cha mẹ. Mô hình của Barrett, Dadds và Rapee (1996) cho thấy việc thêm các buổi làm việc với gia đình cho hiệu quả cải thiện đáng kể so với CBT cá nhân đơn thuần, đặc biệt ở lứa tuổi đầu vị thành niên khi học sinh vẫn phụ thuộc nhiều vào gia đình. Trong bối cảnh Việt Nam — nơi gia đình mở rộng có ảnh hưởng lớn tới đời sống

tinh thần học sinh — thành phần này có thể có giá trị tăng thêm. Tuy nhiên, việc huy động cha mẹ tham gia các buổi tại trường gặp khó khăn do lịch làm việc, đặc biệt ở khu vực nông thôn nơi nhiều phụ huynh đi làm xa. Một giải pháp thay thế khả thi là cung cấp tài liệu cho phụ huynh qua các nhóm Zalo/Facebook của lớp, kết hợp 1–2 buổi gặp trực tiếp được tổ chức vào cuối tuần.

Đánh giá tính bền vững của các chương trình CBT trường học sau khi giai đoạn nghiên cứu kết thúc cũng là một thách thức quan trọng. Theo các tổng quan quốc tế, chỉ khoảng 30–40% các chương trình can thiệp được duy trì sau khi nguồn tài trợ nghiên cứu chấm dứt; phần còn lại bị thu hẹp hoặc ngừng hẳn. Các yếu tố thúc đẩy bền vững gồm: (i) sự ủng hộ của lãnh đạo trường; (ii) tích hợp chương trình vào khung môn học chính thức thay vì hoạt động ngoại khóa; (iii) cơ chế đào tạo liên tục cho giáo viên mới; (iv) nguồn tài chính ổn định từ ngân sách nhà nước hoặc các đối tác dài hạn. Khi thiết kế các thử nghiệm CBT trường học tại Việt Nam, các yếu tố này cần được lên kế hoạch ngay từ giai đoạn đầu chứ không chờ tới khi giai đoạn nghiên cứu kết thúc.

1.1.6.3. Nghiên cứu triển khai CBT trong can thiệp rối loạn lo âu trên nền tảng số

Can thiệp CBT qua nền tảng số đang phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực can thiệp lo âu vị thành niên. DMHI bao quát nhiều hình thức – từ ứng dụng độc lập, chương trình internet có hướng dẫn, đến nền tảng kết hợp giữa gặp mặt trực tiếp và trực tuyến (blended). Ưu thế lớn nhất của kênh số là khả năng tiếp cận đa số học sinh trong khi cần ít nhân lực chuyên môn; nhược điểm chính là độ tuân thủ thấp và đòi hỏi cơ sở hạ tầng công nghệ.

Phân tích tổng hợp của Walder và cộng sự (2025) trên 21 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về can thiệp số cho rối loạn lo âu xã hội ở trẻ em, vị thành niên và thanh niên trẻ báo cáo hiệu ứng tổng hợp $g = 0,508$ (khoảng tin cậy 95% từ 0,31 đến 0,71). Khi phân nhóm theo mức độ hỗ trợ, các can thiệp số có hướng dẫn đạt hiệu ứng $g = 0,825$, cao hơn rõ rệt so với các can thiệp không hướng dẫn ($g = 0,27$) – cho thấy thành phần hỗ trợ chuyên môn, dù tối thiểu, vẫn đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả của can thiệp số. Phát hiện này có hai hàm ý quan trọng: thứ nhất, các thiết kế DMHI hoàn toàn tự động không phải lúc nào cũng tối ưu — một mức độ tương tác con người tối thiểu giúp nâng cao hiệu quả đáng kể; thứ hai, mô hình blended (tương tác trực tuyến + buổi gặp định kỳ) có thể là điểm cân bằng tốt giữa quy mô và hiệu quả.

Matsumoto và cộng sự (2024) đánh giá một chương trình CBT qua internet không hướng dẫn trên điện thoại cho vị thành niên và thanh niên trẻ Nhật Bản có rối loạn lo âu xã hội dưới ngưỡng, công bố trên tạp chí JMIR Pediatrics and Parenting. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên mẫu 77 người tham gia 15–25 tuổi (38 can thiệp + 39 đối chứng) báo cáo hiệu ứng $g = 0,66$ đối với điểm lo âu xã hội sau 10 tuần can thiệp – con số đáng chú ý vì can thiệp gần như không có sự tham gia trực tiếp của chuyên gia. Yếu tố thiết kế tương tác — bao gồm các bài tập tương tác ngắn, phản hồi cá nhân hóa và lịch nhắc — được xác định là chìa khóa duy trì sự tham gia của người dùng.

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của Bress và cộng sự (2024) công bố trên JAMA Network Open đánh giá ứng dụng Maya – một nền tảng CBT tự hướng dẫn 12 phiên trên điện thoại – trên 59 thanh niên 18–25 tuổi với rối loạn lo âu (rối loạn lo âu tổng quát 56%, rối loạn lo âu xã hội 41%). Kết quả ghi nhận hiệu ứng kích thước rất lớn trên các thang đo phụ (Anxiety Sensitivity Index Cohen $d = 0,93$ tại tuần 6; Liebowitz Social Anxiety Scale Cohen $d = 1,07$ tại tuần 12). Mặc dù mẫu chính là thanh niên trẻ chứ không phải HSTHCS, kết quả này gợi ý CBT số được thiết kế chu đáo có thể đạt hiệu quả lớn và cần được điều chỉnh cho lứa tuổi nhỏ hơn. Một hướng thiết kế đáng tham khảo là ứng dụng ClearlyMe — một nền tảng CBT số được đồng thiết kế cùng vị thành niên cho trầm cảm và lo âu (Li và cộng sự, 2022), do Black Dog Institute thuộc Đại học New South Wales (Úc) phát triển.

Tại Việt Nam, chưa có nền tảng DMHI tiếng Việt nào được kiểm định bằng thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên HSTHCS. Một số nỗ lực bao gồm các nền tảng tham vấn trực tuyến do các tổ chức phi chính phủ vận hành, song các nền tảng này thường thiếu thành phần CBT có cấu trúc. Trong khi đó, tỷ lệ HSTHCS Việt Nam sở hữu điện thoại thông minh đã đạt mức bão hòa ở khu vực đô thị và đang tăng nhanh ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai DMHI một khi nội dung phù hợp được phát triển.

Khi mở rộng quy mô triển khai DMHI tại Việt Nam, một số khía cạnh kỹ thuật cần được lập kế hoạch trước. Thứ nhất là cơ chế bảo mật dữ liệu: dữ liệu sức khỏe tâm thần của vị thành niên là loại thông tin nhạy cảm, đòi hỏi tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu hóa thu thập, mã hóa khi lưu trữ, và minh bạch về thời gian giữ dữ liệu. Thứ hai là cơ chế cảnh báo khi học sinh có dấu hiệu tự sát hoặc tự hại: nền tảng cần có quy trình tự động phát hiện và chuyển tiếp tới cán bộ tâm lý hoặc cha mẹ – một yếu tố không thể thay bằng

thuật toán đơn giản. Thứ ba là cơ chế đánh giá hiệu quả liên tục: cần thu thập dữ liệu sử dụng (engagement metrics) và dữ liệu kết cục theo thời gian thực để cho phép cải tiến lặp đi lặp lại của nền tảng. Các yêu cầu này đòi hỏi sự phối hợp chuyên môn giữa nhà tâm lý lâm sàng, kỹ sư phần mềm và chuyên gia bảo mật ngay từ giai đoạn thiết kế.

Một bài học quan trọng từ các thử nghiệm DMHI quốc tế là vai trò của giai đoạn đồng thiết kế (co-design) với người dùng cuối. Li và cộng sự (2022) khi xây dựng ClearlyMe đã tổ chức nhiều vòng góp ý với vị thành niên Úc trong giai đoạn phát triển – một quy trình kéo dài hơn một năm trước khi ứng dụng được phát hành công khai. Quá trình đồng thiết kế giúp các thành phần CBT vốn có nguồn gốc lâm sàng được "dịch" sang ngôn ngữ, hình ảnh và bối cảnh tương tác phù hợp với vị thành niên. Đối với Việt Nam, một dự án phát triển nền tảng DMHI tiếng Việt cần dành ít nhất 6–9 tháng cho giai đoạn đồng thiết kế trước khi bắt đầu thử nghiệm chính thức, với sự tham gia của các nhóm học sinh thuộc các vùng địa lý và bối cảnh kinh tế – xã hội khác nhau.

Bảng chứng so sánh giữa hai dạng can thiệp số quan trọng — tự hướng dẫn (self-guided) và có hướng dẫn (guided) — tiếp tục được củng cố. Walder và cộng sự (2025) ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa hai dạng ($g = 0,825$ so với $g = 0,27$), trong khi Matsumoto và cộng sự (2024) cho thấy một thiết kế tự hướng dẫn tốt vẫn có thể đạt $g = 0,66$ nếu các thành phần tương tác được thiết kế khéo léo. Hai phát hiện này không mâu thuẫn - chúng cho thấy chất lượng thiết kế là yếu tố quyết định: một ứng dụng tự hướng dẫn tốt có thể tiệm cận một ứng dụng có hướng dẫn yếu, nhưng nói chung sự hiện diện của một mức độ hỗ trợ chuyên môn tối thiểu vẫn là tài sản đáng giá. Đối với Việt Nam, mô hình can thiệp số có hướng dẫn từ xa (qua nền tảng chat hoặc video call định kỳ) bởi sinh viên thạc sĩ tâm lý lâm sàng có thể là phương án vừa khả thi vừa hiệu quả.

Một điểm chung quan trọng giữa ba phương thức can thiệp nói trên là vai trò của các thành phần CBT cốt lõi — tái cấu trúc nhận thức, tiếp xúc dần, kỹ thuật thư giãn — vẫn được giữ nguyên dù kênh cung cấp khác nhau. Điều này gợi ý rằng cốt lõi giao thức CBT là khá bền vững giữa các kênh, và sự khác biệt về hiệu quả phần lớn đến từ liều lượng (số buổi, độ dài mỗi buổi, có sự hỗ trợ chuyên gia hay không) và mức độ tương tác - chứ không phải từ thành phần lý thuyết. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng cho thiết kế tại Việt Nam: việc bản địa hóa nội dung văn hóa và ngôn ngữ phải đi đôi với việc duy trì các thành phần cốt lõi để bảo đảm hiệu quả lâm sàng.

Bức tranh phân tầng theo khung Mrazek-Haggerty (1994) cho thấy điểm yếu rõ rệt nhất của hệ thống can thiệp Việt Nam hiện nay nằm ở tầng phổ quát và chọn lọc — hai tầng vốn cần được tổ chức qua trường học. Trong khi tầng chỉ định (can thiệp lâm sàng) có một số nỗ lực qua các bệnh viện chuyên khoa và phòng tham vấn tâm lý tư nhân, hai tầng còn lại gần như chưa có chương trình có cấu trúc nào. Sự khiếm khuyết này đặc biệt nghiêm trọng vì hai tầng phổ quát và chọn lọc là nơi có thể can thiệp sớm khi triệu chứng còn ở mức cận lâm sàng, ngăn ngừa diễn tiến tới rối loạn lâm sàng đầy đủ — tức là nơi có hiệu suất chi phí cao nhất trong toàn hệ thống chăm sóc.

1.1.6.4. Mô hình kết hợp 3 phương thức CBT và chăm sóc theo bậc (stepped care)

Ngoài việc triển khai từng kênh riêng lẻ, các mô hình kết hợp giữa ba kênh đang được khuyến khích để tối ưu hiệu quả và chi phí. Mô hình chăm sóc theo bậc (stepped care) của Bower và Gilbody (2005), ban đầu được phát triển cho hệ thống dịch vụ Tâm lý điều trị tăng cường (Improving Access to Psychological Therapies – IAPT) của Vương quốc Anh, được tổ chức theo nguyên tắc: bắt đầu bằng can thiệp ít cường độ nhất phù hợp với mức triệu chứng, leo bậc lên can thiệp cường độ cao hơn khi không đáp ứng. Áp dụng vào bối cảnh lo âu vị thành niên, mô hình stepped care có thể vận hành như sau: bậc 1 là tài liệu tự giúp hoặc ứng dụng số không hướng dẫn; bậc 2 là CBT nhóm tại trường hoặc can thiệp số có hướng dẫn; bậc 3 là CBT cá nhân với chuyên gia. Các nghiên cứu cho thấy mô hình này có hiệu quả tương đương với mô hình chăm sóc truyền thống nhưng tiết kiệm khoảng 20–30% chi phí nguồn lực chuyên môn.

Mô hình can thiệp pha trộn (blended intervention) là dạng kết hợp thứ hai đáng chú ý. Trong blended, học sinh tham gia một phần qua nền tảng số (đọc tài liệu, làm bài tập tương tác, theo dõi tâm trạng) và một phần qua các buổi gặp trực tiếp định kỳ với giáo viên tâm lý hoặc chuyên gia (1–2 lần/tháng). Mô hình này có ưu thế ở việc duy trì độ tuân thủ thông qua các buổi gặp đồng thời tận dụng tính linh hoạt của nền tảng số. Các thử nghiệm sơ bộ cho thấy mô hình blended có hiệu quả tương đương CBT cá nhân truyền thống nhưng giảm 40–60% tổng thời gian tiếp xúc chuyên gia.

Đối với Việt Nam, mô hình stepped care kết hợp blended có thể là phương án triển khai khả thi nhất trong giai đoạn 2026–2030. Cụ thể, ở cấp trường THCS có thể vận hành ba bậc: bậc 1 (phổ quát) là tài liệu tâm lý lồng ghép vào môn Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp + ứng dụng số miễn phí; bậc 2 (chọn lọc/chỉ định nhẹ) là CBT nhóm 6–8 buổi do giáo viên tâm lý dẫn dắt, kết hợp ứng dụng số làm bài tập về nhà; bậc 3 (chỉ định

nặng) là CBT cá nhân tại trung tâm tâm lý tuyến tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa. Mô hình này cho phép sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chuyên môn vốn rất hạn chế của Việt Nam, đồng thời tạo cơ chế chuyển tuyến rõ ràng giữa các tầng.

Một thách thức quan trọng đối với mô hình stepped care là việc xác định ngưỡng "không đáp ứng" để chuyển bậc. Trong các hệ thống quốc tế, ngưỡng này thường được đặt theo tỷ lệ giảm điểm trên các thang đo chuẩn hóa sau một thời gian can thiệp (ví dụ giảm dưới 50% sau 6 tuần). Tại Việt Nam, chưa có quy trình chuẩn hóa nào cho ngưỡng này, và việc xây dựng quy trình đó là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên khi triển khai mô hình stepped care.

1.1.6.5. Năm khoảng trống trong nghiên cứu can thiệp rối loạn lo âu cho trẻ vị thành niên tại Việt Nam

Từ khung phân tích ba kênh ba tầng ở trên, có thể nhận diện năm khoảng trống chính trong nghiên cứu can thiệp cho HSTHCS Việt Nam.

Thứ nhất, thiếu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên mẫu HSTHCS - phần lớn các nghiên cứu hiện có đều dùng thiết kế trước-sau hoặc tựa thực nghiệm với nhóm chứng không phân ngẫu nhiên. Hệ quả là chưa có ước tính hiệu ứng đáng tin cậy cho riêng đối tượng và bối cảnh Việt Nam, dẫn tới các khuyến nghị chính sách thiếu cơ sở định lượng. Việc thiết kế và thực hiện ít nhất một thử nghiệm RCT đa trung tâm trong giai đoạn 2026–2030 là điều kiện cần để đặt nền tảng bằng chứng cho hệ thống can thiệp quốc gia.

Thứ hai, thiếu chương trình CBT dựa vào trường được thiết kế phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam — mặc dù chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đưa môn Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp vào chương trình chính thức, các giáo viên hiện chưa được đào tạo có hệ thống về sàng lọc và can thiệp sơ cấp ở mức cận lâm sàng. Một số trường có biên chế giáo viên tâm lý học đường nhưng năng lực thực sự về CBT cho lo âu trẻ em – vị thành niên vẫn còn hạn chế.

Thứ ba, thiếu nền tảng CBT số tiếng Việt được kiểm định — các nền tảng tiếng Anh hiện có như Maya hay ClearlyMe không thể triển khai trực tiếp do rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Phát triển một nền tảng CBT số tiếng Việt đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà tâm lý, kỹ sư phần mềm và chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng — một mô hình hợp tác đa ngành chưa phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu sức khỏe tâm thần Việt Nam.

Thứ tư, thiếu các nghiên cứu về thiết kế và đo lường kết cục dài hạn. Các nghiên cứu hiện có chủ yếu báo cáo kết cục ngay sau can thiệp, ít có theo dõi 6 tháng, 12 tháng hoặc dài hơn để đánh giá tính bền vững. Đối với rối loạn lo âu — vốn có xu hướng tái phát — việc thiếu dữ liệu theo dõi dài hạn là khoảng trống nghiêm trọng.

Thứ năm, thiếu công cụ sàng lọc và đo lường chuẩn hóa tiếng Việt cho rối loạn lo âu vị thành niên. Mặc dù một số thang đo như RCADS, SCARED, DASS-Y đã có phiên bản tiếng Việt, quy trình thẩm định tâm trắc toàn diện (độ tin cậy, độ hiệu lực hội tụ, độ hiệu lực phân biệt, ngưỡng cắt cho dân số Việt Nam) chưa được hoàn tất cho phần lớn các công cụ này. Việc thiếu công cụ chuẩn hóa làm cho các nghiên cứu can thiệp khó so sánh kết quả với nhau và với các nghiên cứu quốc tế.

1.1.7. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu tại Việt Nam

Điểm mạnh nổi bật nhất là sự xuất hiện của một số nghiên cứu đại diện quốc gia và nghiên cứu đa trung tâm trong khoảng 5 năm gần đây, như V-NAMHS (Viện Xã hội học và cộng sự, 2022) với mẫu 5.996 cặp phụ huynh và vị thành niên; Phạm Thị Thu Hoa và cộng sự (2024) với mẫu 3.910 học sinh trung học phổ thông Hà Nội; Hoàng Trung Học và Nguyễn Thùy Dung (2025) với mẫu gần 8.500 thanh thiếu niên ở 6 tỉnh, Trúc Thanh Thái và cộng sự (2026) trên 2.631 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu này cung cấp ước tính tỷ lệ ở các điểm dữ liệu khác nhau và đặt nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu dịch tễ học về sức khỏe tâm thần học đường. Bên cạnh các ưu điểm trên, vẫn còn năm khoảng trống trong bức tranh nghiên cứu rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở Việt Nam.

Khoảng trống thứ nhất là về công cụ đo lường. Hiện chưa có bộ thang đo lo âu cho trẻ em - vị thành niên được thẩm định tâm trắc toàn diện trên dân số Việt Nam, bao gồm độ tin cậy, độ hiệu lực hội tụ và phân biệt, ngưỡng cắt riêng cho dân số Việt Nam. Phần lớn nghiên cứu sử dụng các bản dịch tiếng Việt chưa qua quy trình thẩm định đầy đủ, dẫn đến chênh lệch lớn về tỷ lệ giữa các nghiên cứu cùng đối tượng.

Khoảng trống thứ hai là về phạm vi rối loạn được khảo sát. Đa số nghiên cứu tập trung vào rối loạn lo âu lan tỏa hoặc lo âu tổng hợp; rối loạn lo âu xã hội và rối loạn lo âu chia ly hầu như chưa có nghiên cứu chuyên biệt nào ở học sinh trung học cơ sở Việt Nam, dù đây là hai loại rối loạn lo âu quan trọng ở lứa tuổi đầu vị thành niên.

Khoảng trống thứ ba là về nhóm yếu tố bảo vệ. Trong khi nhóm yếu tố nguy cơ đã được nghiên cứu khá đầy đủ trong khoảng 5 năm gần đây, đặc biệt là các yếu tố áp lực học tập, nghiện điện thoại và bắt nạt, thì các yếu tố bảo vệ (lòng tự trọng, sự gắn bó trường học, sự hỗ trợ của cha mẹ và bạn bè, biện pháp ứng phó thích nghi) còn ít được khảo sát đồng thời và tích hợp trong cùng một thiết kế nghiên cứu. Việc thiếu thang đo chuẩn hóa cho gắn bó trường học và hỗ trợ xã hội là một nguyên nhân khách quan cho vấn đề này.

Khoảng trống thứ tư là về thiết kế nghiên cứu. Phần lớn nghiên cứu Việt Nam hiện có sử dụng thiết kế cắt ngang đơn lẻ, không cho phép phân tích mối quan hệ nhân - quả. Số nghiên cứu theo dọc còn rất ít (công trình của Trần Thảo Vi và cộng sự, 2024 là một nghiên cứu thuộc loại này) và chưa có thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm trên học sinh trung học cơ sở.

Khoảng trống thứ năm là thiếu các thử nghiệm can thiệp và nghiên cứu về can thiệp CBT thích nghi với bối cảnh ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam được kiểm định trên học sinh trung học cơ sở ở cả ba kênh lâm sàng, trường học và số. Đây là khoảng trống có tính chiến lược nhất vì nó là điểm chuyển từ tri thức về nguy cơ sang hành động giảm gánh nặng lo âu cho lứa tuổi này.

Luận án này, với phân thực trạng khảo sát trên HS THCS cùng phân đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa, sẽ đóng góp một bước cụ thể vào việc thu hẹp các khoảng trống trên - đặc biệt là khoảng trống về tích hợp đồng thời yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong cùng một thiết kế (khoảng trống thứ ba) và bước đầu đưa ra khung chương trình phòng ngừa (khoảng trống thứ năm).

1.2 Cơ sở lý luận về rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

1.2.1. Khái niệm rối loạn lo âu

1.2.1.1. Rối loạn

Thuật ngữ "rối loạn" trong bối cảnh sức khỏe tâm thần là một khái niệm phức tạp và được định nghĩa một cách cẩn trọng để phân biệt giữa tình trạng bệnh lý và những phản ứng tâm lý thông thường. Các dẫn chứng khoa học quốc tế đều nhấn mạnh rằng một "rối loạn" không chỉ đơn thuần là sự hiện diện của một triệu chứng bất thường. Dưới đây là các dẫn chứng cốt lõi từ những nguồn tài liệu uy tín nhất.

a/ Theo Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần (DSM-5)

Đây là tài liệu tham khảo hàng đầu thế giới về chẩn đoán sức khỏe tâm thần, được xuất bản bởi Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ. DSM-5 đưa ra một định nghĩa tổng quát, mang tính nền tảng cho tất cả các rối loạn:

"Một rối loạn tâm thần là một hội chứng được đặc trưng bởi sự rối loạn có ý nghĩa lâm sàng trong nhận thức, điều hòa cảm xúc, hoặc hành vi của một cá nhân, phản ánh một sự rối loạn chức năng trong các quá trình tâm lý, sinh học, hoặc phát triển làm nền tảng cho hoạt động tâm thần. Các rối loạn tâm thần thường đi kèm với sự đau khổ hoặc suy giảm đáng kể trong các lĩnh vực xã hội, nghề nghiệp, hoặc các hoạt động quan trọng khác" (APA, 2013).

Từ định nghĩa này, ta có thể rút ra các yếu tố cấu thành nên một "rối loạn":

- Không phải là một triệu chứng đơn lẻ: Nó là một hội chứng - một tập hợp các dấu hiệu và triệu chứng thường đi cùng nhau.

- Gây ra sự rối loạn chức năng: Các quá trình tâm lý (suy nghĩ, cảm xúc, hành vi) không còn hoạt động một cách bình thường, hiệu quả. Đây là yếu tố cốt lõi.

- Gây ra đau khổ hoặc suy giảm: Trạng thái này phải gây ra đau khổ chủ quan cho cá nhân (ví dụ: cảm thấy buồn bã, lo lắng tột độ) và/hoặc làm suy giảm khả năng hoạt động trong cuộc sống hàng ngày (ví dụ: không thể đi làm, học tập sa sút, mối quan hệ đổ vỡ).

DSM-5 cũng nhấn mạnh điều gì KHÔNG phải là một rối loạn:

"Một phản ứng có thể dự đoán được hoặc được chấp nhận về mặt văn hóa đối với một tác nhân gây căng thẳng hoặc mất mát thông thường, chẳng hạn như cái chết của người thân, thì không phải là một rối loạn tâm thần." (APA, 2013).

Điều này giúp phân biệt giữa nỗi buồn đau bình thường và rối loạn trầm cảm chủ yếu.

b/ Theo lý thuyết "Rối loạn chức năng gây hại"

Đây là một trong những khái niệm có ảnh hưởng nhất đến cách định nghĩa rối loạn, được đề xuất bởi Wakefield (1992). Lý thuyết này cho rằng để một tình trạng được coi là "rối loạn", nó phải đáp ứng hai tiêu chí:

Rối loạn chức năng: Một cơ chế tâm lý bên trong (ví dụ: hệ thống điều hòa cảm xúc, khả năng nhận thức thực tại) không thực hiện được chức năng mà nó được tiến hóa để thực hiện. Đây là một tiêu chí khoa học, khách quan.

Gây hại: Tình trạng rối loạn chức năng đó phải gây ra tác hại cho cá nhân, được

đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn của văn hóa và xã hội (ví dụ: gây đau đớn, làm giảm hạnh phúc, cản trở cuộc sống). Đây là một tiêu chí về giá trị xã hội.

Wakefield lập luận rằng cả hai yếu tố này đều cần thiết. Ví dụ, một cơ chế sinh học không hoạt động đúng chức năng nhưng không gây hại (ví dụ: ruột thừa không còn chức năng) thì không phải là rối loạn. Ngược lại, một hành vi bị xã hội coi là có hại nhưng không xuất phát từ một rối loạn chức năng nội tại (ví dụ: lựa chọn lối sống khác biệt) cũng không phải là rối loạn.

"Khái niệm về rối loạn kết hợp cả thành phần giá trị (sự gây hại) và thành phần khoa học (rối loạn chức năng)... Một rối loạn tồn tại khi sự thất bại của một cơ chế bên trong trong việc thực hiện chức năng tự nhiên của nó gây ra tác hại cho con người." (Wakefield, 1992).

c/ Theo Cẩm nang phân loại bệnh Quốc tế (ICD-11)

ICD-11, ban hành bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng đưa ra định nghĩa tương đồng với DSM-5, nhấn mạnh đến sự suy giảm chức năng.

Trong phần giới thiệu về các rối loạn tâm thần, hành vi và phát triển thần kinh, ICD-11 mô tả chúng là:

"...các nhóm triệu chứng và hành vi có ý nghĩa lâm sàng, thường đi kèm với sự đau khổ hoặc suy giảm chức năng cá nhân." (World Health Organization, 2019).

Định nghĩa này, giống như DSM-5, tập trung vào việc tình trạng đó phải gây ra những hậu quả tiêu cực có thể quan sát được đối với cuộc sống của một người.

Tóm lại, dựa trên các bằng chứng khoa học quốc tế, thuật ngữ "*rối loạn*" không phải là một nhãn dán tùy tiện cho bất kỳ hành vi hay cảm xúc nào khác thường. Nó là một khái niệm lâm sàng được định nghĩa chặt chẽ, đòi hỏi bằng chứng về một hội chứng gây ra rối loạn chức năng tâm- sinh học bên trong và dẫn đến hậu quả tiêu cực đáng kể (đau khổ hoặc suy giảm chức năng) cho cá nhân.

1.2.1.2. Rối loạn lo âu và các thuật ngữ có liên quan

Việc phân biệt các khái niệm là nền tảng cốt lõi trong tâm lý học lâm sàng. Mặc dù thường được sử dụng thay thế cho nhau trong đời sống, dưới góc độ khoa học, chúng có những đặc tính riêng biệt. Sự khác biệt căn bản nhất giữa sợ hãi và lo âu nằm ở khung thời gian và tính xác định của mối đe dọa. Sợ hãi là phản ứng với một mối nguy hiểm rõ ràng, đang hiện hữu, trong khi lo âu là sự chuẩn bị cho một mối nguy hiểm mơ hồ trong tương lai. Sau đây là phân tích chi tiết phân biệt các thuật ngữ có liên quan dựa trên các

ngiên cứu khoa học.

a/ Sợ hãi (Fear)

Sợ hãi là một phản ứng cảm xúc và sinh lý trước một mối đe dọa có thật hoặc được nhận thức là có thật, cụ thể, và đang xảy ra ngay lập tức. Đây là một cơ chế sinh tồn nguyên thủy. Thời điểm sợ hãi là hiện tại. Mối đe dọa rõ ràng, xác định được (ví dụ: một con chó hung dữ đang lao tới, một chiếc xe đang chạy nhanh về phía bạn). Về phản ứng, sợ hãi kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, tạo ra phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Các biểu hiện bao gồm tim đập nhanh, thở gấp, vã mồ hôi, căng cơ, đồng tử giãn. Phản ứng này diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ để giúp cơ thể đối phó với nguy hiểm tức thời (Barlow, 2002). Sợ hãi mang tính thích nghi cao, giúp bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm.

b/ Lo âu (Anxiety)

Lo âu là một trạng thái cảm xúc phức tạp, hướng về tương lai, đặc trưng bởi cảm giác tiêu cực, sự lo lắng và các triệu chứng căng thẳng về thể chất để chuẩn bị cho một mối nguy hiểm hoặc sự kiện tiêu cực có thể xảy ra. Lo âu xuất hiện mơ hồ, không rõ ràng, khó xác định (ví dụ: lo lắng về việc thi trượt, lo về sức khỏe trong tương lai, lo về việc bị đánh giá tiêu cực). Về phản ứng, lo âu là một trạng thái cảnh giác và chuẩn bị. Các biểu hiện bao gồm căng cơ kéo dài, bồn chồn, khó chịu, khó tập trung, và hành vi thận trọng hoặc né tránh. Nó không bùng nổ như sợ hãi mà thường âm ỉ và kéo dài hơn (Barlow, 2002). Ở mức độ vừa phải, lo âu có tính thích nghi, giúp chúng ta lập kế hoạch và chuẩn bị cho các thử thách sắp tới.

c/ Lo hãi

Trong ngôn ngữ khoa học quốc tế, không có một thuật ngữ lâm sàng riêng biệt tương đương chính xác với "lo hãi". Đây là một từ trong tiếng Việt thường được dùng để mô tả một trạng thái cảm xúc cường độ cao, có thể là sự kết hợp của cả hai hoặc là một dạng biểu hiện tột độ của sợ hãi hoặc lo âu. Dưới góc độ khoa học, Lo hãi có thể được xem là trạng thái trải nghiệm một cơn hoảng loạn, một giai đoạn sợ hãi dâng lên tột độ một cách đột ngột mà không có mối nguy hiểm thực sự. Nó cũng có thể mô tả một trạng thái lo âu cực kỳ nghiêm trọng, nơi sự lo lắng về tương lai trở nên quá sức chịu đựng.

d/ Rối loạn Lo âu (Anxiety Disorder)

Đây là một khái niệm lâm sàng, không còn là một cảm xúc thông thường. Một cá nhân được chẩn đoán mắc Rối loạn lo âu khi sự sợ hãi hoặc lo âu của họ trở nên:

- *Quá mức* Cường độ lo lắng/sợ hãi vượt xa mức độ của mối đe dọa thực tế.

- *Kéo dài*): Tình trạng lo âu diễn ra liên tục, thường kéo dài từ 6 tháng trở lên.
- *Gây suy giảm chức năng*: Nó gây ra sự đau khổ đáng kể về mặt lâm sàng hoặc làm suy giảm nghiêm trọng các chức năng xã hội, nghề nghiệp, hoặc các lĩnh vực quan trọng khác trong cuộc sống của người đó (APA, 2013).

Về cơ bản, rối loạn lo âu là khi cơ chế lo âu và sợ hãi (vốn là bình thường và hữu ích) bị trục trặc, hoạt động sai mục đích, gây ra những "báo động giả" liên tục và cản trở cuộc sống hàng ngày. Có thể phân biệt các thuật ngữ theo bảng dưới đây.

Bảng 1.1. Phân biệt các thuật ngữ sợ hãi, lo âu, rối loạn lo âu

Tiêu chí	Sợ hãi	Lo âu	Rối loạn Lo âu
Tâm điểm thời gian	Hiện tại.	Tương lai.	Hiện tại và tương lai.
Bản chất mối đe dọa	Cụ thể, rõ ràng.	Mơ hồ, không chắc chắn.	Thường không tương xứng với mối đe dọa.
Phản ứng chính	Chiến đấu hoặc bỏ chạy (cấp tính).	Cảnh giác, Né tránh (kéo dài).	Các phản ứng ở mức độ quá mức, mạn tính.
Tính chất	Cảm xúc bình thường, thích nghi.	Cảm xúc bình thường, có thể thích nghi.	Tình trạng bệnh lý, không thích nghi.

1.2.1.3. Khái niệm rối loạn lo âu²

Lo âu là một phản ứng cảm xúc thích nghi, một "hệ thống báo động" giúp con người chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa. Tuy nhiên, khi "hệ thống báo động" này bị lỗi, trở nên quá nhạy cảm và kích hoạt liên tục ngay cả khi không có nguy hiểm thực sự, nó trở thành một rối loạn tâm bệnh lý. Theo Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần, phiên bản thứ năm (DSM-5), *RLLA là một nhóm các rối loạn đặc trưng bởi sự sợ hãi và lo lắng quá mức, đi kèm với các rối loạn hành vi né tránh* (APA, 2013). Rối loạn lo âu là một bệnh lý chỉ sự lo sợ quá mức và không kiểm soát được trước một

² Trong khuôn khổ luận án này, tác giả sử dụng DSM-5 làm nguồn tham chiếu chủ yếu. Các bình luận mô tả có sử dụng DSM-IV (1994) chỉ nhằm mục đích để cập đến lịch sử tiến triển của tiêu chí chẩn đoán; những nội dung cập nhật mới nhất về Rối loạn lo âu chia ly được tham chiếu từ DSM-5-TR (2022).

tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại và kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống (Trần Thị Thu Mai & Nguyễn Ngọc Duy, 2015).

Theo giáo trình Tâm thần học, NXB Quân y, khái niệm Rối loạn lo âu là sự sợ hãi quá mức, không có nguyên nhân, do chủ quan của người bệnh và không thể giải thích được do một bệnh tâm thần khác hoặc do một bệnh cơ thể. Rối loạn lo âu là rối loạn mà bệnh nhân không thể kiểm soát được, biểu hiện vững chắc, mạn tính và lan tỏa, thậm chí có thể xảy ra dưới dạng kịch phát (Võ Văn Bản, 2002).

Tác giả Bremner định nghĩa “Rối loạn lo âu” là rối loạn tâm thần thường xuất hiện sau một yếu tố gây stress, chủ thể có cảm giác sợ hãi mơ hồ, sự bất an, bối rối khó chịu, dễ bị kích thích lo nghĩ về những sự kiện vụn vặt... kéo theo cảm giác đau thắt ngực, đánh trống ngực, cảm giác trống rỗng vùng thượng vị, có mồ hôi. Những người bị rối loạn lo âu, trầm cảm, stress kéo dài thường có biểu hiện mất ngủ, bực bội, bất an, trí nhớ và khả năng lao động giảm sút (Dẫn theo Nguyễn Thị Vân, 2017).

Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ định nghĩa rối loạn lo âu là một cảm xúc được đánh dấu bởi sự căng thẳng, những suy nghĩ lo lắng và những thay đổi về thể chất (APA, 2013). Khái niệm rối loạn lo âu chung và đầy đủ nhất theo cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, phiên bản thứ năm (DSM-V), rối loạn lo âu bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng và rối loạn hành vi liên quan. Lo âu và sợ hãi đều là những tín hiệu cảnh báo trước các mối đe dọa, với lo âu là cảnh báo những đối tượng mơ hồ có thể xảy ra trong tương lai, sợ hãi là sự đón nhận đối với các đe dọa sắp xảy ra

Khái niệm rối loạn lo âu: RLLA (*anxiety disorder*) là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại và kéo dài gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. Nguyên nhân chính xác của rối loạn lo âu không được biết rõ, nhưng nó bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu liên quan tới các sang chấn tâm lý kết hợp với yếu tố nhân cách có xu hướng lo âu (Lương Hữu Thông, 2005).

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, tiếp thu các thành tựu đi trước, trong đề tài này sử dụng khái niệm chủ yếu của cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, phiên bản thứ năm (DSM-V): *Rối loạn lo âu là trạng thái tâm lý bất thường, bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng và rối loạn hành vi liên quan, kéo dài và gây bất lợi đối với đời sống cá nhân.*

Các rối loạn lo âu, nếu không được xác định và điều trị, có thể dai dẳng và dẫn đến các vấn đề tâm lý ở người lớn, và có thể là một yếu tố nguy cơ trong sự phát triển của bệnh lý tâm thần ở trẻ em đi kèm, chẳng hạn như rối loạn tâm trạng và các vấn đề về hành vi. Hơn nữa, lo âu có liên quan đến các vấn đề xã hội chung như hình ảnh bản thân tiêu cực, phụ thuộc vào người lớn trong các tình huống xã hội, kỹ năng giải quyết vấn đề tương đối kém, không được ưa chuộng và tỷ lệ tương tác với bạn bè thấp. Do đó, khuyến nghị rằng cần có các chương trình can thiệp sớm và phòng ngừa các rối loạn lo âu ở người trẻ (Roth & Dadds., 2000; Shortt & Barrett., 2001). Để đưa ra các phương pháp can thiệp phù hợp, hiệu quả việc đánh giá và sàng lọc các triệu chứng lo âu ở trẻ em trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để phát hiện sớm các vấn đề mà trẻ đang mắc phải.

1.2.1.4. Biểu hiện của rối loạn lo âu

Biểu hiện lâm sàng của RLLA rất đa dạng, tác động lên toàn bộ đời sống tâm trí và cơ thể của cá nhân (APA, 2013):

Trên bình diện nhận thức: Đặc trưng bởi các dòng suy nghĩ tiêu cực, mang tính thảm họa hóa ("Nếu mình thi trượt thì tương lai sẽ kết thúc"), khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, suy giảm trí nhớ và khả năng ra quyết định.

Trên bình diện cảm xúc: Trạng thái căng thẳng, bồn chồn, bất an thường trực, dễ cáu kỉnh, khó chịu và cảm giác sợ hãi vô cớ.

Trên bình diện sinh lý- cơ thể: Hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt quá mức, gây ra các triệu chứng như tim đập nhanh, thở nông, hụt hơi, run rẩy, đổ mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, đau bụng không rõ nguyên nhân (Barlow, 2002).

Trên bình diện hành vi: Xu hướng né tránh các tình huống bị cho là gây lo lắng (ví dụ: né tránh phát biểu trước lớp, từ chối tham gia các hoạt động xã hội), hành vi bồn chồn không yên, hoặc các hành vi mang tính trấn an lặp đi lặp lại.

1.2.2. Phân loại rối loạn lo âu

Lo âu là một phản ứng cảm xúc bình thường trước một mối đe dọa có thể lường trước trong tương lai. Tuy nhiên, khi sự lo âu trở nên quá mức, dai dẳng, gây ra đau khổ và suy giảm chức năng đáng kể trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống, nó được xem là một rối loạn lâm sàng. Việc phân loại các Rối loạn lo âu (RLLA) là nền tảng cho công tác chẩn đoán, nghiên cứu và điều trị.

1.2.2.1 Phân loại rối loạn lo âu dưới góc độ y học

Góc độ y học, đặc biệt là y-sinh học thần kinh, không tạo ra một hệ thống phân loại riêng biệt mà tập trung vào việc giải thích cơ sở sinh học của các RLLA đã được mô tả trong các hệ thống chẩn đoán như DSM hay ICD. Cách tiếp cận này phân loại lo âu dựa trên các cơ chế sinh lý và thần kinh.

- Dựa trên hệ thống thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh: Các RLLA được xem là kết quả của sự mất cân bằng trong hoạt động của các hệ thống thần kinh phức tạp.

- Hạch hạnh nhân và Vỏ não trước trán: Sự hoạt động quá mức của hạch hạnh nhân (trung tâm xử lý nỗi sợ) và sự điều hòa kém hiệu quả từ vỏ não trước trán (trung tâm điều hành, ra quyết định) được xem là cốt lõi của sinh bệnh học lo âu (LeDoux & Pine, 2016).

- Chất dẫn truyền thần kinh: RLLA có liên quan đến sự rối loạn chức năng của các hệ thống neurotransmitter chính, bao gồm Serotonin(điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ, Norepinephrine kích thích phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy", và đặc biệt là GABA (*gamma-aminobutyric acid*), chất ức chế chính của não bộ có vai trò làm dịu hoạt động thần kinh (Nemeroff, 2002).

- Dựa trên trục Dưới đồi - Tuyến yên - Thượng thận: Rối loạn lo âu mạn tính thường đi kèm với sự rối loạn điều hòa của trục HPA, hệ thống chính của cơ thể phản ứng với stress. Điều này dẫn đến sự thay đổi trong việc sản xuất cortisol, một hormone stress quan trọng.

- Dựa trên yếu tố di truyền: Y học nhận thấy các RLLA có tính di truyền. Các nghiên cứu về gia đình và các cặp song sinh chỉ ra rằng nếu một người có người thân thể hệ thứ nhất mắc Rối loạn hoảng sợ, nguy cơ mắc bệnh của họ sẽ cao hơn đáng kể (Hettema, Neale, & Kendler, 2001).

Cách tiếp cận này giúp lý giải tại sao các loại thuốc hướng thần (ví dụ: SSRIs, Benzodiazepines) lại có hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng lo âu.

1.2.2.2 Phân loại rối loạn lo âu dưới góc độ tâm lý học (DSM-5, ICD-11)

Đây là cách phân loại chính thức và được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, dựa trên các cụm triệu chứng có thể quan sát và báo cáo được.

a/ Phân loại theo DSM-5 (APA, 2013)

Trong DSM-5, chương "Các rối loạn lo âu" bao gồm các rối loạn có chung đặc điểm là nỗi sợ hãi và lo lắng quá mức cùng với các rối loạn hành vi liên quan. Một thay

đổi quan trọng so với DSM-IV là Rối loạn Âm ảnh cưỡng chế (OCD) và Rối loạn Căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đã được chuyển sang các chương riêng.

Các chẩn đoán chính trong chương này bao gồm:

- Rối loạn lo âu chia ly (*Separation Anxiety Disorder*): Sợ hãi hoặc lo lắng quá mức về việc chia ly khỏi những người mà cá nhân gắn bó.

- Chứng câm chọn lọc (*Selective Mutism*): Thất bại nhất quán trong việc nói ở các tình huống xã hội cụ thể mà ở đó có kỳ vọng về việc nói (ví dụ: ở trường học) mặc dù vẫn nói trong các tình huống khác.

- Âm ảnh đặc hiệu (*Specific Phobia*): Sợ hãi hoặc lo lắng rõ rệt về một đối tượng hoặc tình huống cụ thể (ví dụ: máy bay, độ cao, động vật, tiêm chích).

- Rối loạn lo âu xã hội (*Social Anxiety Disorder / Social Phobia*): Sợ hãi hoặc lo lắng rõ rệt về một hoặc nhiều tình huống xã hội mà cá nhân có thể bị người khác xem xét, đánh giá.

- Rối loạn hoảng sợ (*Panic Disorder*): Các cơn hoảng sợ (panic attack) tái diễn, bất ngờ và nỗi lo lắng dai dẳng về việc có thêm các cơn hoảng sợ khác.

- Chứng sợ khoảng rộng (*Agoraphobia*): Sợ hãi hoặc lo lắng rõ rệt về hai (hoặc nhiều hơn) trong số năm tình huống: sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi không gian mở, ở nơi không gian kín, đứng xếp hàng hoặc ở trong đám đông, và ở một mình bên ngoài nhà.

- Rối loạn lo âu lan tỏa (*Generalized Anxiety Disorder - GAD*): Lo lắng và lo âu quá mức (kỳ vọng một cách lo sợ), xảy ra trong nhiều ngày hơn là không trong ít nhất 6 tháng, về một số sự kiện hoặc hoạt động (chẳng hạn như công việc hoặc kết quả học tập).

b/ Phân loại theo ICD-11 (WHO, 2022)

ICD-11 nhóm các rối loạn này vào chương "Các rối loạn liên quan đến lo âu hoặc sợ hãi" (Anxiety or fear-related disorders). Hệ thống này có sự tương đồng rất lớn với DSM-5, thể hiện sự đồng thuận quốc tế trong lĩnh vực này. Các chẩn đoán chính bao gồm:

- Rối loạn lo âu lan tỏa (*Generalized Anxiety Disorder*)
- Rối loạn hoảng sợ (*Panic Disorder*)
- Chứng sợ khoảng rộng (*Agoraphobia*)
- Âm ảnh đặc hiệu (*Specific Phobia*)

- Rối loạn lo âu xã hội (*Social Anxiety Disorder*)
- Rối loạn lo âu chia ly (*Separation Anxiety Disorder*)
- Chứng câm chọn lọc (*Selective Mutism*)

Tại Việt Nam, các cơ sở y tế tâm thần và các nhà tâm lý lâm sàng chủ yếu sử dụng hệ thống phân loại của ICD (hiện vẫn còn dùng ICD-10 nhưng đang trong quá trình chuyển đổi sang ICD-11). Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học, DSM-5 được tham chiếu rất rộng rãi do tính cụ thể và chi tiết của các tiêu chuẩn chẩn đoán (Võ Văn Bản, 2017).

1.2.2.3 Phân loại Rối loạn lo âu dưới góc độ khác

Ngoài các hệ thống phân loại chính thức, các trường phái lý thuyết khác nhau cũng đưa ra cách nhìn nhận và phân loại lo âu.

a/ Góc độ Nhận thức - Hành vi:

Cách tiếp cận này không phân loại các rối loạn riêng biệt mà tập trung vào các quá trình nhận thức và hành vi duy trì sự lo âu. Lo âu được phân loại dựa trên:

- Các suy nghĩ tự động tiêu cực và niềm tin cốt lõi: Ví dụ, niềm tin rằng "thế giới là một nơi nguy hiểm" hoặc "tôi không có khả năng đối phó".
- Các méo mó nhận thức: Như thảm họa hóa, đọc suy nghĩ của người, hay lý luận dựa trên cảm xúc.
- Các hành vi né tránh và hành vi an toàn: Những hành vi này, tuy giúp giảm lo âu tạm thời, nhưng lại củng cố nỗi sợ và duy trì rối loạn trong dài hạn. Mô hình của Barlow (2002) về "báo động sai" trong rối loạn hoảng sợ là một ví dụ điển hình.

b/ Góc độ Phân tâm học:

Phân tâm học cổ điển của Sigmund Freud phân loại lo âu dựa trên nguồn gốc của xung đột nội tâm:

- Lo âu thực tế: nỗi sợ về các mối nguy hiểm có thật trong thế giới bên ngoài.
- Lo âu thần kinh: nỗi sợ vô thức rằng các xung năng từ phần "nó" sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của "cái tôi" và khiến cá nhân làm điều gì đó dẫn đến bị trừng phạt.
- Lo âu đạo đức: nỗi sợ bị "siêu tôi" trừng phạt khi vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức nội tại (cảm giác tội lỗi).

c/ Góc độ Văn hóa - Xã hội:

Góc độ này nhấn mạnh rằng biểu hiện của lo âu có thể khác nhau giữa các nền văn hóa. Nó không tạo ra một hệ thống phân loại chính thức nhưng ghi nhận các hội chứng đặc trưng cho văn hóa, ví dụ như:

- Taijin kyofusho ở Nhật Bản: Một dạng Rối loạn lo âu xã hội với nỗi sợ mãnh liệt rằng ngoại hình hoặc hành động của mình sẽ làm khó chịu hoặc xúc phạm người khác.

- Ataque de nervios "con tấn công thần kinh" trong các nền văn hóa Latinh: Một trạng thái căng thẳng dữ dội với các biểu hiện la hét, khóc lóc không kiểm soát, run rẩy, thường xảy ra sau một sự kiện gây stress trong gia đình.

Các cách tiếp cận này bổ sung cho hệ thống chẩn đoán của DSM và ICD, cung cấp một cái nhìn sâu sắc và đa chiều hơn về bản chất phức tạp của các Rối loạn lo âu.

Đề tài nghiên cứu tập trung ba dạng rối loạn lo âu chủ yếu được xác định trong hệ thống phân loại DSM-V bao gồm: *Rối loạn lo âu chia ly*, *Rối loạn lo âu xã hội*, và *Rối loạn lo âu lan tỏa*. Mỗi rối loạn này đại diện cho một biểu hiện đặc thù của quá trình lo âu bệnh lý, với những đặc điểm lâm sàng, cơ chế nhận thức - hành vi, và hệ quả chức năng khác biệt nhưng cũng có sự giao thoa nhất định. Sự lựa chọn ba rối loạn này nhằm mục tiêu khám phá sâu hơn về các yếu tố nguy cơ, biểu hiện triệu chứng và tác động lên chức năng tâm lý-xã hội ở đối tượng nghiên cứu, đồng thời cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dựng các can thiệp tâm lý chuyên biệt và có căn cứ thực nghiệm.

1.2.3. Biểu hiện của rối loạn lo âu

1.2.3.1 Rối loạn lo âu lan tỏa

Về mặt triệu chứng, Rối loạn lo âu lan tỏa thường bao gồm các nhóm biểu hiện như: Căng thẳng thần kinh cơ (ví dụ: bồn chồn), Tăng hoạt động hệ thần kinh tự động (ví dụ: đổ mồ hôi, chóng mặt, tim đập nhanh), Dự đoán lo âu (ví dụ: lo lắng, sợ hãi), và Tăng cảnh giác và dò xét môi trường (ví dụ: khó tập trung, cáu gắt). Tuy nhiên, các bằng chứng sau này (Barlow & Di Nardo, 1991) chỉ ra rằng một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân đến khám tại các phòng khám lo âu mô tả triệu chứng lo âu kéo dài và căng thẳng do lo nghĩ, không liên quan đến các rối loạn cảm xúc khác (chẳng hạn như lo lắng về tài chính, công việc, hoặc các chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày). Do đó, tiêu chí chẩn đoán GAD đã được sửa đổi đáng kể trong bản DSM-III-R (APA, 1987):

- Tiêu chí chính được xác định là lo âu quá mức và/hoặc phi thực tế ở ít nhất hai lĩnh vực không liên quan đến các rối loạn khác thuộc trục I.

- Các triệu chứng đi kèm phải bao gồm ít nhất 6 biểu hiện trong danh sách 18 triệu chứng, được chia thành 3 nhóm: căng cơ, tăng hoạt động thần kinh tự động, và tăng cảnh giác.
- Thời gian tối thiểu để chẩn đoán được kéo dài từ 1 tháng lên 6 tháng, nhằm phân biệt GAD với phản ứng tạm thời trước các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống (ví dụ: rối loạn thích nghi).
- GAD không còn bị xem là một chẩn đoán “dư thừa” hay phụ nữa.

Sau đó, đến DSM-IV (1994), các tiêu chí cho GAD tiếp tục được sửa đổi để dễ sử dụng hơn và tập trung vào quá trình lo âu mang tính dự đoán. Trong phiên bản này, GAD được xác định bởi đặc điểm cốt lõi là lo âu quá mức và khó kiểm soát về nhiều sự kiện/hoạt động trong đời sống, kèm theo ít nhất ba trong sáu triệu chứng đi kèm thuộc nhóm ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực hoặc căng thẳng. Điều quan trọng là lo âu phải được người bệnh nhận thức là khó kiểm soát, và mức độ, tần suất, thời gian lo âu phải vượt quá mức hợp lý so với khả năng xảy ra hoặc mức độ ảnh hưởng thực tế của sự kiện gây lo âu. Các nghiên cứu so sánh bệnh nhân GAD và nhóm đối chứng cho thấy không có khác biệt đáng kể về nội dung nỗi lo, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về mức độ kiểm soát nỗi lo, thời lượng lo mỗi ngày, tần suất lo không có nguyên nhân rõ ràng, và số lượng lĩnh vực lo âu. Điều này củng cố cho sự thay đổi định nghĩa của GAD trong DSM-IV (APA, 1994).

a. Lo âu và lo lắng quá mức (kỳ vọng lo âu), xảy ra trong hầu hết các ngày, kéo dài ít nhất 6 tháng, về nhiều sự kiện hoặc hoạt động khác nhau (như hiệu suất học tập hoặc công việc).

b. Người bệnh cảm thấy khó kiểm soát được sự lo lắng.

c. Lo âu và lo lắng đi kèm với ít nhất ba (hoặc nhiều hơn) trong số sáu triệu chứng sau (ít nhất một số triệu chứng xuất hiện trong hầu hết các ngày của 6 tháng gần nhất).

Lưu ý: Trẻ em chỉ cần một triệu chứng.

- Bồn chồn hoặc cảm giác bị kích thích, căng thẳng
- Dễ mệt mỏi
- Khó tập trung hoặc đầu óc trống rỗng
- Cáu gắt
- Căng cơ
- Rối loạn giấc ngủ (khó ngủ, ngủ không sâu, hoặc ngủ không thỏa mãn)

d. Trọng tâm của lo âu không chỉ giới hạn ở các đặc điểm của các rối loạn trục I khác, ví dụ: không phải lo âu về cơn hoảng loạn (như trong rối loạn hoảng sợ), sợ bị bề mặt (rối loạn lo âu xã hội), lo bị nhiễm bệnh (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), xa cách người thân (Rối loạn lo âu chia ly), tăng cân (biếng ăn tâm thần), các triệu chứng cơ thể (rối loạn phân ly), hoặc bệnh tật nghiêm trọng (rối loạn nghi bệnh).

e. Lo âu, lo lắng, hoặc các triệu chứng cơ thể gây ra đau khổ rõ rệt về mặt lâm sàng hoặc làm suy giảm chức năng trong xã hội, công việc, hoặc các lĩnh vực quan trọng khác.

f. Rối loạn không phải do ảnh hưởng sinh lý trực tiếp của chất (thuốc, chất gây nghiện) hoặc tình trạng y tế chung (ví dụ: cường giáp), và không xảy ra duy nhất trong rối loạn khí sắc, loạn thần hoặc rối loạn phát triển lan tỏa.

DSM-IV giảm số lượng triệu chứng cần thiết từ 18 còn 6, giữ lại các triệu chứng từ nhóm căng cơ và tăng cảnh giác, loại bỏ phần lớn nhóm tăng hoạt động thần kinh tự động (như tim đập nhanh, khó thở), vì ít được bệnh nhân GAD báo cáo. Các triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân GAD bao gồm: cáu gắt, bồn chồn, căng cơ, dễ mệt, khó ngủ và khó tập trung. Các nghiên cứu sau này cũng cho thấy GAD đặc trưng bởi trạng thái lo âu lan tỏa, kéo dài và khó kiểm soát, khác với các rối loạn lo âu khác như rối loạn hoảng sợ vốn liên quan nhiều hơn đến các phản ứng sinh lý cấp tính (Beesdo et al., 2010).

1.2.3.2 Rối loạn lo âu xã hội

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lo âu xã hội theo DSM-IV (APA, 1994):

- Có nỗi sợ rõ rệt và dai dẳng đối với một hoặc nhiều tình huống xã hội hoặc tình huống biểu hiện trước người khác, khi phải tiếp xúc với người lạ hoặc có khả năng bị người khác đánh giá soi xét.
- Cá nhân sợ rằng mình sẽ hành xử theo cách nào đó (hoặc thể hiện các triệu chứng lo âu) gây xấu hổ hoặc nhục nhã.
- Tiếp xúc với tình huống gây sợ hãi gần như luôn khiến người đó lo âu, có thể biểu hiện dưới dạng cơn hoảng loạn.
- Cá nhân nhận thức được rằng nỗi sợ của mình là thái quá hoặc phi lý.
- Các tình huống xã hội hoặc biểu hiện bị sợ hãi đó được tránh né hoặc chịu đựng với mức độ lo âu và đau khổ rất cao.
- Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt thường ngày, công việc (hoặc học tập), các hoạt động xã hội hoặc các mối quan hệ, hoặc gây căng thẳng rõ rệt liên quan đến ám ảnh này.

- Nỗi sợ hoặc hành vi né tránh không phải do tác động sinh lý trực tiếp của một chất (ví dụ: thuốc hoặc chất gây nghiện) hoặc một tình trạng y khoa nói chung, và không được giải thích tốt hơn bởi một rối loạn tâm thần khác.
- Nếu có một tình trạng y khoa hoặc rối loạn tâm thần khác kèm theo, nỗi sợ xã hội hoặc sợ biểu hiện không liên quan trực tiếp đến tình trạng đó (ví dụ: nỗi sợ run rẩy không phải do bệnh Parkinson).
- Chỉ định là thể lan tỏa nếu các nỗi sợ bao gồm phần lớn các tình huống xã hội.

1.2.3.3. Rối loạn lo âu chia ly

Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, phiên bản 4 (**DSM-IV**) giới hạn chẩn đoán SeAD cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, trong DSM-5, chẩn đoán đã được mở rộng để bao gồm cả người lớn được chẩn đoán mắc SeAD lần đầu tiên ở tuổi trưởng thành (Feriante et al, 2023). Để đưa ra chẩn đoán chính thức, cần tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5-TR áp dụng. Tiêu chuẩn Rối loạn lo âu chia ly DSM-5-TR:

a. Lo lắng quá mức và không phù hợp về mặt phát triển khi bị tách khỏi người mà mình gắn bó, được chứng minh bằng ít nhất 3 trong số các dấu hiệu sau:

- Đau khổ quá mức tái diễn khi thực sự hoặc dự đoán sẽ xa nhà hoặc người gắn bó.
- Lo lắng dai dẳng và lan rộng về việc mất đi người gắn bó hoặc những tổn hại có thể xảy ra với họ, chẳng hạn như bệnh tật, thương tích, thảm họa hoặc tử vong
- Lo lắng dai dẳng và lan rộng rằng bệnh nhân có thể gặp phải một sự kiện bất trắc và dẫn đến sự xa cách kéo dài hoặc vĩnh viễn
- Không muốn hoặc từ chối ra ngoài, chẳng hạn như đi học hoặc đi làm, vì sợ bị chia cắt
- Từ chối ở một mình tại nhà hoặc ở những nơi khác
- Từ chối ngủ nếu không ở gần người gắn bó
- Những cơn ác mộng liên tục về sự chia ly
- Các triệu chứng vật lý lặp lại khi sự tách biệt xảy ra hoặc được dự đoán (Bögels SM et al, 2013)

b. Các triệu chứng phải kéo dài ít nhất 4 tuần ở trẻ em và thanh thiếu niên nhưng thường kéo dài trong 6 tháng hoặc hơn ở người lớn.

c. Rối loạn này gây ra suy giảm đáng kể về mặt lâm sàng đối với chức năng chính của cuộc sống (ví dụ như chức năng học tập hoặc nghề nghiệp).

d. Các triệu chứng này không thể được giải thích tốt hơn bằng tình trạng tâm thần khác.

Tóm lại

Tổng hợp các tiêu chuẩn chẩn đoán hiện hành và các phát hiện thực nghiệm cho thấy, ba loại rối loạn lo âu chính: Rối loạn lo âu lan tỏa, Rối loạn lo âu xã hội và Rối loạn lo âu chia ly đều biểu hiện bằng sự lo âu quá mức, dai dẳng và khó kiểm soát, song khác biệt về nội dung lo âu trung tâm, bối cảnh khởi phát và đặc điểm biểu hiện.

Rối loạn lo âu lan tỏa (GAD) nổi bật bởi đặc điểm lo âu lan tỏa, khó kiểm soát về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày, kèm theo các biểu hiện về căng cơ, dễ mệt, khó ngủ và giảm tập trung. Lo âu trong GAD thường mang tính dự đoán và diễn ra gần như liên tục trong thời gian kéo dài, dẫn đến sự suy giảm đáng kể về chức năng xã hội và nghề nghiệp.

Rối loạn lo âu xã hội (SAD) lại đặc trưng bởi nỗi sợ mãnh liệt khi bị người khác quan sát, đánh giá trong các tình huống xã hội hoặc biểu hiện. Bệnh nhân SAD thường tránh né hoặc chịu đựng các tình huống này với mức độ lo âu rất cao, đi kèm với các phản ứng sinh lý như đỏ mặt, run tay, hoặc cảm giác buồn nôn. Dạng lan tỏa biểu hiện qua sợ hãi trong hầu hết các tình huống xã hội và có liên quan mật thiết đến sự tự ti và lo sợ bị chỉ trích.

Rối loạn lo âu chia ly trước đây chỉ áp dụng cho trẻ em, nay đã được mở rộng cho cả người lớn trong DSM-5. Rối loạn này thể hiện qua nỗi sợ dai dẳng, không phù hợp với giai đoạn phát triển, khi phải xa rời người gần bó, thường đi kèm các biểu hiện như từ chối rời khỏi nhà, ác mộng, hoặc triệu chứng cơ thể khi tách biệt xảy ra. Biểu hiện rối loạn này có thể kéo dài nhiều tháng, đặc biệt ở người trưởng thành, và gây ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng học tập, công việc và các quan hệ xã hội.

Mặc dù có một số đặc điểm tương đồng về triệu chứng giữa ba rối loạn (như mức độ lo âu cao, khó kiểm soát, và tránh né) nhưng việc xác định mức độ rối loạn dựa trên số lượng, cường độ, tần suất và thời gian của triệu chứng, cũng như mức độ ảnh hưởng đến chức năng cá nhân- xã hội, là yếu tố quyết định trong phân tầng can thiệp, từ hỗ trợ tâm lý giáo dục, can thiệp hành vi- nhận thức đến điều trị phối hợp thuốc trong các trường hợp nặng. Nhận diện rõ mẫu biểu hiện của từng rối loạn là cơ sở khoa học thiết yếu để thiết kế chương trình phòng ngừa, sàng lọc và trị liệu có mục tiêu.

1.2.4. Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

1.2.4.1. Học sinh trung học cơ sở

Giai đoạn trung học cơ sở (THCS), tương ứng với thời kỳ đầu của tuổi vị thành niên, là một trong những giai đoạn phát triển năng động và phức tạp nhất trong vòng đời con người. Đây không chỉ là một quá trình chuyển tiếp đơn thuần từ trẻ em sang người lớn mà là một cuộc tái cấu trúc sâu sắc trên cả hai phương diện sinh lý và tâm lý. Các nghiên cứu khoa học hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thần kinh và tâm lý học phát triển, đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự tương tác mật thiết giữa những thay đổi của não bộ, sự bùng nổ của hormone và sự hình thành bản sắc cá nhân. Bài luận này sẽ tổng hợp và phân tích các đặc điểm tâm-sinh lý cốt lõi của học sinh lứa tuổi THCS dựa trên các bằng chứng khoa học cập nhật nhất.

Nền tảng của những thay đổi tâm lý ở tuổi THCS chính là những biến đổi sinh học mạnh mẽ, bao gồm sự phát triển vượt bậc của tuổi dậy thì và một quá trình tái tổ chức não bộ mang tính quyết định.

a/ Sự bùng nổ của tuổi dậy thì

Tuổi dậy thì được khởi động bởi sự kích hoạt của trục Dưới đồi - Tuyến yên - Tuyến sinh dục (HPG axis), dẫn đến việc sản xuất hàng loạt các hormone giới tính (Sisk & Foster, 2004). Quá trình này gây ra những thay đổi thể chất rõ rệt, từ sự tăng trưởng nhanh về chiều cao, cân nặng cho đến sự phát triển của các đặc điểm giới tính phụ. Bên cạnh đó, các biến động hormone này còn tác động trực tiếp đến nhịp điệu sinh học của cơ thể. Các nghiên cứu của Carskadon (2011) đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng có một sự trì hoãn pha sinh học trong chu kỳ ngủ-thức của thanh thiếu niên, khiến các em có xu hướng tự nhiên là thức khuya và dậy muộn hơn.

b/ Tái cấu trúc não bộ

Song song với sự thay đổi của cơ thể, não bộ của học sinh THCS cũng trải qua một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng. Một trong những phát hiện có ảnh hưởng lớn nhất trong khoa học thần kinh vị thành niên là sự phát triển không đồng bộ giữa các vùng não (Casey et al., 2008). Hệ viền, trung tâm xử lý cảm xúc và phần thưởng, phát triển nhanh và trở nên cực kỳ nhạy cảm trong giai đoạn này. Ngược lại, vỏ não trước trán, khu vực chịu trách nhiệm về chức năng điều hành như kiểm soát xung động, lập kế hoạch và ra quyết định hợp lý, lại phát triển chậm hơn và chỉ hoàn thiện hoàn toàn vào giữa những năm 20 tuổi (Steinberg, 2005).

Sự "lệch pha" này tạo ra một "cửa sổ cơ hội" cho các hành vi bốc đồng, tìm kiếm sự mới lạ, mạo hiểm và sự nhạy cảm cao độ với các kích thích xã hội, đặc biệt là từ bạn bè đồng trang lứa. Đồng thời, não bộ cũng tiến hành quá trình "cắt tía synap" loại bỏ các kết nối thần kinh không cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, định hình nền tảng thần kinh cho các kỹ năng và tri thức trong tương lai (Blakemore & Choudhury, 2006).

Những thay đổi về sinh lý và thần kinh đã tạo ra một đời sống tâm lý vô cùng phong phú, đặc trưng bởi sự phát triển nhận thức, quá trình tìm kiếm bản sắc và sự thay đổi trong các mối quan hệ xã hội.

c/ Bước nhảy vọt về nhận thức

Theo lý thuyết kinh điển của Piaget, lứa tuổi này bước vào giai đoạn tư duy hình thức, cho phép các em suy nghĩ một cách trừu tượng, logic và giả định (Santrock, 2021). Các em có thể lập luận về các vấn đề phức tạp, hình thành lý tưởng và nhìn nhận một vấn đề từ nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển nhận thức này cũng đi kèm với một dạng thức mới của "tính vị kỷ". Elkind (1967) đã mô tả hai khía cạnh nổi bật: "khán giả tưởng tượng" tức là niềm tin rằng mình luôn là trung tâm của sự chú ý và phán xét; và "huyền thoại cá nhân" cảm giác rằng trải nghiệm của mình là độc nhất và mình là người bất khả xâm phạm.

d/ Cuộc khủng hoảng bản sắc và tầm quan trọng của quan hệ bạn bè

Đây là giai đoạn trung tâm của cuộc khủng hoảng tâm lý xã hội "Bản sắc và sự mơ hồ vai trò" theo lý thuyết của Erikson (1968). Câu hỏi "Tôi là ai?" trở thành nỗi trăn trở cốt lõi. Trong hành trình này, nhóm bạn đồng trang lứa đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các mối quan hệ chuyển dịch từ phụ thuộc vào gia đình sang gắn bó mật thiết với bạn bè (Brown & Larson, 2009). Nhu cầu được chấp nhận và thuộc về một nhóm bạn trở thành động lực chính, chi phối mạnh mẽ các lựa chọn, hành vi và cảm xúc của các em. Đồng thời, quá trình tìm kiếm sự tự chủ cũng tất yếu dẫn đến những xung đột gia tăng với cha mẹ, vốn là một phần lành mạnh của quá trình trưởng thành (Smetana, 2011).

e/ Đời sống cảm xúc

Sự kết hợp giữa hệ viền nhạy cảm và vỏ não trước trán chưa trưởng thành khiến đời sống cảm xúc của học sinh THCS trở nên mãnh liệt, đa dạng nhưng cũng thiếu ổn định. Các em trải nghiệm cảm xúc ở mức độ cao hơn và gặp khó khăn hơn trong việc tự điều tiết so với người lớn (Casey et al., 2008). Điều này lý giải cho những thay đổi tâm trạng đột ngột và các phản ứng cảm xúc có vẻ "thái quá" thường thấy ở lứa tuổi này.

Tóm lại, lứa tuổi trung học cơ sở là một giai đoạn định hình quan trọng, được kiến tạo bởi sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố sinh học và tâm lý- xã hội. Sự hiểu biết về nền tảng thần kinh của hành vi, sự phát triển nhận thức và các nhu cầu tâm lý xã hội không chỉ giúp giải mã những hành vi khó hiểu của các em mà còn là chìa khóa để gia đình, nhà trường và xã hội có thể đồng hành, hỗ trợ một cách hiệu quả nhất, giúp các em vượt qua giai đoạn "bão táp" để hướng tới sự trưởng thành một cách lành mạnh.

1.2.4.2. Sức khỏe tâm lý của học sinh trung học cơ sở

Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn thường phân loại nhóm tuổi này là "vị thành niên" và thường tập trung vào các khoảng tuổi chồng lấn với bậc học này. Ví dụ, các nghiên cứu tại Hoa Kỳ khảo sát nhóm tuổi từ 12-17 (Mojtabai et al., 2016; Twenge et al., 2019) hoặc 13-18 (Merikangas et al., 2010), bao trọn đối tượng học sinh cơ sở. Các phân tích gánh nặng bệnh tật toàn cầu xem xét một khoảng rộng hơn là người trẻ từ 10-24 tuổi, trong đó giai đoạn học sinh cơ sở là một phần cốt lõi và dễ bị tổn thương nhất (Gore et al., 2011).

Giai đoạn học sinh cơ sở được các nghiên cứu xác định là một "cửa sổ nguy cơ" quan trọng cho sự khởi phát của phần lớn các rối loạn tâm lý. Nghiên cứu nền tảng của Kessler và cộng sự (2005) chỉ ra rằng 50% tổng số các rối loạn tâm lý trong đời khởi phát trước 14 tuổi, độ tuổi trung tâm của bậc học này. Cụ thể hơn, tuổi khởi phát trung vị của các rối loạn lo âu và rối loạn xung động là 11 tuổi. Điều này định nghĩa học sinh cơ sở không chỉ là một nhóm nhân khẩu học trong hệ thống giáo dục mà còn là một nhóm dân số có nguy cơ cao về mặt lâm sàng, đòi hỏi sự chú trọng đặc biệt vào phòng ngừa và can thiệp sớm.

Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự chuyển đổi lớn về môi trường học đường và xã hội, từ bậc tiểu học lên một bậc học có yêu cầu cao hơn. Các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần trong bối cảnh học đường thường nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường này đối với sự phát triển của học sinh. Ví dụ, báo cáo của Úc xem xét sức khỏe tâm thần của trẻ em và vị thành niên đến 17 tuổi, nhấn mạnh vai trò của trường học như một nơi quan trọng để tìm kiếm sự giúp đỡ (Lawrence et al., 2015). Gần đây hơn, tác động của các sự kiện toàn cầu như đại dịch COVID-19 cho thấy nhóm vị thành niên (bao gồm học sinh cơ sở) đặc biệt nhạy cảm với những gián đoạn trong học tập và tương tác xã hội, dẫn đến tỷ lệ các triệu chứng trầm cảm và lo âu tăng gấp đôi (Racine et al., 2021).

Tóm lại, từ góc độ khoa học quốc tế, "học sinh cơ sở" được định nghĩa là nhóm nhân khẩu học trong giai đoạn vị thành niên sớm và giữa, một thời kỳ chuyển tiếp đầy biến động về sinh học, tâm lý và xã hội, đồng thời là giai đoạn có nguy cơ cao nhất cho sự khởi phát của các vấn đề sức khỏe tâm thần.

1.2.4.3. Học sinh trung học cơ sở và Rối loạn lo âu

a/ Liên quan đến Rối loạn lo âu lan tỏa (GAD)

- *Biến động Hormone*: Sự tăng giảm đột ngột của các hormone giới tính ảnh hưởng trực tiếp đến các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ như serotonin và dopamine, vốn có vai trò điều chỉnh tâm trạng. Sự mất cân bằng này có thể khiến học sinh cảm thấy bất an, cáu kỉnh và dễ lo lắng hơn về mọi thứ xung quanh.

- *Rối loạn giấc ngủ*: Thay đổi sinh học trong giai đoạn dậy thì thường làm thay đổi chu kỳ ngủ-thức (thức khuya hơn, dậy muộn hơn). Thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn làm giảm khả năng điều chỉnh cảm xúc và tăng mức độ lo âu tổng thể.

- *Phát triển tư duy trừu tượng*: Học sinh THCS bắt đầu có khả năng suy nghĩ về tương lai, các vấn đề giả định và các kịch bản "nếu-thì". Đặc điểm này, khi kết hợp với xu hướng lo lắng, có thể dẫn đến việc các em liên tục suy diễn về những kết quả tiêu cực có thể xảy ra trong học tập, các mối quan hệ, hoặc các vấn đề của gia đình. Đây chính là cốt lõi của GAD - sự lo lắng quá mức và khó kiểm soát về nhiều sự kiện, hoạt động.

- *Áp lực học tập và định hướng tương lai*: Gánh nặng từ điểm số, các kỳ thi chuyên cấp, và những kỳ vọng từ gia đình bắt đầu gia tăng. Áp lực này trở thành nguồn "nhiên liệu" dồi dào cho những lo lắng lan tỏa, không chỉ giới hạn trong việc học mà còn mở rộng ra các khía cạnh khác của cuộc sống.

b/ Liên quan đến Rối loạn lo âu xã hội

- *Thay đổi ngoại hình*: Dậy thì mang đến những thay đổi rõ rệt về cơ thể (chiều cao, cân nặng, mụn trứng cá, phát triển các đặc điểm giới tính phụ). Sự lúng túng, tự ti về ngoại hình không đồng đều hoặc khác biệt so với bạn bè có thể khiến các em cảm thấy mình đang bị "soi mói", làm gia tăng nỗi sợ bị đánh giá tiêu cực trong các bối cảnh xã hội.

- *Phản ứng cơ thể mạnh mẽ*: Hệ thần kinh giao cảm của thanh thiếu niên rất nhạy cảm. Khi lo lắng, các em dễ gặp phải các triệu chứng thể chất rõ rệt như tim đập nhanh,

đỏ mặt, run rẩy, đổ mồ hôi. Chính nỗi sợ những phản ứng này sẽ bị người khác phát hiện lại càng làm cho sự Rối loạn lo âu xã hội trở nên tồi tệ hơn.

- *Sự hình thành "Cái tôi" và nhạy cảm với sự đánh giá*: Đây là giai đoạn các em cực kỳ quan tâm đến hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Nỗi sợ bị chê bai, phán xét, hoặc làm điều gì đó ngớ ngẩn trước mặt bạn bè là rất lớn. Điều này tạo ra một môi trường hoàn hảo cho Rối loạn lo âu xã hội phát triển, biểu hiện qua việc sợ phát biểu trước lớp, sợ tham gia các hoạt động nhóm, hoặc né tránh các tương tác xã hội.

- *Tầm quan trọng của nhóm bạn*: Bạn bè trở thành trung tâm trong thế giới của học sinh THCS. Nhu cầu được chấp nhận và thuộc về một nhóm là rất cao. Nỗi sợ bị từ chối, cô lập, hoặc trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường có thể gây ra sự lo lắng tột độ trong các tình huống xã hội.

c/ Liên quan đến rối loạn lo âu chia ly

- *Triệu chứng cơ thể hóa*: Khi lo lắng về việc phải xa cách cha mẹ, học sinh THCS có thể biểu hiện các triệu chứng thực thể như đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Những triệu chứng này thường xuất hiện trước khi đến trường hoặc khi cha mẹ chuẩn bị đi xa, và chúng có cơ sở sinh lý rõ ràng do stress gây ra, không phải là giả vờ. Đây là một cách cơ thể "báo động" về nỗi sợ chia ly.

- *Mâu thuẫn giữa nhu cầu tự lập và gắn bó*: Dù học sinh THCS đang trong quá trình muốn khẳng định sự độc lập, tách khỏi cha mẹ, nhưng sâu bên trong, các em vẫn còn rất cần sự an toàn và hỗ trợ từ gia đình. Sự mâu thuẫn này có thể làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi khi phải xa cách người thân. Rối loạn lo âu chia ly ở lứa tuổi này có thể không biểu hiện bằng việc "bám dính" như trẻ nhỏ, mà qua việc lo lắng quá mức cho sự an toàn của cha mẹ, không muốn đi học xa, hoặc từ chối tham gia các chuyến đi dã ngoại qua đêm.

Tóm lại, sự giao thoa giữa những biến đổi tâm lý phức tạp và các thay đổi sinh lý mạnh mẽ trong giai đoạn THCS tạo ra một cửa sổ cơ hội cho các rối loạn lo âu khởi phát hoặc trở nên trầm trọng hơn. Việc nhận biết sớm những mối liên hệ này là rất quan trọng để có thể hỗ trợ các em một cách kịp thời.

1.2.4.4. Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở được các nhà nghiên cứu định nghĩa dưới nhiều góc độ khác nhau, phản ánh sự phức tạp của vấn đề này.

Theo nghiên cứu của Essau và cộng sự (2012), rối loạn lo âu ở lứa tuổi học sinh THCS được coi là "một trạng thái cảm xúc tiêu cực kéo dài, đặc trưng bởi sự lo lắng quá

mức và liên tục về các sự kiện trong tương lai, đi kèm với các triệu chứng sinh lý và hành vi như khó ngủ, mệt mỏi và tránh né các tình huống gây lo lắng" (Essau et al., 2012). Nghiên cứu của Hale và cộng sự (2018) lại nhấn mạnh ở góc độ nhận thức ở những học sinh có rối loạn lo âu, cho rằng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở là "mô hình tư duy sai lệch, trong đó các em có xu hướng đánh giá quá cao mối đe dọa từ các tình huống xã hội và học thuật, đồng thời đánh giá thấp khả năng đối phó của bản thân" (Hale et al., 2018). Nghiên cứu của Costello, Egger và Angold (2005) tiếp cận khái niệm rối loạn lo âu từ góc độ dịch tễ học lâm sàng, coi rối loạn lo âu là "một nhóm các chẩn đoán tâm thần được đặc trưng bởi nỗi sợ hãi và lo lắng quá mức, gây ra những suy giảm đáng kể về chức năng học tập, xã hội và gia đình (Costello, Egger & Angold, 2005). Nghiên cứu của Pine và Klein (2010) thì mô tả rối loạn lo âu ở lứa tuổi trung học cơ sở là "một trạng thái tâm sinh lý, trong đó sự mất cân bằng trong hệ thống thần kinh và cảm xúc dẫn đến các phản ứng sợ hãi không phù hợp với mức độ nguy hiểm của tình huống, làm ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh cảm xúc của học sinh" (Pine & Klein, 2010). Nghiên cứu của Merikangas và cộng sự (2010) định nghĩa rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở là "một phổ các biểu hiện, từ những lo lắng thoáng qua, có thể kiểm soát được, đến những nỗi sợ hãi tột độ, có thể dẫn đến các hành vi tránh né nghiêm trọng và hạn chế khả năng tham gia vào các hoạt động hàng ngày" (Merikangas et al., 2010).

Trên cơ sở các phân tích đi trước nêu trên, và các nghiên cứu trong cơ sở lý luận của đề tài, có thể đưa ra khái niệm về rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở để sử dụng trong phạm vi đề tài này như sau:

Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở là *trạng thái tâm lý bất thường, mất cân bằng trong cảm xúc, bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng, phản ứng sợ hãi không phù hợp với mức độ nguy hiểm của tình huống và rối loạn hành vi liên quan, đi kèm với các biểu hiện sinh lý, kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng học tập, chất lượng cuộc sống của học sinh.*

1.2.4.5. Biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

Một số nghiên cứu đi trước đã mô tả về các biểu hiện của rối loạn lo âu ở lứa tuổi học sinh THCS, các mặt biểu hiện rất đa dạng, bao gồm các triệu chứng về mặt cảm xúc, thể chất, nhận thức và hành vi.

Nghiên cứu của Costello và cộng sự (2005) chỉ ra các biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh THCS bao gồm sự lo lắng quá mức và dai dẳng về các sự kiện trong tương lai,

kèm theo các dấu hiệu thể chất như đau đầu, đau bụng, buồn nôn, và đổ mồ hôi (Costello et al., 2005). Nghiên cứu của Essau và cộng sự (2012) cho rằng các biểu hiện nổi bật của rối loạn lo âu ở học sinh THCS thể hiện ở các hành vi: né tránh các tình huống gây lo âu, chẳng hạn như không muốn đến trường, từ chối tham gia các hoạt động xã hội hoặc thuyết trình trước lớp (Essau et al., 2012). Nghiên cứu của Hale và cộng sự (2018) chỉ ra rằng, biểu hiện lo âu ở lứa tuổi này bao gồm những suy nghĩ tiêu cực, tự chỉ trích, và lo sợ thất bại. Các em thường xuyên đánh giá thấp khả năng của bản thân và phóng đại mức độ nguy hiểm của các tình huống (Hale et al., 2018). Trong một nghiên cứu khác, Merikangas và cộng sự (2010) đã mô tả biểu hiện lo âu như một phổ các triệu chứng, từ những nỗi sợ hãi cụ thể (ví dụ: sợ nói chuyện trước đám đông) đến những cơn hoảng loạn đột ngột và dữ dội. Nghiên cứu này cũng ghi nhận sự đi kèm của các rối loạn tâm thần khác, như trầm cảm, làm phức tạp thêm các biểu hiện của lo âu (Merikangas et al., 2010). Nghiên cứu của Jenkins và cộng sự (2023) cho thấy các biểu hiện của rối loạn lo âu thay đổi theo giới tính và môi trường xã hội, với các nữ sinh thường có biểu hiện lo âu nội tâm hóa hơn, trong khi các nam sinh có thể thể hiện ra ngoài bằng sự cáu gắt, dễ bị kích động (Jenkins et al., 2023).

Trên cơ sở các nghiên cứu đi trước, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi xem xét biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh THCS dựa trên các thang đo, trắc nghiệm đi trước đã được khẳng định giá trị thực tiễn, bao gồm: thang đo rối loạn lo âu lan tỏa DASS A, thang đo rối loạn lo âu lan tỏa DSMV, thang đo rối loạn lo âu xã hội DSMV và thang đo rối loạn lo âu chia ly DSMV. Ngoài ra, trên cơ sở các nghiên cứu đi trước, thang đo Rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS được xây dựng để sử dụng trong nghiên cứu này, trong đó tập trung vào các biểu hiện của rối loạn lo âu trên các mặt tâm lý và sinh lý.

1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở

1.2.5.1. Yếu tố chủ quan

Các yếu tố chủ quan, bao gồm những đặc điểm tâm lý, sinh lý cá nhân của học sinh, giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển rối loạn lo âu ở lứa tuổi trung học cơ sở.

- **Đặc điểm sinh lý lứa tuổi** là nền tảng quan trọng chi phối các quá trình tâm lý và hành vi của học sinh. Giai đoạn 11-14 tuổi tương ứng với thời kỳ dậy thì sớm, khi hệ nội tiết hoạt động mạnh, đặc biệt là sự gia tăng hormone sinh dục, dẫn đến những biến đổi nhanh chóng về thể chất và trạng thái cơ thể. Những thay đổi này thường diễn ra

không đồng đều giữa các cá nhân, dễ gây ra cảm giác thiếu ổn định và làm gia tăng nhạy cảm cảm xúc. Ở cấp độ thần kinh- sinh học, não bộ đang trong quá trình tái cấu trúc với sự phát triển không đồng bộ giữa hệ viền và vỏ não trước trán. Hệ viền, đặc biệt là hạch hạnh nhân - trung tâm xử lý cảm xúc, phát triển nhanh và phản ứng mạnh với các kích thích, trong khi vỏ não trước trán chịu trách nhiệm kiểm soát hành vi và điều chỉnh cảm xúc phát triển chậm hơn (Casey et al., 2008). Sự mất cân bằng này khiến học sinh dễ rơi vào trạng thái phản ứng cảm xúc mạnh, bốc đồng nhưng hạn chế về khả năng kiểm soát và điều tiết, từ đó làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biểu hiện lo âu. Đồng thời, hệ thần kinh tự chủ ở lứa tuổi này cũng nhạy cảm hơn, khiến các phản ứng sinh lý như tim đập nhanh, căng cơ, rối loạn giấc ngủ dễ xuất hiện khi gặp stress, góp phần hình thành các triệu chứng rối loạn lo âu mang tính cơ thể.

- Trên nền tảng sinh lý đó, **các đặc điểm nhận thức và xử lý thông tin** tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Học sinh THCS có xu hướng diễn giải các tình huống theo hướng tiêu cực, phóng đại nguy cơ và đánh giá thấp khả năng đối phó của bản thân, từ đó làm gia tăng lo âu lan tỏa (Beesdo-Baum et al., 2022). Sự phát triển của tư duy trừu tượng giúp các em có khả năng suy nghĩ về tương lai, nhưng đồng thời cũng làm tăng xu hướng lo lắng nếu thiếu định hướng phù hợp. Bên cạnh đó, mức độ tự ý thức cao và sự nhạy cảm với đánh giá xã hội khiến học sinh dễ hình thành lo âu xã hội, đặc biệt ở những em có xu hướng tự đánh giá tiêu cực (La Greca & Harrison, 2021).

- **Về mặt cảm xúc**, học sinh ở lứa tuổi này thường có mức độ phản ứng cảm xúc cao nhưng khả năng điều chỉnh còn hạn chế, do sự chưa hoàn thiện của các cơ chế điều hành thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy khó khăn trong điều chỉnh cảm xúc có liên hệ chặt chẽ với mức độ lo âu cao hơn và nguy cơ kéo dài triệu chứng theo thời gian (Compas et al., 2020). Ngược lại, những học sinh có khả năng nhận diện và điều chỉnh cảm xúc hiệu quả có xu hướng thích ứng tốt hơn với rối loạn lo âu.

- Một yếu tố chủ quan quan trọng khác là **các chiến lược đối phó**. Ở lứa tuổi THCS, học sinh bắt đầu hình thành các cách thức đối phó với căng thẳng trong cuộc sống, nhưng các chiến lược này chưa ổn định và dễ bị chi phối bởi cảm xúc tức thời. Các nghiên cứu cho thấy các chiến lược đối phó né tránh như phủ nhận, rút lui hoặc tránh né tình huống có liên hệ thuận với mức độ rối loạn lo âu cao hơn, trong khi các chiến lược tích cực như giải quyết vấn đề và tìm kiếm hỗ trợ có vai trò bảo vệ (Myruski et al., 2024). Do

đó, đối phó không chỉ là đặc điểm cá nhân mà còn là cơ chế trung gian quan trọng giữa các vấn đề cuộc sống và rối loạn lo âu.

- Ngoài ra, **đặc điểm nhân cách và khí chất** cũng góp phần làm gia tăng hoặc giảm nguy cơ rối loạn lo âu. Những học sinh có xu hướng rối loạn lo âu tính cách cao, nhạy cảm với lo âu hoặc có khuynh hướng né tránh thường dễ phát triển các rối loạn lo âu hơn (Silverman et al., 2020). Bên cạnh đó, các đặc điểm như tự ti, cầu toàn hoặc hướng nội cũng liên quan đến rối loạn lo âu, đặc biệt là rối loạn lo âu xã hội. Sự khác biệt về giới tính cũng được ghi nhận, khi học sinh nữ thường có mức độ rối loạn lo âu cao hơn học sinh nam, có thể do sự khác biệt về sinh học và xã hội hóa (Racine et al., 2021).

Tại Việt Nam, các nghiên cứu bước đầu cũng cho thấy vai trò của các yếu tố chủ quan trong rối loạn lo âu ở học sinh. Học sinh có mức tự đánh giá thấp, kỹ năng đối phó hạn chế và khả năng điều chỉnh cảm xúc kém có nguy cơ cao hơn đối với các vấn đề rối loạn lo âu và stress học đường (Bộ Y tế, 2020).

Như vậy, các yếu tố chủ quan ở học sinh THCS bao gồm nền tảng sinh lý đặc thù của giai đoạn dậy thì, kết hợp với các đặc điểm nhận thức, cảm xúc, nhân cách và chiến lược đối phó. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến rối loạn lo âu mà còn đóng vai trò trung gian và điều tiết trong mối quan hệ giữa các tác động môi trường và sức khỏe tâm thần của học sinh.

1.2.5.2. Yếu tố khách quan

Bên cạnh các yếu tố chủ quan, các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống và học tập đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở. Theo quan điểm hệ sinh thái, sự phát triển tâm lý của học sinh chịu ảnh hưởng từ nhiều tầng môi trường khác nhau, bao gồm gia đình, nhà trường và bối cảnh xã hội rộng lớn (Bronfenbrenner, 1979). Ở lứa tuổi THCS, khi cá nhân còn phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh, các yếu tố khách quan này có thể trở thành nguồn gây căng thẳng kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lo âu.

- Trước hết, **áp lực học tập** được xem là một trong những yếu tố nguy cơ nổi bật nhất trong bối cảnh học đường. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy căng thẳng học tập có mối liên hệ chặt chẽ với các triệu chứng rối loạn lo âu và trầm cảm ở thanh thiếu niên (Stearns et al., 2023). Áp lực này có thể xuất phát từ khối lượng bài tập lớn, kỳ vọng thành tích cao và các kỳ thi chuyển cấp. Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận tình trạng học sinh phải đối mặt với áp lực học tập cao, trong đó căng thẳng học đường có liên

quan đáng kể đến các biểu hiện rối loạn lo âu và rối loạn cảm xúc (Nguyễn Công Khanh, 2017; Bộ Y tế, 2020). Điều này cho thấy môi trường học tập có thể trở thành nguồn rối loạn lo âu.

- Thứ hai, **mối quan hệ bạn bè và trải nghiệm bắt nạt học đường** là yếu tố khách quan có ảnh hưởng mạnh đến rối loạn lo âu, đặc biệt là rối loạn lo âu xã hội. Các nghiên cứu gần đây cho thấy học sinh bị bắt nạt có nguy cơ cao hơn đáng kể đối với các rối loạn lo âu, đồng thời mối quan hệ này có thể mang tính hai chiều, khi lo âu cũng làm tăng khả năng trở thành nạn nhân (Deng et al., 2024). Trong bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu về bắt nạt học đường cho thấy tỷ lệ học sinh trải nghiệm bắt nạt không thấp và có liên hệ với các vấn đề sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn lo âu và stress (Nguyễn Thị Hồng Thuận, 2018). Điều này phản ánh vai trò quan trọng của môi trường xã hội ngang hàng trong sự phát triển tâm lý của học sinh.

- Thứ ba, **môi trường gia đình và mức độ hỗ trợ xã hội** là yếu tố bảo vệ quan trọng đối với rối loạn lo âu. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy hỗ trợ xã hội từ gia đình và bạn bè có mối liên hệ nghịch với mức độ rối loạn lo âu và có thể làm giảm tác động tiêu cực của rối loạn lo âu (Fitzpatrick et al., 2024). Ngược lại, môi trường gia đình thiếu ổn định, kỳ vọng quá cao hoặc thiếu sự quan tâm có thể làm gia tăng nguy cơ lo âu. Tại Việt Nam, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mối quan hệ gia đình tích cực và sự hỗ trợ từ cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tâm thần học sinh (Bộ Y tế, 2020).

- Thứ tư, **mức độ gắn bó với nhà trường** là một yếu tố khách quan có ý nghĩa bảo vệ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy học sinh có cảm nhận tích cực về môi trường học đường, cảm thấy được tôn trọng và thuộc về tập thể có nguy cơ thấp hơn đối với rối loạn lo âu và trầm cảm (Allen et al., 2024; Raniti et al., 2022). Ngược lại, môi trường học đường thiếu an toàn, thiếu hỗ trợ hoặc tiêu cực có thể làm gia tăng stress và rối loạn lo âu. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc xây dựng môi trường học đường tích cực trong phòng ngừa rối loạn lo âu.

- Thứ năm, **ảnh hưởng của công nghệ và hành vi sử dụng thiết bị số** ngày càng trở thành yếu tố khách quan quan trọng trong thời đại hiện nay. Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức có liên hệ đáng kể với rối loạn lo âu, đặc biệt là rối loạn lo âu xã hội và rối loạn lo âu lan tỏa (Wei et al., 2023; Lee & Lee, 2023). Môi trường trực tuyến không chỉ làm gia tăng so sánh xã hội mà còn có thể tạo ra

các trải nghiệm tiêu cực như bắt nạt trên mạng, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.

- Cuối cùng, **các yếu tố xã hội rộng lớn** như biến động kinh tế, dịch bệnh hoặc thay đổi trong hệ thống giáo dục cũng có thể tác động gián tiếp đến rối loạn lo âu. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình, khi các nghiên cứu toàn cầu cho thấy sự gia tăng đáng kể các triệu chứng rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên do gián đoạn học tập và giảm tương tác xã hội (Racine et al., 2021). Tại Việt Nam, các báo cáo cũng ghi nhận những ảnh hưởng tiêu cực tương tự đến sức khỏe tâm thần học sinh trong giai đoạn này (Bộ Y tế, 2020).

Như vậy, các yếu tố khách quan, bao gồm áp lực học tập, quan hệ bạn bè, môi trường gia đình, gắn bó nhà trường và ảnh hưởng của công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển rối loạn lo âu ở học sinh THCS. Những yếu tố này không tồn tại độc lập mà tương tác với các đặc điểm cá nhân, tạo thành một hệ thống tác động phức hợp đến sức khỏe tâm thần học sinh. Việc nhận diện và kiểm soát các yếu tố khách quan này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các chương trình phòng ngừa và can thiệp hiệu quả trong bối cảnh học đường.

1.3. Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS

1.3.1. Cơ sở khoa học

Việc đề xuất chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS cần được đặt trên quan điểm rằng lo âu ở lứa tuổi thiếu niên không phải là hiện tượng đơn nhất, mà là một nhóm biểu hiện nội tâm, gây nên và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố thành phần, đồng thời hoặc gián tiếp, chẳng hạn như các yếu tố cá nhân, quan hệ xã hội và bối cảnh gia đình, học đường. Tổng quan nghiên cứu gần đây cho thấy các rối loạn lo âu ở trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm khó khăn tâm lý phổ biến, do đó, phòng ngừa và can thiệp sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là bối cảnh phát triển hàng ngày và thường xuyên tiếp cận liên tục đối với học sinh (Rapee et al., 2023). Trong công tác phòng ngừa, trường học không chỉ là nơi phát hiện sớm triệu chứng mà còn là nơi mà học sinh dùng hầu hết thời gian sống và sinh hoạt, do vậy, có thể đưa ra các tác động nhằm thay đổi các điều kiện sinh lý, tâm lý, xã hội, áp lực học tập, quan hệ bạn bè, cảm nhận an toàn, mức độ gắn bó với trường và cách học sinh ứng phó với stress để học sinh có thể có một sức khỏe cơ thể khỏe mạnh và một sức khỏe tinh thần đầy đủ.

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, áp lực học tập có liên hệ nhất quán với các vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, trong đó có lo âu (Stearns et al., 2023). Ngược lại, sự gắn bó với trường học được xem là một yếu tố bảo vệ quan trọng, với nhiều nghiên cứu dọc chỉ ra rằng mức độ gắn bó cao hơn có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với các triệu chứng lo âu và trầm cảm (Raniti et al., 2022; Allen et al., 2024). Điều này cho thấy các can thiệp trong nhà trường cần đồng thời hướng đến giảm thiểu yếu tố nguy cơ và tăng cường các nguồn lực bảo vệ trong môi trường học đường.

Từ góc độ tâm lý học trường học, một chương trình phòng ngừa hiệu quả không nên chỉ tập trung vào bản thân triệu chứng lo âu, mà cần tổ chức theo mô hình kiểm soát yếu tố nguy cơ, gia tăng yếu tố bảo vệ, đồng thời tác động vào các cơ chế tâm lý- xã hội có liên quan trực tiếp đến sự hình thành và duy trì rối loạn lo âu. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nạn nhân bắt nạt học đường có liên hệ đáng kể với lo âu xã hội, và mối quan hệ này có tính hai chiều theo thời gian (Deng et al., 2024). Ở chiều cạnh hành vi số trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ hiện nay, rối loạn lo âu xã hội và việc sử dụng điện thoại thông minh có mối liên quan lẫn nhau, đồng thời việc sử dụng điện thoại quá mức có liên quan đáng kể đến rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên (Wei et al., 2023; Lee & Lee, 2023). Những bằng chứng này cho thấy cần tích hợp nội dung kiểm soát hành vi số vào các chương trình phòng ngừa rối loạn lo âu học đường.

Trong những năm gần đây, ở một số nước đã thử nghiệm xây dựng khung chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm cho HS như chương trình can thiệp Workshop CBT (DISCOVER) với thời lượng 1 ngày của Brown JSL và cs. (2024) ở Anh; chương trình 8 phiên CBT, do giáo viên thực hiện sau khi được các chuyên gia tâm lý tập huấn về CBT của Sinha De Silva và cs. (2024) ở Srilanka; chương trình iCBT của K. Matsumoto và cs. (2024) ở Nhật; chương trình Mobile CBT của Zhang Qiaochu và cs. (2025) ở Trung Quốc,...

Trên cơ sở tổng hợp các bằng chứng từ các nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm gần đây trên thế giới, có thể khẳng định rằng chương trình phòng ngừa rối loạn lo âu học đường cho học sinh THCS cần được thiết kế theo hướng đa thành phần, kết hợp giữa kiểm soát các yếu tố nguy cơ (áp lực học tập, bắt nạt, hành vi số không kiểm soát) và tăng cường các yếu tố bảo vệ (hỗ trợ xã hội, gắn bó nhà trường, đối phó tích cực). Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế hiện đại của tâm lý học trường học, nhấn mạnh phòng ngừa sớm, can thiệp toàn diện và dựa trên bằng chứng.

1.3.2. Khái niệm khung chương trình

Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường ở học sinh trung học cơ sở được hiểu là một hệ thống định hướng mang tính cấu trúc, có cơ sở khoa học, bao gồm các mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy trình triển khai và cơ chế đánh giá, được thiết kế nhằm tác động có chủ đích vào các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ liên quan đến rối loạn lo âu, qua đó góp phần ngăn ngừa sự hình thành và giảm thiểu mức độ lo âu trong bối cảnh học đường (Fazel et al., 2014; World Health Organization [WHO], 2021). Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng can thiệp học đường hiện đại, trong đó các chương trình phòng ngừa được xây dựng dựa trên bằng chứng và hướng tới can thiệp sớm ở cấp độ quần thể học sinh.

Khung chương trình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà hướng tới phát triển các năng lực tâm lý cốt lõi của học sinh, đặc biệt là năng lực nhận diện và điều chỉnh cảm xúc, tái cấu trúc nhận thức và lựa chọn các chiến lược đối phó thích ứng. Các thành phần này đã được chứng minh là cơ chế trung tâm trong việc giảm lo âu thông qua các chương trình can thiệp dựa trên liệu pháp nhận thức- hành vi và các tiếp cận điều chỉnh cảm xúc (Compas et al., 2020; Dunning et al., 2022). Đồng thời, khung chương trình được xây dựng theo cách tiếp cận đa tầng kết hợp giữa phòng ngừa phổ quát và chọn lọc, nhằm đảm bảo tính bao phủ và tối ưu hóa hiệu quả can thiệp trong môi trường học đường (WHO, 2021).

Về bản chất, khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường là một mô hình can thiệp dựa trên bằng chứng, trong đó nội dung được thiết kế dựa trên các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cơ chế hình thành và duy trì rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên. Các yếu tố như áp lực học tập, quan hệ bạn bè, hành vi sử dụng công nghệ và chiến lược đối phó đã được xác định là các biến có ý nghĩa trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm, đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo và điều tiết rối loạn lo âu (Stockings et al., 2022; Racine et al., 2021). Đồng thời, việc điều chỉnh chương trình theo đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi và bối cảnh văn hóa- giáo dục cụ thể là điều kiện cần để đảm bảo tính hiệu lực và khả năng áp dụng trong thực tiễn (Fazel et al., 2014).

Do đó, khung chương trình này được xem là công cụ định hướng cho các lực lượng giáo dục, bao gồm nhà trường, gia đình và chuyên viên tâm lý học đường trong việc phối hợp triển khai các hoạt động phòng ngừa rối loạn lo âu một cách hệ thống, nhất quán và hiệu quả (WHO, 2021).

1.3.3. Cấu trúc khung chương trình

Trong nghiên cứu và thực hành tâm lý học học đường, các chương trình phòng ngừa rối loạn lo âu ngày càng được xây dựng theo hướng hệ thống, dựa trên bằng chứng thực nghiệm và các mô hình lý thuyết đã được kiểm chứng. Các tổng quan gần đây cho thấy các chương trình can thiệp hiệu quả thường tích hợp nhiều thành phần, bao gồm tái cấu trúc nhận thức, điều chỉnh cảm xúc và phát triển kỹ năng đối phó, nhằm tác động đồng thời vào các cơ chế tâm lý cốt lõi của lo âu (Stockings et al., 2022; Dunning et al., 2022). Bên cạnh đó, cách tiếp cận đa tầng trong môi trường học đường kết hợp giữa phòng ngừa phổ quát và hỗ trợ chọn lọc, được xem là mô hình tối ưu trong việc giảm nguy cơ và tăng cường yếu tố bảo vệ cho học sinh (Fazel et al., 2014; WHO, 2021). Các nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả của chương trình không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn vào cấu trúc triển khai, sự phù hợp văn hóa và khả năng đánh giá kết quả dựa trên các công cụ đo lường chuẩn hóa (Weare & Nind, 2011; Durlak et al., 2011). Trên cơ sở đó, một khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS cần được thiết kế theo cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo tính logic giữa cơ sở lý luận, mục tiêu, nội dung và đánh giá hiệu quả.

Cấu trúc khung chương trình gồm có các mục như sau:

1/ Cơ sở xây dựng chương trình được xác định trên nền tảng các lý thuyết tâm lý học hiện đại, đặc biệt là liệu pháp nhận thức - hành vi, lý thuyết điều chỉnh cảm xúc và mô hình hệ sinh thái, đồng thời dựa vào các kết quả nghiên cứu thực tiễn về thực trạng lo âu và các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ trong bối cảnh học đường.

2/ Mục tiêu chương trình được thiết kế theo hai cấp độ, trong đó mục tiêu tổng quát hướng tới phòng ngừa và giảm nguy cơ rối loạn lo âu, còn mục tiêu cụ thể tập trung vào việc nâng cao nhận thức về lo âu, phát triển kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, cải thiện chiến lược đối phó và tăng cường các yếu tố bảo vệ tâm lý.

3/ Đối tượng và phạm vi áp dụng của chương trình được xác định rõ ràng, với học sinh trung học cơ sở là đối tượng chính, đồng thời có sự phối hợp của giáo viên, phụ huynh và cán bộ tư vấn học đường, được triển khai theo hướng phòng ngừa phổ quát cho toàn bộ học sinh và hỗ trợ chọn lọc cho nhóm có nguy cơ cao.

4/ Nguyên tắc xây dựng chương trình được đảm bảo dựa trên tiếp cận dựa vào bằng chứng khoa học, phù hợp với đặc điểm văn hóa và đặc điểm phát triển lứa tuổi, đồng thời hướng tới tính hệ thống và khả năng triển khai trong bối cảnh thực tiễn của nhà trường.

5/ *Nội dung chương trình* được cấu trúc thành các module liên kết chặt chẽ, bao gồm nhận thức về lo âu, kỹ năng nhận diện và điều chỉnh cảm xúc, tái cấu trúc nhận thức, phát triển kỹ năng đối phó, rèn luyện kỹ năng xã hội và tăng cường các yếu tố bảo vệ như hỗ trợ xã hội và gắn bó với nhà trường.

6/ *Phương pháp và hình thức tổ chức* được thiết kế theo hướng tích cực hóa người học, sử dụng các hoạt động nhóm, thảo luận tình huống, đóng vai và thực hành kỹ năng nhằm giúp học sinh trải nghiệm và nội hóa các nội dung tập huấn.

7/ *Quy trình triển khai chương trình* được thực hiện theo các giai đoạn rõ ràng, bao gồm chuẩn bị, triển khai và theo dõi - củng cố, nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của can thiệp.

8/ *Đánh giá hiệu quả chương trình* được thực hiện thông qua thiết kế trước – sau can thiệp, sử dụng các công cụ đo lường chuẩn hóa để đánh giá mức độ thay đổi về lo âu, kỹ năng đối phó, stress và các yếu tố bảo vệ liên quan.

9/ *Điều kiện triển khai chương trình* bao gồm các yếu tố về nhân lực, thời lượng và tài liệu hỗ trợ, trong đó nhấn mạnh vai trò của giáo viên và chuyên gia tâm lý trong việc đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình.

10/ *Kết quả kỳ vọng của chương trình* hướng tới việc giảm mức độ lo âu, nâng cao kỹ năng đối phó tích cực, tăng cường hỗ trợ xã hội và cải thiện khả năng thích ứng học đường của học sinh.

Trên cơ sở phân tích trên, đề tài này sẽ lựa chọn các thành phần đáp ứng yêu cầu của đề tài để đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường ở học sinh THCS.

TIỂU KẾT CHƯƠNG I

Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở là *trạng thái tâm lý bất thường, mất cân bằng trong cảm xúc, bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng, phản ứng sợ hãi không phù hợp với mức độ nguy hiểm của tình huống và rối loạn hành vi liên quan, đi kèm với các biểu hiện sinh lý, kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng học tập, chất lượng cuộc sống của học sinh.*

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy ở Việt Nam còn một số khoảng trống trong lĩnh vực này như: Thứ nhất, chưa có bộ thang đo rối loạn lo âu dành cho trẻ em - vị thành niên được kiểm định về chất lượng phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, dẫn đến biên độ ước tính tỷ lệ lo âu rất rộng (từ 2,3% theo chẩn đoán đầy đủ đến trên 50%, tùy theo thang đo sàng lọc). Thứ hai, phần lớn nghiên cứu tập trung vào lo âu lan tỏa bằng thang đo GAD-7 hoặc DASS-21, trong khi lo âu xã hội và lo âu chia ly hầu như chưa được khảo sát chuyên biệt. Thứ ba, các yếu tố bảo vệ - bao gồm lòng tự trọng, gắn bó trường học, hỗ trợ của cha mẹ và bạn bè, biện pháp ứng phó - chưa được nghiên cứu đồng thời và tích hợp với yếu tố nguy cơ trong cùng một thiết kế nghiên cứu. Thứ tư, thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc và thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm còn rất ít. Thứ năm, còn thiếu các nghiên cứu về chương trình can thiệp theo tiếp cận nhận thức - hành vi trên học sinh trung học cơ sở Việt Nam để đem lại các bằng chứng hiệu quả của can thiệp như một số nước trên thế giới và trong khu vực Châu Á đã thực hiện.

CHƯƠNG 2

TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Tổ chức nghiên cứu

2.1.1 Nhiệm vụ cụ thể của nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở, bao gồm mức độ và các biểu hiện cụ thể của rối loạn lo âu và xác định vai trò của các yếu tố ảnh hưởng (yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó) đối với rối loạn lo âu ở học sinh. Cụ thể:

- Tổng quan các nghiên cứu có liên quan tại Việt nam và nước ngoài; hệ thống hóa cơ sở lý luận về rối loạn lo âu và các yếu tố ảnh hưởng.

- Xác định mức độ và các biểu hiện của rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở thông qua các chỉ số thống kê mô tả.

- Phân tích mức độ và biểu hiện của các yếu tố nguy cơ (áp lực học tập, nghiện điện thoại, bắt nạt học đường) và các yếu tố bảo vệ (gắn bó trường học, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, tự trọng).

- Phân tích tác động của các yếu tố đến rối loạn lo âu thông qua sử dụng mô hình phương trình cấu trúc SEM để kiểm định mức độ và hướng tác động của các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đối với rối loạn lo âu.

- Mô tả các chiến lược đối phó của học sinh và phân tích tác động của các biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu thông qua mô hình SEM. **Biện pháp đối phó được phân tách thành hai chiều theo lý thuyết Lazarus và Folkman (1984) cùng lý thuyết phân tích tổng hợp của Compas và cộng sự (2017): chiều đối phó thích nghi và chiều đối phó không thích nghi.** Hai chiều này được kiểm định riêng biệt với kỳ vọng chiều thích nghi cho hệ số β âm và chiều không thích nghi cho hệ số β dương khi đặt trong mô hình dự báo rối loạn lo âu.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất xây dựng khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh trung học cơ sở

2.1.2 Vài nét về địa bàn nghiên cứu

Nghiên cứu được triển khai tại hai trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện cho hai bối cảnh đô thị có đặc điểm khác biệt về mức độ phát triển kinh tế - xã hội và môi trường học đường, bao gồm khu vực nội thành và khu vực ven đô. Việc lựa chọn này nhằm đảm bảo tính đa dạng của mẫu nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện phân tích ảnh hưởng của bối cảnh môi trường đến rối loạn lo âu ở học sinh.

a/ Trường THCS Nhật Tân - Hà Nội

Trường THCS Nhật Tân nằm trong khu vực nội thành Hà Nội, nơi có mức độ đô thị hóa cao, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển và hệ thống giáo dục tương đối ổn định. Môi trường học đường tại đây có xu hướng được tổ chức chặt chẽ, cơ sở vật chất đầy đủ và định hướng học tập rõ ràng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị phát triển, học sinh thường phải đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến rối loạn lo âu, cụ thể:

- Áp lực học tập và thành tích cao do kỳ vọng từ gia đình và nhà trường;
- Sự cạnh tranh trong học tập và so sánh xã hội;
- Tác động của môi trường đô thị như nhịp sống nhanh, mạng xã hội và yêu cầu thích nghi cao.

Bên cạnh đó, môi trường học đường cũng có thể góp phần hình thành và củng cố các yếu tố bảo vệ, như mức độ gắn bó với trường học, sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, cũng như sự phát triển của lòng tự trọng.

Sự tác động đồng thời của các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong bối cảnh này có thể ảnh hưởng đến mức độ biểu hiện rối loạn lo âu ở học sinh, phù hợp với hướng tiếp cận nghiên cứu của đề tài.

b/ Trường THCS Tây Mỗ - Hà Nội

Trường THCS Tây Mỗ thuộc khu vực ven đô vùng chuyển tiếp giữa đô thị và ngoại thành, đặc trưng bởi sự đa dạng về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường học tập. Bối cảnh này tạo nên sự khác biệt nhất định trong trải nghiệm học đường của học sinh, đặc biệt liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu.

Trong môi trường này, học sinh có thể chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố liên quan trực tiếp đến mô hình nghiên cứu, bao gồm:

- *Các yếu tố nguy cơ*, như áp lực trong học tập và môi trường học đường, mức độ tiếp xúc và sử dụng điện thoại, cũng như các trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè (như bị bắt nạt);
- *Các yếu tố bảo vệ*, như mức độ gắn bó với trường học, sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, cũng như mức độ tự trọng của học sinh.

Sự khác biệt về điều kiện sống và môi trường học tập trong khu vực ven đô có thể làm thay đổi mức độ biểu hiện của các yếu tố nguy cơ và bảo vệ này, từ đó ảnh hưởng đến mức độ rối loạn lo âu ở học sinh.

Ý nghĩa của việc lựa chọn địa bàn nghiên cứu

Việc lựa chọn hai trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội được thực hiện nhằm đảm bảo tính phù hợp và độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu trong bối cảnh học đường thực tế.

(1) *Đảm bảo tính đa dạng của mẫu nghiên cứu*: Việc thu thập dữ liệu tại hai trường giúp mẫu nghiên cứu phản ánh được đặc điểm chung của học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đô thị, góp phần tăng độ tin cậy và khả năng khái quát của kết quả nghiên cứu.

(2) *Tạo điều kiện thu thập dữ liệu đầy đủ cho các biến nghiên cứu*: Bối cảnh học đường tại các trường cung cấp môi trường phù hợp để khảo sát các biến trong mô hình nghiên cứu, bao gồm: rối loạn lo âu, các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó của học sinh.

(3) *Phục vụ kiểm định mô hình nghiên cứu*: Dữ liệu thu thập từ hai trường là cơ sở để tiến hành các phân tích thống kê và kiểm định mô hình phương trình cấu trúc SEM, qua đó đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và rối loạn lo âu.

Việc lựa chọn địa bàn nghiên cứu thể hiện cách tiếp cận chọn mẫu có chủ đích, phù hợp với mục tiêu thu thập dữ liệu phục vụ kiểm định mô hình nghiên cứu. Bối cảnh học đường được lựa chọn cho phép khảo sát các biến nghiên cứu trong môi trường thực tế, qua đó làm rõ mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và rối loạn lo âu ở học sinh. Đồng thời, cách lựa chọn này đảm bảo tính nhất quán với thiết kế nghiên cứu, trong đó các biến được xem xét trong mối quan hệ tác động đến rối loạn lo âu theo mô hình nghiên cứu đã đề xuất.

2.1.3. Thời gian tiến hành nghiên cứu

Nghiên cứu này được tiến hành trong năm học 2025-2026.

2.2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

2.2.1. Khách thể nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu sử dụng trong phân tích số liệu gồm 1.352 học sinh trung học cơ sở, được phân bố tương đối đồng đều theo giới tính, trường học và khối lớp. Mẫu nghiên cứu được thu thập theo thiết kế chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo trường và khối lớp, kết hợp với chọn cụm ở cấp lớp học, nhằm đảm bảo tính đại diện tương đối của học sinh THCS trong bối cảnh nghiên cứu. Trong mỗi cụm lớp, học sinh được lựa chọn theo phương pháp thuận tiện trên cơ sở tự nguyện tham gia khảo sát. Cách tiếp cận này phù hợp với nghiên cứu học đường quy mô lớn, vừa đảm bảo tính khả thi trong thu thập dữ liệu, vừa duy trì được sự đa dạng về đặc điểm khách thể.

Kết quả được thể hiện trong Bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 2.1. Đặc điểm khách thể nghiên cứu

Đặc điểm		Số lượng (1352)	Tỉ lệ (%)
Giới tính	Nam	614	45,4
	Nữ	738	54,6
Trường	THCS Tây Mỗ	720	53,3
	THCS Nhật Tân	632	46,7
Lớp	6	368	27,2
	7	316	23,4
	8	340	25,1
	9	328	24,3
Học lực	Yếu	38	2,8
	Trung bình	168	12,4
	Khá	521	38,5
	Giỏi	463	34,2
	Xuất sắc	117	8,7
	Không cung cấp dữ liệu	45	3,3

Kết quả tại Bảng 2.1 cho thấy mẫu khách thể trong nghiên cứu bao gồm 1.352 học sinh trung học cơ sở có sự phân bố khá cân bằng giữa các nhóm đặc điểm. Về giới tính, tỷ lệ nữ cao hơn nam (54,6% so với 45,4%) nhưng mức độ chênh lệch không lớn. Về

trường học, số lượng học sinh giữa hai trường khá tương đương (THCS Tây Mỗ: 53,3%; THCS Nhật Tân: 46,7%).

Phân bố theo khối lớp tương đối đồng đều (từ 23,4% đến 27,2%), đảm bảo đại diện cho cả bốn khối 6-9. Về học lực, đa số học sinh đạt mức khá và giỏi (38,5% và 34,2%), trong khi tỷ lệ học sinh yếu và trung bình chiếm tỷ lệ thấp hơn. Nhìn chung, mẫu nghiên cứu có sự phân bố hợp lý giữa các đặc điểm cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho các phân tích thống kê và đảm bảo độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

2.2.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào tìm hiểu và làm rõ thực trạng mức độ và biểu hiện của rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở; mức độ và biểu hiện của các yếu tố ảnh hưởng (yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó); tác động của các yếu tố ảnh hưởng đối với rối loạn lo âu thông qua mô hình phương trình cấu trúc SEM; khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS.

2.3. Các giai đoạn thực hiện nghiên cứu

2.3.1. Giai đoạn nghiên cứu lý luận

Mục đích nghiên cứu lý luận:

Nghiên cứu tổng quan các công trình trong và ngoài nước liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở, bao gồm: thực trạng rối loạn lo âu và các dạng rối loạn lo âu ở học sinh THCS; các yếu tố ảnh hưởng (yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ) đối với rối loạn lo âu; thực trạng các công cụ sử dụng trong nghiên cứu rối loạn lo âu hiện hành trên thế giới; các biện pháp đối phó với rối loạn lo âu ở lứa tuổi học sinh THCS; khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở lứa tuổi học sinh THCS làm cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu của đề tài.

Nội dung nghiên cứu lý luận:

Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về rối loạn lo âu và các dạng rối loạn lo âu ở học sinh THCS, các yếu tố ảnh hưởng (yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ), các biện pháp đối phó với rối loạn lo âu ở lứa tuổi học sinh THCS. Trên cơ sở đó, hệ thống hóa các khái niệm, xây dựng cơ sở lý luận về các vấn đề nghiên cứu.

Cách thức tiến hành:

Sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa tài liệu khoa học. Nghiên cứu tiến hành thu thập và lựa chọn các nguồn tài liệu trong và ngoài nước (sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học,...) liên quan đến rối loạn lo âu, các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp đối phó ở học sinh trung học cơ sở. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích, so sánh và tổng hợp nhằm xây dựng cơ sở lý luận và định hướng mô hình nghiên cứu của đề tài.

2.3.2. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn

Mục đích nghiên cứu:

Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn được triển khai nhằm tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở trên các khía cạnh: rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn lo âu xã hội và rối loạn lo âu chia ly. Đồng thời, nghiên cứu tập trung xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu ở học sinh trong bối cảnh học đường.

Nội dung nghiên cứu:

Tập trung vào việc khảo sát và phân tích dữ liệu thực trạng tại thời điểm nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu xem xét mức độ và biểu hiện của rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở, đồng thời đánh giá mức độ biểu hiện của các yếu tố nguy cơ như áp lực học tập, nghiện điện thoại và bắt nạt học đường, cũng như các yếu tố bảo vệ bao gồm gắn bó với trường học, hỗ trợ xã hội và lòng tự trọng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tìm hiểu mức độ sử dụng các biện pháp đối phó của học sinh và phân tích mối quan hệ giữa rối loạn lo âu với các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó, làm cơ sở cho việc kiểm định mô hình nghiên cứu.

Cách thức tiến hành:

Tiến hành theo quy trình lập kế hoạch nghiên cứu, liên hệ các trường để tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu bằng bảng hỏi, sàng lọc và xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu thực tiễn được triển khai theo bốn giai đoạn chính như sau:

(1) Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu

- Hoàn thiện bộ công cụ nghiên cứu: Hiệu chỉnh và hoàn thiện bộ công cụ định lượng; Xây dựng đề cương phỏng vấn bán cấu trúc cho nghiên cứu định tính; Soạn thảo các tài liệu khác phục vụ cho nghiên cứu, đảm bảo ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.

- Tiến hành liên hệ và xin phép nghiên cứu từ Ban Giám hiệu các trường THCS được lựa chọn trong mẫu nghiên cứu, trình bày mục tiêu, nội dung nghiên cứu, kế hoạch triển khai và các yêu cầu phối hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu nhận được sự chấp thuận của nhà trường và thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức khảo sát.

- Tập huấn nhóm nghiên cứu: Tổ chức tập huấn cho các giáo viên và cộng tác viên trực tiếp thu thập dữ liệu ở trường THCS nơi nghiên cứu. Nội dung tập huấn tập trung vào: (1) Quy trình triển khai khảo sát, (2) Quy trình thu thập và kiểm tra, xử lý phiếu điều tra. (3) Kỹ năng phỏng vấn và sử dụng tài liệu nghiên cứu, (4) Kỹ năng nghiên cứu trường hợp.

(2) Giai đoạn khảo sát thử

Khảo sát thử được tiến hành trên một nhóm học sinh trung học cơ sở được lựa chọn thuận tiện từ địa bàn nghiên cứu, đảm bảo có đặc điểm tương đồng với mẫu khảo sát chính thức. Việc lựa chọn khách thể khảo sát thử nhằm kiểm tra tính phù hợp của công cụ đo lường trong bối cảnh thực tế.

Quá trình khảo sát được thực hiện dưới sự hướng dẫn của người nghiên cứu, đảm bảo học sinh hiểu rõ mục đích nghiên cứu, tham gia tự nguyện và cung cấp thông tin một cách trung thực. Đồng thời, người nghiên cứu tiến hành thu thập ý kiến phản hồi trực tiếp từ học sinh về mức độ rõ ràng của câu hỏi, độ dài bảng hỏi, mức độ dễ hiểu của ngôn ngữ và sự phù hợp của các nội dung thang đo.

Dữ liệu khảo sát thử được sử dụng để đánh giá sơ bộ độ tin cậy của các thang đo thông qua các chỉ số như Cronbach's alpha và McDonald's omega. Trên cơ sở đó, các mục hỏi chưa phù hợp, khó hiểu hoặc có hệ số tương quan thấp được xem xét điều chỉnh hoặc loại bỏ. Kết quả khảo sát thử và ý kiến góp ý của người tham gia là cơ sở để hoàn thiện bảng hỏi, đảm bảo công cụ nghiên cứu có tính rõ ràng, phù hợp khách thể nghiên cứu và khả thi trước khi triển khai khảo sát chính thức.

(3) Giai đoạn khảo sát chính thức

Thu thập dữ liệu định lượng:

Khảo sát chính thức được triển khai tại hai trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, Trường THCS Nhật Tân (quận Tây Hồ) đại diện cho khu vực nội thành có mức độ đô thị hóa cao, và Trường THCS Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) đại diện cho khu vực ven đô với đặc điểm chuyển tiếp giữa đô thị và ngoại thành. Việc lựa chọn này nhằm đa dạng về mẫu nghiên cứu và bao hàm sự khác biệt trong các nhóm mẫu nghiên cứu.

Quy trình thu thập dữ liệu tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu. Học sinh được cung cấp thông tin đầy đủ về mục đích nghiên cứu, quyền tham gia tự nguyện, quyền từ chối hoặc dừng tham gia bất kỳ lúc nào, đồng thời được đảm bảo về tính bảo mật thông tin. Chỉ những học sinh đồng ý tham gia mới được phát phiếu khảo sát.

Dữ liệu được thu thập bằng bảng hỏi tự điền tại lớp học, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của người nghiên cứu và sự hỗ trợ của giáo viên. Trước khi phát phiếu, người nghiên cứu hướng dẫn cách trả lời, giải thích các nội dung cần thiết và nhấn mạnh yêu cầu trả lời trung thực theo trải nghiệm cá nhân.

Trong quá trình khảo sát, người nghiên cứu giám sát trực tiếp nhằm đảm bảo học sinh làm bài độc lập, không trao đổi, từ đó hạn chế sai lệch trong thu thập dữ liệu. Các thắc mắc của học sinh được giải đáp kịp thời nhưng không ảnh hưởng đến nội dung phản hồi.

Thu thập dữ liệu định tính (Phỏng vấn sâu)

Từ kết quả phân tích sơ bộ dữ liệu định lượng, nhóm nghiên cứu tiến hành chọn mẫu có chủ đích. Tiêu chí lựa chọn là các học sinh có điểm số lo âu từ trung bình đến cao, và có thể bao gồm cả một số trường hợp không có biểu hiện để đối chứng, đại diện cho các đặc điểm nhân khẩu khác nhau về giới tính và khối lớp. Mời phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm của nhà trường theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện cá nhân (1:1) tại một địa điểm riêng tư, an toàn và yên tĩnh trong trường học. Nghiên cứu viên sử dụng đề cương phỏng vấn để phỏng vấn học sinh và giáo viên.

(4) Giai đoạn xử lý và phân tích dữ liệu

Dữ liệu thu thập được nhập và xử lý bằng phần mềm thống kê (SPSS phiên bản 31.0, AMOS phiên bản 31.0). Trước khi tiến hành các phân tích chính thức, dữ liệu được kiểm tra và làm sạch một cách hệ thống nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính hợp lệ của kết quả nghiên cứu.

Quá trình làm sạch dữ liệu được thực hiện theo nhiều bước:

a) Sàng lọc thủ công:

Tiến hành kiểm tra trực tiếp các phiếu khảo sát để phát hiện và loại bỏ các trường hợp không hợp lệ, bao gồm: phiếu bỏ trống nhiều mục, trả lời theo một phương án duy nhất cho toàn bộ thang đo, hoặc có dấu hiệu trả lời không nghiêm túc.

b) Sàng lọc bằng phần mềm:

Dữ liệu được kiểm tra thông qua các chỉ số thống kê nhằm phát hiện các trường hợp bất thường, bao gồm:

- Các mẫu trả lời lặp lại hoặc thiếu nhất quán
- Các trường hợp có độ lệch bất thường giữa các item kiểm định (đặc biệt ở các câu đảo chiều);
- Các giá trị ngoại lai (*outliers*) có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

c) Xử lý dữ liệu khuyết (missing data):

Các trường hợp khuyết dữ liệu do bỏ quên, giá trị thiếu được ước lượng và thay thế dựa trên xu hướng trả lời của khách thể (ví dụ: giá trị trung bình hoặc trung vị của thang đo tương ứng), nhằm đảm bảo tính nhất quán và hạn chế sai lệch dữ liệu. Ngược lại, các phiếu có tỷ lệ dữ liệu khuyết vượt quá ngưỡng cho phép hoặc thiếu tập trung ở một thang đo cụ thể sẽ bị loại khỏi bộ dữ liệu phân tích.

Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch, dữ liệu hợp lệ được đưa vào các bước phân tích tiếp theo, bao gồm:

- Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach's alpha, McDonald's omega);
- Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm định cấu trúc thang đo;
- Thống kê mô tả nhằm xác định mức độ và biểu hiện của các biến nghiên cứu;
- Phân tích phương sai (ANOVA) để kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm;
- Xây dựng và kiểm định mô hình phương trình cấu trúc (SEM) nhằm đánh giá tác động của các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu. Trong mô hình SEM, biến biện pháp đối phó được đo lường ở hai chiều thích nghi và không thích nghi. Hai chiều này được đặt làm hai biến tiềm ẩn riêng biệt trong mô hình, cho phép quan sát chiều và độ lớn của hệ số β cho mỗi chiều mà không nhập gộp chúng thành một biến tổng.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

Phương pháp nghiên cứu lý luận được sử dụng nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu liên quan đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở, bao gồm các loại lo âu phổ biến như lo âu lan tỏa, lo âu xã hội và lo âu chia ly. Đồng thời, phương pháp này giúp làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu, bao gồm yếu tố nguy cơ,

yếu tố bảo vệ và các biện pháp đối phó của học sinh, qua đó hình thành nền tảng lý luận cho mô hình nghiên cứu.

Nghiên cứu tiến hành thu thập và phân tích các tài liệu khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh thông qua hệ thống từ khóa liên quan đến rối loạn lo âu và các biến nghiên cứu. Nguồn tài liệu bao gồm sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học có bình duyệt, luận văn và luận án, được khai thác từ các cơ sở dữ liệu học thuật uy tín như Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, Scopus, SAGE Journals, Wiley Online Library và các tạp chí khoa học trong nước, cùng với thư viện điện tử của các trường đại học.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu, nghiên cứu tiến hành phân loại, hệ thống hóa và liên kết các khái niệm, lý thuyết và kết quả nghiên cứu theo một cấu trúc logic, tập trung vào các nội dung chính như khái niệm và phân loại rối loạn lo âu, các yếu tố ảnh hưởng và các mô hình lý thuyết liên quan. Từ đó, nghiên cứu khái quát hóa các vấn đề cốt lõi, xác định các mối quan hệ giữa các biến và xây dựng khung lý thuyết làm nền tảng cho việc đề xuất giả thuyết và mô hình nghiên cứu về tác động của các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó đối với rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở.

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

2.4.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Mục đích nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở trên các khía cạnh: rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn lo âu xã hội và rối loạn lo âu chia ly; đồng thời xác định vai trò của các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó đối với rối loạn lo âu.

Cách thức tiến hành:

Khảo sát được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực tiếp thông qua bảng hỏi giấy đối với học sinh trung học cơ sở. Quy trình thực hiện được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Xây dựng kế hoạch khảo sát, xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng và cách thức triển khai.

Bước 2: Liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để trình bày kế hoạch nghiên cứu và xin phép triển khai khảo sát.

Bước 3: Sau khi được chấp thuận, tiến hành khảo sát tại các lớp học. Trước khi phát phiếu, người thực hiện nghiên cứu hướng dẫn học sinh cách trả lời, giải thích các nội dung cần thiết và lưu ý học sinh trả lời trung thực.

Bước 4: Thu hồi phiếu khảo sát, kiểm tra sơ bộ và niêm phong nhằm đảm bảo tính bảo mật và đầy đủ của dữ liệu.

Bước 5: Sàng lọc các phiếu không hợp lệ hoặc không đạt yêu cầu dựa trên các tiêu chí về tính đầy đủ và mức độ hợp lệ của câu trả lời.

Bước 6: Nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS, mã hóa biến và tiến hành sàng lọc lần hai trên phần mềm nhằm lựa chọn bộ dữ liệu đạt tiêu chuẩn để đưa vào phân tích.

Cấu trúc hệ đo lường:

Trong nghiên cứu này, các biến nghiên cứu được đo lường bằng các công cụ đã được kiểm chứng rộng rãi trong nghiên cứu quốc tế. Cụ thể, rối loạn lo âu được đánh giá bằng Revised Child Anxiety and Depression Scale (Chorpita et al., 2000), áp lực học tập được đo bằng Educational Stress Scale for Adolescents (Sun et al., 2011), và nghiện điện thoại được đánh giá thông qua Smartphone Addiction Scale - Short Version (Kwon et al., 2013). Bắt nạt học đường được đo bằng Olweus Bully/Victim Questionnaire (Olweus, 1996), trong khi gắn bó với trường học được đánh giá bằng Psychological Sense of School Membership (Goodenow, 1993). Hỗ trợ xã hội cảm nhận được đo bằng Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al., 1988), tự trọng được đo bằng Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965), và các chiến lược đối phó được đánh giá thông qua Brief COPE Inventory (Carver, 1997). Các thang đo này đều đã được sử dụng rộng rãi trên các mẫu thanh thiếu niên, với bằng chứng vững chắc về độ tin cậy và giá trị đo lường trong nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau.

Các thang đo sử dụng trong nghiên cứu được chuẩn hóa với các định dạng thang Likert khác nhau, phù hợp với đặc điểm của từng công cụ, nhằm đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy trong đo lường các biến nghiên cứu. Quy trình kiểm định thang đo được thực hiện theo hai bước chính, bao gồm đánh giá độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach's alpha và McDonald's omega, cùng với phân tích nhân tố khẳng định (CFA) nhằm kiểm định cấu trúc khái niệm của các thang đo.

- *Biến nghiên cứu chính của đề tài là rối loạn lo âu*, nghiên cứu sử dụng thang đo RCADS (Revised Children's Anxiety and Depression Scale) do Chorpita (2000) phát triển, nhằm đánh giá ba loại lo âu phổ biến ở học sinh trung học cơ sở gồm lo âu lan tỏa,

lo âu chia ly và lo âu xã hội. Thang đo được sử dụng theo dạng Likert 4 mức độ. Quy trình thích ứng thang đo được thực hiện chặt chẽ thông qua dịch xuôi- dịch ngược, tham vấn chuyên gia và khảo sát thử nghiệm. Trên cơ sở phân tích độ tin cậy và tính phù hợp nội dung, từ 21 mục hỏi ban đầu, nghiên cứu giữ lại 15 mục (lo âu lan tỏa: 7 items; lo âu chia ly: 4 items; lo âu xã hội: 4 items), đảm bảo vừa duy trì cấu trúc khái niệm gốc vừa phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

- *Đối với nhóm yếu tố nguy cơ*, nghiên cứu sử dụng ba thang đo. Thang đo ESSA (Sun et al., 2011) được sử dụng để đánh giá áp lực học tập với thang Likert 4 mức; sau quá trình hiệu chỉnh, thang đo được rút gọn còn 4 mục phản ánh các biểu hiện cốt lõi của áp lực học tập. Thang đo SAS-SV (Kwon et al., 2013) được sử dụng để đo lường nghiện điện thoại thông minh; từ 10 mục ban đầu, nghiên cứu giữ lại 5 mục sau khi loại bỏ các biến không đạt yêu cầu về độ tin cậy. Đối với bắt nạt học đường, thang đo OBVQ (Olweus, 1996) được sử dụng với hai dạng phổ biến là bắt nạt thể chất và bắt nạt lời nói; kết quả giữ lại 8 mục (mỗi dạng 4 mục), phản ánh các hành vi bắt nạt trực tiếp và phổ biến trong môi trường học đường.

- *Đối với nhóm yếu tố bảo vệ*, nghiên cứu sử dụng ba thang đo. Thang đo PSSM (Goodenow, 1993) được sử dụng để đánh giá mức độ gắn bó với trường học; từ 18 mục ban đầu, sau khi hiệu chỉnh và phân tích độ tin cậy, giữ lại 7 mục phù hợp. Thang đo MSPSS (Zimet et al., 1988) được sử dụng để đo lường hỗ trợ xã hội cảm nhận; nghiên cứu tập trung vào hai nguồn hỗ trợ chính là gia đình và bạn bè, với 8 mục được giữ lại (mỗi nguồn 4 mục). Thang đo tự trọng RSES (Rosenberg, 1965) được sử dụng theo thang Likert 4 mức; nghiên cứu lựa chọn 5 mục thuộc nhóm đánh giá tích cực về bản thân nhằm phản ánh rõ nét mức độ tự trọng của học sinh.

- *Đối với biến biện pháp đối phó rối loạn lo âu*, nghiên cứu sử dụng thang đo Brief-COPE (Carver, 1997). Từ cấu trúc gốc gồm 28 mục, các tiểu thang được nhóm lại thành ba dạng chiến lược chính gồm đối phó tập trung giải quyết vấn đề, đối phó tìm kiếm hỗ trợ và đối phó tránh né. Sau quá trình hiệu chỉnh, thang đo được rút gọn còn 15 mục (đối phó tránh né: 5 mục; giải quyết vấn đề: 6 mục; tìm kiếm hỗ trợ: 4 mục), đảm bảo phản ánh các chiến lược đối phó cốt lõi và phù hợp với mô hình nghiên cứu. **Ba tiểu thang đo gốc của Brief-COPE được phân nhóm thành hai chiều: chiều thích nghi, bao gồm đối phó giải quyết vấn đề và đối phó tìm kiếm sự hỗ trợ; chiều không thích nghi là đối phó tránh né. Cấu trúc CFA của ba tiểu thang đo vẫn được báo cáo riêng để minh chứng giá trị đo**

lượng; sau đó, phân tích SEM sẽ dùng hai chiều thích nghi/không thích nghi làm biến nghiên cứu chính.

Cơ sở của việc rút gọn là dựa trên nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng giá trị sử dụng của thang đo trong nghiên cứu này. Việc sử dụng các thang đo với số mức Likert khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc khái niệm cốt lõi của từng công cụ giúp đảm bảo tính chính xác trong đo lường, đồng thời phản ánh đầy đủ mức độ biểu hiện của các biến nghiên cứu trong phân tích và kiểm định mô hình.

Do nghiên cứu sử dụng thang đo Likert với các mức độ khác nhau (4 mức và 5 mức), để đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh giữa các biến/thang đo, các giá trị điểm số được chuẩn hóa về cùng một thang điểm từ 0 đến 100. Phương pháp chuẩn hóa được sử dụng là min-max normalization, một dạng biến đổi tuyến tính nhằm đưa dữ liệu về một khoảng giá trị xác định mà vẫn giữ nguyên mối quan hệ giữa các giá trị ban đầu. Theo phương pháp này, điểm số được tính theo công thức:

$$Score = \frac{X - Min}{Max - Min} \times 100$$

Trong đó:

- *X*: điểm gốc của người trả lời;
- *Min*: giá trị nhỏ nhất của thang đo;
- *Max*: giá trị lớn nhất của thang đo.

Phương pháp này giúp đưa các biến về cùng một hệ đo mà không làm thay đổi cấu trúc dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh và phân tích trong các mô hình thống kê (Han, Kamber & Pei, 2011).

Ví dụ, đối với thang đo áp lực học tập (ESSA) sử dụng thang Likert 4 mức (1-4), điểm số được quy đổi như sau:

$$Score = \frac{Mean - 1}{4 - 1} \times 100 = \frac{Mean - 1}{3} \times 100$$

Cơ sở lý thuyết của phương pháp:

Chuẩn hóa dữ liệu là kỹ thuật phổ biến trong xử lý dữ liệu nhằm đưa các biến về cùng một khoảng giá trị, thường là [0,1] hoặc [0,100], giúp loại bỏ ảnh hưởng của đơn vị đo và đảm bảo các biến có trọng số tương đương trong phân tích (Han, Kamber & Pei, 2011).

Trong đó, min-max normalization là phương pháp được sử dụng rộng rãi, thực hiện phép biến đổi tuyến tính từ giá trị gốc sang một khoảng giá trị mới, đồng thời bảo toàn mối quan hệ giữa các giá trị dữ liệu ban đầu (Han, Kamber & Pei, 2011). Ngoài ra, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng giúp tăng tính so sánh giữa các biến và hỗ trợ hiệu quả cho các phương pháp phân tích thống kê và mô hình hóa (Darbyshire & Beitsayadeh, 2025).

Cấu trúc bảng hỏi nghiên cứu: Bảng hỏi được thiết kế gồm hai phần.

Phần 1: Thông tin chung của khách thể nghiên cứu, bao gồm các đặc điểm như giới tính, khối lớp, học lực và một số đặc điểm liên quan đến sức khỏe, tâm lý và hành vi sinh hoạt của học sinh.

Phần 2: Các thang đo về thực trạng rối loạn lo âu và các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm:

- Thang đo rối loạn lo âu RCADS, đo lường các loại lo âu lan tỏa (7 items), lo âu xã hội (4 items) và lo âu chia ly (4 items).

- Các thang đo yếu tố nguy cơ: Áp lực học tập (4 items); Nghiện điện thoại (5 items); Bất nạt học đường trong đó bất nạt thể chất (4 items), bất nạt lời nói (4 items).

- Các thang đo yếu tố bảo vệ: Gắn bó với trường học (7 items); Hỗ trợ xã hội, trong đó tiểu thang đo hỗ trợ cha mẹ (4 items), tiểu thang đo hỗ trợ bạn bè (4 items); Lòng tự trọng (5 items).

- Thang đo biện pháp đối phó: **tổng hợp hai chiều, trong đó tiểu thang đo dành cho chiều không thích nghi - đối phó tránh né vấn đề (5 items); dành cho chiều thích nghi (10 items), gồm đối phó tập trung giải quyết vấn đề (6 items) và đối phó tìm kiếm sự hỗ trợ (4 items).**

Kiểm định giá trị các thang đo

Nghiên cứu đã kiểm định giá trị đo lường của các thang đo sử dụng trong nghiên cứu này và trình bày tại chương 3, mục 3.1. Nội dung kiểm định gồm có độ tin cậy và cấu trúc của thang đo.

2.4.2.2. Phương pháp phỏng vấn

Mục đích nghiên cứu: Thu thập các thông tin liên quan đến rối loạn lo âu và các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở bổ sung cho phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, đồng thời tìm hiểu sâu đặc điểm tâm lý của khách thể thông qua các trường hợp điển hình, khai thác thêm các quan điểm, ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề rối loạn lo âu của học sinh trung học cơ sở từ cả giáo viên và học sinh.

Nội dung phỏng vấn: Nội dung phỏng vấn tập trung vào các vấn đề cốt lõi của nghiên cứu, bao gồm: (1) Thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở; (2) Các dạng rối loạn lo âu thường gặp (lo âu lan tỏa, lo âu xã hội, lo âu chia ly); (3) Các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu (yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ); (4) Các biện pháp phòng ngừa và can thiệp rối loạn lo âu trong môi trường học đường.

Cách thức tiến hành: Nghiên cứu xây dựng phiếu phỏng vấn sâu theo hướng bán cấu trúc, với hệ thống câu hỏi định hướng, linh hoạt. Trước khi tiến hành, người tham gia được thông báo về mục đích nghiên cứu, đảm bảo tính tự nguyện và bảo mật thông tin. Quá trình phỏng vấn được thực hiện trực tiếp với từng đối tượng trong điều kiện phù hợp, đảm bảo tính riêng tư và sự thoải mái khi chia sẻ. Người nghiên cứu sử dụng các câu hỏi gợi mở để khai thác sâu nội dung, ghi chép đầy đủ các thông tin thu thập được. Sau khi thu thập, dữ liệu phỏng vấn được tổng hợp, phân tích định tính theo các nội dung nghiên cứu.

2.4.2.3. Phương pháp quan sát

Mục đích nghiên cứu: Thu thập thông tin trực tiếp về biểu hiện hành vi, cảm xúc và tương tác của học sinh trong các bối cảnh làm bài khảo sát, phỏng vấn trường hợp, bổ sung nguồn kiểm chứng cho dữ liệu thu được từ bảng hỏi và phỏng vấn.

Cách thức tiến hành: Quan sát được thực hiện trực tiếp trong giờ học, giờ ra chơi và thời điểm học sinh thực hiện bảng hỏi, trả lời phỏng vấn. Bên cạnh đó, người nghiên cứu ghi nhận trạng thái tâm lý - thể chất của học sinh tại thời điểm quan sát, như mức độ tập trung, dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi hoặc mất ổn định cảm xúc, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đến độ tin cậy của dữ liệu. Quá trình quan sát được thực hiện kín đáo, hạn chế tối đa sự can thiệp vào hành vi tự nhiên của học sinh. Các thông tin thu thập được được ghi chép, tổng hợp và sử dụng như căn cứ hỗ trợ trong quá trình diễn giải kết quả nghiên cứu.

2.4.3. Phương pháp thống kê toán học

Phương pháp thống kê toán học được sử dụng nhằm phân tích dữ liệu định lượng thu thập từ bảng hỏi, chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu chuẩn để phân tích ý nghĩa khoa học, kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Phương pháp này còn được sử dụng để đánh giá độ tin cậy và giá trị của các thang đo trong nghiên cứu, và phân tích thống kê mô tả

và suy luận, cũng như kiểm định mô hình tác động của các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu.

Dữ liệu thu thập được nhập và xử lý bằng phần mềm thống kê chuyên dụng, bao gồm IBM SPSS Statistics 31.0 và IBM SPSS AMOS 31.0. Trước khi tiến hành các phân tích, dữ liệu được kiểm tra và làm sạch nhằm đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy. Sau bước làm sạch dữ liệu, độ tin cậy và cấu trúc thang đo được đánh giá để đảm bảo công cụ hoạt động tốt trên nhóm mẫu nghiên cứu trước khi tiến hành các phân tích tiếp theo. Độ tin cậy của các thang đo được kiểm định thông qua hệ số Cronbach's alpha và McDonald's omega. Cấu trúc thang đo được kiểm định bằng phân tích nhân tố khẳng định (CFA) trên phần mềm AMOS. Chỉ những thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị cấu trúc mới được sử dụng trong nghiên cứu này. Các phân tích thống kê được thực hiện bao gồm thống kê mô tả (giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, thứ bậc, tỉ lệ phần trăm) nhằm mô tả đặc điểm, mức độ của các biến nghiên cứu, phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng để kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm khách thể, và mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng nhằm đánh giá các mối quan hệ giữa các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ, biện pháp đối phó và rối loạn lo âu. Mức độ phù hợp của mô hình CFA và SEM được đánh giá thông qua các chỉ số χ^2/df (< 5), CFI và TLI ($\geq 0,90$), và RMSEA ($\leq 0,08$), theo các khuyến nghị trong nghiên cứu tâm lý học.

2.5. Đạo đức nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Luận án, quản lý bởi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; thu thập dữ liệu được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu, cha mẹ và học sinh các trường THCS tham gia (có thông báo nghiên cứu gửi nhà trường, cha mẹ và học sinh). Người tham gia được cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, nội dung và quy trình nghiên cứu, sự tự nguyện tham gia, quyền từ chối hoặc rút lui mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Sự đồng thuận được thể hiện trực tiếp trên phiếu khảo sát và phiếu phỏng vấn sâu.

Dữ liệu nghiên cứu được bảo mật nghiêm ngặt. Thông tin định danh được mã hóa và tách biệt khỏi dữ liệu phân tích, chỉ nhóm nghiên cứu có quyền truy cập. Kết quả được trình bày dưới dạng tổng hợp, đảm bảo không thể nhận diện cá nhân. Trong trường hợp học sinh có dấu hiệu khó khăn tâm lý do làm khảo sát sẽ được hỗ trợ kịp thời bởi giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, nhóm nghiên cứu và phụ huynh để hỗ trợ kịp thời. Nghiên

cứu cam kết đảm bảo tính trung thực và toàn vẹn khoa học trong toàn bộ quá trình thực hiện, kết quả được công bố trong các điều kiện khuôn khổ của đề tài nghiên cứu.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày một cách hệ thống về tổ chức và phương pháp nghiên cứu, bao gồm thiết kế nghiên cứu, đặc điểm khách thể, quy trình thu thập dữ liệu và hệ thống công cụ đo lường. Nghiên cứu được triển khai trên mẫu học sinh trung học cơ sở với quy mô lớn, được lựa chọn theo thiết kế phân tầng theo trường và khối lớp, kết hợp với chọn cụm ở cấp lớp học, qua đó đảm bảo tính đại diện tương đối và tính khả thi trong bối cảnh nghiên cứu học đường.

Quá trình nghiên cứu được triển khai qua hai giai đoạn: Giai đoạn nghiên cứu lý luận và giai đoạn nghiên cứu thực tiễn. Các phương pháp được sử dụng trong đề tài bao gồm: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp trắc nghiệm, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp quan sát, phương pháp nghiên cứu trường hợp và phương pháp thống kê toán học. Sự kết hợp giữa hai phương pháp giúp tăng cường độ tin cậy, tính giá trị và khả năng giải thích của kết quả nghiên cứu.

Hệ thống công cụ đo lường bao gồm các thang đo đã được kiểm chứng quốc tế, được hiệu chỉnh theo quy trình chặt chẽ (dịch xuôi- dịch ngược, tham vấn chuyên gia, khảo sát thử nghiệm), đảm bảo tính phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Các thang đo sau khi sàng lọc đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị cấu trúc thông qua phân tích Cronbach's alpha, McDonald's omega và CFA. Cấu trúc bảng hỏi được xây dựng gồm hai phần chính: Phần 1: Thu thập thông tin chung của khách thể (giới tính, khối lớp, học lực và một số đặc điểm liên quan đến sức khỏe, tâm lý và hành vi sinh hoạt của học sinh); Phần 2: Tập trung đánh giá thực trạng rối loạn lo âu và các yếu tố ảnh hưởng.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU

Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung chương này tập trung vào trình bày chi tiết về một số các nội dung chính sau đây:

- Hiệu lực đo lường của các thang đo sử dụng trong nghiên cứu.
- Thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh THCS và các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu (yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ), các biện pháp đối phó của học sinh THCS.
- Kết quả nghiên cứu trường hợp về rối loạn lo âu ở học sinh THCS.
- Đề xuất khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường ở học sinh THCS.

3.1. Hiệu lực đo lường của các thang đo sử dụng trong nghiên cứu

Trong các nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, việc đánh giá hiệu lực đo lường của các thang đo là điều kiện tiên quyết nhằm bảo đảm rằng các biến tiềm ẩn được phản ánh một cách chính xác thông qua các biến quan sát. Theo cách tiếp cận hiện đại, hiệu lực đo lường được xem là một quá trình tích lũy bằng chứng về mức độ phù hợp giữa dữ liệu thực nghiệm và cấu trúc lý thuyết của thang đo, thay vì chỉ là một đặc tính cố định của công cụ đo lường. Trong bối cảnh này, các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh vai trò trung tâm của các chỉ số độ tin cậy nội tại như Cronbach's alpha và McDonald's omega kết hợp với phân tích nhân tố khẳng định CFA nhằm đánh giá đồng thời tính nhất quán nội tại, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các cấu trúc tâm lý (Hair et al., 2021; Hayes & Coutts, 2020; Rodríguez et al., 2020). Đặc biệt, đối với các cấu trúc đa chiều như rối loạn lo âu và các yếu tố ảnh hưởng việc kiểm định mô hình đo lường thông qua CFA cho phép xác nhận cấu trúc nhân tố giả định, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu thông qua các chỉ số như CFI, TLI và RMSEA. Các nghiên cứu gần đây khuyến nghị rằng một mô hình đo lường đạt chuẩn cần có hệ số tải nhân tố đủ lớn ($\geq 0,50$), độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích xuất đạt ngưỡng chấp nhận, cũng như các chỉ số phù hợp mô hình nằm trong giới hạn cho phép ($CFI, TLI \geq 0,90$; RMSEA

$\leq 0,08$), từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc kiểm định các mối quan hệ cấu trúc ở các phân tích tiếp theo (Hair et al., 2021; Kline, 2023; Shi et al., 2020).

Để đảm bảo kết quả nghiên cứu phù hợp với môi trường văn hóa và đặc điểm tâm lý học sinh THCS tại Việt Nam, nghiên cứu này đã tiến hành thích nghi và hiệu chỉnh các thang đo nhằm đạt giá trị đo lường thông qua hai bước chính: (i) kiểm định độ tin cậy nội tại bằng các hệ số Cronbach's alpha và McDonald's omega, và (ii) kiểm định cấu trúc nhân tố thông qua phân tích CFA cho từng tiểu thang đo. Quy trình này nhằm bảo đảm rằng các thang đo sử dụng trong nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn tâm trắc học hiện đại, đồng thời cung cấp cơ sở vững chắc cho các phân tích cấu trúc ở các phần tiếp theo.

3.1.1. Hiệu lực đo lường của thang đo rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo rối loạn lo âu được trình bày tại bảng dưới đây.

Bảng 3.1 Hệ số tin cậy và tương quan trong thang đo rối loạn lo âu

TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω	1	2	3
1	RLLALT	0,811	0,811	1	0,311**	0,690**
2	RLLACL	0,726	0,726		1	0,297**
3	RLLAXH	0,744	0,750			1

(Ghi chú. RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu Chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội).

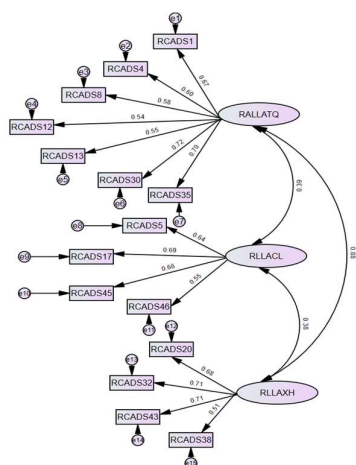
Bảng 3.2 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo rối loạn lo âu

Mô hình	Scales	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	RLLALT	59,152 (14)	4,225	0,982	0,972	0,049	0,036; 0,062
2	RLLACL	28,228 (2)	14,114	0,975	0,926	0,099	0,068; 0,132
3	RLLAXH	11,743 (2)	5,871	0,992	0,976	0,060	0,030; 0,095
4	RLLA (3 factors)	376,067 (87)	4,323	0,951	0,941	0,050	0,045 - 0,055

(Ghi chú. RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu Chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Kết quả Bảng 3.1 cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy chấp nhận được đến tốt, với Cronbach's α và McDonald's ω dao động từ 0,726 đến 0,811. Sự tương đồng giữa hai chỉ số cho thấy ước lượng độ tin cậy ổn định. Các hệ số tương quan giữa các tiểu thang đều dương và có ý nghĩa thống kê ($p < 0,01$). Trong đó, lo âu lan tỏa tương quan mạnh với lo âu xã hội ($r = 0,690$), trong khi các tương quan liên quan đến lo âu chia ly ở mức trung bình ($r = 0,297-0,311$), bước đầu ủng hộ giá trị hội tụ và phân biệt.

Kết quả CFA (Bảng 3.2) cho thấy mô hình đơn nhân tố của lo âu lan tỏa và lo âu xã hội đạt độ phù hợp tốt ($CFI \geq 0,982$; $RMSEA \leq 0,060$). Ngược lại, mô hình lo âu chia ly có mức phù hợp chưa tối ưu ($RMSEA = 0,099$). Đáng chú ý, mô hình ba nhân tố cho thấy độ phù hợp tổng thể tốt ($CFI = 0,951$; $TLI = 0,941$; $RMSEA = 0,050$), ủng hộ cấu trúc đa chiều của rối loạn lo âu. Nhìn chung, kết quả này cung cấp bằng chứng về độ tin cậy và giá trị cấu trúc của mô hình lo âu ba yếu tố, với các thành phần vừa phân biệt vừa có liên hệ với nhau.



Hình 3.1. Mô hình CFA thang đo rối loạn lo âu

3.1.2. Hiệu lực đo lường của các thang đo yếu tố NGUY CƠ

Phần này trình bày kết quả kiểm định hiệu lực đo lường của các thang đo yếu tố nguy cơ thông qua các phân tích độ tin cậy và cấu trúc nhân tố nhằm đánh giá mức độ phù hợp của các công cụ sử dụng trong nghiên cứu.

3.1.2.1. Thang đo áp lực học tập

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo áp lực học tập được trình bày tại các bảng dưới đây.

Bảng 3.3 Hệ số tin cậy thang đo áp lực học tập

TT	Thang đo	Cronbach's α	McDonald's ω
1	Áp lực học tập	0,708	0,716

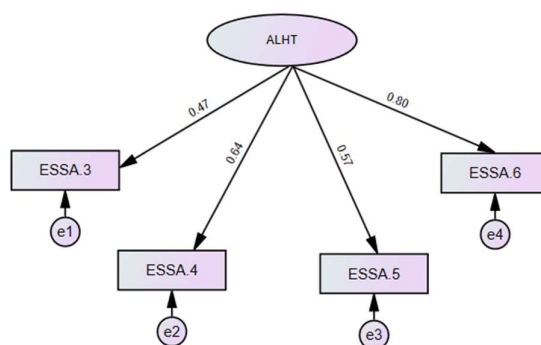
Bảng 3.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo áp lực học tập

Mô hình	Thang đo	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	Áp lực học tập	3,543 (2)	1,772	0,998	0,995	0,024	0,000 - 0,064

Kết quả phân tích tại Bảng 3.3 cho thấy thang đo áp lực học tập đạt độ tin cậy chấp nhận được, với Cronbach's $\alpha = 0,708$ và McDonald's $\omega = 0,716$. Hai chỉ số đều trên 0,70 cho thấy các mục đo có mức độ nhất quán nội tại phù hợp để sử dụng trong nghiên cứu này.

Kết quả CFA (Bảng 3.4) chỉ ra rằng mô hình đo lường của thang đo áp lực học tập có độ phù hợp rất tốt với dữ liệu ($\chi^2/df = 1,772$; CFI = 0,998; TLI = 0,995; RMSEA = 0,024). Khoảng tin cậy 90% của RMSEA nằm trong ngưỡng lý tưởng (0,000 - 0,064), củng cố thêm bằng chứng về mức độ phù hợp của mô hình sử dụng trong nghiên cứu.

Nhìn chung, các kết quả này cung cấp bằng chứng cho thấy thang đo áp lực học tập có độ tin cậy và giá trị cấu trúc tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nghiên cứu.

**Hình 3.2.** Mô hình CFA thang đo áp lực học tập

3.1.2.2. Thang đo nghiên cứu điện thoại

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo nghiên cứu điện thoại được trình bày tại các bảng dưới đây.

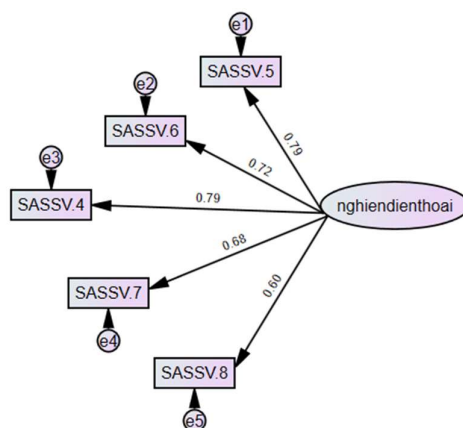
Bảng 3.5 Hệ số tin cậy thang đo nghiên cứu điện thoại

TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω
1	Nghiện điện thoại (NĐT)	0,836	0,839

Bảng 3.6 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo nghiện điện thoại

Mô hình	Thang đo	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	Nghiện điện thoại	15,234 (5)	3,047	0,996	0,992	0,039	0,018 - 0,062

Kết quả phân tích tại Bảng 3.5 cho thấy thang đo nghiện điện thoại đạt độ tin cậy tốt, với Cronbach's $\alpha = 0,836$ và McDonald's $\omega = 0,839$. Các hệ số đều $>0,80$, phản ánh mức độ nhất quán nội tại cao giữa các mục đo. Kết quả CFA (Bảng 3.6) cho thấy mô hình đo lường của thang đo này có độ phù hợp rất tốt với dữ liệu ($\chi^2/df = 3,047$; CFI = 0,996; TLI = 0,992; RMSEA = 0,039). Khoảng tin cậy 90% của RMSEA (0,018 - 0,062) nằm trong ngưỡng chấp nhận, củng cố tính phù hợp của mô hình. Nhìn chung, các kết quả cung cấp bằng chứng vững chắc về độ tin cậy và giá trị cấu trúc của thang đo nghiện điện thoại, đủ điều kiện sử dụng trong các phân tích tiếp theo.



Hình 3.3. Mô hình CFA thang đo nghiện điện thoại

3.1.2.3. Thang đo bất nạt học đường

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo bất nạt học đường được trình bày tại các bảng dưới đây.

Bảng 3.7 Hệ số tin cậy và tương quan trong thang đo bất nạt học đường

TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω	1	2
----	---------	---------------------	---------------------	---	---

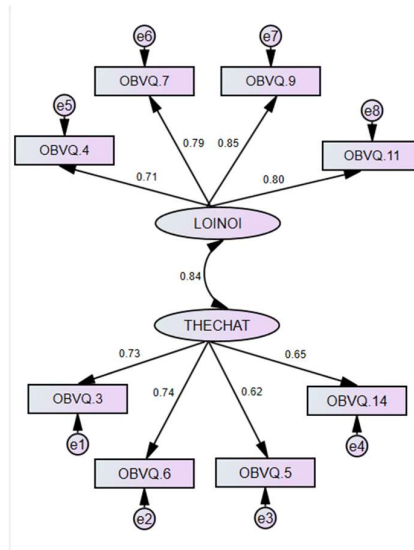
1	Bất nạt thể chất	0,775	0,777	1	0,697**
2	Bất nạt lời nói	0,864	0,864		1
3	Bất nạt học đường	0,810	0,810	-	-

Bảng 3.8 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo bất nạt học đường

Mô hình	Thang đo	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	Bất nạt thể chất	8,779 (2)	4,389	0,995	0,986	0,050	0,020 – 0,086
2	Bất nạt lời nói	15,897 (2)	7,949	0,995	0,984	0,072	0,042 - 0,106
3	Bất nạt học đường (2 factors)	102,853 (19)	5,413	0,983	0,975	0,057	0,047 – 0,068

Kết quả Bảng 3.7 cho thấy các tiểu thang đo bất nạt thể chất ($\alpha = 0,775$; $\omega = 0,777$) và bất nạt lời nói ($\alpha = 0,864$; $\omega = 0,864$) đều đạt độ tin cậy từ chấp nhận được đến tốt, trong đó thang đo bất nạt lời nói có độ tin cậy cao hơn. Thang đo tổng thể bất nạt học đường cũng đạt độ tin cậy tốt ($\alpha = 0,810$; $\omega = 0,810$). Hệ số tương quan giữa hai tiểu thang ở mức cao ($r = 0,697$, $p < 0,01$), cho thấy hai thang đo bất nạt có mối liên hệ chặt chẽ nhưng vẫn phân biệt với nhau.

Kết quả CFA (Bảng 3.8) cho thấy các mô hình đơn nhân tố đều đạt mức độ phù hợp chấp nhận được. Cụ thể, mô hình bất nạt thể chất có chỉ số phù hợp tốt ($CFI = 0,995$; $RMSEA = 0,050$), trong khi mô hình bất nạt lời nói có $RMSEA = 0,072$, cho thấy mức phù hợp trung bình. Đáng chú ý, mô hình hai nhân tố của thang đo bất nạt học đường đạt độ phù hợp tổng thể tốt ($CFI = 0,983$; $TLI = 0,975$; $RMSEA = 0,057$), ủng hộ cấu trúc gồm hai thành phần phân biệt nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau.



Hình 3.4. Mô hình CFA thang đo bắt nạt học đường

3.1.3. Hiệu lực đo lường của các thang đo yếu tố bảo vệ

Phần này trình bày kết quả kiểm định hiệu lực đo lường của các thang đo yếu tố bảo vệ thông qua các phân tích độ tin cậy và cấu trúc nhân tố nhằm đánh giá mức độ phù hợp của các công cụ sử dụng trong nghiên cứu.

3.1.3.1. Thang đo gắn bó với trường học

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo gắn bó với trường học được trình bày dưới đây.

Bảng 3.9 Hệ số tin cậy thang đo gắn bó với trường học

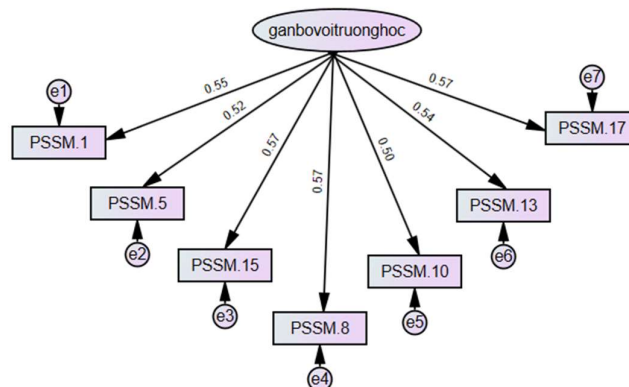
TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω
1	Gắn bó với trường học	0,747	0,746

Bảng 3.10 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo gắn bó với trường học

Mô hình	Scales	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	Gắn bó với trường học	48,081 (14)	3,434	0,978	0,966	0,042	0,030 - 0,056

Kết quả tại Bảng 3.9 cho thấy thang đo gắn bó với trường học đạt độ tin cậy chấp nhận được, với Cronbach's $\alpha = 0,747$ và McDonald's $\omega = 0,746$, phản ánh mức độ nhất

quán nội tại phù hợp giữa các mục đo. Kết quả CFA (Bảng 3.10; Hình 3.5) cho thấy mô hình đơn nhân tố của thang đo có độ phù hợp tốt với dữ liệu ($\chi^2/df = 3,434$; CFI = 0,978; TLI = 0,966; RMSEA = 0,042). Khoảng tin cậy 90% của RMSEA (0,030 - 0,056) nằm trong ngưỡng lý tưởng, củng cố thêm bằng chứng về giá trị cấu trúc của thang đo. Nhìn chung, các kết quả cho thấy thang đo gắn bó với trường học có độ tin cậy và giá trị đo lường tốt, phù hợp yêu cầu sử dụng trong các phân tích tiếp theo.



Hình 3.5. Mô hình CFA thang đo gắn bó với trường học

3.1.3.2. Thang đo cảm nhận hỗ trợ

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo cảm nhận hỗ trợ được trình bày dưới đây.

Bảng 3.11 Hệ số tin cậy và tương quan trong thang đo cảm nhận hỗ trợ

TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω	1	2
1	Cảm nhận hỗ trợ từ cha mẹ	0,847	0,848	1	0,370**
2	Cảm nhận hỗ trợ từ bạn bè	0,837	0,837		1

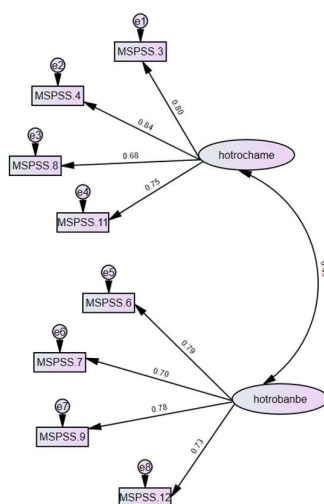
Bảng 3.12 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo cảm nhận hỗ trợ

Mô hình	Scales	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
---------	--------	--------------	-------------	-----	-----	-------	--------------

1	Cảm nhận hỗ trợ từ cha mẹ	11,914 (2)	5,957	0,996	0,987	0,061	0,031 - 0,096
2	Cảm nhận hỗ trợ từ bạn bè	13,162 (2)	6,581	0,995	0,984	0,064	0,034 - 0,099
3	Cảm nhận hỗ trợ (2 factors)	70,392 (19)	3,705	0,989	0,983	0,045	0,034 - 0,056

Kết quả phân tích tại Bảng 3.11 cho thấy các tiểu thang đo cảm nhận hỗ trợ từ cha mẹ ($\alpha = 0,847$; $\omega = 0,848$) và cảm nhận hỗ trợ từ bạn bè ($\alpha = 0,837$; $\omega = 0,837$) đều đạt độ tin cậy tốt. Các hệ số đều lớn hơn 0,80, cho thấy mức độ nhất quán nội tại cao giữa các mục đo. Hệ số tương quan giữa hai tiểu thang ở mức trung bình ($r = 0,370$, $p < 0,01$), cho thấy hai nguồn hỗ trợ có mối liên hệ với nhau nhưng vẫn đảm bảo tính phân biệt.

Kết quả CFA (Bảng 3.12) cho thấy các mô hình đơn nhân tố đều đạt mức độ phù hợp chấp nhận được. Cụ thể, mô hình cảm nhận hỗ trợ từ cha mẹ và cảm nhận hỗ trợ từ bạn bè có chỉ số phù hợp tốt. Đáng chú ý, mô hình hai nhân tố của thang đo cảm nhận hỗ trợ đạt độ phù hợp tổng thể tốt ($CFI = 0,989$; $TLI = 0,983$; $RMSEA = 0,045$), ủng hộ cấu trúc gồm hai thành phần phân biệt nhưng có liên hệ với nhau.



Hình 3.6. Mô hình CFA thang đo cảm nhận hỗ trợ (2 factors)

3.1.3.3. Thang đo biện pháp đối phó

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo biện pháp đối phó được trình bày dưới đây.

Bảng 3.13 Hệ số tin cậy thang đo biện pháp đối phó

TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω
1	Tránh né	0,727	0,705
2	Đối phó giải quyết vấn đề	0,700	0,699
3	Tìm kiếm sự hỗ trợ	0,773	0,775

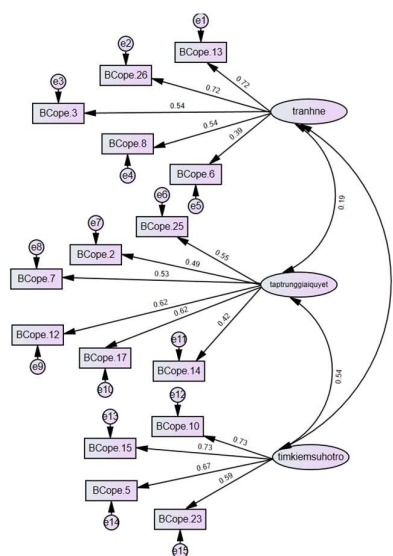
Bảng 3.14 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo biện pháp đối phó

Mô hình	Scales	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	Tránh né	198,886 (5)	39,78	0,862	0,724	0,169	0,150 - 0,190
2	Đối phó giải quyết vấn đề	41,734 (9)	4,637	0,972	0,953	0,052	0,037 - 0,068
3	Tìm kiếm sự hỗ trợ	0,680 (2)	0,340	1,000	1,003	0,000	0,000 - 0,039
4	Biện pháp đối phó (3 factors)	526,681 (87)	6,05	0,901	0,880	0,061	0,056 - 0,066

Kết quả phân tích tại Bảng 3.13 cho thấy các tiểu thang đo đều đạt độ tin cậy từ chấp nhận được đến tốt. Cụ thể, tránh né ($\alpha = 0,727$; $\omega = 0,705$), đối phó giải quyết vấn đề ($\alpha = 0,700$; $\omega = 0,699$) và tìm kiếm sự hỗ trợ ($\alpha = 0,773$; $\omega = 0,775$). Nhìn chung, các hệ số ổn định đều tương đương 0,70, cho thấy mức độ nhất quán nội tại phù hợp.

Kết quả CFA (Bảng 3.14) cho thấy mức độ phù hợp của các mô hình có sự khác biệt. Mô hình tránh né có độ phù hợp kém (CFI = 0,862; RMSEA = 0,169). Ngược lại, mô hình đối phó giải quyết vấn đề đạt mức phù hợp tốt (CFI = 0,972; RMSEA = 0,052), và mô hình tìm kiếm sự hỗ trợ có độ phù hợp rất tốt (CFI = 1,000; RMSEA = 0,000). Đối với mô hình ba nhân tố, các chỉ số cho thấy mức phù hợp chấp nhận được (CFI = 0,901; TLI = 0,880; RMSEA = 0,061). Nhìn chung, thang đo biện pháp đối phó đạt độ tin cậy

chấp nhận được, tuy nhiên cấu trúc mô hình chưa đồng đều giữa các thành phần, trong đó yếu tố tránh né có mức độ phù hợp thấp hơn so với các yếu tố còn lại. Mặc dù mô hình CFA ba tiểu thang gốc cho thấy tránh né có độ phù hợp kém ($CFI = 0,862$; $RMSEA = 0,169$), khi gộp lại thành hai chiều - thích nghi/ không thích nghi - cho phân tích chính, kết quả độ tin cậy và phù hợp được đánh giá lại ở cấp độ hai chiều - phù hợp với cách phân tích theo lý thuyết Lazarus và Folkman (1984).



Hình 3.7. Mô hình CFA thang đo biện pháp đối phó (3 factors)

3.1.3.4. Thang đo tự trọng

Kết quả phân tích và diễn giải hiệu lực đo lường của thang đo tự trọng được trình bày dưới đây.

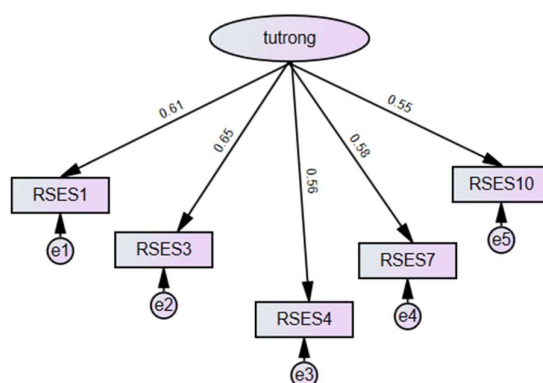
Bảng 3.15 Hệ số tin cậy thang đo tự trọng

TT	Mệnh đề	Cronbach's α	McDonald's ω
1	Tự trọng	0,725	0,724

Bảng 3.16 Phân tích nhân tố khẳng định CFA thang đo tự trọng

Mô hình	Scales	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
1	Tự trọng	18,567 (5)	3,713	0,988	0,976	0,045	0,024 - 0,067

Kết quả tại Bảng 3.15 cho thấy thang đo tự trọng đạt độ tin cậy chấp nhận được, với Cronbach's $\alpha = 0,725$ và McDonald's $\omega = 0,724$, phản ánh mức độ nhất quán nội tại phù hợp giữa các mục đo. Kết quả CFA (Bảng 3.16) cho thấy mô hình đơn nhân tố của thang đo có độ phù hợp tốt với dữ liệu ($\chi^2/df = 3,713$; CFI = 0,988; TLI = 0,976; RMSEA = 0,045). Khoảng tin cậy 90% của RMSEA (0,024 - 0,067) nằm trong ngưỡng chấp nhận, củng cố thêm bằng chứng về giá trị cấu trúc của thang đo. Có thể nhận định rằng, thang đo tự trọng có độ tin cậy và giá trị đo lường tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các phân tích tiếp theo.



Hình 3.8. Mô hình CFA thang đo tự trọng

3.2. Thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh THCS

Phần này trình bày kết quả phân tích mức độ và biểu hiện của các rối loạn lo âu ở học sinh THCS thông qua các chỉ số thống kê mô tả, qua đó làm rõ đặc điểm phân bố và sự khác biệt giữa các biểu hiện lo âu trong mẫu nghiên cứu.

3.2.1. Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS

Kết quả phân tích, diễn giải mức độ và biểu hiện của rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS được trình bày ở bảng 3.17 dưới đây.

Bảng 3.17 Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS

TT	Mệnh đề	Min	Max	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
RCADS1	Tôi lo lắng về mọi thứ.	1	4	49,14	30,72	6
RCADS4	Tôi lo lắng khi nghĩ rằng mình đã không làm tốt điều gì đó.	1	4	64,28	29,69	1

RCADS8	Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng ai đó đang giận tôi.	1	4	59,02	33,48	3
RCADS12	Tôi lo lắng rằng mình sẽ làm bài tập ở trường kém.	1	4	55,13	33,84	5
RCADS13	Tôi lo lắng rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với ai đó trong gia đình tôi.	1	4	59,62	35,86	2
RCADS30	Tôi lo lắng về việc mắc lỗi.	1	4	57,69	31,26	4
RCADS35	Tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra.	1	4	45,86	33,83	7

(Ghi chú: Min=điểm tối thiểu; Max=điểm tối đa; ĐTB=điểm trung bình; DLC=Độ lệch chuẩn)

Kết quả tại Bảng 3.17 cho thấy điểm trung bình của các biểu hiện rối loạn lo âu lan tỏa ở học sinh THCS dao động từ 45,86 đến 64,28, phản ánh sự khác biệt giữa các biểu hiện lo âu. Trong đó, học sinh lo lắng nhiều nhất khi nghĩ rằng mình đã không làm tốt điều gì đó (ĐTB = 64,28) suy nghĩ này phản ánh đặc thù của lứa tuổi vị thành niên — tự đánh giá nghiêm khắc và xu hướng tự trách; tiếp theo là lo lắng về việc có điều tồi tệ xảy ra với người thân - lo âu mang tính giả định (ĐTB = 59,62) và lo lắng khi nghĩ rằng ai đó đang giận mình (ĐTB = 59,02). Các biểu hiện lo lắng về mắc lỗi (ĐTB = 57,69) và kết quả học tập (ĐTB = 55,13) cũng xuất hiện với mức độ đáng kể. Trong khi đó, mức độ lo lắng thấp hơn được ghi nhận ở các nội dung lo lắng về mọi thứ nói chung (ĐTB = 49,14) và lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai (ĐTB = 45,86). Các biểu hiện này phù hợp với khung phát triển Steinberg (2014) về sự nhạy cảm tăng dần với tự đánh giá ở tuổi dậy thì.

Độ lệch chuẩn của các biến dao động từ 29,69 đến 35,86, cho thấy sự phân tán đáng kể trong mức độ lo âu giữa các học sinh. Nhìn chung, học sinh có xu hướng lo lắng nhiều hơn đối với các tình huống liên quan đến đánh giá bản thân, học tập, mối quan hệ xã hội và gia đình.

3.2.2. Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu chia ly ở học sinh THCS

Kết quả phân tích, diễn giải mức độ và biểu hiện của rối loạn lo âu chia ly ở học sinh THCS được trình bày ở bảng 3.18 dưới đây.

Bảng 3.18 *Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu chia ly ở học sinh THCS*

TT	Mệnh đề	Min	Max	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
RCADS5	Tôi cảm thấy sợ khi ở một mình ở nhà.	1	4	25,35	33,375	2
RCADS17	Tôi cảm thấy sợ nếu phải ngủ một mình.	1	4	25,49	33,777	2
RCADS45	Tôi lo lắng khi đi ngủ vào ban đêm.	1	4	21,52	30,771	4
RCADS46	Tôi sẽ cảm thấy sợ nếu phải ở xa nhà qua đêm.	1	4	27,88	33,109	1

(Ghi chú: Min=điểm tối thiểu; Max=điểm tối đa; ĐTB=điểm trung bình; ĐLC=Độ lệch chuẩn)

Kết quả phân tích tại Bảng 3.18 cho thấy, điểm trung bình của các biểu hiện rối loạn lo âu chia ly ở học sinh THCS dao động từ 21,52 đến 27,88, phản ánh mức độ lo âu khác nhau tùy theo bối cảnh tách rời. Trong đó, học sinh lo lắng nhiều nhất khi phải ở xa nhà qua đêm (ĐTB = 27,88), tiếp theo là sợ khi phải ngủ một mình (ĐTB = 25,49) và khi ở một mình ở nhà (ĐTB = 25,35). Mức độ lo lắng thấp hơn được ghi nhận ở biểu hiện lo lắng khi đi ngủ vào ban đêm (ĐTB = 21,52). Độ lệch chuẩn của các biến dao động từ 30,771 đến 33,777, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các cá nhân.

3.2.3. Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu xã hội ở học sinh THCS

Kết quả phân tích, diễn giải mức độ và biểu hiện của rối loạn lo âu xã hội ở học sinh THCS được trình bày ở bảng 3.19 dưới đây.

Bảng 3.19 Mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu xã hội ở học sinh THCS

TT	Mệnh đề	Min	Max	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
RCADS20	Tôi lo rằng mình sẽ trông ngốc nghếch.	1	4	42,09	34,075	4
RCADS32	Tôi lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình.	1	4	56,98	34,992	1
RCADS43	Tôi sợ rằng mình sẽ làm trò cười trước mặt người khác.	1	4	49,26	35,139	2
RCADS38	Tôi cảm thấy sợ nếu phải nói trước lớp.	1	4	45,32	35,068	3

(Ghi chú: Min=điểm tối thiểu; Max=điểm tối đa; ĐTB=điểm trung bình; DLC=Độ lệch chuẩn)

Kết quả phân tích trong Bảng 3.19 cho thấy, điểm trung bình của các biểu hiện rối loạn lo âu xã hội ở học sinh THCS dao động từ 42,09 đến 56,98, phản ánh sự khác biệt giữa các tình huống mang tính đánh giá xã hội. Trong đó, học sinh lo lắng nhiều nhất về việc người khác nghĩ gì về mình (ĐTB = 56,98), tiếp theo là sợ trở thành trò cười trước mặt người khác (ĐTB = 49,26) và sợ phải nói trước lớp (ĐTB = 45,32). Mức độ lo lắng thấp hơn được ghi nhận ở biểu hiện lo rằng mình sẽ trông ngốc nghếch (ĐTB = 42,09). Độ lệch chuẩn của các biến dao động từ 34,075 đến 35,139, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các học sinh. Nhìn chung, các biểu hiện lo âu xã hội tập trung vào nỗi sợ bị đánh giá tiêu cực và hình ảnh bản thân trước người khác. Số liệu này phù hợp với mô hình Clark & Wells (1995) về lo âu xã hội: tâm điểm là mối bận tâm với đánh giá tiêu cực từ người khác.

Bảng 3.20 Mức độ rối loạn lo âu ở học sinh THCS qua các biến đặc điểm khách thể

Biến	Nhóm	SL	RLLALT ĐTB (DLC)	RLLACL ĐTB (DLC)	RLLAXH ĐTB (DLC)	RLLA ĐTB (DLC)
Giới tính	Male	614	51,43 (22,010)	25,42 (25,459)	43,20 (25,093)	40,02 (19,020)
	Female	738	59,47 (22,072)	24,76 (23,294)	52,74 (26,311)	45,66 (18,913)
			$F = 44,484$ $p < 0,001$	$F = 0,246$ $p = 0,620$	$F = 45,984$ $p < 0,001$	$F = 29,642$ $p < 0,001$
Khối lớp	6	368	54,32 (21,390)	32,13 (26,350)	46,42 (24,056)	44,29 (19,079)
	7	316	53,65 (21,905)	27,14 (24,062)	48,10 (26,233)	42,96 (18,727)
	8	340	55,63 (23,701)	20,88 (22,914)	46,37 (26,691)	40,96 (19,508)
	9	328	59,79 (22,165)	19,46 (21,144)	53,05 (27,435)	44,10 (19,199)

(Ghi chú: *RLLALT*=rối loạn lo âu lan tỏa; *RLLACL*=rối loạn lo âu chia ly; *RLLAXH*=rối loạn lo âu xã hội; *RLLA*=rối loạn lo âu)

Kết quả phân tích ở Bảng 3.20 cho thấy, có sự khác biệt về mức độ rối loạn lo âu theo giới tính. Cụ thể, học sinh nữ có điểm trung bình cao hơn học sinh nam ở rối loạn lo âu lan tỏa (59,47 so với 51,43), lo âu xã hội (52,74 so với 43,20) và tổng thể rối loạn lo âu (45,66 so với 40,02). Các khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê ($F = 44,484$; $F = 45,984$; $F = 29,642$; $p < 0,001$). Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đó. Cụ thể, nghiên cứu của Ngô Anh Vinh và cộng sự cho thấy học sinh nữ có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có lo âu, cao hơn so với học sinh nam (Ngô Anh Vinh & cộng sự, 2022). Tương tự, Đinh Văn Tài và cộng sự cũng ghi nhận tỷ lệ lo âu ở học sinh nữ cao hơn học sinh nam (Đinh Văn Tài & cộng sự, 2021). Ngược lại, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về lo âu chia ly giữa hai giới ($F = 0,246$; $p = 0,620$).

Đối với khối lớp, kết quả phân tích phương sai cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về rối loạn lo âu lan tỏa ($F = 5,020$; $p = 0,002$), lo âu chia ly ($F = 21,239$; $p < 0,001$) và lo âu xã hội ($F = 4,879$; $p = 0,002$) giữa các khối lớp. Cụ thể, lo âu lan tỏa có xu hướng tăng dần từ khối 6 (ĐTB = 54,32) đến khối 9 (ĐTB = 59,79). Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó khi cho thấy học sinh các khối lớp cuối cấp trung học cơ sở (lớp 8-9) có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, bao gồm lo âu, cao hơn so với học sinh các khối lớp đầu cấp (lớp 6-7). Sự khác biệt này có thể liên quan đến việc mức độ khó của chương trình học tăng dần theo khối lớp, kéo theo áp lực học tập ngày càng lớn. Đồng thời, học sinh cuối cấp còn phải đối mặt với áp lực thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biểu hiện lo âu (Ngô Anh Vinh & cộng sự, 2022). Ngược lại, lo âu chia ly giảm dần theo khối lớp (từ 32,13 ở khối 6 xuống 19,46 ở khối 9). Lo âu xã hội dao động giữa các khối nhưng đạt giá trị cao nhất ở khối 9 (ĐTB = 53,05).

Riêng về lo âu chia ly, số liệu này đưa ra một phát hiện phù hợp với khung lý thuyết: sự giảm dần mức độ lo âu chia ly theo khối lớp, từ lớp 6 đến lớp 9: từ 32,13 $\rightarrow$ 27,14 $\rightarrow$ 20,88 đến 19,4, với tổng điểm 12,67 trong 3 năm. Điều này phù hợp với khung DSM-5: lo âu chia ly là rối loạn khởi phát sớm và giảm khi trẻ bắt đầu trưởng thành tự lập.

Đối với rối loạn lo âu tổng thể, mặc dù có sự khác biệt về điểm trung bình giữa các khối lớp, kiểm định ANOVA cho thấy sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê ($F =$

2,195; $p = 0,087$). Nhìn chung, mức độ rối loạn lo âu khác biệt theo giới tính và có sự khác biệt theo khối lớp ở một số loại lo âu cụ thể.

3.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu

Phần này trình bày kết quả phân tích thực trạng các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh THCS thông qua các chỉ số thống kê mô tả, nhằm làm rõ mức độ và biểu hiện của các yếu tố nguy cơ trong mẫu nghiên cứu.

3.3.1. Thực trạng các yếu tố NGUY CƠ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu

Bảng 3.21 Mức độ và biểu hiện của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến rối RLLA

TT	Mệnh đề	Min	Max	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
A. Áp lực học tập		0	100	51,13	23,922	1
ESSA.3	Tôi cảm thấy có quá nhiều bài tập về nhà.	0	100	50,49	33,045	2
ESSA.4	Việc học tập và đòi hỏi sự nghiệp tương lai mang lại cho tôi rất nhiều áp lực học tập.	0	100	58,56	31,972	1
ESSA.5	Cha mẹ tôi quá quan tâm đến điểm số của tôi, điều đó gây cho tôi nhiều áp lực.	0	100	49,58	33,857	3
ESSA.6	Tôi cảm thấy có quá nhiều kết quả kiểm tra/ kỳ thi kém.	0	100	45,91	32,161	4
B. Nghiện điện thoại		0	100	28,38	24,565	2
SASSV.5	Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn và bồn chồn khi không cầm điện thoại trên tay .	0	100	23,89	31,238	4

SASSV.6	Tâm trí tôi luôn nghĩ về điện thoại ngay cả khi không sử dụng nó.	0	100	20,91	29,107	5
SASSV.4	Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nếu không có điện thoại.	0	100	34,15	33,397	2
SASSV.7	Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc dùng điện thoại ngay cả khi nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi.	0	100	27,05	29,953	3
SASSV.8	Tôi liên tục kiểm tra điện thoại để không bỏ lỡ các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội (Facebook, tiktok, zalo,...)	0	100	35,92	34,015	1
C. Bắt nạt thể chất		0	100	13,52	19,874	3
OBVQ.3	Tôi bị đánh đá, xô đẩy, hoặc bị nhốt trong nhà.	0	100	10,60	23,681	4
OBVQ.6	Tôi bị đe dọa hoặc ép buộc làm những việc mình không muốn làm.	0	100	14,20	26,602	2
OBVQ.5	Tôi bị lấy mất tiền hoặc bị hư hỏng tài sản	0	100	18,49	28,375	1
OBVQ.14	Tôi bị bắt nạt theo một cách khác	0	100	10,78	23,966	3
D. Bắt nạt lời nói		0	100	18,51	24,677	4
OBVQ.4	Các bạn học khác đã nói dối hoặc lan truyền tin đồn thất thiệt về tôi và cố gắng khiến người khác ghét tôi.	0	100	21,80	30,302	1

OBVQ.7	Tôi bị bắt nạt bằng những cái tên hoặc những lời lẽ ác ý về đặc điểm cơ thể hoặc quần áo của mình.	0	100	19,86	31,011	2
OBVQ.9	Tôi bị bắt nạt bằng những lời lẽ hoặc bình luận cử chỉ thô lỗ.	0	100	16,57	27,897	3
OBVQ.11	Tôi bị bắt nạt bằng những lời lẽ hoặc bình luận cử chỉ ác ý mang tính chất tình dục.	0	100	15,79	27,833	4

(Ghi chú: Min=điểm tối thiểu; Max=điểm tối đa; ĐTB=điểm trung bình; DLC=Độ lệch chuẩn)

Kết quả tại Bảng 3.21 cho thấy mức độ các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh THCS có sự khác biệt rõ rệt, với điểm trung bình dao động từ 13,52 đến 51,13. Trong đó, áp lực học tập có điểm trung bình cao nhất (ĐTB = 51,13), tiếp theo là nghiện điện thoại (ĐTB = 28,38), bắt nạt lời nói (ĐTB = 18,51) và bắt nạt thể chất (ĐTB = 13,52).

Đối với áp lực học tập, học sinh chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ áp lực liên quan đến kỳ vọng học tập và định hướng tương lai (ĐTB = 58,56), tiếp theo là khối lượng bài tập (ĐTB = 50,49) và áp lực từ cha mẹ (ĐTB = 49,58). Trong khi đó, cảm nhận về kết quả học tập kém có mức thấp hơn (ĐTB = 45,91).

Ở yếu tố nghiện điện thoại, hành vi kiểm tra điện thoại liên tục để không bỏ lỡ thông tin có mức cao nhất (ĐTB = 35,92), tiếp đến là cảm giác không thể thiếu điện thoại (ĐTB = 34,15). Các biểu hiện còn lại có mức thấp hơn, dao động từ 20,91 đến 27,05.

Đối với bắt nạt học đường, mức độ bắt nạt thể chất nhìn chung thấp hơn so với bắt nạt lời nói. Trong đó, hành vi bị lấy tài sản có mức cao nhất trong nhóm bắt nạt thể chất (ĐTB = 18,49), còn ở bắt nạt lời nói, việc bị lan truyền tin đồn và cô lập xã hội có mức cao nhất (ĐTB = 21,80).

Độ lệch chuẩn của các biến tương đối lớn, cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các học sinh về mức độ trải nghiệm các yếu tố nguy cơ.

Như vậy, ba nhóm yếu tố nguy cơ trên có thứ tự cường độ: *áp lực học tập* (ĐTB = 51,13) > *nghiện điện thoại* (28,38) > *bắt nạt thể chất* (13,52). *Áp lực học tập* là yếu tố có cường độ cao nhất trong nhóm nguy cơ — vượt giữa thang đo (50/100). Trong áp lực học

tập, biểu hiện cao nhất là ESSA.4 "việc học và đòi hỏi sự nghiệp tương lai" (ĐTB = 58,56). Điều này phản ánh đặc thù bối cảnh giáo dục Việt Nam: học sinh THCS đã chịu áp lực tương lai sớm hơn so với học sinh ở các nước phát triển khối Âu Mỹ.

Nhìn chung, áp lực học tập là yếu tố nguy cơ nổi bật nhất, trong khi các yếu tố liên quan đến bất nạt có mức độ thấp hơn nhưng vẫn hiện diện trong trải nghiệm của học sinh. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đó khi đều nhấn mạnh vai trò của áp lực học tập đối với rối loạn lo âu ở học sinh. Cụ thể, nghiên cứu của Lê Thị Phương Thanh và cộng sự cho thấy áp lực học tập là một yếu tố quan trọng liên quan đến tình trạng lo âu và căng thẳng (Lê Thị Phương Thanh & cộng sự, 2024). Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nguyễn Thị Vân cũng chỉ ra rằng các nguyên nhân liên quan đến học tập được đánh giá có mức độ ảnh hưởng cao nhất đến rối loạn lo âu ở học sinh, qua đó củng cố thêm kết quả của nghiên cứu này (Nguyễn Thị Vân, 2018).

Kết quả này, phù hợp với kết quả phỏng vấn của học sinh. Phỏng vấn học sinh NND học sinh lớp 9 chia sẻ: *“Trong thời gian gần đây điều em lo lắng là vấn đề về việc sắp thi cấp ba và điểm số của bản thân mình, em thường xuyên lo lắng về việc này vì đó là tương lai của bản thân”*. Phát biểu này phản ánh rõ áp lực về kỳ vọng học tập và định hướng tương lai - yếu tố có điểm trung bình cao nhất. Điều đó cho thấy, thi cử và kết quả học tập gắn chặt với nhận thức về tương lai, từ đó làm gia tăng lo âu. Sự nhất quán giữa dữ liệu định lượng và định tính củng cố kết luận rằng áp lực học tập, đặc biệt là áp lực về tương lai, là yếu tố nguy cơ nổi bật đối với sức khỏe tâm thần học sinh.

3.3.2. Thực trạng các yếu tố BẢO VỆ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu

Bảng 3.22 Mức độ và biểu hiện của các yếu tố bảo vệ ảnh hưởng đến RLLA

TT	Mệnh đề	Min	Max	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
<i>F. Gắn bó với trường học</i>		<i>0</i>	<i>100</i>	<i>52,60</i>	<i>20,021</i>	<i>4</i>
PSSM.1	Tôi cảm thấy mình là một phần của ngôi trường này.	0	100	47,86	32,273	5
PSSM.5	Phần lớn giáo viên ở trường quan tâm đến tôi.	0	100	47,36	29,127	6
PSSM.15	Mọi người ở trường biết rằng tôi có thể học tập/ làm việc tốt.	0	100	52,02	30,687	4

PSSM.8	Mọi người ở trường thân thiện với tôi.	0	100	57,40	29,350	2
PSSM.10	Tôi được tham gia vào nhiều hoạt động ở trường.	0	100	57,69	32,242	1
PSSM.13	Tôi có thể thực sự là chính mình khi ở trường.	0	100	53,25	33,580	3
G. Cảm nhận hỗ trợ từ cha mẹ		0	100	57,65	27,001	1
MSPSS.3	Gia đình tôi thực sự cố gắng giúp đỡ tôi.	0	100	65,48	31,441	1
MSPSS.4	Tôi nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ về mặt cảm xúc mà tôi cần từ gia đình.	0	100	59,82	32,806	2
MSPSS.8	Tôi có thể nói chuyện về những vấn đề của mình với gia đình.	0	100	47,54	34,157	4
MSPSS.11	Gia đình tôi sẵn sàng giúp tôi đưa ra quyết định.	0	100	57,75	31,969	3
H. Cảm nhận hỗ trợ từ bạn bè		0	100	54,27	25,907	3
MSPSS.6	Bạn bè tôi thực sự cố gắng giúp đỡ tôi.	0	100	57,12	31,060	2
MSPSS.7	Tôi có thể trông cậy vào bạn bè khi mọi việc không suôn sẻ.	0	100	42,38	30,421	4
MSPSS.9	Tôi có những người bạn mà tôi có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.	0	100	61,93	32,387	1
MSPSS.12	Tôi có thể nói chuyện về những vấn đề của mình với bạn bè.	0	100	55,66	32,540	3
K. Tự trọng		0	100	54,85	18,995	2
RSES1	Nhìn chung, tôi hài lòng với bản thân mình.	0	100	52,19	27,419	4
RSES3	Tôi cảm thấy mình có nhiều phẩm chất tốt.	0	100	53,23	26,021	2

RSES4	Tôi có khả năng làm mọi việc tốt như hầu hết những người khác.	0	100	50,02	26,688	5
RSES7	Tôi cảm thấy mình là một người có giá trị, ít nhất là ngang bằng với người khác.	0	100	53,01	28,317	3
RSES10	Tôi có thái độ tích cực đối với bản thân.	0	100	65,80	29,135	1

(Ghi chú: Min=điểm tối thiểu; Max=điểm tối đa; ĐTB=điểm trung bình; DLC=Độ lệch chuẩn)

Kết quả phân tích ở Bảng 3.22 cho thấy mức độ các yếu tố bảo vệ ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh THCS có sự khác biệt, với điểm trung bình dao động từ 52,60 đến 57,65. Trong đó, hỗ trợ từ cha mẹ có điểm trung bình cao nhất (ĐTB = 57,65), tiếp theo là tự trọng (ĐTB = 54,85), hỗ trợ từ bạn bè (ĐTB = 54,27) và gắn bó với trường học (ĐTB = 52,60).

Đối với hỗ trợ từ cha mẹ, học sinh đánh giá cao nhất ở việc gia đình cố gắng giúp đỡ (ĐTB = 65,48) và hỗ trợ về mặt cảm xúc (ĐTB = 59,82), trong khi khả năng chia sẻ vấn đề với gia đình có mức thấp hơn (ĐTB = 47,54).

Ở yếu tố gắn bó với trường học, các biểu hiện nổi bật là được tham gia hoạt động (ĐTB = 57,69) và cảm nhận sự thân thiện từ mọi người (ĐTB = 57,40), trong khi cảm nhận được giáo viên quan tâm (ĐTB = 47,36) và cảm giác thuộc về trường học (ĐTB = 47,86) có mức thấp hơn.

Đối với hỗ trợ từ bạn bè, học sinh có xu hướng đánh giá cao việc có bạn để chia sẻ (ĐTB = 61,93), nhưng mức độ tin cậy vào bạn bè khi gặp khó khăn thấp hơn (ĐTB = 42,38). Ở yếu tố tự trọng, học sinh có thái độ tích cực đối với bản thân (ĐTB = 65,80), trong khi đánh giá về năng lực bản thân có mức thấp hơn (ĐTB = 50,02).

Độ lệch chuẩn của các biến tương đối lớn cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các học sinh trong trải nghiệm các yếu tố bảo vệ.

Kết quả trên cho thấy thứ tự cường độ của yếu tố bảo vệ: *hỗ trợ từ cha mẹ* (ĐTB = 57,65) > *hỗ trợ từ bạn bè* (54,27) > *gắn bó trường học* (52,60). Như vậy, cha mẹ là nguồn hỗ trợ cao nhất, điều này phù hợp đặc thù văn hóa Việt Nam tập trung vào gia đình.

Đáng chú ý là trong nhóm hỗ trợ cha mẹ, mục cao nhất MSPSS.3 "gia đình thực sự cố gắng giúp đỡ" (65,48) phản ánh sự *hỗ trợ thực tế*, trong khi mục thấp nhất MSPSS.8

"có thể nói chuyện về vấn đề" (47,54) phản ánh sự hỗ trợ về giao tiếp cảm xúc. Sự chênh lệch này nói lên thực trạng cha mẹ Việt Nam giỏi hỗ trợ thực tế hơn là hỗ trợ về giao tiếp cảm xúc. Số liệu này phù hợp với phát hiện của Phạm Hoa và cộng sự (2024). Xu hướng này cũng được tìm thấy trong nghiên cứu của Lê Thị Phương Thanh và cs. (2024) về khía cạnh học sinh ít chia sẻ với cha mẹ.

Trong gần bó trường học, mục có điểm thấp nhất là PSSM.5 "phần lớn giáo viên quan tâm đến tôi" (47,36). Điều này gợi ý điểm yếu về mối quan hệ giữa giáo viên và HS, cần can thiệp tập huấn thêm cho giáo viên về kỹ năng quan tâm và lắng nghe HS.

Kết quả này cũng được củng cố bởi dữ liệu phỏng vấn. Một học sinh lớp 9 (MNA) chia sẻ: *"Khi gặp khó khăn hoặc lo lắng, tùy từng lúc em mới chia sẻ với gia đình, có lẽ do cách nói chuyện chưa phù hợp. Gia đình em quan tâm và hỗ trợ nhẹ nhàng nhưng cũng khá nghiêm khắc. Về bạn bè, em có hai người bạn thân thường giúp em giải thích những câu hỏi chưa hiểu và an ủi khi em buồn. Ở trường, em cảm thấy gần bó với trường, lớp vì các bạn hòa đồng và thân thiện."*

Nội dung này cho thấy, mặc dù học sinh nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng việc chia sẻ còn hạn chế; trong khi đó, bạn bè và môi trường lớp học lại đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ cảm xúc. Điều này phù hợp với kết quả định lượng khi khả năng chia sẻ với gia đình có mức thấp hơn so với các khía cạnh hỗ trợ khác, đồng thời củng cố nhận định về sự khác biệt trong trải nghiệm các yếu tố bảo vệ ở học sinh.

3.4 Tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh THCS

Mục này trình bày kết quả phân tích tác động của các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu ở học sinh THCS thông qua mô hình phương trình cấu trúc SEM, nhằm đánh giá mức độ và hướng tác động của từng yếu tố đối với các dạng rối loạn lo âu.

3.4.1. Tác động của các yếu tố NGUY CƠ đối với rối loạn lo âu

3.4.1.1. Tác động của áp lực học tập đối với rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của áp lực học tập đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.23 *Model fit của SEM*

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
ALHT - RLLALT	146,315 (43)	3,403	0,972	0,965	0,042	0,035 - 0,050
ALHT - RLLACL	71,739 (19)	3,776	0,975	0,964	0,045	0,034 - 0,057
ALHT - RLLAXH	59,943 (19)	3,155	0,983	0,975	0,040	0,029 - 0,052
ALHT - RLLA (3 factors)	31,015 (13)	2,386	0,992	0,987	0,032	0,018 - 0,047
ALHT - RLLA (2 factors)	23,049 (8)	2,881	0,993	0,987	0,037	0,020 - 0,056

(Ghi chú. ALHT=Áp lực học tập; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu Chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.24 Tác động áp lực học tập đến rối loạn lo âu

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	ALHT → RLLALT	0,510	0,066	10,984	< 0,001	—
2	ALHT → RLLACL	0,253	0,055	6,405	< 0,001	—
3	ALHT → RLLAXH	0,490	0,068	10,369	< 0,001	—
4	ALHT → RLLA (3 factors)	0,533	0,141	8,888	< 0,001	0,284
5	ALHT → RLLA (2 factors)	0,530	0,411	11,476	< 0,001	0,281

(Ghi chú. ALHT=Áp lực học tập; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu Chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

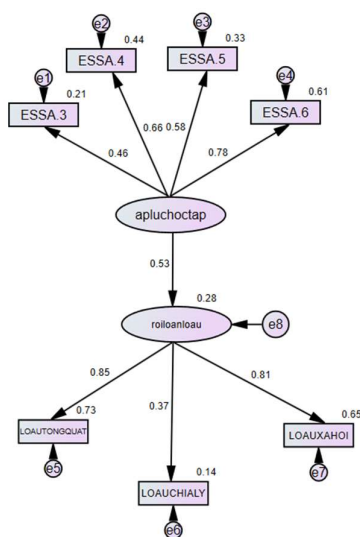
Kết quả phân tích tại Bảng 3.23 cho thấy, các mô hình SEM đều có độ phù hợp tốt với dữ liệu, các chỉ số đạt ngưỡng chấp nhận ($CFI \geq 0,972$; $TLI \geq 0,964$; $RMSEA \leq 0,045$). Đặc biệt, mô hình tổng thể (3 factors) và mô hình rút gọn (2 factors) đều có độ phù hợp tốt ($\chi^2/df < 3$; $RMSEA < 0,05$), cho thấy cấu trúc mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thu thập.

Kết quả ở Bảng 3.24 cho thấy áp lực học tập có cường độ tác động MẠNH NHẤT lên ba dạng RLLA. β chuẩn hóa: ALHT → RLLALT = 0,510 (large theo Cohen 1988); ALHT → RLLAXH = 0,490 (large); ALHT → RLLACL = 0,253 (small-to-medium); ALHT → RLLA tổng (3 factors) = 0,533, $R^2 = 0,284$. Tất cả $p < 0,001$.

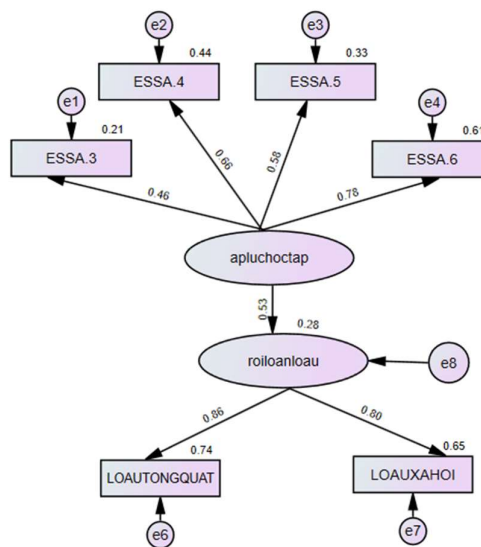
Mô hình ALHT tác động MẠNH NHẤT lên LO ÂU TỔNG QUÁT và LO ÂU XÃ HỘI (hai dạng liên quan đến đánh giá), YẾU NHẤT là lên LO ÂU CHIA LY (rối loạn khởi phát sớm ít phụ thuộc bối cảnh học đường). Kết quả này phù hợp với khung 6 trục của Pascoe, Hetrick và Parker (2020): áp lực thi cử tác động qua trục HPA, thay thế giấc ngủ, và mất kết nối trường học.

Phát hiện này phù hợp với $\beta = 0,508$ (Walder và cộng sự, 2025 meta DMHI 21 RCT) và bằng chứng cấp dân số của Brunborg và cộng sự (2025) trên 979.043 thanh thiếu niên Na Uy: bất mãn trường học giải thích TOÀN BỘ xu hướng tăng căng thẳng tâm thần.

Nhìn chung, áp lực học tập là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến rối loạn lo âu, với mức độ tác động khác nhau giữa các loại lo âu. Kết quả này phù hợp với tổng quan hệ thống của Steare và cộng sự khi cho thấy áp lực học tập có mối liên hệ tích cực với các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, trong đó có lo âu. Cụ thể, phần lớn các nghiên cứu trong tổng quan đều ghi nhận mối liên hệ dương giữa áp lực học tập và các biểu hiện lo âu, cho thấy mức độ áp lực càng cao thì nguy cơ xuất hiện các triệu chứng lo âu càng tăng (Steare et al, 2023).



Hình 3.9 Mô hình tác động áp lực học tập đến rối loạn lo âu (3 factors)



Hình 3.10 Mô hình tác động áp lực học tập đến rối loạn lo âu (2 factors)

3.4.1.2. Tác động của nghiện điện thoại đối với rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của nghiện điện thoại đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.25 *Model fit của SEM*

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
NĐT - RLLALT	161,730 (53)	3,052	0,979	0,973	0,039	0,032 - 0,046
NĐT - RLLACL	98,082 (26)	3,772	0,980	0,972	0,045	0,036 - 0,055
NĐT - RLLAXH	77,349 (26)	2,975	0,987	0,981	0,038	0,029 - 0,048
NĐT - RLLA (3 factors)	81,038 (19)	4,265	0,983	0,975	0,049	0,038 - 0,060
NĐT - RLLA (2 factors)	38,930 (13)	2,995	0,993	0,988	0,038	0,025 - 0,053

(Ghi chú. NĐT= Nghiện điện thoại; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.26 *Tác động nghiện điện thoại đến rối loạn lo âu*

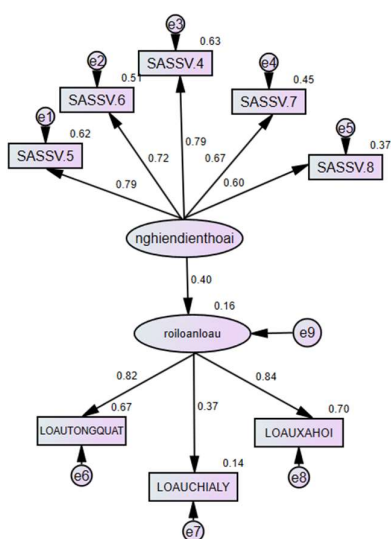
Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	NĐT → RLLALT	0,336	0,029	10,000	< 0,001	—
2	NĐT → RLLACL	0,265	0,031	7,501	< 0,001	—
3	NĐT → RLLAXH	0,383	0,032	10,661	< 0,001	—
4	NĐT → RLLA (3 factors)	0,400	0,178	11,792	< 0,001	0,160
5	NĐT → RLLA (2 factors)	0,390	0,186	10,614	< 0,001	0,152

(Ghi chú. NĐT= Nghiện điện thoại; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

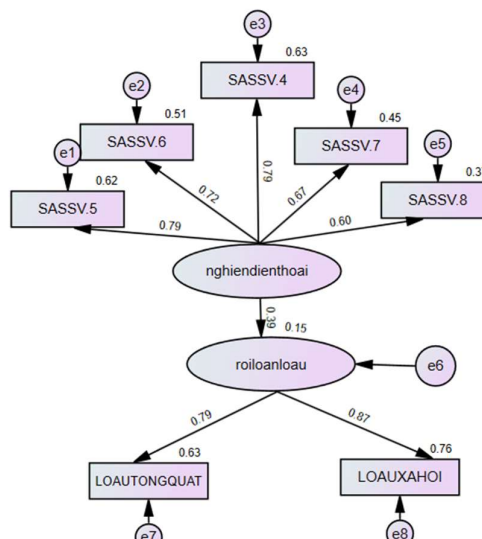
Kết quả phân tích tại Bảng 3.25 cho thấy, các mô hình SEM đều có độ phù hợp tốt với dữ liệu, với các chỉ số đạt ngưỡng chấp nhận ($CFI \geq 0,979$; $TLI \geq 0,972$; $RMSEA \leq 0,049$). Các mô hình tổng thể (3 factors) và rút gọn (2 factors) cũng đạt mức phù hợp tốt ($\chi^2/df < 5$; $RMSEA < 0,06$), cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thu thập.

Kết quả Bảng 3.26 cho thấy nghiện điện thoại tác động mạnh nhất lên lo âu xã hội ($\beta = 0,383$, $p < 0,001$) — cao hơn cả tổng quát ($\beta = 0,336$) và chia ly ($\beta = 0,265$). β tổng (3 factors) = 0,400; $R^2 = 0,160$ (medium). Phát hiện hệ số chuẩn hóa β của nghiện điện thoại cao nhất đối với RLLAXH phù hợp với cơ chế so sánh xã hội và nỗi sợ bị đánh giá trên mạng xã hội. Số liệu này phù hợp với Fassi và cộng sự (2025) nghiên cứu trên 3.340 thanh thiếu niên ở Anh với chẩn đoán lâm sàng là thanh thiếu niên có rối loạn nội hóa dùng mạng xã hội nhiều hơn và kém hài lòng hơn về quan hệ trên mạng.

Nhìn chung, nghiện điện thoại là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến rối loạn lo âu. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Li và cộng sự khi cho thấy sự phụ thuộc điện thoại thông minh có liên quan đến nguy cơ xuất hiện các triệu chứng lo âu ở thanh thiếu niên, đặc biệt ở nhóm có tình trạng phụ thuộc mới khởi phát hoặc kéo dài (Li et al, 2025).



Hình 3.11 Mô hình tác động của nghiện điện thoại đến rối loạn lo âu (3 factors)



Hình 3.12 Mô hình tác động của nghiện điện thoại đến rối loạn lo âu (2 factors)

3.4.1.3. Tác động của bắt nạt học đường đối với rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của bắt nạt học đường đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.27 Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA A	90% CI RMSEA
BNHĐ - RLLALT	90,581 (26)	3,484	0,982	0,975	0,043	0,033 - 0,053
BNHĐ - RLLACL	43,206 (8)	5,401	0,984	0,970	0,057	0,041 - 0,074
BNHĐ - RLLAXH	27,416 (8)	3,427	0,991	0,984	0,042	0,026 - 0,060
BNHĐ - RLLA (3 factors)	94,392 (4)	23,598	0,959	0,897	0,129	0,107 - 0,153
BNHĐ - RLLA (2 factors)	2,197 (1)	2,197	0,999	0,996	0,030	0,000 - 0,085

(Ghi chú. BNHĐ= Bắt nạt học đường; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

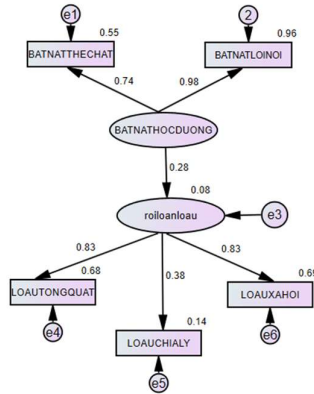
Bảng 3.28 Tác động bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	BNHĐ → RLLALT	0,215	0,006	7,349	< 0,001	—
2	BNHĐ → RLLACL	0,376	0,007	9,242	< 0,001	—
3	BNHĐ → RLLAXH	0,253	0,007	7,763	< 0,001	—
4	BNHĐ → RLLA (3 factors)	0,276	0,013	7,553	< 0,001	0,076
5	BNHĐ → RLLA (2 factors)	0,254	0,041	7,294	< 0,001	0,065

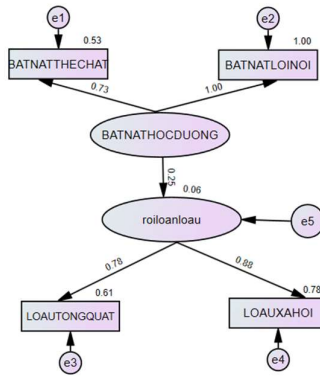
(Ghi chú. BNHĐ= Bắt nạt học đường; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Kết quả tại Bảng 3.27 cho thấy các mô hình SEM nhìn chung đạt mức độ phù hợp chấp nhận được với dữ liệu. Cụ thể, các mô hình đơn (RLLA tổng quát, chia ly và xã hội) đều có chỉ số phù hợp tốt ($CFI \geq 0,982$; $RMSEA \leq 0,057$). Mô hình hai nhân tố có độ phù hợp rất tốt ($\chi^2/df = 2,197$; $CFI = 0,999$; $RMSEA = 0,030$). Ngược lại, mô hình ba nhân tố có mức độ phù hợp kém ($\chi^2/df = 23,598$; $RMSEA = 0,129$), cho thấy cấu trúc này chưa phù hợp với dữ liệu. Kết quả phân tích tại Bảng 3.28 cho thấy bắt nạt học đường có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến tất cả các dạng rối loạn lo âu. Cụ thể, bắt nạt học đường có ảnh hưởng mạnh nhất đến lo âu chia ly ($\beta = 0,376$; $p < 0,001$), tiếp theo là lo

âu xã hội ($\beta = 0,253$; $p < 0,001$) và lo âu lan tỏa ($\beta = 0,215$; $p < 0,001$). Ở mô hình tổng thể, bắt nạt học đường có tác động đáng kể đến rối loạn lo âu ($\beta = 0,276$; $p < 0,001$), tuy nhiên mức độ giải thích phương sai còn hạn chế ($R^2 = 0,076$). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở mô hình hai nhân tố ($\beta = 0,254$; $R^2 = 0,065$).



Hình 3.13 Mô hình tác động của bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu (3 factors)



Hình 3.14 Mô hình tác động của bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu (2 factors)

Nhìn chung, bắt nạt học đường là yếu tố có ảnh hưởng có ý nghĩa đến rối loạn lo âu. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Fang và cộng sự khi cho thấy nạn nhân bị bắt nạt có nguy cơ lo âu cao hơn đáng kể so với nhóm không bị bắt nạt, qua đó củng cố kết quả nghiên cứu hiện tại về tác động của bắt nạt học đường đến rối loạn lo âu (Fang et al, 2022).

Số liệu trên cũng cho thấy bắt nạt học đường có mẫu hình khác biệt với áp lực học tập và lòng tự trọng. Bắt nạt học đường có hệ số chuẩn hóa β đối với LACL là 0,376, mạnh nhất trong cả ba dạng RLLA ($\beta \rightarrow LATQ = 0,215$; $\beta \rightarrow LAXH = 0,253$), với $p < 0,001$.

Có thể lý giải sự nổi trội của mẫu hình bắt nạt học đường đối với LACL theo 3 giả thuyết: 1) Cơ chế gắn bó-an toàn: học sinh bị bắt nạt mất cảm giác an toàn ở trường, không muốn tách khỏi cha mẹ - biểu hiện chính của LACL; 2) Từ chối đến trường: từ bị bắt nạt đến từ chối đi học có biểu hiện giống như lo âu chia ly; 3) Với đặc thù lứa tuổi THCS chuyển tiếp, vấn đề bắt nạt có thể kích hoạt lại mẫu hình lo âu chia ly trước đây, chưa hoàn toàn biến mất.

Đây là phát hiện đặc thù của Việt Nam — chưa được ghi nhận rõ rệt trong y văn quốc tế. Phát hiện này gợi ý cần theo dõi học sinh có biểu hiện bỏ học và kiểm tra liệu có phải là do sợ bị bắt nạt hay không, không chỉ là biểu hiện "lo âu chia ly đơn thuần".

3.4.2. Tác động của các yếu tố **BẢO VỆ** đối với rối loạn lo âu

3.4.2.1. Tác động của gắn bó trường học đối với rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của gắn bó với trường học đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.29 *Model fit của SEM*

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
GBTH - RLLALT	198,365 (76)	2,610	0,970	0,964	0,035	0,029 - 0,040
GBTH - RLLACL	112,906 (43)	2,626	0,973	0,965	0,035	0,027 - 0,043
GBTH - RLLAXH	123,336 (43)	2,868	0,971	0,963	0,037	0,030 - 0,045
GBTH - RLLA	112,352 (34)	3,304	0,970	0,960	0,041	0,033 - 0,050
GBTH - RLLA (2 factor)	79,072 (26)	3,041	0,978	0,970	0,039	0,029 - 0,049

(Ghi chú. GBTH = gắn bó trường học; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.30 *Tác động gắn bó với trường học đến rối loạn lo âu*

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	GBTH → RLLALT	-0,108	0,049	-3,073	0,002	—
2	GBTH → RLLACL	0,014	0,052	0,390	0,696	—
3	GBTH → RLLAXH	-0,187	0,054	-5,005	< 0,001	—
4	GBTH → RLLA	-0,155	0,255	-4,326	< 0,001	0,024
5	GBTH → RLLA (2 factor)	-0,146	0,278	-2,648	0,008	0,021

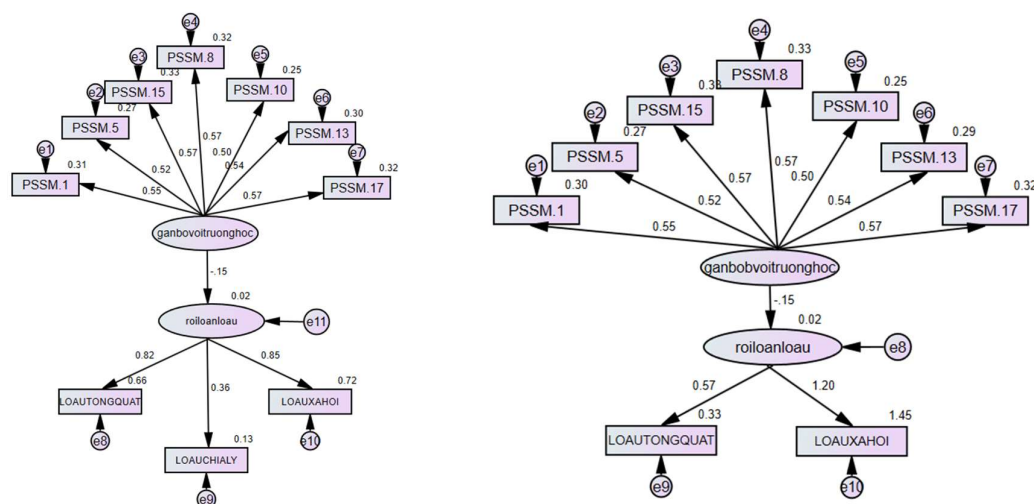
(Ghi chú. GBTH = gắn bó trường học; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Kết quả tại Bảng 3.29 cho thấy các mô hình SEM đều có độ phù hợp tốt với dữ liệu với các chỉ số đạt ngưỡng chấp nhận ($CFI \geq 0,970$; $TLI \geq 0,960$; $RMSEA \leq 0,041$). Các mô hình đơn và mô hình tổng thể đều có $\chi^2/df < 5$, cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thu thập.

Kết quả phân tích tại Bảng 3.30 cho thấy gắn bó với trường học có tác động đến rối loạn lo âu. Cụ thể, gắn bó với trường học có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu lan tỏa ($\beta = -0,108$; $p = 0,002$) và lo âu xã hội ($\beta = -0,187$; $p < 0,001$), cho thấy mức độ gắn bó với trường học càng cao thì mức độ lo âu ở các khía cạnh này càng thấp. Ngược lại, không ghi nhận tác động có ý nghĩa thống kê của gắn bó với trường học đối với lo âu chia ly ($\beta = 0,014$; $p = 0,696$). Ở mô hình tổng thể, gắn bó với trường học có tác động âm và có ý nghĩa đến rối loạn lo âu ($\beta = -0,155$; $p < 0,001$), tuy nhiên mức độ giải thích phương sai còn thấp ($R^2 = 0,024$). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở mô hình hai nhân tố ($\beta = -0,146$; $R^2 = 0,021$).

Số liệu này cũng cho thấy gắn bó trường học bảo vệ mạnh nhất cho lo âu xã hội (theo logic qua bạn bè và giáo viên) nhưng không có tác động đối với lo âu chia ly (theo logic chia ly, liên quan nhiều đến gắn bó với cha mẹ, ít liên quan đến trường học). Điều này phù hợp với quan điểm của Goodenow (1993).

Nhìn chung, gắn bó với trường học là yếu tố bảo vệ có ý nghĩa đối với một số dạng rối loạn lo âu, đặc biệt là lo âu xã hội, tuy nhiên mức độ tác động còn hạn chế. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Islam và cộng sự (2025) khi cho thấy gắn bó với trường học có liên quan tích cực đến sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ gắn kết với trường học cao có liên quan đến mức độ lo âu và trầm cảm thấp hơn, đồng thời đóng vai trò trung gian trong mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ và vấn đề sức khỏe tâm thần (Islam et al, 2025).



Hình 3.16 Mô hình tác động của gắn bó trường học đến rối loạn lo âu (2 factors)

Hình 3.15 Mô hình tác động của
gắn bó trường học đến rối loạn lo
âu (3 factors)

3.4.2.2. Tác động của tự trọng đối với rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của tự trọng đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.31 Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
TTr - RLLALT	182,604 (53)	3,445	0,966	0,958	0,043	0,036 - 0,049
TTr - RLLACL	104,738 (26)	4,028	0,965	0,951	0,047	0,038 - 0,057
TTr - RLLAXH	98,631 (26)	3,794	0,971	0,960	0,045	0,036 - 0,055
TTr - RLLA (3 factors)	83,915 (19)	4,417	0,973	0,960	0,050	0,040 - 0,062
TTr - RLLA (2 factors)	56,420 (13)	4,340	0,981	0,969	0,050	0,037 - 0,063

(Ghi chú. TTr= Tự trọng; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.32 Tác động tự trọng đến rối loạn lo âu

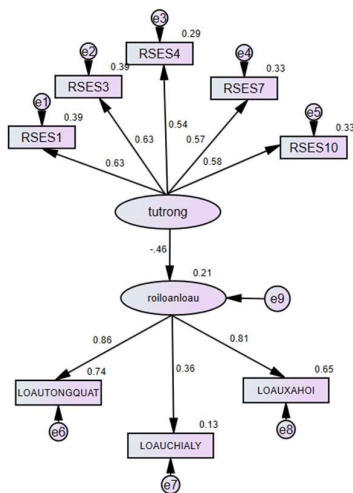
Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	TTr → RLLALT	-0,455	0,050	-11,412	< 0,001	—
2	TTr → RLLACL	-0,087	0,048	-2,335	0,020	—
3	TTr → RLLAXH	-0,415	0,053	-10,039	< 0,001	—
4	TTr → RLLA (3 factors)	-0,457	0,305	-11,735	< 0,001	0,209
5	TTr → RLLA (2 factors)	-0,466	0,311	-11,696	< 0,001	0,217

(Ghi chú. TTr= Tự trọng; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

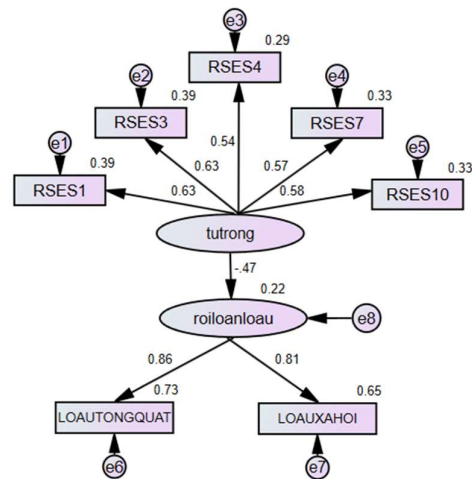
Kết quả phân tích tại Bảng 3.31 cho thấy, các mô hình SEM đều đạt mức độ phù hợp chấp nhận được với dữ liệu với các chỉ số phù hợp ở mức tốt ($CFI \geq 0,965$; $TLI \geq 0,951$; $RMSEA \leq 0,050$). Các mô hình đều có $\chi^2/df < 5$, cho thấy cấu trúc mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.

Kết quả số liệu tại Bảng 3.32 cho thấy tự trọng có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến tất cả các dạng rối loạn lo âu. Cụ thể, tự trọng có ảnh hưởng mạnh đến rối loạn lo âu lan tỏa ($\beta = -0,455$; $p < 0,001$) và lo âu xã hội ($\beta = -0,415$; $p < 0,001$), trong khi ảnh hưởng đến lo âu chia ly ở mức thấp hơn ($\beta = -0,087$; $p = 0,020$). Ở mô hình tổng thể, tự trọng có tác động âm đáng kể đến rối loạn lo âu ($\beta = -0,457$; $p < 0,001$), giải thích 20,9% phương sai của biến phụ thuộc ($R^2 = 0,209$). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở mô hình hai nhân tố ($\beta = -0,466$; $R^2 = 0,217$).

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tự trọng là yếu tố bảo vệ có ảnh hưởng mạnh đến rối loạn lo âu, đặc biệt đối với lo âu lan tỏa và lo âu xã hội, lòng tự trọng có cường độ tác động tương đương (~85–89%) với áp lực học tập. Đây là phát hiện quan trọng, phù hợp giả thuyết "lòng tự trọng là yếu tố bảo vệ thuộc nhóm mạnh". Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tự trọng và lo âu xã hội có vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và sức khỏe tâm thần, trong đó tự trọng góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần và giảm các biểu hiện lo âu (Feng et al, 2024).



Hình 3.17 Mô hình SEM tác động của tự trọng đến rối loạn lo âu (3 factors)



Hình 3.18 Mô hình SEM tác động của tự trọng đến rối loạn lo âu (2 factors)

3.4.2.3. Tác động của hỗ trợ từ cha mẹ đối với rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của hỗ trợ từ cha mẹ đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.33 *Model fit của SEM*

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
HTCM - RLLALT	136,234 (43)	3,168	0,981	0,975	0,040	0,033 - 0,048
HTCM - RLLACL	87,436 (19)	4,602	0,980	0,970	0,052	0,041 - 0,063
HTCM - RLLAXH	61,229 (19)	3,223	0,988	0,983	0,041	0,029 - 0,052
HTCM - RLLA	84,551 (13)	6,504	0,979	0,966	0,064	0,051 - 0,077
HTCM - RLLA (2 factor)	48,008 (8)	6,001	0,988	0,977	0,061	0,045 - 0,078

(Ghi chú. HTCM = Hỗ trợ cha mẹ; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.34 *Tác động hỗ trợ cha mẹ đến rối loạn lo âu*

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	HTCM → RLLALT	-0,172	0,021	-5,299	< 0,001	—
2	HTCM → RLLACL	0,000	0,022	-0,003	0,997	—
3	HTCM → RLLAXH	-0,273	0,022	-7,896	< 0,001	—
4	HTCM → RLLA	-0,234	0,123	-7,035	< 0,001	0,055
5	HTCM → RLLA (2 factor)	-0,222	0,137	-4,902	< 0,001	0,049

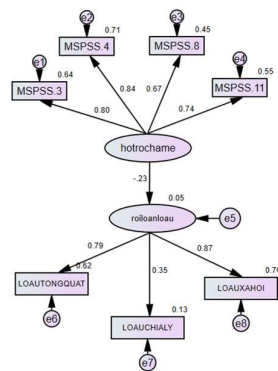
(Ghi chú. HTCM = Hỗ trợ cha mẹ; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Kết quả phân tích dữ liệu tại Bảng 3.33 cho thấy các mô hình SEM đều đạt mức độ phù hợp chấp nhận được với dữ liệu, với các chỉ số phù hợp tốt ($CFI \geq 0,979$; $TLI \geq 0,966$; $RMSEA \leq 0,064$). Các mô hình đơn đều có độ phù hợp tốt ($RMSEA \leq 0,052$), trong khi các mô hình tổng thể có mức phù hợp chấp nhận được.

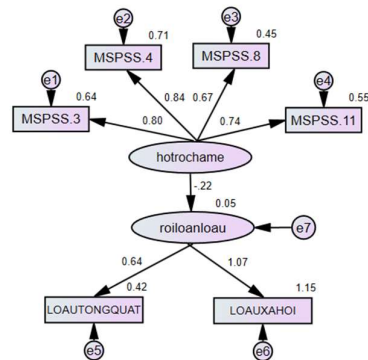
Kết quả từ Bảng 3.34 cho thấy hỗ trợ từ cha mẹ có tác động đến rối loạn lo âu. Cụ thể, hỗ trợ từ cha mẹ có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu lan tỏa ($\beta = -0,172$; $p < 0,001$) và lo âu xã hội ($\beta = -0,273$; $p < 0,001$), cho thấy mức độ hỗ trợ từ cha mẹ cao hơn có liên hệ với mức độ lo âu thấp hơn ở các khía cạnh này. Ngược lại,

không ghi nhận tác động có ý nghĩa thống kê đối với lo âu chia ly ($\beta \approx 0$; $p = 0,997$). Ở mô hình tổng thể, hỗ trợ từ cha mẹ có tác động âm và có ý nghĩa đến rối loạn lo âu ($\beta = -0,234$; $p < 0,001$), tuy nhiên mức độ giải thích phương sai còn hạn chế ($R^2 = 0,055$). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở mô hình hai nhân tố ($\beta = -0,222$; $R^2 = 0,049$).

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hỗ trợ từ cha mẹ là yếu tố bảo vệ có ý nghĩa đối với một số dạng rối loạn lo âu, đặc biệt là lo âu xã hội. Kết quả này phù hợp với Qian và cộng sự (2018), khi cho thấy hỗ trợ cảm xúc từ cha mẹ có liên hệ với việc giảm các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, qua đó củng cố kết quả nghiên cứu hiện tại về vai trò bảo vệ của yếu tố này (Qian et al, 2018).



Hình 3.19 Mô hình SEM tác động của hỗ trợ cha mẹ đến rối loạn lo âu (3 factors)



Hình 3.20 Mô hình SEM tác động của hỗ trợ cha mẹ đến rối loạn lo âu (2 factors)

3.4.2.4. Tác động của hỗ trợ từ bạn bè và rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của hỗ trợ từ bạn bè đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.35 Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
HTBB - RLLALT	141,023 (43)	3,280	0,978	0,972	0,041	0,034 - 0,049
HTBB - RLLACL	73,495 (19)	3,868	0,983	0,974	0,046	0,035 - 0,057
HTBB - RLLAXH	63,041 (19)	3,318	0,987	0,980	0,041	0,030 - 0,053
HTBB - RLLA	52,207 (13)	4,016	0,987	0,980	0,047	0,034 - 0,061

HTBB - RLLA (2 factor)	30,523 (8)	3,815	0,992	0,986	0,046	0,029 - 0,063
---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	---------------

(Ghi chú. HTBB = Hỗ trợ bạn bè; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.36 Tác động hỗ trợ bạn bè đến rối loạn lo âu

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	HTBB → RLLALT	-0,015	0,021	-0,459	0,646	—
2	HTBB → RLLACL	-0,019	0,023	0,558	0,577	—
3	HTBB → RLLAXH	-0,079	0,023	-2,318	0,020	—
4	HTBB → RLLA	-0,044	0,133	-1,331	0,183	0,002
5	HTBB → RLLA (2 factor) mô hình lỗi	-0,039	0,144	-0,438	0,661	0,002

(Ghi chú. HTBB = Hỗ trợ bạn bè; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Kết quả từ phân tích dữ liệu Bảng 3.35 cho thấy các mô hình SEM đều đạt mức độ phù hợp chấp nhận được với dữ liệu, với các chỉ số phù hợp tốt ($CFI \geq 0,978$; $TLI \geq 0,972$; $RMSEA \leq 0,047$). Các mô hình đơn và mô hình tổng thể đều có $\chi^2/df < 5$, cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thu thập.

Kết quả ở Bảng 3.36 cho thấy hỗ trợ từ bạn bè có tác động hạn chế đến các dạng rối loạn lo âu. Cụ thể, không ghi nhận tác động có ý nghĩa thống kê của hỗ trợ từ bạn bè đối với rối loạn lo âu lan tỏa ($\beta = -0,015$; $p = 0,646$) và lo âu chia ly ($\beta = -0,019$; $p = 0,577$). Tuy nhiên, hỗ trợ từ bạn bè có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến lo âu xã hội ($\beta = -0,079$; $p = 0,020$), cho thấy mức độ hỗ trợ từ bạn bè cao hơn có liên hệ với mức độ lo âu xã hội thấp hơn. Ở mô hình tổng thể, hỗ trợ từ bạn bè không có tác động có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu ($\beta = -0,044$; $p = 0,183$), với mức độ giải thích phương sai rất thấp ($R^2 = 0,002$). Mô hình hai nhân tố không đạt ý nghĩa thống kê và có dấu hiệu không ổn định.

Số liệu này trái với y văn quốc tế (Murphy 2024). Để lý giải, có thể đặt ra những giả thuyết như: 1) Đặc thù lứa tuổi THCS: học sinh lớp 6–9 chưa phát triển đầy đủ kỹ năng dựa vào bạn bè như ở THPT; sự hỗ trợ bạn bè ở HSTHCS có thể đi theo hướng lây lan cảm xúc tiêu cực, giải pháp ứng phó tiêu cực; 2) Văn hóa Việt Nam chủ yếu tập trung vào gia đình: cha mẹ là nguồn hỗ trợ chính, bạn bè ở vị trí thứ yếu.

3.4.3. Mô hình ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ và bảo vệ đối với rối loạn lo âu

3.4.3.1. Ảnh hưởng của yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.37. Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
YTNC&YTBV – RLLA	153,792 (17)	9,047	0,937	0,897	0,077	0,066 - 0,089

(Ghi chú: YTBV= yếu tố bảo vệ; YTNC=yếu tố nguy cơ)

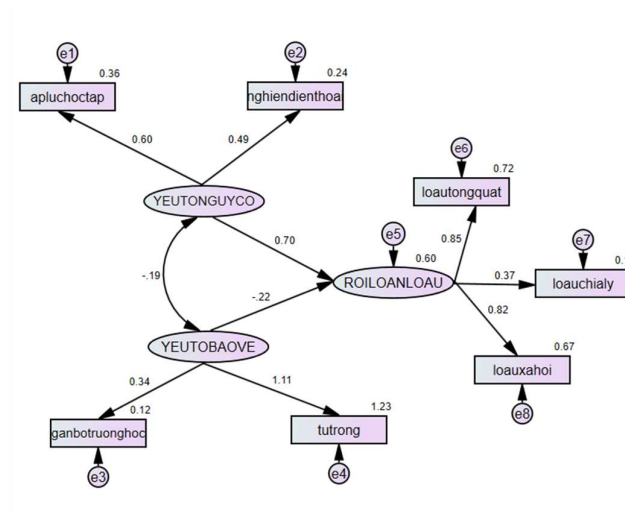
Bảng 3.38 Tác động yếu tố nguy cơ & yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	YTNC → RLLA	0,669	0,166	9,103	< 0,001	0,598
2	YTBV → RLLA	-0,220	0,082	-4,725	< 0,001	

(Ghi chú: YTBV= yếu tố bảo vệ; YTNC=yếu tố nguy cơ)

Kết quả (Bảng 3.37) cho thấy mô hình SEM tổng hợp giữa các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và rối loạn lo âu đạt mức độ phù hợp chấp nhận được với dữ liệu (CFI = 0,937; RMSEA = 0,077), mặc dù chỉ số χ^2/df = 9,047 và TLI = 0,897 cho thấy mô hình chưa đạt mức phù hợp tối ưu. Kết quả từ Bảng 3.38 cho thấy các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu. Cụ thể, yếu tố nguy cơ có tác động dương mạnh đến rối loạn lo âu (β = 0,669; p < 0,001), cho thấy khi mức độ các yếu tố nguy cơ gia tăng thì mức độ rối loạn lo âu cũng tăng theo. Ngược lại, yếu tố bảo vệ có tác động âm và có ý nghĩa thống kê (β = -0,220; p < 0,001), cho thấy các yếu tố bảo vệ có liên hệ với việc giảm mức độ rối loạn lo âu.

Đáng chú ý, mức độ tác động của yếu tố nguy cơ lớn hơn đáng kể so với yếu tố bảo vệ, đồng thời mô hình giải thích được 59,8% phương sai của rối loạn lo âu (R^2 = 0,598), cho thấy vai trò nổi bật của các yếu tố nguy cơ trong việc dự báo rối loạn lo âu ở học sinh. Nhìn chung, cả yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đều có vai trò quan trọng, trong đó các yếu tố nguy cơ thể hiện mức độ ảnh hưởng mạnh hơn đến rối loạn lo âu so với các yếu tố bảo vệ.



Hình 3.21. Mô hình tác động của yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

3.4.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố NGUY CƠ đến rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của hỗ trợ từ bạn bè đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.39 Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
YTNC - RLLA	12,407 (4)	3,102	0,994	0,986	0,039	0,016 - 0,065

(Ghi chú: YTNC=yếu tố nguy cơ; RLLA = Rối loạn lo âu)

Bảng 3.40 Tác động yếu tố nguy cơ đến rối loạn lo âu

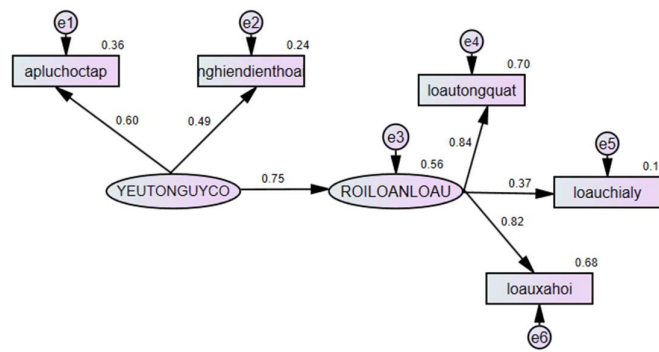
Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	YTNC → RLLA	0,747	0,168	10,241	<0,001	0,558

(Ghi chú: YTNC=yếu tố nguy cơ; RLLA = Rối loạn lo âu)

Kết quả phân tích cho thấy (Bảng 3.39) mô hình SEM giữa yếu tố nguy cơ và rối loạn lo âu có độ phù hợp tốt với dữ liệu ($\chi^2/df = 3,102$; CFI = 0,994; TLI = 0,986; RMSEA = 0,039). Khoảng tin cậy 90% của RMSEA (0,016 - 0,065) nằm trong ngưỡng chấp nhận, củng cố thêm độ phù hợp của mô hình. Kết quả phân tích tại Bảng 3.40 cho thấy yếu tố nguy cơ có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu ($\beta = 0,747$; $p < 0,001$), cho thấy khi mức độ các yếu tố nguy cơ gia tăng thì mức độ rối loạn lo âu cũng

gia tăng tương ứng. Mô hình giải thích được 55,8% phương sai của rối loạn lo âu ($R^2 = 0,558$), phản ánh mức độ ảnh hưởng đáng kể của yếu tố nguy cơ đối với biến phụ thuộc.

Nhìn chung, kết quả cho thấy yếu tố nguy cơ đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo rối loạn lo âu ở học sinh, với mức độ tác động mạnh và có ý nghĩa thống kê.



Hình 3.22 Mô hình tác động của yếu tố nguy cơ đến rối loạn lo âu

3.4.3.3. Ảnh hưởng của yếu tố BẢO VỆ đến rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của yếu tố bảo vệ đối với rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.41 Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
YTBV - RLLA	30,608 (4)	7,652	0,982	0,954	0,070	0,048 - 0,094

(Ghi chú: YTBV=yếu tố bảo vệ; RLLA = Rối loạn lo âu)

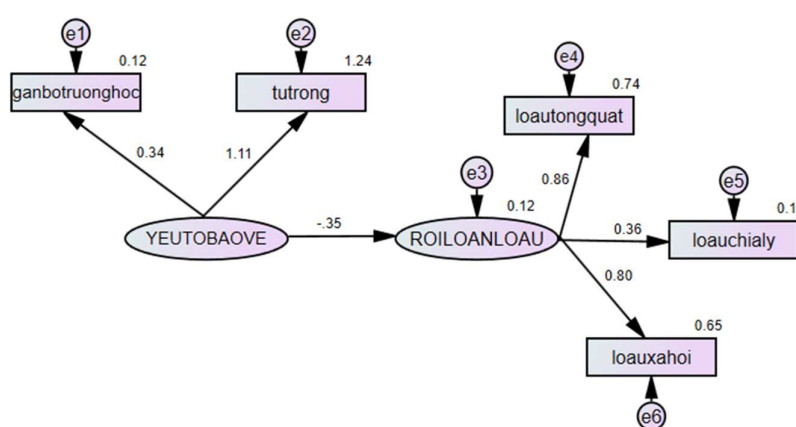
Bảng 3.42 Tác động yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R^2
1	YTBV $\rightarrow$ RLLA	-0,352	0,102	-9,890	< 0,001	0,124

(Ghi chú: YTBV=yếu tố bảo vệ; RLLA = Rối loạn lo âu)

Kết quả tại Bảng 3.41 cho thấy mô hình SEM giữa yếu tố bảo vệ và rối loạn lo âu đạt mức độ phù hợp chấp nhận được với dữ liệu (CFI = 0,982; TLI = 0,954; RMSEA = 0,070). Tuy nhiên, chỉ số $\chi^2/df = 7,652$ cho thấy mô hình chưa đạt mức phù hợp tối ưu. Kết quả từ Bảng 3.42 cho thấy yếu tố bảo vệ có tác động âm và có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu ($\beta = -0,352$; $p < 0,001$), cho thấy khi mức độ các yếu tố bảo vệ gia tăng thì mức độ rối loạn lo âu có xu hướng giảm. Mô hình giải thích được 12,4% phương sai của rối loạn lo âu ($R^2 = 0,124$), phản ánh mức độ ảnh hưởng ở mức trung bình - thấp của yếu

tổ bảo vệ đối với biến phụ thuộc. Như vậy, có thể nhận định, yếu tố bảo vệ có vai trò làm giảm rối loạn lo âu, tuy nhiên mức độ tác động thấp hơn so với yếu tố nguy cơ trong mô hình nghiên cứu.



Hình 3.23 Mô hình tác động của yếu tố bảo vệ đến rối loạn lo âu

3.5. Thực trạng các biện pháp đối phó của học sinh THCS

3.5.1. Thực trạng các biện pháp đối phó

Kết quả phân tích và diễn giải thực trạng các biện pháp đối phó phòng ngừa rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.43 Mức độ và biểu hiện của các biện pháp đối phó với RLLA

TT	Mệnh đề	Min	Max	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
Tránh né vấn đề		0	100	41,34	22,641	3
Bcope.13	Tôi đã tự chỉ trích bản thân.	0	100	45,83	34,209	2
Bcope.26	Tôi đã tự trách bản thân về những điều đã xảy ra.	0	100	50,42	33,170	1
Bcope.3	Tôi đã tự nói với mình rằng “điều này không phải là thật”.	0	100	40,34	34,106	3
Bcope.8	Tôi đã từ chối tin rằng điều đó đã xảy ra.	0	100	36,88	33,032	4

BCope.6	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng giải quyết nó.	0	100	33,21	28,949	5
<i>Tập trung giải quyết vấn đề</i>		0	100	53,18	19,974	2
BCope.25	Tôi đã suy nghĩ kỹ về những bước cần thực hiện với nó.	0	100	47,76	30,375	6
BCope.2	Tôi đã tập trung nỗ lực vào việc làm điều gì đó về tình huống mà tôi đang gặp phải.	0	100	52,76	28,051	4
BCope.7	Tôi đã hành động để cố gắng làm cho tình huống trở nên tốt hơn.	0	100	59,15	28,422	1
BCope.12	Tôi đã cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, để làm cho nó có vẻ tích cực hơn.	0	100	54,61	29,833	2
BCope.17	Tôi đã tìm kiếm điều tích cực trong những gì đang xảy ra.	0	100	54,29	30,668	3
BCope.14	Tôi đã cố gắng nghĩ ra một chiến lược về việc nên làm gì.	0	100	50,52	40,432	5
<i>Tìm kiếm sự hỗ trợ</i>		0	100	55,00	24,288	1
BCope.10	Tôi đã nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên từ người khác.	0	100	59,91	31,317	1
BCope.15	Tôi đã nhận được sự an ủi và thấu hiểu từ ai đó.	0	100	57,05	31,954	2
BCope.5	Tôi đã nhận được sự hỗ trợ về mặt cảm xúc từ người khác.	0	100	53,06	30,896	3
BCope.23	Tôi đã cố gắng tìm lời khuyên hoặc sự giúp đỡ từ	0	100	49,98	31,780	4

	người khác về việc nên làm gì.					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

(Ghi chú: Min=điểm tối thiểu; Max=điểm tối đa; ĐTB=điểm trung bình; ĐLC=Độ lệch chuẩn)

Kết quả phân tích tại Bảng 3.43 cho thấy mức độ sử dụng các biện pháp đối phó với rối loạn lo âu ở học sinh THCS có sự khác biệt. Trong đó, tìm kiếm sự hỗ trợ là biện pháp được sử dụng nhiều nhất (ĐTB = 55,00), tiếp theo là tập trung giải quyết vấn đề (ĐTB = 53,18), và thấp nhất là tránh né vấn đề (ĐTB = 41,34). Có thể nhận thấy, học sinh THCS Việt Nam có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ nhiều nhất, điều này phù hợp văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, ĐTB tránh né vẫn ở mức khá cao (41,34, gần giữa thang). Điều này phản ánh thực trạng một bộ phận học sinh đang dùng chiến lược ứng phó ít thích ứng. Thực trạng này phù hợp với nhận xét của Compas và cs. (2017) cho rằng xu hướng né tránh, phủ nhận, ức chế cảm xúc thường xuất hiện nhiều hơn với các triệu chứng nội hóa. Phân tích theo hai chiều cho thấy chiều thích nghi (tập trung giải quyết vấn đề + tìm kiếm hỗ trợ) được học sinh sử dụng phổ biến hơn chiều không thích nghi (tránh né), với điểm trung bình hai chiều khác biệt rõ rệt. Kết quả này phù hợp với xu hướng học sinh THCS đã có ý thức sử dụng các chiến lược đối phó tích cực, dù hiệu quả thực tế còn cần xem xét qua phân tích hệ số tác động.

Xét ở từng biểu hiện cụ thể, trong nhóm tránh né, hành vi tự trách bản thân về những điều đã xảy ra có điểm trung bình cao nhất (ĐTB = 50,42), tiếp theo là tự chỉ trích bản thân (ĐTB = 45,83). Trong nhóm tập trung giải quyết vấn đề, hành động để cải thiện tình huống có giá trị cao nhất (ĐTB = 59,15), cho thấy xu hướng chủ động đối phó ở một bộ phận học sinh. Trong khi đó, ở nhóm tìm kiếm sự hỗ trợ, biểu hiện nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên từ người khác có điểm trung bình cao nhất (ĐTB = 59,91), tiếp đến là nhận được sự an ủi và thấu hiểu (ĐTB = 57,05). Độ lệch chuẩn của các biến dao động tương đối lớn (từ khoảng 19,97 đến 40,43), cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các học sinh trong việc sử dụng các biện pháp đối phó. Nhìn chung, kết quả phân tích chỉ ra rằng học sinh có xu hướng ưu tiên các chiến lược đối phó mang tính tích cực như tìm kiếm sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề hơn so với các chiến lược tránh né.

3.5.2. Tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu

Kết quả phân tích và diễn giải tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu được trình bày dưới đây.

Bảng 3.44 Model fit của SEM

Mô hình	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
BPĐP - RLLALT	327,439 (34)	9,631	0,911	0,882	0,080	0,072 - 0,088
BPĐP - RLLACL	186,218 (13)	14,324	0,883	0,811	0,099	0,087 - 0,112
BPĐP - RLLAXH	277,710 (13)	21,362	0,865	0,782	0,123	0,110 - 0,136
BPĐP - RLLA (3 factors)	234,071 (8)	29,259	0,882	0,779	0,145	0,129 - 0,161
BPĐP - RLLA (2 factor)	229,057 (4)	57,264	0,871	0,678	0,204	0,182 - 0,227

(Ghi chú. BPĐP = Biện pháp đối phó; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

Bảng 3.45 Tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu

Mô hình	Path	β	S.E.	C.R.	p	R ²
1	BPĐP → RLLALT	0,749	0,025	6,488	< 0,001	0,561
2	BPĐP → RLLACL	0,132	0,040	2,912	0,004	0,017
3	BPĐP → RLLAXH	0,670	0,027	4,920	< 0,001	0,449
4	BPĐP → RLLA (3 factors)	0,735	0,156	6,137	<0,001	0,540
5	BPĐP → RLLA (2 factor)	0,728	0,157	6,021	<0,001	0,529

(Ghi chú. BPĐP = Biện pháp đối phó; RLLALT=rối loạn lo âu lan tỏa; RLLACL= rối loạn lo âu chia ly; RLLAXH= rối loạn lo âu xã hội; RLLA=rối loạn lo âu).

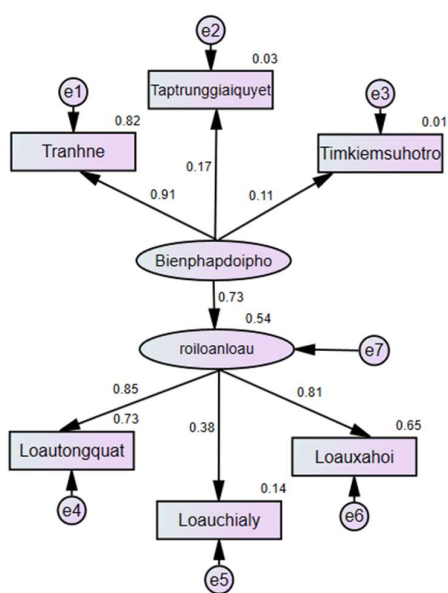
Kết quả phân tích dữ liệu tại Bảng 3.44 cho thấy các mô hình SEM giữa biện pháp đối phó và rối loạn lo âu chưa đạt mức độ phù hợp với dữ liệu. Cụ thể, các chỉ số χ^2/df đều cao (từ 9,631 đến 57,264), trong khi CFI và TLI ở nhiều mô hình chưa đạt ngưỡng chấp nhận (CFI < 0,90; TLI < 0,90), và RMSEA ở mức cao (0,080 - 0,204), cho thấy mô hình có mức độ phù hợp kém. Do đó, các kết quả trong phân tích này có độ chính xác hạn chế, cần được xem xét thận trọng. Kết quả Bảng 3.45 cho thấy biện pháp đối phó có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến các dạng rối loạn lo âu. Cụ thể, biện pháp đối phó có tác động đáng kể đến rối loạn lo âu lan tỏa ($\beta = 0,749$; $p < 0,001$; $R^2 = 0,561$) và lo âu xã hội ($\beta = 0,670$; $p < 0,001$; $R^2 = 0,449$), trong khi tác động đến lo âu chia ly ở mức thấp hơn ($\beta = 0,132$; $p = 0,004$; $R^2 = 0,017$). Ở mô hình tổng thể, biện pháp đối phó

tiếp tục cho thấy tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến rối loạn lo âu ($\beta = 0,735$; $p < 0,001$; $R^2 = 0,540$), kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở mô hình hai nhân tố ($\beta = 0,728$; $R^2 = 0,529$). Khi phân tích riêng từng chiều, chiều THÍCH NGHĨ (giải quyết vấn đề và tìm kiếm hỗ trợ) cho hệ số β dương với điểm rối loạn lo âu - kết quả TRÁI VỚI KỲ VỌNG lý thuyết ban đầu (kỳ vọng β âm). Chiều KHÔNG THÍCH NGHĨ (tránh né) cho hệ số β dương - phù hợp với kỳ vọng lý thuyết.

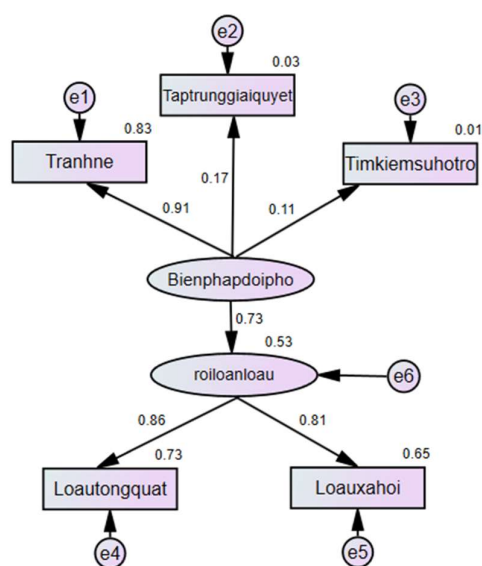
Mặc dù mô hình chưa đạt độ phù hợp tốt, kết quả vẫn cho thấy mối liên hệ giữa biện pháp đối phó và rối loạn lo âu, trong đó mức độ sử dụng các chiến lược đối phó cao có xu hướng đi kèm với mức độ lo âu cao hơn.

Kết quả này cũng được củng cố bởi dữ liệu phỏng vấn. Một học sinh lớp 6 (NĐMK) chia sẻ: *“Khi lo lắng em thường tập trung giải quyết vấn đề, nhưng thi thoảng em cảm thấy những cách đó không giúp ích vì em không tìm được cách giải quyết”*.

Phát biểu này cho thấy học sinh có xu hướng sử dụng các chiến lược đối phó mang tính giải quyết vấn đề, tuy nhiên hiệu quả còn hạn chế. Điều này gợi ý rằng việc gia tăng sử dụng biện pháp đối phó không đồng nghĩa với giảm lo âu, đặc biệt khi các chiến lược chưa phù hợp hoặc không mang lại kết quả. Như vậy, kết quả định tính góp phần lý giải mối quan hệ dương giữa biện pháp đối phó và rối loạn lo âu trong phân tích định lượng. Có thể lý giải hệ số β dương ở chiều ứng phó thích nghi như sau: 1) Mẫu nghiên cứu là học sinh THCS - lứa tuổi đang học kỹ năng đối phó; sự tăng sử dụng có thể phản ánh đáp ứng với mức stress cao hơn (cause-effect ngược trong mô hình cắt ngang); 2) Hiệu quả của một chiến lược đối phó phụ thuộc vào cách sử dụng và phối hợp, không chỉ tần suất học sinh có thể sử dụng giải quyết vấn đề một cách thiếu hiệu quả; 3) Trong thiết kế nghiên cứu cắt ngang, các chiến lược đối phó được đo đồng thời với triệu chứng lo âu - không phân biệt nguyên nhân - kết quả. Kết quả này gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo: cần thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc để kiểm chứng mối quan hệ - nhân quả thời gian, và đo lường chất lượng đối phó chứ không chỉ đo tần suất sử dụng.



Hình 3.24 Mô hình tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu (3 factors)



Hình 3.25 Mô hình tác động của biện pháp đối phó đến rối loạn lo âu (2 factor)

3.6. Bàn luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh THCS có xu hướng lo âu cao hơn ở các nội dung liên quan đến đánh giá bản thân, kết quả học tập và các mối quan hệ xã hội. Kết quả này có thể được lý giải trong bối cảnh các nghiên cứu trước đây về lo âu ở vị thành niên, khi chỉ ra rằng những lo lắng liên quan đến việc bị người khác đánh giá, khó khăn trong tương tác và áp lực trong các tình huống giao tiếp là những biểu hiện phổ biến của lo âu ở lứa tuổi này (Alev Üstündağ et al, 2025). Bên cạnh đó, các bằng chứng thực nghiệm từ nghiên cứu Jystad và cộng sự năm (2021) cũng cho thấy rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên có liên quan đáng kể đến các khó khăn trong hoạt động học đường như kết quả học tập kém thuận lợi, sự không hài lòng với trường học và xu hướng giảm nguyện vọng học tập, đồng thời đi kèm với tình trạng bị cô lập trong các mối quan hệ xã hội (Jystad et al, 2021). Như vậy, kết quả nghiên cứu hiện tại phù hợp với các bằng chứng trước đó khi cho thấy lo âu ở học sinh thường tập trung vào các nội dung cốt lõi của đời sống học đường và xã hội, bao gồm đánh giá bản thân, thành tích học tập và tương tác xã hội. Điều này đồng thời phản ánh đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi vị thành niên, khi nhu cầu được công nhận gia tăng cùng với sự nhạy cảm đối với các đánh giá từ môi trường xung quanh.

Sự khác biệt theo giới tính cũng được ghi nhận rõ ràng, với học sinh nữ có mức độ lo âu cao hơn học sinh nam ở nhiều khía cạnh. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Ngô Anh Vinh và cộng sự (2022) cũng như Đinh Văn Tài và cộng sự (2021), khi các tác giả đều chỉ ra rằng nữ giới có nguy cơ gặp các vấn đề lo âu cao hơn. Sự tương đồng này cho thấy kết quả nghiên cứu có tính nhất quán với bối cảnh nghiên cứu trong nước, đồng thời củng cố độ tin cậy của dữ liệu thu thập.

Đối với khối lớp, kết quả cho thấy lo âu lan tỏa có xu hướng gia tăng ở các lớp cuối cấp, trong khi lo âu chia ly giảm dần theo độ tuổi. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước khi cho rằng áp lực học tập và định hướng tương lai tăng lên theo khối lớp, đặc biệt ở giai đoạn chuyển cấp (Ngô Anh Vinh & cộng sự, 2022). Như vậy, kết quả nghiên cứu không chỉ phản ánh đúng xu hướng phát triển tâm lý mà còn cho thấy sự nhạy cảm của thang đo trong việc phát hiện sự khác biệt theo đặc điểm phát triển.

Về các yếu tố nguy cơ, kết quả cho thấy áp lực học tập là yếu tố nổi bật nhất ảnh hưởng đến rối loạn lo âu. Điều này không chỉ thể hiện ở mức độ biểu hiện mà còn được khẳng định qua mô hình SEM khi áp lực học tập có tác động mạnh và có ý nghĩa đến tất cả các loại lo âu. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lê Thị Phương Thanh và cộng sự (2024), cũng như Nguyễn Thị Vân (2018), khi đều nhấn mạnh vai trò trung tâm của áp lực học tập đối với sức khỏe tâm thần học sinh. Đồng thời, kết quả cũng nhất quán với tổng quan của Steare và cộng sự (2023), khi cho thấy mối liên hệ dương giữa áp lực học tập và lo âu. Sự hội tụ này cho thấy mô hình nghiên cứu đã phản ánh đúng bản chất của mối quan hệ giữa áp lực học tập và rối loạn lo âu.

Bên cạnh đó, nghiện điện thoại cũng được xác định là yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng đáng kể đến rối loạn lo âu. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Li và cộng sự (2025), khi chỉ ra rằng sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh có liên quan đến gia tăng các triệu chứng lo âu ở thanh thiếu niên. Đáng chú ý, nghiện điện thoại có ảnh hưởng mạnh hơn đến lo âu xã hội, cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng thiết bị số và sự nhạy cảm trong các tình huống giao tiếp xã hội. Điều này phản ánh một xu hướng tâm lý mới trong bối cảnh hiện đại, và là điểm mà nghiên cứu đã làm rõ thêm.

Đối với bắt nạt học đường, kết quả cho thấy đây là yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến rối loạn lo âu, mặc dù mức độ giải thích phương sai còn hạn chế. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Fang và cộng sự (2022), khi cho thấy học sinh bị bắt nạt có nguy cơ lo âu cao hơn. Tuy nhiên, việc mức độ ảnh hưởng không quá lớn gợi ý rằng bắt nạt

không phải là yếu tố duy nhất mà cần được xem xét trong mối quan hệ với các yếu tố khác, điều này thể hiện cách tiếp cận đa yếu tố của nghiên cứu.

Ở nhóm yếu tố bảo vệ, kết quả cho thấy gắn bó với trường học có tác động làm giảm lo âu, đặc biệt là lo âu xã hội. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Islam và cộng sự (2025), khi nhấn mạnh vai trò của cảm giác thuộc về trong việc bảo vệ sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, mức độ tác động không lớn và không có ý nghĩa với lo âu chia ly cho thấy vai trò của yếu tố này mang tính chọn lọc, phụ thuộc vào từng loại lo âu cụ thể.

Đối với tự trọng, kết quả cho thấy đây là yếu tố bảo vệ có ảnh hưởng mạnh đến rối loạn lo âu, đặc biệt là lo âu lan tỏa và lo âu xã hội. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Feng và cộng sự (2024), khi cho rằng tự trọng có vai trò quan trọng trong việc giảm các vấn đề sức khỏe tâm thần. Việc tự trọng có mức độ giải thích phương sai tương đối cao cho thấy đây là một trong những yếu tố cá nhân quan trọng mà nghiên cứu đã xác định được.

Đối với biện pháp đối phó, kết quả mô hình SEM cho thấy các chiến lược đối phó có tác động cùng chiều (hệ số β dương) đến rối loạn lo âu, thể hiện ở các đường dẫn từ biến biện pháp đối phó đến các loại lo âu đều mang dấu dương trong mô hình. Điều này cho thấy khi mức độ sử dụng các biện pháp đối phó tăng lên thì mức độ lo âu cũng có xu hướng tăng theo. Kết quả này phản ánh rằng các chiến lược đối phó mà học sinh đang sử dụng chưa thực sự hiệu quả, thậm chí có thể góp phần duy trì hoặc làm gia tăng trạng thái lo âu. Điều này đặc biệt phù hợp với khung lý thuyết về đối phó của Carver (1997), khi các chiến lược đối phó không thích hợp, nhất là các dạng né tránh, không giúp giải quyết nguồn gây căng thẳng mà có thể làm trầm trọng thêm các phản ứng tiêu cực. Như vậy, biện pháp đối phó trong nghiên cứu không đóng vai trò bảo vệ mà phản ánh hạn chế trong kỹ năng thích ứng của học sinh. *Khi phân tích theo hai chiều thích nghi và không thích nghi, kết quả cho thấy cả chiều thích nghi và không thích nghi đều cho hệ số dương. Trong khi chiều không thích nghi với hệ số dương là phù hợp với lý thuyết, chiều thích nghi với hệ số dương cần được giải thích một cách khoa học. Cách lý giải của Joanna Herres và cs. (2015) cho rằng, có thể là các em đang dùng các chiến lược ứng phó thích nghi nhưng không đầy đủ, cũng là một gợi ý để tiếp tục nghiên cứu, kiểm chứng.*

Tổng thể, các kết quả nghiên cứu cho thấy sự nhất quán cao với các nghiên cứu trước đó, đồng thời làm rõ hơn mức độ và cơ chế tác động của từng yếu tố trong cùng một mô hình. Điểm nổi bật của đề tài là đã tích hợp đồng thời các yếu tố nguy cơ và bảo

vệ trong một mô hình phân tích thống nhất, qua đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về rối loạn lo âu ở học sinh THCS. Điều này không chỉ củng cố các kết luận trước đây mà còn góp phần làm rõ vai trò tương đối của từng yếu tố trong bối cảnh nghiên cứu cụ thể.

3.7 Đề xuất Khung Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS dựa trên kết quả nghiên cứu

3.7.1 Cơ sở khoa học của Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS

3.7.1.1 Cơ sở lý thuyết

Cơ sở lý thuyết của chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS được xây dựng trên sự kết hợp giữa tâm lý học phát triển lứa tuổi THCS, các mô hình giải thích rối loạn lo âu, cách tiếp cận sức khỏe tâm thần học đường theo toàn trường, và bằng chứng thực nghiệm từ nghiên cứu thực trạng. Cách kết hợp này nhằm bảo đảm chương trình không chỉ đúng về mặt lý thuyết mà còn phù hợp với đặc điểm học sinh THCS và nhu cầu thực tiễn của nhà trường.

- Thứ nhất, chương trình dựa trên cơ sở tâm lý học phát triển lứa tuổi thiếu niên sớm. Học sinh THCS đang ở giai đoạn có nhiều thay đổi mạnh về sinh học, nhận thức, cảm xúc và quan hệ xã hội; đồng thời đây cũng là thời kỳ chuyển tiếp học đường, khi yêu cầu học tập tăng lên và sự nhạy cảm với đánh giá của người khác trở nên rõ hơn. Vì vậy, rối loạn lo âu ở lứa tuổi này thường gắn chặt với áp lực học tập, hình ảnh bản thân, quan hệ bạn bè và cảm giác thuộc về trường lớp (Steinberg, 2014). Đây là lý do chương trình phải được thiết kế theo hướng gần với trải nghiệm đời sống học sinh, nhấn mạnh kỹ năng tự nhận diện cảm xúc, tự điều chỉnh và tìm kiếm hỗ trợ, thay vì chỉ cung cấp kiến thức khái niệm.

- Thứ hai, cơ sở lý thuyết quan trọng nhất của chương trình là mô hình nhận thức hành vi (Cognitive Behavioral Theory – CBT). Theo tiếp cận này, lo âu không chỉ xuất phát từ sự kiện bên ngoài mà còn được duy trì bởi cách cá nhân diễn giải tình huống, các suy nghĩ tự động tiêu cực và các hành vi né tránh (Beck, 1976; Hofmann và cộng sự, 2012). Do đó, một chương trình phòng ngừa lo âu cho học sinh THCS cần giúp các em nhận ra mối liên hệ giữa nhận thức – cảm xúc – hành vi, nhận diện các kiểu suy nghĩ sai lệch như sợ sai, sợ bị đánh giá, thảm họa hóa kết quả học tập, và học cách thay thế bằng

cách diễn giải linh hoạt hơn. Cụ thể, các chương trình CBT học đường hiện đại tại châu Á thường được thiết kế theo cấu trúc 8–12 buổi – mỗi buổi 60–90 phút – tích hợp sáu mô-đun lõi: (1) tâm lý giáo dục về lo âu (psychoeducation); (2) theo dõi triệu chứng (symptom tracking); (3) thử thách suy nghĩ thảm họa (cognitive challenges); (4) kỹ thuật thư giãn (relaxation tools — thờ 4-7-8, grounding 5-4-3-2-1); (5) kích hoạt hành vi (behavioral activation); (6) thang phơi nhiễm (exposure ladder) — phù hợp với cấu trúc app Clear Fear (Samele và cộng sự, 2025) và mô hình EACP của Lochman và cộng sự (2025). Các nghiên cứu gần đây cho thấy can thiệp học đường dựa trên CBT là một trong những hướng có bằng chứng tốt nhất đối với lo âu ở trẻ em và thanh thiếu niên (Hofmann và cộng sự, 2012); phân tích tổng hợp 21 RCT của Walder và cộng sự (2025) trên Journal of Medical Internet Research xác lập thêm: can thiệp sức khỏe tâm thần số (Digital Mental Health Intervention – DMHI) thiết kế đặc thù cho lo âu xã hội đạt hiệu lực LỚN (Hedges $g = 0,878$), gần gấp đôi DMHI tổng quát ($g = 0,508$). Đây là cơ sở bằng chứng để bổ sung thành phần iCBT (internet-delivered CBT) vào chương trình can thiệp cho học sinh có nguy cơ cao.

- Thứ ba, chương trình dựa trên khung năng lực học tập cảm xúc – xã hội (Social and Emotional Learning, SEL), đặc biệt là khung của CASEL. Theo khung này, sự phát triển của học sinh không chỉ phụ thuộc vào kiến thức học thuật mà còn vào các năng lực như tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm. Đối với chương trình phòng ngừa lo âu, khung SEL cung cấp nền tảng để xây dựng các nội dung như nhận diện cảm xúc, điều hòa cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, xử lý xung đột, tìm kiếm hỗ trợ và duy trì quan hệ tích cực với gia đình, thầy cô, bạn bè (Durlak và cộng sự, 2011). Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lo âu học đường không chỉ là vấn đề nội tâm mà còn chịu ảnh hưởng mạnh từ các mối quan hệ trong hệ sinh thái học đường.

- Thứ tư, chương trình được đặt trong cách tiếp cận sức khỏe tâm thần học đường theo tổng thể trường học. Các nghiên cứu cho thấy phòng ngừa sức khỏe tâm thần trong nhà trường sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp giữa can thiệp cá nhân và môi trường học đường, bao gồm vai trò của giáo viên, gia đình và văn hóa lớp học (Weare & Nind, 2011; WHO, 2021). Vì vậy, chương trình không thiết kế như một chuỗi bài giảng rời, mà là một can thiệp trong hệ sinh thái học đường. Phân tích tổng hợp 21 RCT can thiệp resilience tại trường của Cai và cộng sự (2025) trên Frontiers in Psychiatry xác lập kích thước hiệu

ứng $SMD = 0,17$ (KTC 95% 0,06–0,29; $p < 0,01$) — hiệu quả nhỏ nhưng có ý nghĩa thống kê. Đáng chú ý, mức độ không đồng nhất rất cao ($I^2 = 81,90\%$) gợi ý hiệu quả phụ thuộc thiết kế can thiệp — do đó chương trình cần cụ thể hóa cho bối cảnh Việt Nam.

- Thứ năm, chương trình kế thừa cách tiếp cận giáo dục kỹ năng sống và năng lực thích ứng trong nhà trường. Giáo dục kỹ năng sống được xem là nền tảng giúp học sinh ứng phó hiệu quả với các thách thức thông qua các kỹ năng như quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề và đối phó với stress (WHO, 1997). Điều này phù hợp với mục tiêu phòng ngừa lo âu ở học sinh THCS trong bối cảnh học tập và đời sống số hiện nay.

- Thứ sáu, chương trình còn dựa trên mô hình nguy cơ – bảo vệ. Theo mô hình này, rối loạn lo âu là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ (Garmezy, 1991; Masten, 2014). Dữ liệu thực nghiệm cho thấy yếu tố nguy cơ có vai trò chi phối mạnh, trong khi các yếu tố bảo vệ như tự trọng và hỗ trợ xã hội giúp giảm thiểu lo âu. Vì vậy, chương trình được thiết kế theo nguyên tắc: giảm nguy cơ và tăng cường bảo vệ.

- Thứ bảy, chương trình cũng dựa trên cơ sở lý thuyết về sự tham gia của gia đình trong hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường. Các nghiên cứu cho thấy sự hỗ trợ của cha mẹ có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên (Yap và cộng sự, 2014). Điều này cho thấy cần tích hợp thành phần phối hợp gia đình trong chương trình. Mô hình Early Adolescent Coping Power (EACP) của Lochman và cộng sự (2025) — RCT cụm 40 trường THCS Mỹ với $n = 709$ học sinh lớp 7 — gợi ý cấu trúc cụ thể: 25 buổi cho học sinh + 16 buổi/ 90 phút cho cha mẹ và thành phần phối hợp với giáo viên. Phát hiện đặc biệt: đối với nữ học sinh trong nhóm EACP, sau can thiệp, mức độ vấn đề ở trường giảm có ý nghĩa thống kê.

- Thứ tám, chương trình bổ sung thành phần *hỗ trợ đồng đẳng* (peer support). Scoping review của Murphy và cộng sự (2024) trong Journal of Community Psychology trên 15 nghiên cứu, 13 can thiệp peer support cho thấy hỗ trợ đồng đẳng có tiềm năng cải thiện kết quả phục hồi, với điều kiện là vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với *hỗ trợ đồng đẳng* cần được xác định rõ ràng và có thêm sự trợ giúp chuyên môn từ chuyên viên tâm lý học đường.

Từ các cơ sở lý thuyết trên, có thể khái quát rằng việc phòng ngừa lo âu học đường hiệu quả cần đồng thời tác động vào cá nhân học sinh, môi trường học đường và hệ thống hỗ trợ gia đình, qua đó tạo nên sự thay đổi bền vững.

3.7.1.2 Cơ sở thực tiễn

Cơ sở thực tiễn của chương trình tập huấn được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng chung của Việt Nam và thực rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở, qua đó cung cấp bằng chứng khoa học về mức độ biểu hiện và các yếu tố ảnh hưởng trong bối cảnh học đường hiện nay.

Trước hết, bối cảnh của công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ VTN ở Việt Nam đang có nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Theo nghiên cứu của Viện Xã hội học và cộng sự (2022), trong *Báo cáo khảo sát sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam*, chỉ có 8,4% trẻ VTN có vấn đề đã tìm kiếm được sử dụng dịch vụ hỗ trợ tâm lý, như vậy là có tới 91,6% có vấn đề nhưng chưa được can thiệp. Trong số 8,4% trẻ VTN có vấn đề đã tìm kiếm sự hỗ trợ, chỉ có 5,5% tìm gặp chuyên viên tâm lý ở trường học, có nghĩa là chỉ có 0,46% số trẻ VTN có vấn đề về SKTT chủ động tìm đến chuyên viên tâm lý trường học ($8,4\% \times 5,5\% \approx 0,46\%$). Về phía cha mẹ, số liệu của nghiên cứu này cũng cho thấy chỉ có 5,1% cha mẹ học sinh nhận ra vấn đề của con cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Về phía giáo viên, số liệu khảo sát của UNICEF và Bộ GD&ĐT (2022), cho thấy có 95 % giáo viên lo ngại về vấn đề sức khỏe tâm thần của HS, 58 % giáo viên nói rằng các nguồn lực và chương trình hiện có không đủ để hỗ trợ học sinh.

Có thể nói tại Việt Nam, các chương trình CBT trong trường học còn ở giai đoạn ban đầu. Báo cáo của Viện Xã hội học và cộng sự (2022) ghi nhận phần lớn trường học được khảo sát có ít nhất một hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, nhưng đa số là sử dụng hình thức tham vấn cá nhân khi học sinh chủ động tìm đến, không phải là chương trình phổ quát có cấu trúc theo CBT. Khoảng trống lớn nhất ở đây là sự thiếu vắng một chương trình can thiệp theo CBT phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, được kiểm định trên học sinh trung học cơ sở, được thiết kế phù hợp với khung chương trình môn Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tính cấp thiết phải huy động sự đồng hành của giáo viên và các bậc cha mẹ trong quá trình can thiệp rối loạn lo âu cho HS cũng là những yếu tố cần được cân nhắc khi thiết kế Khung chương trình tập huấn cho các trường THCS ở Việt Nam.

Những số liệu về thực trạng bối cảnh chung của đất nước đặt ra vấn đề phải nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và của học sinh, phải tập huấn nguồn lực là giáo viên và cha mẹ HS để họ cùng tham gia hỗ trợ tâm lý cho HS, không chỉ hoàn toàn dựa vào đội ngũ chuyên viên tâm lý học đường.

Riêng về rối loạn lo âu, kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy rối loạn lo âu ở học sinh THCS có mức độ phổ biến ở ngưỡng trung bình, với sự khác biệt giữa các loại lo âu. Trong đó, lo âu lan tỏa có xu hướng nổi trội hơn so với lo âu xã hội và lo âu chia ly, phản ánh đặc điểm tâm lý của học sinh trong bối cảnh áp lực học tập và yêu cầu thích nghi ngày càng cao. Các biểu hiện lo âu tập trung chủ yếu vào áp lực học tập, sự tự đánh giá bản thân và các tình huống xã hội, cho thấy lo âu không chỉ mang tính cá nhân mà còn gắn chặt với môi trường học đường và các mối quan hệ xã hội của học sinh.

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng chỉ ra rằng rối loạn lo âu chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ. Cụ thể, các yếu tố nguy cơ như áp lực học tập, nghiện điện thoại và trải nghiệm bắt nạt học đường có tác động cùng chiều đến mức độ lo âu, với hệ số chuẩn hóa β trong mô hình SEM lần lượt là: *áp lực học tập* có cường độ lớn nhất $\beta = 0,510$ (RLLALT) và $\beta = 0,490$ (RLLAXH); nghiện điện thoại và bắt nạt học đường có cường độ ở mức đáng kể. Yếu tố nguy cơ tổng hợp có hệ số chuẩn hóa $\beta = 0,747$, giải thích 55,8% phương sai của rối loạn lo âu ($R^2 = 0,558$), trong đó áp lực học tập nổi lên như một yếu tố trung tâm trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Điều này phản ánh thực tế rằng học sinh không chỉ chịu áp lực từ yêu cầu học tập mà còn từ sự cạnh tranh và kỳ vọng xã hội. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thoại quá mức và các trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè góp phần làm gia tăng nguy cơ lo âu ở học sinh.

Ngược lại, các yếu tố bảo vệ như mức độ gắn bó với trường học, sự hỗ trợ xã hội từ gia đình và bạn bè, cũng như lòng tự trọng có vai trò làm giảm mức độ rối loạn lo âu. Hệ số β chuẩn hóa của lòng tự trọng với các loại RLLALT và RLLAXH đều cao ($\beta = -0,455$ và $-0,415$) có cường độ bảo vệ mạnh nhất. Sự hỗ trợ từ phía cha mẹ và gắn bó trường học đều có bằng chứng hiệu quả, tuy ở mức độ còn thấp. Điều này cho thấy môi trường học đường tích cực và các nguồn lực tâm lý – xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh thích nghi và giảm thiểu các vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bảo vệ còn hạn chế, cho thấy các nguồn lực này chưa được khai thác và phát huy một cách hiệu quả trong thực tiễn giáo dục.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các biện pháp đối phó của học sinh có xu hướng liên hệ cùng chiều với rối loạn lo âu, gợi ý rằng các chiến lược đối phó hiện tại có thể chưa phù hợp hoặc chưa hiệu quả trong việc kiểm soát căng thẳng và lo âu. Cụ thể, hệ số chuẩn hóa β của Biện pháp đối phó đối với RLLALT có cường độ cực lớn ($\beta = 0,749$), tuy chưa có bằng chứng hiệu quả, dẫn đến vẫn duy trì và gia tăng mức độ lo âu.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải trang bị cho học sinh các kỹ năng đối phó mang tính thích ứng, có định hướng và dựa trên bằng chứng khoa học.

Ngoài ra, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ rối loạn lo âu theo giới tính và khối lớp cho thấy yếu tố phát triển và đặc điểm cá nhân cũng cần được xem xét trong quá trình thiết kế chương trình can thiệp. Điều này gợi ý cho cách triển khai các nội dung tập huấn linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Tổng hợp các kết quả trên cho thấy rối loạn lo âu ở học sinh THCS là một vấn đề có tính hệ thống, chịu ảnh hưởng đa chiều từ cá nhân, gia đình và môi trường học đường. Do đó, việc xây dựng chương trình tập huấn phòng ngừa không thể chỉ tập trung vào một yếu tố riêng lẻ, mà cần tiếp cận theo hướng tích hợp, kết hợp giữa giảm thiểu yếu tố nguy cơ, tăng cường yếu tố bảo vệ và phát triển các kỹ năng đối phó hiệu quả cho học sinh. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất và thiết kế chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu trong bối cảnh trường trung học cơ sở hiện nay.

3.7.2 Mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng và phạm vi áp dụng của chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh trung học cơ sở

3.7.2.1 Mục tiêu

Trong bối cảnh sức khỏe tâm thần học sinh ngày càng được quan tâm, các chương trình phòng ngừa rối loạn lo âu trong trường học được thiết kế nhằm can thiệp sớm vào các yếu tố nguy cơ và tăng cường các yếu tố bảo vệ tâm lý. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các chương trình tập huấn kiến thức dựa trên trường học có thể giúp giảm đáng kể mức độ lo âu và cải thiện khả năng thích ứng của học sinh, đặc biệt khi tập trung vào phát triển kỹ năng nhận thức, điều chỉnh cảm xúc (Stockings và cộng sự, 2022; Dunning và cộng sự, 2022). Trên cơ sở đó, mục tiêu của chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở được cụ thể hóa thành các mục tiêu cốt lõi: 1) *giảm yếu tố nguy cơ* (áp lực học tập, nghiện điện thoại, bắt nạt học đường); 2) *tăng yếu tố bảo vệ* (lòng tự trọng, hỗ trợ cha mẹ, gắn bó trường học), đặc biệt chọn điểm nhấn là *lòng tự trọng - yếu tố bảo vệ mạnh nhất* ($\beta = -0,455$); 3) *phát triển kỹ năng đối phó, thích ứng*; 4) *tích hợp thành phần can thiệp trên các phương tiện Số*, xây dựng app iCBT cho nhóm có nguy cơ cao, dựa trên Walder và cộng sự (2025). Hiệu quả của chương trình tập huấn sẽ được đánh giá qua so sánh trước-sau can thiệp bằng các thang chuẩn quốc tế (RCADS, GAD-7, ESSA, RSES, MSPSS, PSSM).

3.7.2.2 Nguyên tắc

Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh trung học cơ sở được xây dựng dựa trên nguyên tắc sau:

- Chương trình được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học, kế thừa các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và các mô hình can thiệp đã được kiểm chứng, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của nội dung can thiệp (Stockings và cộng sự, 2022).

- Chương trình đảm bảo tính phù hợp văn hóa, được điều chỉnh theo bối cảnh giáo dục và đặc điểm văn hóa – xã hội của học sinh Việt Nam, nhằm tăng khả năng tiếp nhận và hiệu quả thực tiễn.

- Nội dung chương trình phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi trung học cơ sở, chú trọng đến đặc điểm sinh lý, nhận thức và cảm xúc của học sinh trong giai đoạn vị thành niên, từ đó lựa chọn phương pháp và nội dung can thiệp phù hợp.

- Chương trình được thiết kế theo tiếp cận đa tầng, kết hợp giữa phòng ngừa phổ quát và phòng ngừa chọn lọc, nhằm tác động đồng thời đến toàn bộ học sinh và nhóm có nguy cơ cao, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa một cách toàn diện (WHO, 2021).

- Chương trình *tích hợp thành phần can thiệp trên các phương tiện Số* (DMHI), xây dựng app iCBT cho nhóm có nguy cơ cao. Dựa trên bằng chứng phân tích tổng hợp 21 RCT của Walder và cộng sự (2025) cho thấy DMHI được thiết kế đặc thù cho HS bị SAD đạt chỉ số độ lớn hiệu ứng cao (Hedges $g = 0,878$). Loại App có người hướng dẫn đạt hiệu ứng cao hơn không hướng dẫn ($g = 0,825$ vs $g \approx 0,2$ không hướng dẫn). App này có thể qua chat-bot hoặc sử dụng tin nhắn với giáo viên/cố vấn học đường. Về app này, nghiên cứu của Qiaochu & Wang (2025) chỉ ra rằng CBT ứng dụng trên điện thoại có hiệu quả yếu cho lo âu nếu không được thiết kế đặc thù: chỉ 2/6 RCT có ý nghĩa). Do đó app phải đặc thù cho HS có SAD hoặc phải có thành phần CBT đầy đủ theo cấu trúc Clear Fear (Samele và cộng sự, 2025).

3.7.2.3 Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng chính của chương trình là học sinh THCS, nhóm lứa tuổi đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ về sinh lý, nhận thức và cảm xúc, đồng thời có nguy cơ cao xuất hiện các rối loạn lo âu nếu không được hỗ trợ kịp thời.

- Đối tượng phối hợp bao gồm giáo viên, phụ huynh và cán bộ tư vấn học đường, là những lực lượng có vai trò trực tiếp trong việc phát hiện, hỗ trợ và duy trì hiệu quả can

thiệp trong môi trường tự nhiên của học sinh, góp phần tăng tính bền vững của chương trình (Fazel và cộng sự, 2014).

- Phạm vi áp dụng của chương trình được triển khai theo hướng phòng ngừa phổ quát đối với toàn bộ học sinh nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tâm lý cơ bản, đồng thời kết hợp phòng ngừa chọn lọc đối với nhóm học sinh có nguy cơ cao, nhằm tối ưu hóa hiệu quả can thiệp và sử dụng nguồn lực hợp lý (WHO, 2021).

3.7.3 Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS

3.7.3.1 Cấu trúc chương trình

Bảng dưới đây trình bày cấu trúc chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường dành cho học sinh THCS. Cấu trúc gồm 8 chủ đề, tổng cộng 19 buổi (8 lý thuyết + 11 thực hành), tương đương ~28–32 giờ – phù hợp với mô hình can thiệp CBT 8–12 buổi của Walder và cộng sự (2025) và EACP của Lochman và cộng sự (2025) đã sử dụng tại châu Á và Mỹ (xem bảng dưới đây có bổ sung cột tham chiếu khoa học và module Số để làm rõ cơ sở của từng chủ đề).

TT	Nội dung tập huấn	Số buổi (LT/TH)	Thời lượng	Mục tiêu	Tham chiếu khoa học	Module Số Module digital
1	Nhận diện rối loạn lo âu học đường	1 LT + 1 TH	90–120 phút	Giúp HS hiểu bản chất và biểu hiện lo âu	Beck (1976); Hofmann (2012)	Module 1 Clear Fear: psychoeducation
2	Áp lực học tập và lo âu	1 LT + 1 TH	90–120 phút	Nhận diện nguồn áp lực học tập	Sun (2011) ESSA; Pascoe (2020); $\beta=0,510$	Module 2 Clear Fear: symptom tracking
3	Kỹ năng quản lý áp lực học tập	1 LT + 2 TH	135–180 phút	Trang bị kỹ năng giảm áp lực	Walder (2025) $g=0,508$	Module 5 Clear Fear: behavioral activation
4	Kiểm soát sử dụng điện thoại	1 LT + 1 TH	90–120 phút	Giảm nguy cơ từ hành vi số	Schmidt-Persson (2024) RCT; $\beta=0,336$	App theo dõi screen time
5	Ứng phó với bất nạt học đường	1 LT + 1 TH	90–120 phút	Tăng kỹ năng tự bảo vệ	Olweus (1996); $\beta=0,376$ cho RLLACL	OBPP module trực tuyến
6	Xây dựng tự trọng tích cực	1 LT + 2 TH	135–180 phút	Tăng yếu tố bảo vệ nội tại	Rosenberg (1965); $\beta=-0,455$ mạnh nhất	—

7	Điều chỉnh suy nghĩ & kỹ năng đối phó	1 LT + 2 TH	135–180 phút	Giảm suy nghĩ tiêu cực và né tránh	Beck CBT; Carver (1997) Brief-COPE	Module 3+4+6 Clear Fear: cognitive challenges, relaxation, exposure ladder
8	Kết nối hỗ trợ gia đình – nhà trường	1 LT + 1 TH	90–120 phút	Tăng nguồn lực hỗ trợ	Yap (2014); EACP 16 buổi cha mẹ; Murphy (2024) peer support	Phụ huynh: chat-bot hỗ trợ

3.7.3.2 Nội dung chương trình

Nội dung 8 chủ đề chi tiết (1) Nhận diện rối loạn lo âu học đường; (2) Áp lực học tập và tác động đến rối loạn lo âu; (3) Kỹ năng quản lý áp lực học tập; (4) Kiểm soát sử dụng điện thoại; (5) Ứng phó với bắt nạt học đường; (6) Xây dựng tự trọng tích cực; (7) Điều chỉnh suy nghĩ và kỹ năng đối phó với lo âu; (8) Tăng cường hỗ trợ từ gia đình và nhà trường — được giữ nguyên từ bản gốc với ba điểm bổ sung trên.

3.7.4 Đánh giá hiệu quả chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường dành cho học sinh THCS

Việc đánh giá hiệu quả chương trình được thực hiện theo thiết kế đa tầng, bao gồm cấp độ toàn trường, nhóm nhỏ và cá nhân, nhằm xác định mức độ thay đổi của học sinh sau tập huấn trên ba phương diện: mức độ rối loạn lo âu, các yếu tố nguy cơ và các yếu tố bảo vệ.

- Ở cấp độ toàn trường, đánh giá được tiến hành theo mô hình đánh giá trước – sau tập huấn nhằm xác định hiệu quả phòng ngừa phổ quát. Các chỉ số chính bao gồm điểm trung bình rối loạn lo âu (tổng quát, xã hội, chia ly), mức độ các yếu tố nguy cơ (áp lực học tập, nghiện điện thoại, bắt nạt học đường) và yếu tố bảo vệ (tự trọng, hỗ trợ từ cha mẹ, gắn bó với trường học). Hiệu quả được xác định khi các chỉ số rối loạn lo âu và nguy cơ giảm, trong khi các yếu tố bảo vệ tăng có ý nghĩa thống kê. Để đo lường hiệu quả, cần sử dụng các thang chuẩn quốc tế: RCADS (Chorpita, 2000) cho RLLA; ESSA 16 mục (Sun, 2011) cho áp lực học tập; SAS-SV hoặc BSMAS cho nghiện điện thoại; OBVQ-R (Olweus, 1996) cho bắt nạt; RSES (Rosenberg, 1965) cho lòng tự trọng; MSPSS (Zimet, 1988) cho hỗ trợ xã hội; PSSM (Goodenow, 1993) cho gắn bó trường học. Mức cải thiện

có ý nghĩa thống kê với Cohen $d \geq 0,3$ (small-to-medium) được xem là thành công bước đầu; $d \geq 0,5$ (medium) được xem là thành công đáng kể.

- Ở cấp độ nhóm nhỏ, đánh giá tập trung vào học sinh có nguy cơ cao, nhằm xem xét hiệu quả phòng ngừa trên nhóm chọn lọc. Ngoài các thang đo định lượng, việc đánh giá được bổ sung bằng quan sát, phản hồi của giáo viên và phụ huynh, cũng như mức độ cải thiện các kỹ năng cụ thể (quản lý học tập, kiểm soát điện thoại, ứng phó với rối loạn lo âu).

- Ở cấp độ cá nhân, việc đánh giá nhằm theo dõi sự thay đổi của từng học sinh, đặc biệt là những trường hợp có biểu hiện rối loạn lo âu nổi bật. Các chỉ báo bao gồm thay đổi điểm số, hành vi thực tế và mức độ đạt được mục tiêu cá nhân. Dữ liệu được thu thập thông qua tự đánh giá của học sinh, nhận xét của giáo viên và phụ huynh, cùng với nhật ký cảm xúc.

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng các phương pháp thống kê như so sánh trước sau về mức độ và biểu hiện. Chương trình được xem là hiệu quả khi mức độ rối loạn lo âu giảm, yếu tố nguy cơ suy giảm, yếu tố bảo vệ gia tăng và học sinh thể hiện sự cải thiện rõ rệt về kỹ năng và hành vi. Khuyến nghị sử dụng SEM trước và sau can thiệp để kiểm tra mô hình tích hợp *yếu tố nguy cơ* và *yếu tố bảo vệ* đối với RLLA; đặc biệt mục tiêu kéo hệ số chuẩn hóa β của *yếu tố nguy cơ* từ 0,747 xuống dưới 0,5 và đẩy hệ số chuẩn hóa β của *yếu tố bảo vệ* từ 0,352 lên trên 0,4 sau can thiệp.

Như vậy, cách tiếp cận đánh giá đa cấp độ này cho phép phản ánh đầy đủ hiệu quả của chương trình ở cả mức độ phổ quát, chọn lọc và cá nhân, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh và triển khai rộng rãi trong môi trường học đường.

3.7.5 Phương pháp và quy trình triển khai chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS

3.7.5.1 Phương pháp triển khai

Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường cho học sinh THCS được triển khai theo tiếp cận đa tầng (phổ quát – chọn lọc – cá nhân hóa), nhằm bảo đảm tác động đồng thời đến toàn bộ học sinh và các nhóm có nguy cơ cao. Về phương pháp, chương trình được tổ chức dưới hình thức tập huấn theo nhóm lớp, lồng ghép vào sinh hoạt lớp hoặc hoạt động trải nghiệm, sử dụng cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm. Trong đó, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn tham gia các hoạt động thực

hành như thảo luận tình huống, đóng vai, tự đánh giá và xây dựng kế hoạch cá nhân. Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành được duy trì cân đối nhằm tăng khả năng vận dụng vào thực tế. Đối với học sinh có nguy cơ cao, nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ bổ sung theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân, bổ sung kênh can thiệp trên các phương tiện Số, đồng thời phối hợp với phụ huynh và giáo viên để tăng hiệu quả can thiệp.

3.7.5.2 Quy trình triển khai

Quy trình triển khai chương trình được tổ chức theo các giai đoạn liên tục và có hệ thống, bao gồm:

- Giai đoạn chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn giáo viên, chuẩn bị tài liệu và công cụ đánh giá, đồng thời thông tin và phối hợp với phụ huynh.
- Giai đoạn đánh giá ban đầu: Khảo sát mức độ lo âu, các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ nhằm xác định thực trạng và nhóm học sinh cần ưu tiên hỗ trợ.
- Giai đoạn triển khai tập huấn: Tổ chức các buổi tập huấn theo trình tự logic từ nhận diện rối loạn lo âu, giảm yếu tố nguy cơ (áp lực học tập, nghiện điện thoại, bắt nạt học đường), đến tăng yếu tố bảo vệ (tự trọng, kỹ năng đối phó) và tăng cường nguồn lực hỗ trợ (gia đình, nhà trường).
- Giai đoạn đánh giá sau tập huấn: Tiến hành đo lường lại các chỉ số đã khảo sát ban đầu để xác định mức độ thay đổi và hiệu quả của chương trình.
- Giai đoạn theo dõi và duy trì: Tiếp tục hỗ trợ học sinh có nguy cơ, tổ chức các hoạt động củng cố và duy trì môi trường học đường tích cực.

Về thời điểm triển khai, chương trình nên được thực hiện vào đầu năm học, khi học sinh đang trong giai đoạn thích nghi và áp lực học tập chưa gia tăng mạnh, nhằm đạt hiệu quả phòng ngừa tối ưu. Ngoài ra, có thể triển khai vào đầu học kỳ II để can thiệp kịp thời khi áp lực bắt đầu tăng. Cần tránh triển khai vào các giai đoạn cao điểm kiểm tra và thi cử để bảo đảm sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của học sinh. Về thời lượng tổng, có 20 buổi (90–120 phút), với 8 chủ đề. Đối với cha mẹ: 16 buổi với 90 phút theo mô hình EACP (Lochman, 2025). Đối với HS có nguy cơ cao: thêm 8–9 tuần sử dụng iCBT app. Như vậy, phương pháp và quy trình triển khai chương trình được thiết kế theo hướng khoa học, hệ thống và khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường THCS và góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa rối loạn lo âu học đường.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Chương 3 đã trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở. Kết quả cho thấy các thang đo sử dụng trong nghiên cứu đạt độ tin cậy tốt, với hệ số Cronbach's alpha và McDonald's omega đều $\geq 0,70$, đồng thời các mô hình CFA đạt mức độ phù hợp chấp nhận được, qua đó khẳng định giá trị đo lường của các công cụ.

Về thực trạng, rối loạn lo âu của học sinh chủ yếu ở mức trung bình; trong đó, lo âu lan tỏa có xu hướng cao hơn so với các dạng còn lại, lo âu xã hội ở mức trung bình, còn lo âu chia ly ở mức thấp. Các biểu hiện lo âu tập trung chủ yếu vào áp lực học tập, đánh giá bản thân và các tình huống xã hội.

Chương này đã kiểm chứng 3 giả thuyết khoa học:

Với giả thuyết về sự khác biệt giới tính, số liệu cho thấy ở hai loại rối loạn lo âu lan tỏa và lo âu xã hội, HS nữ có mức độ lo âu cao hơn HS nam. Riêng về lo âu chia ly, nghiên cứu này không tìm thấy sự khác biệt giới tính có ý nghĩa thống kê.

Với giả thuyết về yếu tố lòng tự trọng, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tự trọng là yếu tố bảo vệ có ảnh hưởng mạnh đến rối loạn lo âu, đặc biệt đối với lo âu lan tỏa và lo âu xã hội, lòng tự trọng có cường độ tác động tương đương ($\sim 85-89\%$) với áp lực học tập.

Với giả thuyết về nhóm yếu tố nguy cơ, kết quả chỉ ra ba nhóm yếu tố nguy cơ có thứ tự cường độ từ cao đến thấp như sau: *áp lực học tập* ($\text{ĐTB} = 51,13$) > *ngại điện thoại* (28,38) > *bất nạt thể chất* (13,52). So sánh cường độ giữa các yếu tố nguy cơ /yếu tố bảo vệ, nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố nguy cơ áp đảo yếu tố bảo vệ ở cấp tổng hợp.

Trước thực trạng nguy cơ như vậy, học sinh đã có nhiều biện pháp đối phó, tuy nhiên kết quả đã chỉ ra rằng các biện pháp đối phó của HS chưa thực sự có hiệu quả trong việc giảm thiểu lo âu. Khi phân tích theo hai chiều thích nghi và không thích nghi, kết quả cho thấy chiều không thích nghi (tránh né) gia tăng rõ rệt cùng với triệu chứng lo âu, điều này phù hợp với kỳ vọng lý thuyết. Trong khi đó, chiều thích nghi (giải quyết vấn đề và tìm kiếm hỗ trợ) cũng đi theo chiều dương cùng triệu chứng lo âu. Thực trạng học sinh có ý thức sử dụng các chiến lược tích cực nhưng chưa đạt hiệu quả có khả năng phản ánh nhu cầu cần được đào tạo thêm về kỹ năng đối phó với chất lượng cao hơn, không chỉ là tần suất sử dụng.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng, phần cuối chương 3 đã đề xuất *Khung chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS* với 8

nội dung cơ bản, kèm theo mô tả quy trình triển khai và đánh giá hiệu quả của chương trình.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Về lý luận

Thuật ngữ "rối loạn" là một khái niệm lâm sàng được định nghĩa chặt chẽ, đòi hỏi bằng chứng về một hội chứng gây ra rối loạn chức năng tâm- sinh lý bên trong và dẫn đến hậu quả tiêu cực đáng kể (đau khổ hoặc suy giảm chức năng) cho cá nhân.

Rối loạn lo âu là trạng thái tâm lý bất thường, bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng và rối loạn hành vi liên quan, kéo dài và gây bất lợi đối với đời sống cá nhân.

Rối loạn lo âu được cấu trúc như một hệ thống đa thành phần, bao gồm các khía cạnh nhận thức, cảm xúc, sinh lý và hành vi. Trên bình diện nhận thức, lo âu gắn với các kiểu suy nghĩ tiêu cực, mang tính thảm họa hóa và thiên lệch nhận thức, làm suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và ra quyết định. Trên bình diện cảm xúc, cá nhân thường trải nghiệm trạng thái căng thẳng, bồn chồn, bất an kéo dài và dễ bị kích thích. Về mặt sinh lý, rối loạn lo âu liên quan đến sự hoạt hóa quá mức của hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến các triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở, run rẩy, đổ mồ hôi hoặc rối loạn tiêu hóa. Trên bình diện hành vi, cá nhân có xu hướng né tránh các tình huống gây lo âu hoặc sử dụng các hành vi trấn an lặp đi lặp lại, qua đó duy trì vòng xoắn lo âu.

Rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở là trạng thái tâm lý bất thường, mất cân bằng trong cảm xúc, bao gồm các biểu hiện của sự sợ hãi quá mức, sự lo lắng, phản ứng sợ hãi không phù hợp với mức độ nguy hiểm của tình huống và rối loạn hành vi liên quan, đi kèm với các biểu hiện sinh lý, kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng học tập, chất lượng cuộc sống của học sinh.

Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy ở Việt Nam còn một số khoảng trống trong lĩnh vực này như: 1) khoảng trống về phương pháp luận trong quy trình kiểm định chất lượng công cụ đo lường, chuẩn hóa cho phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, để đảm bảo các dữ liệu thu thập được từ các công cụ thang đo, bảng hỏi và phiếu phỏng vấn phản ánh đúng thực trạng, góp phần khắc phục hiện tượng chênh lệch nhau quá lớn về số liệu thực trạng của rối loạn lo âu ở HS ở trong cùng một nước, cùng một nền văn hóa, với cùng một thang đo; 2) khoảng trống trong nghiên cứu các loại

rối loạn lo âu khác nhau, không chỉ thiên lệch vào hướng nghiên cứu rối loạn lo âu lan tỏa như hiện nay; 3) khoảng trống về thiếu những công trình nghiên cứu về rối loạn lo âu trên đối tượng là HS trung học cơ sở, trong bối cảnh đa số các nghiên cứu hiện nay gộp giai đoạn lứa tuổi này vào tuổi vị thành niên, thậm chí có những nghiên cứu đưa ra khoảng độ tuổi rộng hơn nữa; 4) cần có thêm bằng chứng về sự khác biệt giới tính trong nghiên cứu rối loạn lo âu của HS, trong bối cảnh có một số công trình ở Châu Á đưa ra kết quả HS nam có mức độ lo âu cao hơn HS nữ (trái ngược với y văn quốc tế); 5) cần có các nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong việc xác định rõ ràng các yếu tố ảnh hưởng/ yếu tố nguy cơ và các yếu tố bảo vệ đối với rối loạn lo âu của học sinh; 6) cần triển khai các nghiên cứu về can thiệp cho học sinh có rối loạn lo âu để cung cấp những bằng chứng đầu tiên ở Việt Nam về nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT); 7) cần bắt đầu nghiên cứu ứng dụng CBT trong việc xây dựng khung chương trình tập huấn phòng ngừa và can thiệp rối loạn lo âu cho HS, trên cơ sở đó tiến tới xây dựng chương trình phòng ngừa và can thiệp trên nền tảng số như ở một số nước Châu Á đang làm.

1.2. Về thực tiễn

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một bức tranh chi tiết về thực trạng rối loạn lo âu trên nhóm mẫu 1352 học sinh THCS tại thời điểm hiện nay.

- Trước hết, trên phương diện đo lường, các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu đã được kiểm định một cách hệ thống về độ tin cậy với các chỉ số Cronbach's alpha, McDonald's omega và kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) đều đạt ngưỡng chấp nhận, cho thấy các công cụ đo lường có độ ổn định và phù hợp với nhóm mẫu học sinh THCS. Hệ thống các thang đo sử dụng trong nghiên cứu sau khi được hiệu chỉnh, kiểm định độ tin cậy và phân tích cấu trúc đã cho thấy mức độ phù hợp với dữ liệu thực tiễn, khẳng định bước đầu về tính khả thi các thang đo này trong ứng dụng khảo sát về rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở.

- Kết quả tổng thể cho thấy mức độ rối loạn lo âu của học sinh THCS chủ yếu tập trung ở mức trung bình, tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ học sinh có biểu hiện rối loạn lo âu ở mức cao, phản ánh nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe tâm thần trong nhóm đối tượng này. Phân tích theo các loại lo âu cho thấy, lo âu lan tỏa và lo âu xã hội có xu hướng nổi trội hơn so với lo âu chia ly.

- Luận án đã kiểm chứng 3 giả thuyết khoa học:

Với giả thuyết về sự khác biệt giới tính, số liệu cho thấy ở hai loại rối loạn lo âu lan tỏa và lo âu xã hội, HS nữ có mức độ lo âu cao hơn HS nam. Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu về lo âu lan tỏa của trẻ vị thành niên trong những năm gần đây (Wen và cs., 2020; Jenkin và cs., 2023, Phạm TH và cs., 2024,...). Riêng về lo âu chia ly, nghiên cứu này không tìm thấy sự khác biệt giới tính có ý nghĩa thống kê. Cũng giống như kết quả nghiên cứu của Allen và cs. (2010) trên 106 trẻ em được chẩn đoán rối loạn LACL (không tìm thấy sự khác biệt giới tính). Các tác giả đã nhận xét lo âu chia ly ở tuổi vị thành niên ít chịu ảnh hưởng bởi giới tính hơn LATQ và LAXH, vì cơ chế sinh học liên quan đến hệ thống gắn bó vốn ít biến đổi theo giới tính.

Với giả thuyết về yếu tố lòng tự trọng, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng lòng tự trọng là yếu tố bảo vệ có ảnh hưởng mạnh đến rối loạn lo âu, đặc biệt là đối với lo âu lan tỏa và lo âu xã hội, lòng tự trọng có cường độ tác động tương đương (~85–89%) với áp lực học tập. Đây là phát hiện quan trọng, phù hợp với giả thuyết "lòng tự trọng là yếu tố bảo vệ thuộc nhóm mạnh". Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lòng tự trọng và lo âu xã hội có vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và sức khỏe tâm thần, trong đó lòng tự trọng góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần và giúp giảm các biểu hiện lo âu (Feng et al, 2024).

Với giả thuyết về nhóm yếu tố nguy cơ, kết quả chỉ ra ba nhóm yếu tố nguy cơ có thứ tự cường độ từ cao đến thấp như sau: *áp lực học tập* (ĐTB = 51,13) > *nghiện điện thoại* (28,38) > *bắt nạt thể chất* (13,52). Trong 3 yếu tố nguy cơ này, *áp lực học tập* và *nghiện điện thoại* xếp ở vị trí số 1 và số 2, đặc biệt là áp lực học tập có cường độ vượt giữa thang đo (50/100). Yếu tố bắt nạt học đường, tuy ở vị trí thứ 3, nhưng có mẫu hình khác biệt với áp lực học tập và tự trọng. Bắt nạt học đường có hệ số chuẩn hóa β đối với LACL là 0,376, mạnh nhất trong cả ba dạng RLLA. So sánh cường độ giữa các yếu tố nguy cơ /yếu tố bảo vệ, số liệu chỉ ra rằng yếu tố nguy cơ áp đảo yếu tố bảo vệ ở cấp tổng hợp (R^2 YTNC riêng lớn gấp 4,5 lần R^2 YTBV riêng). Kết quả này đưa ra gợi ý ưu tiên giảm các yếu tố nguy cơ trong can thiệp.

- Về các biện pháp đối phó, kết quả nghiên cứu cho thấy các chiến lược đối phó hiện tại của học sinh THCS chưa thực sự hiệu quả. **Cụ thể là, chiều thích nghi (giải quyết vấn đề và tìm kiếm hỗ trợ) hiện đang ở mức trung bình, nhưng chưa cho hiệu ứng giảm lo âu như kỳ vọng; chiều không thích nghi (tránh né) gia tăng cùng triệu chứng lo âu.** Kết

qua này gợi ý cho định hướng can thiệp đồng thời loại bỏ các chiến lược không thích nghi và tăng chất lượng của các chiến lược thích nghi ở HS.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực trạng, luận án đã đề xuất được *Khung Chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu ở học sinh THCS*, đáp ứng yêu cầu cấp thiết hiện nay về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho HS ở Việt Nam.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực trạng và phân tích cơ chế tác động, các kiến nghị được đề xuất theo hướng can thiệp có mục tiêu, trong đó rối loạn lo âu được xác định là vấn đề trung tâm cần được phòng ngừa, còn các yếu tố như căng thẳng/áp lực học tập, bắt nạt học đường, hành vi sử dụng thiết bị số và chiến lược đối phó được xem là các vấn đề tác động cần được kiểm soát hoặc điều chỉnh.

2.1. Đối với học sinh

Từ góc độ cá nhân, việc phòng ngừa rối loạn lo âu cần tập trung vào việc nâng cao năng lực tự điều chỉnh tâm lý, đặc biệt là khả năng nhận diện và quản lý các trạng thái lo âu trong những tình huống cụ thể của học đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy lo âu không chỉ phát sinh từ các yếu tố bên ngoài mà còn phụ thuộc vào cách học sinh diễn giải và phản ứng với các tình huống đó. Do vậy, học sinh cần được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhận diện các dấu hiệu rối loạn lo âu sớm, hiểu rõ mối liên hệ giữa suy nghĩ-cảm xúc-hành vi, từ đó từng bước kiểm soát phản ứng rối loạn lo âu của bản thân.

Đặc biệt, trong mô hình chiến lược đối phó, các can thiệp tâm lý cần chú ý giảm các chiến lược không thích nghi (tránh né, tự đổ lỗi) qua kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức - thành phần cốt lõi của liệu pháp CBT - và nâng cao chất lượng của các chiến lược thích nghi (giải quyết vấn đề và tìm kiếm hỗ trợ) thông qua chương trình huấn luyện các kỹ năng cụ thể cho HS. Việc thay đổi cách thức phản ứng này có ý nghĩa trực tiếp trong việc cắt đứt quá trình chuyển hóa từ các yếu tố nguy cơ thành trạng thái rối loạn lo âu kéo dài. Đồng thời, trong bối cảnh môi trường số có ảnh hưởng đến rối loạn lo âu, học sinh cần phát triển năng lực sử dụng công nghệ một cách có kiểm soát, tránh lạm dụng các trải nghiệm điện thoại trực tuyến làm gia tăng rối loạn lo âu xã hội hoặc rối loạn lo âu lan tỏa.

2.2. Đối với giáo viên và nhà trường

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn lo âu ở học sinh chịu ảnh hưởng mạnh từ các đặc điểm của môi trường học đường, đặc biệt là những yếu tố có khả năng tạo ra hoặc duy trì trạng thái lo âu. Do đó, nhà trường cần chuyển từ cách tiếp cận “xử lý hậu quả” sang phòng ngừa có hệ thống đối với lo âu học đường.

Trước hết, cần lồng ghép nội dung của chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu cho học sinh THCS trong các hoạt động đầu giờ, chào cờ, sinh hoạt lớp và sinh hoạt chuyên đề, trong các sinh hoạt định kỳ thường xuyên, và có thể tổ chức dưới dạng các cuộc thi dành cho học sinh THCS. Bên cạnh đó, cần rà soát và điều chỉnh các yếu tố trong hoạt động dạy học có khả năng làm gia tăng rối loạn lo âu, như áp lực đánh giá, cạnh tranh thành tích hoặc môi trường học tập thiếu hỗ trợ. Mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn áp lực mà là kiểm soát mức độ áp lực trong ngưỡng thích ứng, tránh để chuyển hóa thành rối loạn lo âu. Bên cạnh đó, để kiểm soát mối liên hệ giữa bắt nạt học đường và rối loạn lo âu, nhà trường cần xây dựng môi trường tâm lý an toàn, trong đó các hành vi tiêu cực trong quan hệ bạn bè được phát hiện và can thiệp sớm, đồng thời thúc đẩy các chuẩn mực tương tác tích cực trong nhà trường thông qua hệ thống các quy tắc giao tiếp giữa học sinh với nhau trong nhà trường.

Giáo viên, với vai trò là người trực tiếp tiếp xúc với học sinh, cần được bồi dưỡng năng lực nhận diện các biểu hiện rối loạn lo âu và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, không chỉ về mặt kiến thức mà còn về mặt tâm lý. Điều này giúp giảm thiểu sự tích lũy rối loạn lo âu trong quá trình học tập hàng ngày.

2.3. Đối với gia đình

Gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết và định hướng trải nghiệm rối loạn lo âu của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố bảo vệ như hỗ trợ xã hội có tác động làm giảm lo âu, do đó gia đình cần được định hướng trở thành nguồn hỗ trợ tâm lý ổn định và tích cực. Cụ thể, phụ huynh cần điều chỉnh kỳ vọng của cha mẹ theo hướng phù hợp với năng lực và đặc điểm tâm lý của con, tránh tạo ra áp lực kéo dài dẫn đến rối loạn lo âu. Đồng thời, cần xây dựng môi trường giao tiếp cởi mở, trong đó học sinh có thể chia sẻ những lo lắng mà không sợ bị đánh giá hoặc áp đặt. Sự hỗ trợ về cảm xúc và sự hiện diện tích cực của gia đình sẽ góp phần làm giảm tác động của các yếu tố nguy cơ từ môi trường học đường, qua đó hạn chế sự hình thành và duy trì rối loạn lo âu.

2.4. Đối với các lực lượng hỗ trợ học đường (*chuyên viên tâm lý, phòng tư vấn học đường, đoàn thanh niên, các câu lạc bộ*)

Từ góc độ hệ thống, việc phòng ngừa rối loạn lo âu đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều lực lượng trong nhà trường. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rối loạn lo âu không phải là vấn đề cá nhân đơn lẻ mà là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố cá nhân và môi trường, do đó cần tiếp cận theo hướng can thiệp tích hợp và đa tầng.

Phòng tư vấn học đường cần triển khai các hoạt động sàng lọc và hỗ trợ sớm đối với học sinh có nguy cơ, đặc biệt là những em có biểu hiện rối loạn lo âu cao hoặc có các yếu tố nguy cơ đi kèm. Các chương trình can thiệp, phòng ngừa cần tập trung vào việc điều chỉnh cơ chế tâm lý liên quan đến rối loạn lo âu, đặc biệt là chiến lược đối phó và cách diễn giải tình huống. Trong khi đó, đoàn thanh niên và các câu lạc bộ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối xã hội, tạo môi trường hoạt động tích cực và nâng cao cảm nhận tích cực của học sinh, qua đó gián tiếp làm giảm rối loạn lo âu.

Sự phối hợp giữa các lực lượng này cần được thực hiện theo hướng có kế hoạch và dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học, đảm bảo rằng các hoạt động hỗ trợ không rời rạc mà gắn kết với các yếu tố đã được xác định trong mô hình nghiên cứu, trong chương trình tập huấn phòng ngừa rối loạn lo âu học đường ở học sinh THCS. Chỉ khi các cấp độ can thiệp, phòng ngừa được triển khai đồng bộ, việc phòng ngừa rối loạn lo âu mới đạt được hiệu quả bền vững.

3. Giới hạn và định hướng nghiên cứu

3.1. Giới hạn nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu về rối loạn lo âu ở học sinh THCS đã đạt được mục tiêu đề ra và cung cấp các bằng chứng thực nghiệm có giá trị về rối loạn lo âu ở học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được xem xét khi diễn giải kết quả.

- Trước hết, về thiết kế nghiên cứu, việc sử dụng thiết kế cắt ngang chỉ cho phép xác định mối liên hệ giữa các biến tại một thời điểm, do đó chưa thể khẳng định quan hệ nhân quả theo chiều thời gian. Các yếu tố tâm lý và hành vi có thể tương tác hai chiều, khiến cơ chế tác động trở nên phức tạp hơn so với những gì mô hình phản ánh.

- Thứ hai, về công cụ đo lường, mặc dù các thang đo đã được kiểm định bằng các chỉ số tâm trắc học hiện đại, một số cấu trúc vẫn chưa đạt mức độ phù hợp tối ưu trong

phân tích CFA. Điều này cho thấy cần tiếp tục điều chỉnh các biến quan sát nhằm nâng cao tính ổn định và độ chính xác của các cấu trúc đo lường.

- Thứ ba, nghiên cứu sử dụng phương pháp tự báo cáo, do đó có thể chịu ảnh hưởng của các sai lệch như xu hướng trả lời xã hội, nhận thức chủ quan hoặc trạng thái cảm xúc tại thời điểm khảo sát, đặc biệt đối với các nội dung nhạy cảm như bắt nạt học đường và các biểu hiện lo âu.

- Thứ tư, phạm vi mẫu nghiên cứu còn giới hạn trong một số trường thuộc cùng khu vực địa lý, do đó khả năng khái quát hóa kết quả chưa cao. Các yếu tố bối cảnh như văn hóa, điều kiện kinh tế- xã hội và môi trường giáo dục có thể ảnh hưởng đến mức độ và biểu hiện rối loạn lo âu.

- Cuối cùng, mô hình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các yếu tố nguy cơ và bảo vệ trực tiếp, chưa xem xét đầy đủ vai trò của các biến trung gian và biến điều tiết. Trong khi đó, sự khác biệt giữa các nhóm học sinh cho thấy các mối quan hệ trong mô hình có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố này.

3.2 Định hướng nghiên cứu trong tương lai

Từ những hạn chế trên, các nghiên cứu tiếp theo về rối loạn lo âu ở học sinh THCS cần được phát triển theo hướng toàn diện và sâu sắc hơn. Trước hết, cần triển khai các nghiên cứu theo thiết kế dọc nhằm theo dõi sự thay đổi của rối loạn lo âu theo thời gian, qua đó làm rõ mối quan hệ nhân quả và xác định các yếu tố dự báo quan trọng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện các công cụ đo lường thông qua việc điều chỉnh các mục hỏi và kiểm định lại cấu trúc thang đo trên các mẫu khác nhau. Việc kết hợp đa phương pháp thu thập dữ liệu (tự báo cáo, đánh giá từ giáo viên, phụ huynh hoặc quan sát hành vi) sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy và tính khách quan của dữ liệu. Ngoài ra, việc mở rộng phạm vi nghiên cứu về mặt địa lý và đối tượng là cần thiết nhằm tăng tính đại diện của mẫu và làm rõ vai trò của các yếu tố bối cảnh đối với rối loạn lo âu ở học sinh. Về mô hình nghiên cứu, các nghiên cứu trong tương lai cần phát triển các mô hình phân tích phức tạp hơn, bao gồm các biến trung gian và điều tiết, nhằm làm rõ cơ chế tác động giữa các yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ và rối loạn lo âu. Về mô hình can thiệp, cần bắt đầu thử nghiệm khung chương trình tập huấn phòng ngừa và can thiệp rối loạn lo âu cho HS như đã đề xuất. Sau đó, tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh và hoàn thiện khung chương trình ứng dụng này. Trên cơ sở đó, tiến tới xây dựng chương trình phòng ngừa

và can thiệp trên nền tảng số như ở một số nước đang làm (Sinha De Silva và cs., 2024; K. Matsumoto và cs., 2024; Zhang Qiaochu và cs., 2025).

Cuối cùng, cần chú trọng triển khai các nghiên cứu thực nghiệm nhằm xây dựng và kiểm định hiệu quả của các chương trình can thiệp phòng ngừa rối loạn lo âu trong bối cảnh học đường, qua đó cung cấp cơ sở khoa học cho việc ứng dụng trong thực tiễn giáo dục và tâm lý học đường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ Y tế. (2022). *Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022–2025* (ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Đặng Hùng Dũng, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Nga, Hà Xuân Nhâm, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Giang, & Nguyễn Hải Quân. (2026). Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới dấu hiệu lo âu ở học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hà Nội. *Vietnam Journal of Community Medicine*, 66(Special Issue CD14), 379–386. <https://doi.org/10.52163/yhc.v66iCD14.4124>
3. Đinh, Văn Tài, & cộng sự. (2021). Thực trạng lo âu của học sinh tại 3 trường trung học cơ sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2020. *Tạp chí Y học Cộng đồng*, 62(5).
4. Giang Thiên Vũ, Cao Đăng Nghi Thư, Đỗ Mai Ý Nhi, Phan Thị Ngân, & Đỗ Thành Bảo Trâm. (2023). *Sức khỏe tâm thần của vị thành niên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Sàng lọc nguy cơ và giải pháp*. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 20(8), 1453–1464. <https://doi.org/10.54607/hcmue.js.20.8.3811>(2023)
5. Hồ Thị Trúc Quỳnh (2025). *Lo âu và trầm cảm ở thanh thiếu niên tại Thừa Thiên Huế và mối quan hệ của nó với sự lạc quan*. Tạp chí Tâm lý học, Số 3 (312), tháng 3/2025, tr. 55–65.
6. Lâm Ngọc Huyền, Nguyen, Binh Thanh, Lê Thị Diễm Trinh, & Vương Văn Quang. (2022). *Stress hậu COVID-19 và các yếu tố liên quan ở nhân viên y tế Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2021*. Tạp chí Y học Việt Nam, 518(1). <https://doi.org/10.51298/vmj.v518i1.3373>
7. Lê Minh Thi, Nguyễn Đăng Khoa, & Ngô Anh Vinh (2025). *Kết quả sàng lọc lo âu, trầm cảm, stress bằng DASS-21 ở học sinh phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang năm 2024*. Tạp chí Y học Việt Nam, 549(1). <https://doi.org/10.51298/vmj.v549i1.13506>
8. Lê Thị Minh Nga. (2020). *Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
9. Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền, & Võ Viết Tiến. (2024). Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, lo âu của học sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, Thành

- phố Đà Nẵng. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng*, 22(5B), 61-76. <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9117>
10. Lương, Hữu Thông. (2005). Rối loạn lo âu - Tâm căn lo âu. Trong *Sức khỏe tâm thần, các rối loạn tâm thần thường gặp* (tr. 130-140). TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Lao động.
 11. Ngô, Anh Vinh, & Phùng, Thị Vân. (2023). Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress của học sinh trung học cơ sở dân tộc miền núi thiểu số ở trường Thái Giàng Phố, xã Thái Giàng, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 527.
 12. Nguyễn Danh Lâm, Lê Minh Giang, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Diệu Thúy, & Nguyễn Thị Thanh Mai (2022). *Thực trạng nguy cơ stress, lo âu, trầm cảm của học sinh trung học phổ thông huyện Yên Định, Thanh Hóa*. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 516(1), 67–70. <https://doi.org/10.51298/vmj.v516i1.2948>
 13. Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, & Nguyễn Thị Thúy Hằng. (2017). *Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên*. *Tạp chí Y Dược học – Trường Đại học Y Dược Huế*, 7(4), 125–130.
 14. Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, Lưu Minh Đức, Vũ Minh Thy, Nguyễn Yến Minh, Nguyễn Châu Anh, Hoàng Lan Vân, & Giáp Thị Thanh Mai. (2025). *Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh THPT tại Hà Nội: Nghiên cứu cắt ngang về trầm cảm, lo âu và căng thẳng*. *Tạp chí Y học Cộng đồng*, 66(CĐ10-HNKH). <https://doi.org/10.52163/yhc.v66iCD10.2617>
 15. Nguyễn Thị Vân (2020). *Một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh*. *Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục*, số 01(25)-tháng 3-2020. ISSN: 2354–0788.
 16. Nguyễn Thị Vân. (2019). *LO ÂU HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH* (Luận án tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).
 17. Nguyễn, Công Khanh. (2023). *Tư vấn và trị liệu cho trẻ em có rối nhiễu hành vi và khó khăn học đường*. Hội thảo Việt-Pháp về Tâm lý học, Hà Nội.
 18. Trần Hồ Vĩnh Lộc, Huỳnh Ngọc Vân Anh, & Tô Gia Kiên. (2024). *Trầm cảm, lo âu, căng thẳng và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh*. *Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh*, 27(5), 100–110. <https://doi.org/10.32895/hcjm.m.2024.05.12>
 19. Trần Nguyễn Ngọc (2018). *Hiệu quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng liệu pháp thư giãn-huyện tập*. Luận án tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.

20. Trần Thị My Lương & Đặng Đức Anh — Học viện Phụ nữ Việt Nam (2020). *Rối loạn lo âu ở HS THPT Chuyên*. Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội, Số 40/2020.
21. Trần Thị Thu Mai, & Nguyễn Ngọc Duy. (2015). Rối loạn lo âu của sinh viên một số trường sư phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh. *Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh*, 11(77).
22. UNICEF và Bộ GD&ĐT (2022). *Nghiên cứu toàn diện về các yếu tố liên quan đến trường học ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của thanh thiếu niên nam và nữ tại Việt Nam*, do UNICEF Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), Hanoi, 2022.
23. Võ Văn Bản (2002), *Các rối loạn lo âu*, Nxb Y học.
24. Võ Văn Bản (Chủ biên). (2017). *Tâm lý học lâm sàng*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

25. Alatawi, Abeer, Alghamdi, Ali, Albalwi, Abdulaziz Aoudh, Altayar, Malik, Jalal, Mohammed, & Frah, Eman A. M. (2020). *Prevalence of generalized anxiety disorder (GAD) among Saudi medical students and associated risk factors*. *International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences*, 5(9), 1–9. <https://doi.org/10.22259/ijrsmhs.0509001>
26. Allen, K.-A., Greenwood, C. J., Berger, E., Patlamazoglou, L., Reupert, A., Wurf, G., May, F., O'Connor, M., Sanson, A., Olsson, C. A., & Letcher, P. (2024). Adolescent school belonging and mental health outcomes in young adulthood: Findings from a multi-wave prospective cohort study. *School Mental Health*, 16(1), 149–160. <https://doi.org/10.1007/s12310-023-09626-6>
27. American Psychiatric Association. (1987). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (3rd ed., revised). Washington, DC: American Psychiatric Association.
28. American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). American Psychiatric Press.
29. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
30. Anderson, T. L., Valiauga, R., Tallo, C., Hong, C. B., Manoranjithan, S., Domingo, C., Paudel, M., Untaroiu, A., Barr, S., & Goldhaber, K. (2025). *Contributing factors to the rise in adolescent anxiety and associated mental health disorders: A narrative review of current literature*. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 38(1), e70009. <https://doi.org/10.1111/jcap.70009>

31. Barlow, David H. (2002). *Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic* (2nd ed.). Guilford Press.
32. Barlow, David H., & Di Nardo, Peter A. (1991). Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-III-R (ADIS-III-R). San Antonio, TX: Psychological Corporation.
33. Beesdo, Katja, Knappe, Susanne, & Pine, Daniel S. (2009). *Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: Developmental issues and implications for DSM-V*. *Psychiatric Clinics of North America*, 32(3), 483–524. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2009.06.002>
34. Beesdo, Katja, Pine, Daniel S., Lieb, Roselind, & Wittchen, Hans-Ulrich. (2010). Incidence and risk patterns of anxiety and depressive disorders and categorization of generalized anxiety disorder. *Archives of General Psychiatry*, 67(1), 47–57. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2009.177>
35. Beesdo-Baum, K., Knappe, S., & Pine, D. S. (2022). Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: Developmental issues and implications for DSM-5. *Annual Review of Clinical Psychology*, 18, 173–199. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-110040>
36. Bernat, Debra H.; Resnick, Michael D. (2009). Connectedness in the lives of adolescents. In Richard J. DiClemente; John S. Santelli; Richard A. Crosby (Eds.), *Adolescent health: Understanding and preventing risk behaviors* (pp. 375–389). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
37. Bhardwaj, R., et al. (2020). *A descriptive study to assess depression, anxiety & stress among higher secondary students of Government schools of Chandigarh, India*. *Journal of IPHA Chandigarh State Branch*, 2020. [Lưu ý: DOI/PMID/PMCID trong bản cũ là copy nhầm từ paper Xu Q. 2021, đã xóa]
38. Blakemore, S.-J., & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: Implications for executive function and social cognition. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(3-4), 296-312. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01611.x>
39. Borgogno, Marta, Davico, Chiara, Vitiello, Benedetto, Martinuzzi, Andrea, Ricci, Federica Silvia, Amianto, Federico, & Marcotulli, Daniele. (2026). Academic pressure and mental health in adolescents: A cross-sectional study. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*. <https://doi.org/10.1186/s13034-026-01051-2>
40. Borowsky, Iris W.; Resnick, Michael D.; Ireland, Mary; Blum, Robert W. (1999). Suicide attempts among American Indian and Alaska Native youth: Risk and protective factors. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 153(6), 573–580.

41. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press
42. Brookmeyer, Kathryn A.; Fanti, Kostas A.; Henrich, Christopher C. (2006). Schools, parents, and youth violence: A multilevel, ecological analysis. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 35(4), 504–514.
43. Brown JSL, James K, Lisk S, Shearer J, Byford S, Stallard P, Deighton J, Saunders D, Yarrum J, Fonagy P, Weaver T, Sclare I, Day C, Evans C, Carter B (2024). "Clinical effectiveness and cost-effectiveness of a brief accessible cognitive behavioural therapy programme for stress in school-aged adolescents (BESST)", *The Lancet Psychiatry*, 11(7): 504–515 (PMID: 38759665). DOI: [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(24\)00101-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(24)00101-9).
44. Brown JSL, Lisk S, Carter B, Stevelink SAM, Van Lieshout R, Michelson D (2022). "How Can We Actually Change Help-Seeking Behaviour for Mental Health Problems among the General Public? Development of the 'PLACES' Model". *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5): 2831. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph19052831>.
45. Brunborg S. G., Sondre Aasen Nilsen, Jens Christoffer Skogen, Lasse Bang (2025). *Possible Explanations for the Upward Trend in Mental Distress among Adolescents in Norway from 2011 to 2024*. *Social Science & Medicine* (Q1, IF = 5,4). Vol. 384 (2025), Article 118528, 10 trang. DOI: 10.1016/j.socscimed.2025.118528.
46. Cai, C., Mei, Z., Wang, Z., & Luo, S. (2025). School-based interventions for resilience in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1594658.
47. Caldwell, David M.; Davies, Sarah R.; Hetrick, Sarah E.; Palmer, Julie C.; Caro, Paula; López-López, José A.; Gunnell, David; Kidger, Judi; Thomas, James; French, Rhiannon; Stockings, Emily; Campbell, Rona; Welton, Nicky J. (2019). School-based interventions to prevent anxiety and depression in children and young people: A systematic review and network meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 6(12), 1011–1020. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30403-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30403-1)
48. Carskadon, M. A. (2011). Sleep in adolescents: The perfect storm. *Pediatric Clinics of North America*, 58(3), 637-647. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2011.03.003>

49. Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol is too long: Consider the brief cope. *International Journal of Behavioral Medicine*, 4(1), 92-100.
50. Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124(1), 111-126. <https://doi.org/10.1196/annals.1440.010>.
51. Cho, J., Park, J., Lee, H., Jo, H., Lee, S., Kim, H. J., Son, Y., Kim, H., Woo, S., Kim, S., Kang, J., Pizzol, D., Hwang, J., Smith, L., & Yon, D. K. (2024). *National trends in adolescents' mental health by income level in South Korea, pre- and post-COVID-19, 2006–2022*. Scientific Reports, 14, 25021. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-74073-5>
52. Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., Williams, E., & Thigpen, J. C. (2017). *Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review*. Psychological Bulletin, 143(9), 939–991. <https://doi.org/10.1037/bul0000110>
53. Costello, E. J., Egger, H. L., & Angold, A. (2005). The developmental epidemiology of anxiety disorders: Phenomenology, prevalence, and comorbidity. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 14(4), 631-644.
54. Crisp D., Debra Rickwood, Richard Burns, Emily Bariola (2025). *The Complete Mental Health of Australia's Adolescents and Emerging Adults: Distress and Wellbeing across 3 Nationally Representative Community Samples*. Epidemiology and Psychiatric Sciences (Q1, IF ≈ 7.0). 2025, Vol. 34, e16, 11 trang. DOI 10.1017/S2045796025000083.
55. Cummings, C. M., Caporino, N. E., & Kendall, P. C. (2014). Comorbidity of anxiety and depression in children and adolescents: 20 years after. *Psychological Bulletin*, 140(3), 816–845. <https://doi.org/10.1037/a0034733>
56. Darbyshire, P., & Beitsayadeh, C. (2025). *Transforming and standardizing Likert scale data: A crucial step in multi-instrument research*. Preprints. Minh chứng PDF file:///C:/Users/NC/Downloads/preprints202503.2064.v1.pdf
57. Data Resource Center for Child & Adolescent Health (2023): National Survey of Children's Health (NSCH) 2020.
58. de Lijster, J. M., Dieleman, G. C., Utens, E. M. W. J., Dierckx, B., Wierenga, M., Verhulst, F. C., & Legerstee, J. S. (2018). Social and academic functioning in adolescents with anxiety disorders: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 230, 108–117. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.01.008>
59. de Lijster, J. M., Dierckx, B., Utens, E. M. W. J., Verhulst, F. C., Zieldorff, C., Dieleman, G. C., & Legerstee, J. S. (2017). The age of onset of anxiety disorders: A meta-

- analysis. *Canadian Journal of Psychiatry*, 62(4), 237–246. <https://doi.org/10.1177/0706743716640757>
60. Deb, S., Strodl, E., & Sun, J. (2015). Academic stress, parental pressure, anxiety and mental health among Indian high school students. *International Journal of Psychology and Behavioral Sciences*, 5(1), 26–34. 57.
 61. Deng, J., Liu, J., Luo, J., Pi, Y., Pan, J., Fu, Z., & Tang, X. (2024). Social anxiety and bullying victimization: A three-level meta-analysis of cross-sectional and longitudinal studies. *Child Abuse & Neglect*, 157, 107052. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107052>
 62. Dinh, Hong-Van Thi, Do, Le-Hang Thi, & Phan, Mai-Huong Thi. (2021). *School factors causing Vietnamese adolescents' anxiety in secondary schools*. *Psychology and Education*, 58(1), 883–894.
 63. Dunning, D. L., Griffiths, K., Kuyken, W., Crane, C., Foulkes, L., Parker, J., & Dalgleish, T. (2019). *The effects of mindfulness-based interventions on cognition and mental health in children and adolescents – A meta-analysis of randomized controlled trials*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 60(3), 244–258. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12980>
 64. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
 65. Ebesutani, Chad, Bernstein, Adam, Nakamura, Bradley J., Chorpita, Bruce F., Weisz, John R., & Research Network on Youth Mental Health. (2010). *A psychometric analysis of the revised child anxiety and depression scale—Parent version in a clinical sample*. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 38(2), 249–260. <https://doi.org/10.1007/s10802-009-9363-8>
 66. Ebesutani, Chad, Reise, Steven P., Chorpita, Bruce F., Ale, Chelsea, Regan, Jennifer, Young, John, Higa-McMillan, Charmaine, & Weisz, John R. (2012). *The Revised Child Anxiety and Depression Scale—Short Version: Scale reduction via exploratory bifactor modeling of the broad anxiety factor*. *Psychological Assessment*, 24(4), 833–845. <https://doi.org/10.1037/a0027283>
 67. Elhai, Jon D., Dvorak, Robert D., Levine, Jason C., & Hall, Brian J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 207, 251–259. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.030>
 68. Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. *Child Development*, 38(4), 1025–1034. <https://doi.org/10.2307/1127100>
 69. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.

70. Essau, C. A., Sasagawa, S., & Sato, H. (2012). Epidemiology of anxiety disorders in adolescents: A review. In C. A. Essau & S. Sasagawa (Eds.), *Adolescent mental health* (pp. 57-74). Palgrave Macmillan.
71. Fang, Die, Lu, Jin, Che, Yusan, Ran, Hailiang, Peng, Junwei, Chen, Lin, Wang, Sifan, Liang, Xuemeng, Sun, Hao, & Xiao, Yuanyuan. (2022). *School bullying victimization-associated anxiety in Chinese children and adolescents: The mediation of resilience*. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 16, 52. <https://doi.org/10.1186/s13034-022-00490-x>
72. Fassi L., Amanda M. Ferguson, Andrew K. Przybylski, Tamsin J. Ford, Amy Orben (2025). *Social Media Use in Adolescents with and without Mental Health Conditions*. *Nature Human Behaviour* (Q1, IF $\approx$ 30). 2025, Vol. 9, pp. 1283–1299, 21 trang. DOI 10.1038/s41562-025-02134-4.
73. Fazel, M., Hoagwood, K., Stephan, S., & Ford, T. (2014). *Mental health interventions in schools in high-income countries*. *The Lancet Psychiatry*, 1(5), 377–387. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)70312-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70312-8)
74. Feng, Wanxuan, Zhao, Liangyu, Ge, Zhang, Zhao, Xiuhan, Li, Tuojian, & Zhu, Qiying. (2024). *Association between physical activity and adolescent mental health in the post COVID-19: The chain mediating effect of self-esteem and social anxiety*. *PLoS One*, 19(5), e0301617. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301617>
75. Feriante, J., Torrico, T. J., & Bernstein, B. (2023). Separation anxiety disorder. In StatPearls. StatPearls Publishing <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560793/>
76. Fitzpatrick, M. M., Anderson, A. M., Browning, C., & Ford, J. L. (2024). Relationship between family and friend support and psychological distress in adolescents. *Journal of Pediatric Health Care*. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2024.06.016>
77. 51. GBD 2021 ASEAN Mental Disorders Collaborators (2025). *The epidemiology and burden of ten mental disorders in countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 1990–2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. *The Lancet Public Health*, 10(7), e480–e491. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(25\)00098-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00098-2)
78. Gore, F. M., Bloem, P. J., Patton, G. C., Ferguson, J., Joseph, V., Sawyer, S. M., & Mathers, C. D. (2011). Global burden of disease in young people aged 10-24 years: a systematic analysis. *The Lancet*, 377(9783), 2093-2102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60512-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60512-6)

79. Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). *Assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research*. Journal of Business Research, 109, 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
80. Hale, W. W., III, Raaijmakers, Q. A. W., & van der Valk, I. (2018). The co-occurrence of depressive symptoms and anxiety symptoms in adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Youth and Adolescence*, 47(1), 1-17.
81. Hale, William W., Raaijmakers, Quinten A. W., Muris, Peter, & Meeus, Wim H. J. (2005).
Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in the general adolescent population. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(3), 283–290. <https://doi.org/10.1097/00004583-200503000-00013>
82. Haugland, S., Wold, B., Stevenson, J., Aarø, L. E., & Woynarowska, B. (2001). *Subjective health complaints in adolescence. A cross-national comparison of prevalence and dimensionality*. European Journal of Public Health, 11(1), 4–10. <https://doi.org/10.1093/eurpub/11.1.4>
83. Hayes, A. F., & Coutts, J. J. (2020). Use omega rather than Cronbach’s alpha for estimating reliability. *Communication Methods and Measures*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/19312458.2020.1718629>
84. Herres J., Christine McCauley Ohannessian (2015). Adolescent coping profiles differentiate reports of depression and anxiety symptoms. *Journal of Affective Disorders* (Elsevier). Tập 186: trang 312–319 (số đặc biệt tháng 8/2015). DOI: 10.1016/j.jad.2015.07.031. PMC4565746. N = 982 học sinh THPT (54% nữ; 46% nam). 16,09 tuổi (SD = 0,68); lớp 10–11
85. Hettema, J. M., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2001). A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. *American Journal of Psychiatry*, 158(10), 1568-1578. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.10.1568>
86. Hoàng Trung Học & Nguyễn Thùy Dung. (2025). Levels of Stress, Anxiety, and Depression in Adolescents during and after the COVID-19 Pandemic in Vietnam: A Cross-sectional study. *American Journal of Psychiatric Rehabilitation*, 28(1), tháng 4/2025, trang 360–367. DOI: 10.69980/ajpr.v28i1.105. ISSN: 1548-7776.
87. Islam, Md Irteja, Cheruvu, Vaikunth Sia, Laska, Caitlin, Esgin, Tuguy, & Martiniuk, Alexandra. (2025). *School connectedness boosts mental health in Indigenous adolescents with adverse childhood experiences: Mediation analysis of a longitudinal study in Australia*. *Journal of School Health*, 95(9), 731–740. <https://doi.org/10.1111/josh.70047>

88. 62. Janis H. Jenkins, Giselle Sanchez, Eric A. Miller, Nadia Irina Santillanes Allande, Grace Urano, Alexandra J. Pryor (2023). *Depression and anxiety among multiethnic middle school students: Age, gender, and sociocultural environment*. International Journal of Social Psychiatry, 2023, Vol. 69(3), 784–794. DOI: 10.1177/00207640221140282. PMID: 36529994 | PMCID: PMC10152214.
89. Jaworska, N., & MacQueen, G. (2015). Adolescence as a unique developmental period. *Journal of Psychiatry & Neuroscience*, 40(5), 291–293. <https://doi.org/10.1503/jpn.150268>
90. Jefferies P., Michael Ungar (2020). *Social Anxiety in Young People: A Prevalence Study in Seven Countries*. PLOS ONE (Q1, IF $\approx$ 3,7). 2020, Vol. 15(9), e0239133, 18 trang. DOI 10.1371/journal.pone.0239133.
91. Jenkins, J. H., Sanchez, G., & colleagues. (2023). Depression and anxiety among multiethnic middle school students: Age, gender, and sociocultural environment. *International Journal of Social Psychiatry*, 69(3), 784-794. doi: 10.1177/00207640221140282
92. Jennifer N.B. et al. (2024). *Efficacy of a Mobile App-Based Intervention for Young Adults With Anxiety Disorders. A Randomized Clinical Trial*, JAMA Network Open vol. 7(8), e2428372, tr. 1–15 (Bress et al. 2024). DOI:10.1001/jamanetworkopen.2024.28372.
93. Jesper Schmidt-Persson et al. (2024). *Screen Media Use and Mental Health of Children and Adolescents: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial*. JAMA Network Open (Q1, IF $\approx$ 13,8). 2024, Vol. 7(7), e2419881, 12 trang. DOI 10.1001/jamanetworkopen.2024.19881.
94. June S. L. Brown & Ben Carter (2025). *School based interventions for depression and anxiety in UK*, Journal of Mental Health, 34(4), 357-361, DOI: 10.1080/09638237.2025.2512332.
95. Jystad, Ingunn., Haugan, Tommy., Bjerkeset, Ottar., Sund, Erik R., & Vaag, Jonas. (2021). *School functioning and educational aspirations in adolescents with social anxiety—The Young-HUNT3 study, Norway*. *Frontiers in Psychology*, 12, 727529. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.727529>
96. Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 593-602. DOI: [10.1001/archpsyc.62.6.593](https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.593)
97. Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey

- Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 617–627. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.617>
98. Kim, Young-Ho. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. *International Journal of Nursing Studies*, 40(2), 115–124. [https://doi.org/10.1016/S0020-7489\(02\)00037-8](https://doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00037-8)
 99. Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling* (5th ed.). Guilford Press.
 100. La Greca, A. M., & Harrison, H. M. (2021). Adolescent peer relations, friendships, and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*. <https://doi.org/10.1080/15374416.2021.1915820>
 101. Lawrence, D., Johnson, S., Hafekost, J., Boterhoven De Haan, K., Sawyer, M., Ainley, J., & Zubrick, S. R. (2015). *The mental health of children and adolescents: Report on the second Australian Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing*. Department of Health.
 102. Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Đức Anh, Trương Thị Thùy Dương, Phạm Minh Huệ, Hoàng Thị Lệ Chi, & Nguyễn Ngọc Anh. (2024). *The current state of social anxiety disorder in the first-year students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy in 2023*. Tạp chí Y học Việt Nam, 17(91), 119.
 103. LeDoux, J. E., & Pine, D. S. (2016). Using neuroscience to help understand fear and anxiety: A two-system framework. *American Journal of Psychiatry*, 173(11), 1083–1093. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16030353>
 104. Lee, M.-S., & Lee, H. (2023). *Problematic smartphone use and its relationship with anxiety and suicidal ideation among South Korean adolescents*. *Psychiatry Investigation*, 20(9), 843–852. <https://doi.org/10.30773/pi.2023.0051>
 105. Li L., Qiner Li, Jingyi Wang, Quan Fu and Meng Chi (2025). *Effects of different interventions on anxiety disorders in children and adolescents: a systematic review and bayesian network meta-analysis*. *BMC Psychiatry* vol. 25, article 809, tr. 1–14 (Li et al. 2025). PROSPERO CRD42024587910. Li et al. *BMC Psychiatry* (2025) 25:809 <https://doi.org/10.1186/s12888-025-07227-y>.
 106. Li, Yanzhi, Lin, Yi-Fan, Wu, Herui, Yang, Liwen, Zhu, Liwan, Sun, Xinchang, Dong, Shuwen, Wang, Wanxin, Yang, Lei, Yan, Bin, & Lu, Ciyong. (2025). *Changes in smartphone dependence and depressive and anxiety symptoms among Chinese adolescents*. *BMC Medicine*, 23, 523. <https://doi.org/10.1186/s12916-025-04372-9>

107. Mandaknalli R., Ragini Malusare (2021). *A cross-sectional study on the prevalence of anxiety among municipality school area*. MedPulse International Journal of Psychology, Volume 18, Issue 3, June 2021, pp. 19-22. ISSN: Print: 2579-0919, Online: 2636-459X.
108. Matsumoto K.; Sayo Hamatani; Kiko Shiga; Kiyoko Iiboshi; Makiko Kasai; Yasuhiro Kimura; Satoshi Yokota; Katsunori Watanabe; Yoko Kubo; Masayuki Nakamura (2024). *Effectiveness of Unguided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Subthreshold Social Anxiety Disorder in Adolescents and Young Adults: Multicenter Randomized Controlled Trial*. JMIR Pediatrics and Parenting vol. 7, tr. 1–13. DOI: 10.2196/55786.
109. Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. *Child Development*, 85(1), 6–20. <https://doi.org/10.1111/cdev.12205>
110. Merikangas, K. R., He, J. P., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., Benjet, C., Georgiades, K., & Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in U.S. adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication-Adolescent Supplement (NCS-A). *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 49(10), 980-989. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.05.017>
111. Mojtabai R. MD, PhD, MPH; Mark Olfson, MD, MPH (2025). *Trends in Mental Disorders in Children and Adolescents Receiving Treatment in the State Mental Health System*. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry — JAACAP* (Q1, IF $\approx$ 11,0). Vol. 64, No. 8, August 2025, 15 trang. DOI: 10.1016/j.jaac.2024.08.008.
112. Mojtabai, R., Olfson, M., & Han, B. (2016). National trends in the prevalence and treatment of depression in adolescents and young adults. *Pediatrics*, 138(6), e20161878. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-1878>
113. Mossman, S. A., Luft, M. J., Schroeder, H. K., Varney, S. T., Fleck, D. E., Barzman, D. H., Gilman, R., DelBello, M. P., & Strawn, J. R. (2017). *The Generalized Anxiety Disorder 7-item scale in adolescents with generalized anxiety disorder: Signal detection and validation*. *Annals of Clinical Psychiatry*, 29(4), 227–234A. PMID: 29069107.
114. Mudunna C., Medhavi Weerasinghe, Thach Tran, Josefine Antoniadis, Lorena Romero, Miyuru Chandradasa, Jane Fisher (2025). *Nature, prevalence and determinants of mental health problems experienced by adolescents in south Asia: a systematic review*.

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. DOI: 10.1016/S2772-3682(25)00003-4.

115. Murphy R., Leigh Huggard, Amanda Fitzgerald, Eilis Hennessy, Ailbhe Booth (2023). *A systematic scoping review of peer support interventions in integrated primary youth mental health care*. Journal of Community Psychology, vol. 52(1):154-180 (2024). ·Wiley· Open Access (CC BY). DOI: 10.1002/jcop.23090. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37740958/>
116. Myruski, S., Pérez-Edgar, K., & Buss, K. A. (2024). Adolescent coping and social media use moderated anxiety change during the COVID-19 pandemic. *Journal of Adolescence*, 96(1), 177–195. <https://doi.org/10.1002/jad.12267>
117. Nakie G., Tesfaye Segon, Mamaru Melkam, Getachew Tesfaw Desalegn, Tadele Amare Zeleke (2022): *Prevalence and associated factors of depression, anxiety, and stress among high school students in Northwest Ethiopia, 2021*. BMC Psychiatry, 2022, 22:739. **DOI:** 10.1186/s12888-022-04393-1. **PMID:** 36443717 | **PMCID:** PMC9707065.
118. Nawaz, Rida F.; Cross, Lynne. (2021, October). School-based mental health interventions: Reducing depression, anxiety and aggressive behaviour. *The Mental Elf*. <https://www.nationalelfservice.net>
119. Nemeroff, C. B. (2002). The neurobiology of anxiety disorders: Brain imaging, genetics, and psychoneuroendocrinology. *Biological Psychiatry*, 52(12), 1017-1019.
120. Ngô Anh Vinh, Vũ Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Bích Vân, Dương Anh Tài, & Lê Thị Thanh Thùy (2024). Mental health among ethnic minority adolescents in Vietnam and correlated factors: A cross-sectional study. *Journal of Affective Disorders Reports*, 17. Tr.1-5. DOI: 10.1016/j.jadr.2024.100795.
121. Novak, Christopher J.; Chang, Edward C.; Xu, Jian; Shen, Jian; Zheng, Shuo; Wang, Yijie. (2021). Basic psychological needs and negative affective conditions in Chinese adolescents: Does coping still matter? *Personality and Individual Differences*, 179, 110889.
122. Orgilés, M., Galán-Luque, T., Hervás, D., Idrobo, A., & Morales, A. (2023). *Validación de la versión para padres de la Escala de Ansiedad Infantil de Spence Breve (SCAS-P-8) en niños ecuatorianos*. Revista Latinoamericana de Psicología, 55, 227–235.
123. Osman, Augustine, Wong, Julie L., Bagge, Courtney L., Freedenthal, Stacey, Gutierrez, Peter M., & Lozano, Gerardo. (2012). The Depression Anxiety Stress Scales—21 (DASS-21): Further examination of dimensions, scale reliability, and correlates. *Journal of Clinical Psychology*, 68(12), 1322–1338. <https://doi.org/10.1002/jclp.21908>

124. Petersen, Anne C., & Leffert, Nancy. (1995). *Developmental issues influencing guidelines for adolescent health research: A review*. *Journal of Adolescent Health*, 17(5), 298–305. [https://doi.org/10.1016/1054-139x\(95\)00184-t](https://doi.org/10.1016/1054-139x(95)00184-t)
125. Phạm Thị Thu Hoa, et al. (2024). *Anxiety symptoms and coping strategies among high school students in Vietnam after COVID-19*. *Frontiers in Public Health*, 12, DOI 10.3389/fpubh.2024.1232856.
126. Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. Basic Books.
127. Pine, D. S., & Klein, R. G. (2010). Anxiety disorders. In M. Rutter & D. J. Fonagy (Eds.), *Rutter's child and adolescent psychiatry* (5th ed., pp. 605-626). Wiley-Blackwell.
128. Praptomojati A., Ajeng Viska Icanervilia, Maaik H. Nauta, Theo K. Bouman (2024). *A systematic review of Culturally Adapted Cognitive Behavioral Therapy (CA-CBT) for anxiety disorders in Southeast Asia*. *A J Psychiatry* vol. 92, pp. 1–9 (Q1, IF ≈ 12). DOI: 10.1016/j.ajp.2023.103896.
129. Prinstein, M. J., Boergers, J., Spirito, A., Little, T. D., & Grapentine, W. L. (2000). *Peer functioning, family dysfunction, and psychological symptoms in a risk factor model for adolescent inpatients' suicidal ideation severity*. *Journal of Clinical Child Psychology*, 29(3), 392–405. https://doi.org/10.1207/S15374424JCCP2903_8
130. Qian, Mengting, Jin, Rui, Lu, Chunping, & Zhao, Mingren. (2024). *Parental emotional support, self-efficacy, and mental health problems among adolescents in Hong Kong: A moderated mediation approach*. *Frontiers in Psychiatry*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1458275>
131. Racine, N., McArthur, B. A., Cooke, J. E., Eirich, R., Zhu, J., & Madigan, S. (2021). Global prevalence of anxiety symptoms. *JAMA Pediatrics*, 175(11), 1142–1150. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482>
132. Racine, Nicole; McArthur, Brittany A.; Cooke, Jessica E.; Eirich, Rachel; Zhu, Jenny; Madigan, Sheri. (2021). Global prevalence of depressive and anxiety symptoms in children and adolescents during COVID-19: A meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 175(11), 1142–1150. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482>
133. Raniti, M., Rakesh, D., Patton, G. C., & Sawyer, S. M. (2022). The role of school connectedness in the prevention of youth depression and anxiety: A systematic review with youth consultation. *BMC Public Health*, 22, 2152. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14364-6>
134. Rapee, R. M., Creswell, C., & Kendall, P. C. (2023). Anxiety disorders in children and adolescents: A summary and overview of the literature. *Behaviour Research and Therapy*, 168, 104376. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2023.104376>

135. Reem Alharbi, Khalid Alsuhaibani, Abdullah Almarshad, Abdulhameed Alyahya (2019): *Depression and anxiety among high school student at Qassim Region*. Journal of Family Medicine and Primary Care, 2019, Vol. 8(2), 504–510. **DOI:** 10.4103/jfmpe.jfmpe_383_18. **PMID:** 30984663 | **PMCID:** PMC6436297.
136. Rodríguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). *Evaluating bifactor models: Calculating and interpreting statistical indices*. Psychological Methods, 21(2), 137–150. <https://doi.org/10.1037/met0000045>
137. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
138. Roth, J. H., & Dadds, M. R. (2000). Early intervention for anxiety disorders in children and adolescents. Australian Academic Press.
139. Ruscio, A. M., Brown, T. A., Chiu, W. T., Sareen, J., Stein, M. B., & Kessler, R. C. (2008). Social fears and social phobia in the USA: Results from the National Comorbidity Survey Replication. *Psychological Medicine*, 38(1), 15-28. <https://doi.org/10.1017/S0033291707001699>
140. Saikia A. M., Hemen Das, Vinoth Rajendran (2023). *Mental Health Morbidities and their Correlates among the Adolescents in Kamrup (Metro), Assam: A School-Based Study*. Indian Journal of Community Medicine, 2023, Vol. 48(6), 835–840. **DOI:** 10.4103/ijcm.ijcm_614_21. **PMCID:** PMC10795877.
141. Santrock, J. W. (2021). *Adolescence* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
142. Schmidt, Matthew E.; Bagwell, Catherine L. (2007). The protective role of friendships in overtly and relationally victimized boys and girls. *Merrill-Palmer Quarterly*, 53(3), 439–460. <https://doi.org/10.1353/mpq.2007.0021>
143. Shi, D., Maydeu-Olivares, A., & Rosseel, Y. (2020). Assessing fit in structural equation models: A Monte Carlo evaluation of approximate fit indices. *Structural Equation Modeling*, 27(5), 725–748. <https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1678503>
144. Shortt, A. L., & Barrett, P. M. (2001). The influence of family and experimental context on cognition in anxious children. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 29(6), 585-596. doi: 10.1023/a:1012289427845.
145. Silove, D. M., Marnane, C. L., Wagner, R., Manicavasagar, V. L., & Rees, S. (2010). The prevalence and correlates of adult separation anxiety disorder in an anxiety clinic. *BMC Psychiatry*, 10, Article 21. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-21>

146. Silva S. D., Renuka Peris, Sudharshi Senaviratne and Dulani Samaranayake (2024). *Effectiveness of a cognitive behavioural therapy (CBT)-based intervention for reducing anxiety among adolescents in the Colombo District, Sri Lanka: cluster randomized controlled trial*. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health vol. 18, article 108, tr. 1–12, DOI 10.1186/s13034-024-00799-9.
147. Silverman, W. K., & Ollendick, T. H. (2005). *Evidence-based assessment of anxiety and its disorders in children and adolescents*. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(3), 380–411. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3403_2
148. Sisk, C. L., & Foster, D. L. (2004). The neural basis of puberty and adolescence. *Nature Neuroscience*, 7(10), 1040-1047. <https://doi.org/10.1038/nn1326>
149. Smetana, J. G. (2011). *Adolescents, families, and social development: How teens construct their worlds*. John Wiley & Sons.
150. Somers, J. M., Goldner, E. M., Waraich, P., & Hsu, L. (2006). Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: A systematic review of the literature. *Canadian Journal of Psychiatry*, 51(2), 100-113. <https://doi.org/10.1177/070674370605100206>
151. Sophie H. Li, Philip J. Batterham, Alexis E. Whitton, Kate Maston, Asaduzzaman Khan, Helen Christensen, Aliza Werner-Seidler (2025). *Cross-sectional and Longitudinal Associations of Screen Time with Adolescent Depression and Anxiety*. British Journal of Clinical Psychology (BJCP) (Q1, IF $\approx$ 3,0). Vol. 64, pp. 873–887, 2025, 15 trang. 4.058 VTN Úc (tuổi TB = 13,9; SD = 0,58), 134 trường trung học. DOI: 10.1111/bjc.12547.
152. Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. *Psychological Bulletin*, 139(1), 213–240. <https://doi.org/10.1037/a0028931>
153. Steare, Thomas, Gutiérrez Muñoz, Carolina, Sullivan, Alice, & Lewis, Gemma. (2023). The association between academic pressure and adolescent mental health: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 339, 302–317. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.028>
154. Steinberg, L. (2005). *Cognitive and affective development in adolescence*. Trends in Cognitive Sciences, 9(2), 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005>
155. Stephens M., Eleanor Keiller, Maev Conneely, Paul Heritage, Mariana Steffen, Victoria Jane Bird (2023). A systematic scoping review of Photovoice within mental health research involving adolescents International Journal of Adolescence and Youth, vol. 28, no. 1, 2244043 (2023). DOI: <https://doi.org/10.1080/02673843.2023.2244043>. 82 (chính: 18 trang; Table 2 mở rộng: 53 trang; refs: 7 trang).

156. Stockings, E., Hall, W. D., Lynskey, M., Morley, K. I., Reavley, N., Strang, J., & Patton, G. (2022). Preventing depression and anxiety in young people. *The Lancet Psychiatry*, 9(6), 471–482. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00063-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00063-3)
157. Strauss, Christopher C., & Last, Cynthia G. (1993). *Social and simple phobias in children*. *Journal of Anxiety Disorders*, 7(2), 141–152. [https://doi.org/10.1016/0887-6185\(93\)90012-A](https://doi.org/10.1016/0887-6185(93)90012-A)
158. Sun, Jiandong, Dunne, Michael P., Hou, Janet, & Xu, Aiqiang. (2011). Educational stress scale for adolescents: Development, validity, and reliability with Chinese students. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 29(6), 534–546.
159. Tarasenko, A., Josy, G., Minnis, H., Hall, J., Danese, A., Lau, J. Y. F., Cortese, S., Stringaris, A., Redlich, C., & Ougrin, D. (2025). *Mental health of children and young people in the WHO Europe region*. *The Lancet Regional Health – Europe*, 57, 101459. <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2025.101459>
160. Thoits, Peggy A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. *Journal of Health and Social Behavior*, 52(2), 145–161. <https://doi.org/10.1177/0022146510395592>
161. Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood--and what that means for the rest of us*. Atria Books.
162. Twenge, J. M., Cooper, A. B., Joiner, T. E., Duffy, M. E., & Binau, S. G. (2019). Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005-2017. *Journal of Abnormal Psychology*, 128(3), 185-199. <https://doi.org/10.1037/abn0000410>
163. UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind-Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
164. USPTSTF, Mangione CM, Barry MJ, Nicholson WK et al. (2022). Screening for Anxiety in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*, 328(14):1438–1444. DOI: 10.1001/jama.2022.16936 — PMID 36219403
165. 137. Üstündağ, Alev., Haydaroglu, Semanur., Sayan, Dilara., & Güngör, Merve. (2025). *The relationship between social anxiety levels and effective communication skills of adolescents participating in sports*. *Scientific Reports*, 15, 15724. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-00800-1>
166. Vũ Mạnh Lợi, et al. (2022). *Viet Nam Adolescent Mental Health Survey (V-NAMHS): Report on Main Findings*. Hanoi: Institute of Sociology.

167. 139. Wakefield, J. C. (1992). The concept of mental disorder: On the boundary between biological facts and social values. *American Psychologist*, 47(3), 373-388. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.3.373>
168. 140. Walder, N., Frey, A., Berger, T., & Schmidt, S. J. (2025). *Digital mental health interventions for prevention and treatment of social anxiety disorder in children, adolescents, and young adults: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials*. *Journal of Medical Internet Research*, 27, e67067. <https://doi.org/10.2196/67067>
169. 141. Walkup, John T., Albano, Anne Marie, Piacentini, John, Birmaher, Boris, Compton, Scott N., Sherrill, Joel T., Ginsburg, Golda S., Rynn, Moira A., McCracken, James, Waslick, Bruce, Iyengar, Sanjiv, March, John S., & Kendall, Philip C. (2008). Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. *New England Journal of Medicine*, 359(26), 2753–2766. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0804633>
170. 142. Wang, Ming-Te, & Degol, Jessica L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. *Educational Psychology Review*, 28(2), 315–352. <https://doi.org/10.1007/s10648-015-9319-1>
171. 143. Weare, K., & Nind, M. (2011). *Mental health promotion and problem prevention in schools: What does the evidence say?* Health Promotion International, 26(suppl_1), i29–i69. <https://doi.org/10.1093/heapro/dar075>
172. 144. Wei, X.-Y., Ren, L., Jiang, H.-B., Liu, C., Wang, H.-X., Geng, J.-Y., Gao, T., Wang, J., & Lei, L. (2023). Does adolescents' social anxiety trigger problematic smartphone use, or vice versa? A comparison between problematic and unproblematic smartphone users. *Computers in Human Behavior*, 140, 107602. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107602>
173. 145. Weyers, Peter; Ising, Marcus; Reuter, Martin; Janke, Wolfgang. (2005). Comparing two approaches for the assessment of coping: Part I. Psychometric properties and intercorrelations. *Journal of Individual Differences*, 26(4), 207–212.
174. 146. World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). <https://icd.who.int/>
175. 147. World Health Organization. (2022). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics* (11th Revision). Retrieved from <https://icd.who.int/>
176. Xi'an Jiao Tong University; Khulna University, Bangladesh; City University of Hong Kong (2025). *Prevalence of and Factors Associated with Anxiety among School*

- Going Adolescents: Analysis from 59 Countries*. Journal of Affective Disorders (Q1, IF $\approx 6,6$). 2025, Vol. 393, 120315, 11 trang. DOI 10.1016/j.jad.2025.06.001.
177. Xian J., Yan Zhang, Bo Jiang (2024). *Psychological interventions for social anxiety disorder in children and adolescents: A systematic review and network meta-analysis*, Journal of Affective Disorders vol. 365, tr. 614–627 (Xian, Zhang & Jiang 2024). PROSPERO CRD42023476829. DOI:10.1016/j.jad.2024.08.097.
 178. Xiaotong Wen, Yixiang Lin, Yuchen Liu, Katie Starcevich, Fang Yuan, Xiuzhu Wang, Xiaoxu Xie, Zhaokang Yuan (2020): *A Latent Profile Analysis of Anxiety among Junior High School Students in Less Developed Rural Regions of China*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(11):4079, tr1- 14. **DOI:** 10.3390/ijerph17114079. **PMID:** 32521646 | **PMCID:** PMC7312008.
 179. 151. Xie, S., Zhang, X., Cheng, W., & Yang, Z. (2021). Adolescent anxiety disorders and the developing brain: Comparing neuroimaging findings in adolescents and adults. *General Psychiatry*, 34(4), e100411. <https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100411>
 180. 152. Xie, Yaning. (1998). Reliability and validity of the simplified coping style questionnaire. *Chinese Journal of Clinical Psychology*, 6(2), 114–115.
 181. 153. Xu, Q., Mao, Z., Wei, D., Liu, P., Fan, K., Wang, J., Wang, X., Lou, X., Lin, H., Wang, C., & Wu, C. (2021). *Prevalence and risk factors for anxiety symptoms during the outbreak of COVID-19: A large survey among 373,216 junior and senior high school students in China*. Journal of Affective Disorders, 288, 17–22. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.03.080>. PMID: 33839554; PMCID: PMC9754660.
 182. Zhameden S. Dieu Yin, Mei Ken Low, Masuma Pervin Mishu (2025). *School-based interventions to prevent anxiety and depression in children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review*. PLOS ONE, 20(4): e0316825. Malaysia).<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316825>.DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316825>.
 183. 155. Zhang, Q., & Wang, Y. (2025). *Effectiveness of mobile-based cognitive behavioural therapy for depression and anxiety in children and young people: A systematic review of randomized controlled trials*. Clinical Psychology & Psychotherapy, 32(4), e70173. <https://doi.org/10.1002/cpp.70173>
 184. Zhangming Chen, Silan Ren, Ruini He, Yudiao Liang, Youguo Tan, Yi Liu, Fanglan Wang, Xu Shao, Shanshan Chen, Yanhui Liao, Ying He, Jin-Guang Li, Xiaogang Chen, Jinsong Tang (2023): *Prevalence and associated factors of depressive and anxiety symptoms among Chinese secondary school students*. BMC Psychiatry,

- 2023, 23:580. **DOI:** 10.1186/s12888-023-05068-1. **PMID:** 37563573 | **PMCID:** PMC10413612.
185. Zhihai Qiu, Ying Guo, Jun Wang, Hongbo Zhang (2022): *Associations of Parenting Style and Resilience With Depression and Anxiety Symptoms in Chinese Middle School Students*. *Frontiers in Psychology*, Volume 13, 2022, Article 897339. **DOI:** 10.3389/fpsyg.2022.897339. **PMID:** 35846635 | **PMCID:** PMC9285101.
186. Zugman A., MD, PhD; Anderson M. Winkler, MD, PhD; Purnima Qamar, BS; Daniel S. Pine, MD (2024). *Current and Future Approaches to Pediatric Anxiety Disorder Treatment*. Section on Development and Affective Neuroscience, National Institute of Mental Health (NIMH), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, Hoa Kỳ. *American Journal of Psychiatry — AJP* (Q1, IF $\approx$ 18). 2024, Vol. 181, No. 3, pp. 189–200, 12 trang. DOI 10.1176/appi.ajp.20231037.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH THCS

Phiếu khảo sát nhằm tìm hiểu thực trạng lo âu và các yếu tố liên quan ở học sinh THCS. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu và không ảnh hưởng đến việc học hay đánh giá cá nhân. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện. Em có thể từ chối hoặc dừng lại bất cứ lúc nào.

Rất mong nhận được sự hợp tác của em. Xin cảm ơn!

- ☐ Hãy tích vào ô trống nếu em đã đọc kỹ hướng dẫn và đồng ý tự nguyện tham gia khảo sát.

Phần I. Thông tin chung

1. Họ và tên.....

2. Giới tính

☐ Nam

☐ Nữ

3. Dân tộc

☐ Kinh

☐ Khác

4. Nơi sinh sống

☐ Nông thôn

☐ Thành thị

☐ Khác

5. Ngày/ tháng/ năm sinh: .../.../...

6. Học lực của em?

☐ Xuất sắc

☐ Giỏi

- ☐ Khá
- ☐ Trung bình
- ☐ Yếu

7. Tâm trạng hiện tại?

- ☐ Tồi tệ
- ☐ Kém
- ☐ Trung bình
- ☐ Tốt
- ☐ Rất tốt

8. Tình hình sức khỏe hiện tại?

- ☐ Tồi tệ
- ☐ Kém
- ☐ Trung bình
- ☐ Tốt
- ☐ Rất tốt

9. Thời gian sử dụng điện thoại/ ngày?

- ☐ Dưới 1 giờ
- ☐ 1 – 2 giờ
- ☐ 3 – 4 giờ
- ☐ Trên 4 giờ

10. Thời gian ngủ/ ngày?

- ☐ Dưới 3 giờ
- ☐ 4 – 5 giờ
- ☐ 6 – 7 giờ
- ☐ Trên 7 giờ

11. Thời gian hoạt động thể chất/ tuần?

- ☐ Không bao giờ
- ☐ 1 – 2 ngày/ tuần
- ☐ 3 – 4 ngày/ tuần
- ☐ 5 ngày trở lên

Phần 2. Nội dung

Câu 1. Rối loạn lo âu

Hướng dẫn:

Các em hãy đọc từng câu và chọn mức độ phù hợp nhất với mình trong thời gian gần đây.

Không có câu trả lời đúng hay sai, hãy trả lời theo cảm nhận thật của em.

Đánh dấu (✓) vào một trong các mức sau:

1 – Chưa bao giờ

2 – Thỉnh thoảng

3 – Nhiều lần

4 – Luôn luôn

TT	Mệnh đề	Mức độ			
		1	2	3	4
1	Tôi lo lắng về mọi thứ.				
2	Tôi lo lắng khi nghĩ rằng mình đã không làm tốt điều gì đó.				
3	Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng ai đó đang giận tôi.				
4	Tôi lo lắng rằng mình sẽ làm bài tập ở trường kém.				
5	Tôi lo lắng rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với ai đó trong gia đình tôi.				
6	Tôi lo lắng về việc mắc lỗi.				
7	Tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra.				
8	Tôi cảm thấy sợ khi ở một mình ở nhà.				
9	Tôi cảm thấy sợ nếu phải ngủ một mình.				
10	Tôi lo lắng khi đi ngủ vào ban đêm.				
11	Tôi sẽ cảm thấy sợ nếu phải ở xa nhà qua đêm.				
12	Tôi lo rằng mình sẽ trông ngốc nghếch.				
13	Tôi lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình.				
14	Tôi sợ rằng mình sẽ làm trò cười trước mặt người khác.				
15	Tôi cảm thấy sợ nếu phải nói trước lớp.				

Câu 2. Các yếu tố nguy cơ

Hướng dẫn:

Các em hãy đọc từng câu và chọn mức độ phù hợp nhất với mình trong thời gian gần đây.

Không có câu trả lời đúng hay sai, hãy trả lời theo cảm nhận thật của em.

Đánh dấu (✓) vào một trong các mức sau:

Thang đo sử dụng thang Likert 4 mức độ, từ 1 = Không đúng đến 4 = Hoàn toàn đúng.

TT	Mệnh đề	Mức độ			
Áp lực học tập		1	2	3	4
1	Tôi cảm thấy có quá nhiều bài tập về nhà.				
2	Việc học tập và đòi hỏi sự nghiệp tương lai mang lại cho tôi rất nhiều áp lực học tập.				
3	Cha mẹ tôi quá quan tâm đến điểm số của tôi, điều đó gây cho tôi nhiều áp lực.				
4	Tôi cảm thấy có quá nhiều kết quả kiểm tra/ kỳ thi kém.				

Thang đo sử dụng thang Likert 4 mức độ, từ 1 = Không đúng đến 4 = Rất đúng.

TT	Mệnh đề	Mức độ			
Nghiện điện thoại		1	2	3	4
1	Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn và bồn chồn khi không cầm điện thoại trên tay .				
2	Tâm trí tôi luôn nghĩ về điện thoại ngay cả khi không sử dụng nó.				
3	Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nếu không có điện thoại.				
4	Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc dùng điện thoại ngay cả khi nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi.				
5	Tôi liên tục kiểm tra điện thoại để không bỏ lỡ các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội (Facebook, tiktok, zalo,...)				

Thang đo sử dụng thang Likert 4 mức độ, từ 1 = Không đồng ý đến 4 = Rất đồng ý.

TT	Mệnh đề	Mức độ				
Bắt nạt thể chất		1	2	3	4	5
1	Tôi bị đánh đá, xô đẩy, hoặc bị nhốt trong nhà.					
2	Tôi bị đe dọa hoặc ép buộc làm những việc mình không muốn làm.					
3	Tôi bị lấy mất tiền hoặc bị hư hỏng tài sản.					
4	Tôi bị bắt nạt theo một cách khác.					

TT	Mệnh đề	Mức độ				
Bắt nạt lời nói		1	2	3	4	5
1	Các bạn học khác đã nói dối hoặc lan truyền tin đồn thất thiệt về tôi và cố gắng khiến người khác ghét tôi.					
2	Tôi bị bắt nạt bằng những cái tên hoặc những lời lẽ ác ý về đặc điểm cơ thể hoặc quần áo của mình.					
3	Tôi bị bắt nạt bằng những lời lẽ hoặc bình luận cừ chi thô lỗ.					
4	Tôi bị bắt nạt bằng những lời lẽ hoặc bình luận cừ chi ác ý mang tính chất tình dục.					

Câu 3. Yếu tố bảo vệ

Hướng dẫn:

Các em hãy đọc từng câu và chọn mức độ phù hợp nhất với mình trong thời gian gần đây.

Không có câu trả lời đúng hay sai, hãy trả lời theo cảm nhận thật của em.

Đánh dấu (✓) vào một trong các mức sau:

Thang đo sử dụng thang Likert 4 mức độ, từ 1 = Chưa bao giờ đúng với tôi đến 4 = Luôn luôn đúng.

TT	Mệnh đề	Mức độ			
Gắn bó với trường học		1	2	3	4
1	Tôi cảm thấy mình là một phần của ngôi trường này.				
2	Phần lớn giáo viên ở trường quan tâm đến tôi.				
3	Mọi người ở trường biết rằng tôi có thể học tập/ làm việc tốt.				
4	Mọi người ở trường thân thiện với tôi.				
5	Tôi được tham gia vào nhiều hoạt động ở trường.				
6	Tôi có thể thực sự là chính mình khi ở trường.				

Thang đo sử dụng thang Likert 5 mức độ, từ 1 = Không đồng ý đến 5 = Rất đồng ý,

TT	Mệnh đề	Mức độ				
Hỗ trợ từ cha mẹ		1	2	3	4	5
1	Gia đình tôi thực sự cố gắng giúp đỡ tôi.					
2	Tôi nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ về mặt cảm xúc mà tôi cần từ gia đình.					
3	Tôi có thể nói chuyện về những vấn đề của mình với gia đình.					
4	Gia đình tôi sẵn sàng giúp tôi đưa ra quyết định.					

Thang đo sử dụng thang Likert 5 mức độ, từ 1 = Không đồng ý đến 5 = Rất đồng ý,

TT	Mệnh đề	Mức độ				
Hỗ trợ từ bạn bè		1	2	3	4	5
1	Bạn bè tôi thực sự cố gắng giúp đỡ tôi.					
2	Tôi có thể trông cậy vào bạn bè khi mọi việc không suôn sẻ.					
3	Tôi có những người bạn mà tôi có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.					
4	Tôi có thể nói chuyện về những vấn đề của mình với bạn bè.					

Thang đo được sử dụng thang Likert 4 mức độ, từ 1 = Chưa bao giờ đúng với tôi đến 4 = Luôn luôn đúng.

TT	Mệnh đề	Mức độ			
Tự trọng		1	2	3	4
1	Nhìn chung, tôi hài lòng với bản thân mình.				
2	Tôi cảm thấy mình có nhiều phẩm chất tốt.				
3	Tôi có khả năng làm mọi việc tốt như hầu hết những người khác.				
4	Tôi cảm thấy mình là một người có giá trị, ít nhất là ngang bằng với người khác.				
5	Tôi có thái độ tích cực đối với bản thân.				

Câu 4. Biện pháp đối phó

Hướng dẫn:

Các em hãy đọc từng câu và chọn mức độ phù hợp nhất với mình trong thời gian gần đây.

Không có câu trả lời đúng hay sai, hãy trả lời theo cảm nhận thật của em.

Đánh dấu (✓) vào một trong các mức sau:

Thang đo sử dụng *thang Likert 4 mức độ*, từ 1 = Chưa bao giờ sử dụng đến 4 = Thường xuyên sử dụng.

TT	Mệnh đề	Mức độ			
<i>Tránh né</i>		1	2	3	4
1	Tôi đã tự chỉ trích bản thân.				
2	Tôi đã tự trách bản thân về những điều đã xảy ra.				
3	Tôi đã tự nói với mình rằng “điều này không phải là thật”.				
4	Tôi đã từ chối tin rằng điều đó đã xảy ra.				
5	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng giải quyết nó.				
<i>Tập trung giải quyết vấn đề</i>					
1	Tôi đã suy nghĩ kỹ về những bước cần thực hiện với nó.				
2	Tôi đã tập trung nỗ lực vào việc làm điều gì đó về tình huống mà tôi đang gặp phải.				
3	Tôi đã hành động để cố gắng làm cho tình huống trở nên tốt hơn.				
4	Tôi đã cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, để làm cho nó có vẻ tích cực hơn.				
5	Tôi đã tìm kiếm điều tích cực trong những gì đang xảy ra.				
6	Tôi đã cố gắng nghĩ ra một chiến lược về việc nên làm gì.				
<i>Tìm kiếm sự hỗ trợ</i>					
1	Tôi đã nhận được sự giúp đỡ và lời khuyên từ người khác.				
2	Tôi đã nhận được sự an ủi và thấu hiểu từ ai đó.				
3	Tôi đã nhận được sự hỗ trợ về mặt cảm xúc từ người khác.				
4	Tôi đã cố gắng tìm lời khuyên hoặc sự giúp đỡ từ người khác về việc nên làm gì.				

PHỤ LỤC 2

PHIẾU PHÒNG VẤN HỌC SINH THCS

(Về rối loạn lo âu, yếu tố ảnh hưởng và biện pháp đối phó)

Người phỏng vấn: Giới tính:

Ngày phỏng vấn:/...../..... Địa điểm phỏng vấn:

Ghi chú bổ sung:

I. Thông tin chung

1. Họ và tên học sinh:

2. Giới tính:

☐ Nam

☐ Nữ

☐ Khác

3. Lớp:

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

4. Trường:

II. Nội dung

1. Cảm nhận chung về rối loạn lo âu

1.1. Trong thời gian gần đây em có cảm thấy lo lắng hay căng thẳng không? Nếu có em thường lo về điều gì? Các biểu hiện diễn ra thỉnh thoảng hay thường xuyên?

.....

.....

.....

Khi lo lắng, em thường có những biểu hiện gì? (Gợi ý dựa trên phiếu khảo sát: suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể, hành vi) Em thấy mức độ lo lắng đó ảnh hưởng đến (học tập, quan hệ bạn bè, sinh hoạt hàng ngày) như thế nào?

.....

.....

.....

.....

2. Yếu tố nguy cơ

2.1. Em có cảm thấy áp lực học tập không? Áp lực học tập của em thường đến từ đâu? (bài tập, thi cử, gia đình, kỳ vọng bản thân)?

.....

.....

.....

Em thường sử dụng điện thoại bao lâu mỗi ngày? Việc sử dụng điện thoại có ảnh hưởng đến: Giấc ngủ/ việc học hay tâm trạng của em không?

.....

.....

.....

Em có từng gặp tình huống bị trêu chọc, cô lập hoặc bắt nạt không? Nếu có, những trải nghiệm đó khiến em cảm thấy như thế nào?

.....

.....

.....

Yếu tố bảo vệ

2.2. Khi gặp khó khăn hoặc lo lắng, em có chia sẻ với gia đình không? Hãy chia sẻ lý do bạn có/ không chia sẻ với gia đình?

.....

.....

.....

Em cảm nhận sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình như thế nào?

.....

.....

.....

Em có cảm thấy mình gắn bó với trường và lớp học không? Điều gì ở trường khiến em cảm thấy thoải mái hoặc không thoải mái?

.....

.....

.....

Em có bao nhiêu bạn thân? Bạn bè giúp em như thế nào khi em buồn hoặc lo lắng?

.....

.....

.....

4. Biện pháp đối phó

4.1. Khi lo lắng, em thường làm gì để cảm thấy tốt hơn? (*Tập trung giải quyết vấn đề/ né tránh vấn đề hay tìm kiếm sự hỗ trợ*)?

.....

.....

.....

Có khi nào em cảm thấy những cách đó không giúp ích không? Vì sao?

.....

.....

.....

5. Nhu cầu hỗ trợ

5.1. Theo em, nhà trường có thể làm gì để giúp học sinh giảm lo âu?

.....

.....

.....

Em mong muốn nhận được sự hỗ trợ như thế nào?

.....

.....

.....

PHỤ LỤC 3

PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN THCS

(Về rối loạn lo âu, yếu tố ảnh hưởng và biện pháp đối phó ở học sinh THCS)

Người phỏng vấn: Giới tính:

Ngày phỏng vấn:/...../..... Địa điểm phỏng vấn:

Ghi chú bổ sung:
.....

III. Thông tin chung

5. Họ và tên GV: Chức danh:

6. Giới tính:

☐ Nam

☐ Nữ

7. Là giáo viên Lớp:

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

8. Trường:

IV. Nội dung

1. Cảm nhận chung về rối loạn lo âu ở học sinh THCS

1.2. Theo cô, trong thời gian gần đây, học sinh THCS có dấu hiệu quá lo lắng không? Nếu có thì thường lo lắng về điều gì? Các biểu hiện diễn ra thỉnh thoảng hay thường xuyên?

.....
.....
.....
.....

Theo cô, những em học sinh có rối loạn lo âu, các em thường có những biểu hiện gì? (Gợi ý dựa trên bảng hỏi về các mặt suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể, hành vi)

.....
.....

.....

.....

2. Yếu tố nguy cơ

2.3. Theo cô, các em học sinh có than phiền về áp lực học tập không? Theo cô, áp lực học tập của HS thường đến từ đâu? (bài tập, thi cử, kỳ vọng gia đình, kỳ vọng bản thân)

.....

.....

.....

Theo cô, HS thường sử dụng điện thoại bao lâu mỗi ngày? Việc sử dụng điện thoại có ảnh hưởng đến: Giấc ngủ/ việc học hay tâm trạng của em không?

.....

.....

.....

Theo cô, HS THCS có tình trạng bị trêu chọc, cô lập hoặc bắt nạt không? Nếu có, những trải nghiệm đó thường biểu hiện như thế nào?

.....

.....

.....

.....

Yếu tố bảo vệ

2.4. Theo cô, khi gặp khó khăn hoặc lo lắng, HS có chia sẻ với gia đình không? các lý do mà học sinh có/ không chia sẻ với gia đình?

.....

.....

.....

Theo cô, sự hỗ trợ từ gia đình đối với học sinh THCS như thế nào?

.....

.....

.....

.....

Theo cô, Học sinh THCS hiện nay có gắn bó với trường và lớp học không? Điều gì khiến các em gắn bó hoặc kém gắn bó với trường học?

.....

.....

.....

Theo cô, mối quan hệ với bạn bè của học sinh THCS như thế nào? Sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè có ảnh hưởng như thế nào khi buồn hoặc lo lắng?

.....

.....

.....

4. Biện pháp đối phó

4.2. Khi lo lắng, Học sinh thường làm gì để cảm thấy tốt hơn? (*Tập trung giải quyết vấn đề/ né tránh vấn đề hay tìm kiếm sự hỗ trợ*)?

.....

.....

.....

Theo cô, những cách nào là chủ yếu và tác động & hiệu quả của các biện pháp đó?

.....

.....

.....

5. Nhu cầu hỗ trợ

5.2. Theo cô, giáo viên nên làm gì để giúp học sinh giảm rối loạn lo âu?

.....

.....

.....

Theo cô, nhà trường nên làm gì để giúp học sinh giảm rối loạn lo âu?

.....

.....

PHỤ LỤC

rối loạn lo âu lan tỏa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	7

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.811	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RCADS1	16.25	16.700	.607	.385	.776	.776
RCADS4	15.79	17.280	.546	.311	.786	.787
RCADS8	15.95	17.059	.488	.252	.796	.797
RCADS12	16.07	17.061	.480	.238	.798	.798
RCADS13	15.93	16.570	.502	.261	.795	.796
RCADS30	15.99	16.469	.627	.408	.772	.773
RCADS35	16.35	16.206	.598	.391	.777	.777

Rối loạn lo âu chia ly

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.726	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
--	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

RCADS5	5.25	5.145	.518	.295	.665	.665
RCADS17	5.24	4.912	.570	.340	.632	.635
RCADS45	5.36	5.369	.532	.285	.657	.671
RCADS46	5.17	5.439	.448	.212	.705	.712

Rối loạn lo âu xã hội

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.750	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RCADS20	7.55	6.165	.525	.296	.692	.704
RCADS32	7.10	5.866	.572	.347	.666	.681
RCADS43	7.33	5.641	.624	.392	.635	.645
RCADS38	7.45	6.448	.435	.203	.742	.743

Rối loạn lo âu chung

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.689	3

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.775	3

Item-Total Statistics^a

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LOAUTONGQUAT	16.8166	23.827	.630	.489	.458
LOAUCHIALY	28.5311	52.408	.331	.110	.779
LOAUXAHOI	25.7293	39.141	.658	.484	.435

a. Omega cannot be estimated under item deletion because the number of items is less than 4.

Áp lực học tập

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.708	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.716	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
ESSA.3	7.62	5.439	.393	.168	.705	.709
ESSA.4	7.38	5.112	.509	.294	.636	.648
ESSA.5	7.65	5.047	.474	.238	.658	.678
ESSA.6	7.76	4.749	.609	.379	.573	.579

Nghiện điện thoại

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.839	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
SASSV.5	7.54	8.827	.695	.504	.787	.790
SASSV.6	7.63	9.373	.644	.428	.803	.807
SASSV.4	7.23	8.481	.701	.501	.785	.786
SASSV.7	7.45	9.393	.613	.382	.810	.813

SASSV.8	7.18	9.150	.548	.304	.830	.833
---------	------	-------	------	------	------	------

Bất nạt thể chất

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	6

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.841	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
OBVQ.12	7.48	13.932	.670	.476	.806	.809
OBVQ.3	7.41	13.335	.679	.467	.802	.803
OBVQ.8	7.52	14.288	.619	.412	.816	.816
OBVQ.6	7.27	12.836	.650	.430	.808	.808
OBVQ.5	7.09	13.126	.549	.315	.833	.833
OBVQ.14	7.40	13.860	.581	.356	.821	.822

Bất nạt lời nói

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.864	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.864	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
OBVQ.4	5.09	9.314	.650	.422	.852	.853

OBVQ.7	5.17	8.786	.716	.521	.825	.826
OBVQ.9	5.30	9.200	.760	.596	.807	.808
OBVQ.11	5.33	9.371	.730	.553	.819	.822

Gắn bó với trường học

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	7

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.746	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
PSSM.1	15.85	13.043	.466	.225	.716	.715
PSSM.5	15.87	13.623	.442	.212	.721	.721
PSSM.15	15.73	13.176	.481	.239	.712	.712
PSSM.8	15.57	13.360	.482	.244	.713	.712
PSSM.10	15.56	13.302	.425	.187	.725	.724
PSSM.13	15.69	12.903	.459	.216	.718	.716
PSSM.17	15.47	12.988	.479	.242	.713	.712

Hỗ trợ cha mẹ

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.848	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
MSPSS.3	9.60	11.126	.710	.531	.796	.797
MSPSS.4	9.83	10.588	.744	.565	.780	.781
MSPSS.8	10.32	11.179	.615	.384	.837	.839
MSPSS.11	9.91	11.240	.675	.461	.810	.814

Hỗ trợ bạn bè

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.837	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
MSPSS.6	9.40	10.158	.692	.484	.783	.786
MSPSS.7	9.99	10.669	.633	.405	.809	.810
MSPSS.9	9.21	9.897	.688	.482	.785	.785
MSPSS.12	9.46	10.035	.661	.440	.797	.800

Đôi phó tập trung giải quyết vấn đề

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	6

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.699	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
--	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

BCope.25	13.14	9.556	.451	.216	.654	.653
BCope.2	12.99	9.975	.422	.183	.664	.663
BCope.7	12.80	9.824	.444	.214	.657	.657
BCope.12	12.93	9.469	.482	.260	.645	.644
BCope.17	12.94	9.396	.476	.257	.646	.646
BCope.14	13.06	8.868	.358	.130	.698	.697

Tự trọng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	5

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.724	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RSES1	10.66	5.500	.503	.259	.670	.671
RSES3	10.63	5.570	.526	.279	.662	.660
RSES4	10.73	5.720	.459	.221	.687	.687
RSES7	10.64	5.482	.481	.236	.679	.679
RSES10	10.25	5.495	.454	.216	.691	.691

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu lan tỏa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS1	1352	1	4	2.47	.921
RCADS4	1352	1	4	2.93	.891
RCADS8	1352	1	4	2.77	1.004
RCADS12	1352	1	4	2.65	1.015
RCADS13	1352	1	4	2.79	1.076
RCADS30	1352	1	4	2.73	.938
RCADS35	1352	1	4	2.38	1.015
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu chia ly

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS5	1352	1	4	1.76	1.001
RCADS17	1352	1	4	1.76	1.013
RCADS45	1352	1	4	1.65	.923
RCADS46	1352	1	4	1.84	.993
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo áp lực học tập

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ESSA.3	1352	1	4	2.51	.991
ESSA.4	1352	1	4	2.76	.959
ESSA.5	1352	1	4	2.49	1.016
ESSA.6	1352	1	4	2.38	.965
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo áp lực học tập

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
essa3chuan	1352	.00	100.00	50.4931	33.04469
essa4chuan	1352	.00	100.00	58.5552	31.97247
essa5chuan	1352	.00	100.00	49.5809	33.85705
essa6chuan	1352	.00	100.00	45.9073	32.16070
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo nghiện điện thoại

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sassv5chuan	1352	.00	100.00	23.8905	31.23815
sassv6chuan	1352	.00	100.00	20.9073	29.10681
sassv4chuan	1352	.00	100.00	34.1469	33.39735
sassv7chuan	1352	.00	100.00	27.0464	29.95328
sassv8chuan	1352	.00	100.00	35.9221	34.01530
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo bất nạt thể chất

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
obvq3chuan	1352	.00	100.00	10.5954	23.68051
obvq6chuan	1352	.00	100.00	14.2012	26.60242
obvq5chuan	1352	.00	100.00	18.4911	28.37470
obvq14chuan	1352	.00	100.00	10.7803	23.96645
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo bất nạt lời nói

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
obvq4chuan	1352	.00	100.00	21.8010	30.30244
obvq7chuan	1352	.00	100.00	19.8595	31.01149
obvq9chuan	1352	.00	100.00	16.5680	27.89660
obvq11chuan	1352	.00	100.00	15.7914	27.83321
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo áp lực, nghiện điện thoại, bất nạt thể chất, bất nạt tinh thần

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
apluc	1352	.00	100.00	51.1341	23.92194
nghiendt	1352	.00	100.00	28.3826	24.56459
bnthechat	1352	.00	100.00	13.5170	19.87380
bnloinoi	1352	.00	100.00	18.5050	24.67692
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo gắn bó với trường học

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pssm.1chuan	1352	.00	100.00	47.8550	32.27281
pssm.5chuan	1352	.00	100.00	47.3619	29.12677
pssm.15chuan	1352	.00	100.00	52.0217	30.68731
pssm.8chuan	1352	.00	100.00	57.3964	29.35040
pssm.10chuan	1352	.00	100.00	57.6923	32.24220
pssm.13chuan	1352	.00	100.00	53.2544	33.58053
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo hỗ trợ cha mẹ

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
msspss3chuan	1352	.00	100.00	65.4771	31.44105
msspss4chuan	1352	.00	100.00	59.8188	32.80644
msspss8chuan	1352	.00	100.00	47.5407	34.15684
msspss11chuan	1352	.00	100.00	57.7478	31.96868
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC hỗ trợ bạn bè

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
msspss6chuan	1352	.00	100.00	57.1191	31.06015
msspss7chuan	1352	.00	100.00	42.3817	30.42119
msspss9chuan	1352	.00	100.00	61.9268	32.38663
msspss12chuan	1352	.00	100.00	55.6583	32.53950
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo đối phó giải quyết vấn đề

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
bcope25chuan	1352	.00	75.00	35.8173	22.78162
bcope2chuan	1352	.00	75.00	39.5710	21.03804
bcope7chuan	1352	.00	75.00	44.3602	21.31626
bcope12chuan	1352	.00	75.00	40.9578	22.37449
bcope17chuan	1352	.00	75.00	40.7175	23.00121
bcope14chuan	1352	.00	750.00	37.8883	30.32389
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo tự trọng

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
rses1chuan	1352	.00	100.00	52.1943	27.41939
rses3chuan	1352	.00	100.00	53.2298	26.02148
rses4chuan	1352	.00	100.00	50.0247	26.68762
rses7chuan	1352	.00	100.00	53.0079	28.31727
rses10chuan	1352	.00	100.00	65.8037	29.13471
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo gắn bó với trường học, hỗ trợ cha mẹ, hỗ trợ bạn bè, đối phó giải quyết vấn đề và tự trọng

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ganbo100	1352	.00	100.00	52.5970	20.02147
chame100	1352	.00	100.00	57.6461	27.00088
banbe100	1352	.00	100.00	54.2714	25.90678
giaiquyet100	1352	.00	100.00	53.0654	19.40718
tutrong100	1352	.00	100.00	54.8521	18.99510
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu lan tỏa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS1chuan	1352	.00	100.00	49.1371	30.71500
RCADS4chuan	1352	.00	100.00	64.2751	29.69318
RCADS8chuan	1352	.00	100.00	59.0237	33.48006
RCADS12chuan	1352	.00	100.00	55.1282	33.83535
RCADS13chuan	1352	.00	100.00	59.6154	35.85915
RCADS30chuan	1352	.00	100.00	57.6923	31.25786
RCADS35chuan	1352	.00	100.00	45.8580	33.82471
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu chia ly

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS5chuan	1352	.00	100.00	25.3452	33.37470
RCADS17chuan	1352	.00	100.00	25.4931	33.77701
RCADS45chuan	1352	.00	100.00	21.5237	30.77120
RCADS46chuan	1352	.00	100.00	27.8846	33.10898
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu xã hội

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS20chuan	1352	.00	100.00	42.0858	34.07497
RCADS32chuan	1352	.00	100.00	56.9773	34.99160
RCADS43chuan	1352	.00	100.00	49.2604	35.13903
RCADS38chuan	1352	.00	100.00	45.3156	35.06833
Valid N (listwise)	1352				

Sự khác biệt giữa các thang đo RLLA theo đặc điểm giới tính

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
RLLALT100	Nam	614	51.4348	22.00979	.88824	.00	100.00
	Nu	738	59.4657	22.07230	.81249	.00	100.00
	Total	1352	55.8185	22.39589	.60909	.00	100.00
RLLACL100	Nam	614	25.4207	25.45898	1.02744	.00	100.00
	Nu	738	24.7629	23.29357	.85745	.00	100.00
	Total	1352	25.0616	24.29397	.66071	.00	100.00
RLLACLXH100	Nam	614	43.2003	25.09318	1.01268	.00	100.00
	Nu	738	52.7439	26.31114	.96853	.00	100.00
	Total	1352	48.4098	26.19067	.71229	.00	100.00

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
RLLALT100	Between Groups	21616.389	1	21616.389	44.484	.000
	Within Groups	656012.454	1350	485.935		
	Total	677628.842	1351			
RLLACL100	Between Groups	145.052	1	145.052	.246	.620
	Within Groups	797210.923	1350	590.527		
	Total	797355.975	1351			
RLLACLXH100	Between Groups	30526.034	1	30526.034	45.984	.000
	Within Groups	896193.846	1350	663.847		
	Total	926719.880	1351			

Sự khác biệt giữa các thang đo RLLA theo đặc điểm lớp học

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
RLLALT100	6	368	54.3219	21.38977	1.11502	.00	100.00
	7	316	53.6468	21.90521	1.23226	.00	100.00
	8	340	55.6303	23.70068	1.28535	.00	100.00
	9	328	59.7851	22.16548	1.22388	.00	100.00
	Total	1352	55.8185	22.39589	.60909	.00	100.00
RLLACL100	6	368	32.1332	26.35004	1.37359	.00	100.00
	7	316	27.1361	24.06193	1.35359	.00	100.00
	8	340	20.8824	22.91354	1.24266	.00	91.67

	9	328	19.4614	21.14376	1.16747	.00	100.00
	Total	1352	25.0616	24.29397	.66071	.00	100.00
RLLACLXH100	6	368	46.4221	24.05559	1.25398	.00	100.00
	7	316	48.1013	26.23323	1.47573	.00	100.00
	8	340	46.3725	26.69053	1.44750	.00	100.00
	9	328	53.0488	27.43454	1.51482	.00	100.00
	Total	1352	48.4098	26.19067	.71229	.00	100.00

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
RLLALT100	Between Groups	7487.439	3	2495.813	5.020	.002
	Within Groups	670141.404	1348	497.138		
	Total	677628.842	1351			
RLLACL100	Between Groups	35987.768	3	11995.923	21.239	.000
	Within Groups	761368.207	1348	564.813		
	Total	797355.975	1351			
RLLACLXH100	Between Groups	9953.768	3	3317.923	4.879	.002
	Within Groups	916766.112	1348	680.094		
	Total	926719.880	1351			

rối loạn lo âu lan tỏa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	7

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.811	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RCADS1	16.25	16.700	.607	.385	.776	.776
RCADS4	15.79	17.280	.546	.311	.786	.787
RCADS8	15.95	17.059	.488	.252	.796	.797

RCADS12	16.07	17.061	.480	.238	.798	.798
RCADS13	15.93	16.570	.502	.261	.795	.796
RCADS30	15.99	16.469	.627	.408	.772	.773
RCADS35	16.35	16.206	.598	.391	.777	.777

Rối loạn lo âu chia ly

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.726	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RCADS5	5.25	5.145	.518	.295	.665	.665
RCADS17	5.24	4.912	.570	.340	.632	.635
RCADS45	5.36	5.369	.532	.285	.657	.671
RCADS46	5.17	5.439	.448	.212	.705	.712

Rối loạn lo âu xã hội

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.750	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RCADS20	7.55	6.165	.525	.296	.692	.704

RCADS32	7.10	5.866	.572	.347	.666	.681
RCADS43	7.33	5.641	.624	.392	.635	.645
RCADS38	7.45	6.448	.435	.203	.742	.743

Rối loạn lo âu chung

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.689	3

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.775	3

Item-Total Statistics^a

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LOAUTONGQUAT	16.8166	23.827	.630	.489	.458
LOAUCHIALY	28.5311	52.408	.331	.110	.779
LOAUXAHOI	25.7293	39.141	.658	.484	.435

a. Omega cannot be estimated under item deletion because the number of items is less than 4.

Áp lực học tập

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.708	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.716	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
ESSA.3	7.62	5.439	.393	.168	.705	.709
ESSA.4	7.38	5.112	.509	.294	.636	.648

ESSA.5	7.65	5.047	.474	.238	.658	.678
ESSA.6	7.76	4.749	.609	.379	.573	.579

Nghien điện thoại

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.839	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
SASSV.5	7.54	8.827	.695	.504	.787	.790
SASSV.6	7.63	9.373	.644	.428	.803	.807
SASSV.4	7.23	8.481	.701	.501	.785	.786
SASSV.7	7.45	9.393	.613	.382	.810	.813
SASSV.8	7.18	9.150	.548	.304	.830	.833

Bất nạt thẻ chất

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.840	6

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.841	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
OBVQ.12	7.48	13.932	.670	.476	.806	.809
OBVQ.3	7.41	13.335	.679	.467	.802	.803
OBVQ.8	7.52	14.288	.619	.412	.816	.816
OBVQ.6	7.27	12.836	.650	.430	.808	.808
OBVQ.5	7.09	13.126	.549	.315	.833	.833
OBVQ.14	7.40	13.860	.581	.356	.821	.822

Bắt nạt lời nói

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.864	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.864	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
OBVQ.4	5.09	9.314	.650	.422	.852	.853
OBVQ.7	5.17	8.786	.716	.521	.825	.826
OBVQ.9	5.30	9.200	.760	.596	.807	.808
OBVQ.11	5.33	9.371	.730	.553	.819	.822

Gắn bó với trường học

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	7

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.746	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
PSSM.1	15.85	13.043	.466	.225	.716	.715
PSSM.5	15.87	13.623	.442	.212	.721	.721
PSSM.15	15.73	13.176	.481	.239	.712	.712
PSSM.8	15.57	13.360	.482	.244	.713	.712
PSSM.10	15.56	13.302	.425	.187	.725	.724
PSSM.13	15.69	12.903	.459	.216	.718	.716
PSSM.17	15.47	12.988	.479	.242	.713	.712

Hỗ trợ cha mẹ

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.848	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
MSPSS.3	9.60	11.126	.710	.531	.796	.797
MSPSS.4	9.83	10.588	.744	.565	.780	.781
MSPSS.8	10.32	11.179	.615	.384	.837	.839
MSPSS.11	9.91	11.240	.675	.461	.810	.814

Hỗ trợ bạn bè

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	4

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.837	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
MSPSS.6	9.40	10.158	.692	.484	.783	.786
MSPSS.7	9.99	10.669	.633	.405	.809	.810
MSPSS.9	9.21	9.897	.688	.482	.785	.785
MSPSS.12	9.46	10.035	.661	.440	.797	.800

Đôi phó tập trung giải quyết vấn đề

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	6

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
.699	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
BCope.25	13.14	9.556	.451	.216	.654	.653
BCope.2	12.99	9.975	.422	.183	.664	.663
BCope.7	12.80	9.824	.444	.214	.657	.657
BCope.12	12.93	9.469	.482	.260	.645	.644
BCope.17	12.94	9.396	.476	.257	.646	.646
BCope.14	13.06	8.868	.358	.130	.698	.697

Tự trọng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	5

Reliability Statistics

McDonald's Omega	N of Items
------------------	------------

.724	5
------	---

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	McDonald's Omega if Item Deleted
RSES1	10.66	5.500	.503	.259	.670	.671
RSES3	10.63	5.570	.526	.279	.662	.660
RSES4	10.73	5.720	.459	.221	.687	.687
RSES7	10.64	5.482	.481	.236	.679	.679
RSES10	10.25	5.495	.454	.216	.691	.691

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu lan tỏa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS1	1352	1	4	2.47	.921
RCADS4	1352	1	4	2.93	.891
RCADS8	1352	1	4	2.77	1.004
RCADS12	1352	1	4	2.65	1.015
RCADS13	1352	1	4	2.79	1.076
RCADS30	1352	1	4	2.73	.938
RCADS35	1352	1	4	2.38	1.015
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu chia ly

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS5	1352	1	4	1.76	1.001
RCADS17	1352	1	4	1.76	1.013
RCADS45	1352	1	4	1.65	.923
RCADS46	1352	1	4	1.84	.993
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo áp lực học tập

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ESSA.3	1352	1	4	2.51	.991
ESSA.4	1352	1	4	2.76	.959
ESSA.5	1352	1	4	2.49	1.016

ESSA.6	1352	1	4	2.38	.965
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo áp lực học tập

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
essa3chuan	1352	.00	100.00	50.4931	33.04469
essa4chuan	1352	.00	100.00	58.5552	31.97247
essa5chuan	1352	.00	100.00	49.5809	33.85705
essa6chuan	1352	.00	100.00	45.9073	32.16070
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo nghiện điện thoại

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sassv5chuan	1352	.00	100.00	23.8905	31.23815
sassv6chuan	1352	.00	100.00	20.9073	29.10681
sassv4chuan	1352	.00	100.00	34.1469	33.39735
sassv7chuan	1352	.00	100.00	27.0464	29.95328
sassv8chuan	1352	.00	100.00	35.9221	34.01530
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo bất nạt thể chất

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
obvq3chuan	1352	.00	100.00	10.5954	23.68051
obvq6chuan	1352	.00	100.00	14.2012	26.60242
obvq5chuan	1352	.00	100.00	18.4911	28.37470
obvq14chuan	1352	.00	100.00	10.7803	23.96645
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC đã quy đổi theo thang điểm 100 thang đo bất nạt lời nói

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
obvq4chuan	1352	.00	100.00	21.8010	30.30244
obvq7chuan	1352	.00	100.00	19.8595	31.01149

obvq9chuan	1352	.00	100.00	16.5680	27.89660
obvq11chuan	1352	.00	100.00	15.7914	27.83321
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo áp lực, nghiện điện thoại, bất nạt thể chất, bất nạt tinh thần

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
apluc	1352	.00	100.00	51.1341	23.92194
nghiendt	1352	.00	100.00	28.3826	24.56459
bnthechat	1352	.00	100.00	13.5170	19.87380
bnloinoi	1352	.00	100.00	18.5050	24.67692
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo gắn bó với trường học

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pssm.1chuan	1352	.00	100.00	47.8550	32.27281
pssm.5chuan	1352	.00	100.00	47.3619	29.12677
pssm.15chuan	1352	.00	100.00	52.0217	30.68731
pssm.8chuan	1352	.00	100.00	57.3964	29.35040
pssm.10chuan	1352	.00	100.00	57.6923	32.24220
pssm.13chuan	1352	.00	100.00	53.2544	33.58053
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo hỗ trợ cha mẹ

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
mspss3chuan	1352	.00	100.00	65.4771	31.44105
mspss4chuan	1352	.00	100.00	59.8188	32.80644
mspss8chuan	1352	.00	100.00	47.5407	34.15684
mspss11chuan	1352	.00	100.00	57.7478	31.96868
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC hỗ trợ bạn bè

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
mspss6chuan	1352	.00	100.00	57.1191	31.06015
mspss7chuan	1352	.00	100.00	42.3817	30.42119
mspss9chuan	1352	.00	100.00	61.9268	32.38663

mspss12chuan	1352	.00	100.00	55.6583	32.53950
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo đối phó giải quyết vấn đề

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
bcope25chuan	1352	.00	75.00	35.8173	22.78162
bcope2chuan	1352	.00	75.00	39.5710	21.03804
bcope7chuan	1352	.00	75.00	44.3602	21.31626
bcope12chuan	1352	.00	75.00	40.9578	22.37449
bcope17chuan	1352	.00	75.00	40.7175	23.00121
bcope14chuan	1352	.00	750.00	37.8883	30.32389
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo tự trọng

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
rses1chuan	1352	.00	100.00	52.1943	27.41939
rses3chuan	1352	.00	100.00	53.2298	26.02148
rses4chuan	1352	.00	100.00	50.0247	26.68762
rses7chuan	1352	.00	100.00	53.0079	28.31727
rses10chuan	1352	.00	100.00	65.8037	29.13471
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo gắn bó với trường học, hỗ trợ cha mẹ, hỗ trợ bạn bè, đối phó giải quyết vấn đề và tự trọng

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ganbo100	1352	.00	100.00	52.5970	20.02147
chame100	1352	.00	100.00	57.6461	27.00088
banbe100	1352	.00	100.00	54.2714	25.90678
giaiquyet100	1352	.00	100.00	53.0654	19.40718
tutrong100	1352	.00	100.00	54.8521	18.99510
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu lan tỏa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS1chuan	1352	.00	100.00	49.1371	30.71500
RCADS4chuan	1352	.00	100.00	64.2751	29.69318
RCADS8chuan	1352	.00	100.00	59.0237	33.48006

RCADS12chuan	1352	.00	100.00	55.1282	33.83535
RCADS13chuan	1352	.00	100.00	59.6154	35.85915
RCADS30chuan	1352	.00	100.00	57.6923	31.25786
RCADS35chuan	1352	.00	100.00	45.8580	33.82471
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu chia ly

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS5chuan	1352	.00	100.00	25.3452	33.37470
RCADS17chuan	1352	.00	100.00	25.4931	33.77701
RCADS45chuan	1352	.00	100.00	21.5237	30.77120
RCADS46chuan	1352	.00	100.00	27.8846	33.10898
Valid N (listwise)	1352				

ĐTB & ĐLC thang đo rối loạn lo âu xã hội

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RCADS20chuan	1352	.00	100.00	42.0858	34.07497
RCADS32chuan	1352	.00	100.00	56.9773	34.99160
RCADS43chuan	1352	.00	100.00	49.2604	35.13903
RCADS38chuan	1352	.00	100.00	45.3156	35.06833
Valid N (listwise)	1352				

Sự khác biệt giữa các thang đo RLLA theo đặc điểm giới tính

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
RLLALT100	Nam	614	51.4348	22.00979	.88824	.00	100.00
	Nu	738	59.4657	22.07230	.81249	.00	100.00
	Total	1352	55.8185	22.39589	.60909	.00	100.00
RLLACL100	Nam	614	25.4207	25.45898	1.02744	.00	100.00
	Nu	738	24.7629	23.29357	.85745	.00	100.00
	Total	1352	25.0616	24.29397	.66071	.00	100.00
RLLACLXH100	Nam	614	43.2003	25.09318	1.01268	.00	100.00
	Nu	738	52.7439	26.31114	.96853	.00	100.00
	Total	1352	48.4098	26.19067	.71229	.00	100.00

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
RLLALT100	Between Groups	21616.389	1	21616.389	44.484	.000
	Within Groups	656012.454	1350	485.935		
	Total	677628.842	1351			
RLLACL100	Between Groups	145.052	1	145.052	.246	.620
	Within Groups	797210.923	1350	590.527		
	Total	797355.975	1351			
RLLACLXH100	Between Groups	30526.034	1	30526.034	45.984	.000
	Within Groups	896193.846	1350	663.847		
	Total	926719.880	1351			

Sự khác biệt giữa các thang đo RLLA theo đặc điểm lớp học

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
RLLALT100	6	368	54.3219	21.38977	1.11502	.00	100.00
	7	316	53.6468	21.90521	1.23226	.00	100.00
	8	340	55.6303	23.70068	1.28535	.00	100.00
	9	328	59.7851	22.16548	1.22388	.00	100.00
	Total	1352	55.8185	22.39589	.60909	.00	100.00
RLLACL100	6	368	32.1332	26.35004	1.37359	.00	100.00
	7	316	27.1361	24.06193	1.35359	.00	100.00
	8	340	20.8824	22.91354	1.24266	.00	91.67
	9	328	19.4614	21.14376	1.16747	.00	100.00
	Total	1352	25.0616	24.29397	.66071	.00	100.00
RLLACLXH100	6	368	46.4221	24.05559	1.25398	.00	100.00
	7	316	48.1013	26.23323	1.47573	.00	100.00
	8	340	46.3725	26.69053	1.44750	.00	100.00
	9	328	53.0488	27.43454	1.51482	.00	100.00
	Total	1352	48.4098	26.19067	.71229	.00	100.00

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
RLLALT100	Between Groups	7487.439	3	2495.813	5.020	.002
	Within Groups	670141.404	1348	497.138		
	Total	677628.842	1351			

RLLACL100	Between Groups	35987.768	3	11995.923	21.239	.000
	Within Groups	761368.207	1348	564.813		
	Total	797355.975	1351			
RLLACLXH100	Between Groups	9953.768	3	3317.923	4.879	.002
	Within Groups	916766.112	1348	680.094		
	Total	926719.880	1351			